

The image features a white background with several pink carnations and individual petals scattered across it. Some flowers are fully bloomed, showing multiple layers of ruffled petals, while others are buds or single petals. The petals are a vibrant pink color, and the buds are green with some pink at the base. The text is centered in the middle of the image.

KUMPULAN SOAL OSCE ANESTESI & TERAPI INTENSIF

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
ANESTESIA OBSTETRIK.....	1
Sectio caesarea dengan spinal anestesia dan manajemen penyulit appendicitis akut.	2
Preeklampsia berat.....	8
NEUROANESTESIA.....	16
Cedera kepala	17
Epidural hematoma (Intubasi).....	24
ANESTESIA REGIONAL & MANAJEMEN NYERI.....	29
Apendisitis akut	30
Combined Spinal Epidural	37
Continuous Spinal Epidural	45
Anestesia Spinal.....	59
ANESTESIA BEDAH THORAKS	66
Thoracotomi / Lobektomi	67
ANESTESIA PEDIATRI.....	77
Adenotonsilektomi pediatri.....	78
Hernia.....	88
Labio palatoschizis	97
Tracheoesophageal Fistula	106
Volvulus pada Anak (Intubasi)	114
Kasus 1.....	114
Kasus 2.....	120
ANESTESIA UROLOGI.....	127
TURP	128
Pemasangan Hemodialisa catheter	135
ANESTESIA ENDOKRIN, METABOLIK, & PENYAKIT KHUSUS	148
Hipertiroid pada operasi darurat (NGT).....	149
Ketoasidosis diabetikum	160
Thyroid intubasi sulit.....	167
ANESTESIA BEDAH KEPALA LEHER	176
Pascaoperasi <i>functional endoscopic sinus surgery</i> (FESS)	177
ANESTESIA BEDAH RAWAT JALAN (LUAR KAMAR BEDAH)	185
Operasi Mata (Pemasangan LMA).....	186
Tumor payudara	194
ANESTESIA PADA PROSEDUR INVASIF INVASIF.....	201

Cricotiroidotomi.....	202
Laparoskopi Appendektomi	213
Pneumothorax ec Laparoscopy	223
Laparoskopi Appendektomi & Obesitas (Intubasi)	233
ANESTESIA EMERGENCY.....	241
Pemasangan CVC.....	242
Kasus 1.....	242
Kasus 2.....	246
Kasus 3.....	252
Cedera kepala (Penanganan peningkatan TIK)	257
Luka bakar (Pemasangan CVC)	266
Luka bakar.....	270
Penyulit Emergency.....	277
Thoracosentesis	285
TERAPI INTENSIF (ICU)	293
Preeklampsia berat dengan edema paru	294
Gagal napas dan Syok kardiogenik	302
Gagal napas.....	308
Kardioversi pada Supraventricular tachycardia.....	314
Sepsis (Pengaturan awal ventilator)	322
ARDS	329

ANESTESIA OBSTETRIK

SOAL UJIAN OSCE STATION ANESTESIA OBSTETRIK

1	Nomor Station	1
2	Judul station	Sectio caesarea dengan spinal anestesia dan manajemen penyulit appendicitis akut.
3	Waktu yang dibutuhkan	17 menit
4	Tujuan station	Menilai kemampuan peserta melakukan rencana tindakan anestesi, keterampilan klinis, monitoring dan manajemen penyulit serta komunikasi, edukasi dan profesionalisme.
5	Kompetensi	1. Evaluasi pra anestesia 2. Diagnosis dan problem aktual – potensial 3. Rencana tindakan anestesi 4. Keterampilan klinis 5. Monitoring dan manajemen penyulit 6. Manajemen pasca anestesia 7. Komunikasi, edukasi dan profesionalisme
6	Kategori	1. Anestesia Obstetrik 2. Anestesia Bedah Saraf 3. Anestesia Regional Dan Manajemen Nyeri 4. Anestesia Bedah Toraks 5. Anestesia Pediatrik 6. Anestesia Kegawatdaruratan 7. Anestesia Urologi 8. Anestesia Untuk Penyakit Penyakit Khusus (Endokrin) 9. Anestesia Bedah Kepala Leher 10. Anestesia Bedah Rawat Jalan / Luar Kamar Bedah 11. Anestesia Pada Prosedur Invasif Minimal 12. Terapi Intensif
7	Instruksi untuk peserta	<u>Skenario Klinik :</u> Seorang perempuan berusia 28 tahun berat badan 75 kg dengan G1P0A0 kehamilan aterm inpartu, letak sungsang, disertai appendicitis akut dengan Tekanan Darah 138/88 mmHg laju nadi 112 x/menit, laju napas 18x/mnt, suhu: 39,2 °C. Pasien akan dilakukan operasi SC cito dan appendiktomi, dengan anestesi spinal. <u>Instruksi Peserta:</u> 1. Sebutkan problem potensial dan aktual pada pasien ini! 2. Sebutkan persiapan pasien sebelum tindakan Anestesi! 3. Lakukan anestesi spinal pada pasien ini! 4. Sebutkan manajemen nyeri pasca anestesi spinal pada pasien ini!
8	Instruksi untuk penguji	INSTRUKSI UMUM 1. Pastikan identitas peserta ujian pada kartu ujian. 2. Tulislah nama dan nomor peserta ujian pada lembar penilaian. 3. Amatilah dan berilah skor (0/1/2/3) atas tugas yang dikerjakan peserta ujian serta skor <i>Global Rating</i> sesuai rubrik penilaian. 4. Hindarilah interupsi dan/atau tindakan selain daripada yang diminta dalam instruksi penguji. 5. Berikan informasi/hasil yang dibutuhkan secara lisan/tulisan hanya apabila peserta ujian telah melakukan dan/atau mengusulkan jenis pemeriksaan yang dimaksud (perhatikan instruksi khusus).

		6. Pada station ini akan digunakan mesin monitor pasien dinamis yang akan dikendalikan oleh penguji sesuai setting yang akan ditentukan pada instruksi khusus penguji 7. Taatilah peraturan serta etika penguji selama menjalankan tugas sebagai penguji OSCE – ATI. INSTRUKSI KHUSUS 1. Penguji menilai peserta menyebutkan problem aktual dan potensial pada pasien ini. Problem aktual: 1. Kehamilan 2. hipertermia 3. nyeri akut Problem potensial: 4. Mual muntah 5. aspirasi 6. hipotensi 7. bradikardia 8. high spinal block 2. Penguji menilai peserta menyebutkan persiapan pasien sebelum tindakan Spinal anestesi yang dikerjakan peserta ujian. 1. Pasang IV line nomor besar dan lancar 2. Rehidrasi dengan cairan kristaloid 3. Puasa atau nothing per oral 4. Turunkan suhu tubuh 5. Pemberian obat anti muntah 6. Pemberian antibiotic 3. Penguji menilai pelaksanaan tindakan Spinal anestesi yang dikerjakan peserta ujian. SPINAL ANESTESI : 1. Melakukan pemasangan monitor standar dan mengamati tanda vital sebelum 2. Memposisikan pasien lateral decubitus kiri atau duduk 3. Membuat landmark yaitu L3-L4 sejajar dengan aspektus superior krista iliaka (<i>Tuffier's line</i>) dan menentukan titik penusukan. 4. Cuci tangan dan memakai gaun bedah steril, memakai sarung tangan steril. 5. Melakukan tindakan aseptik dan antiseptik pada landmark yang sudah ditentukan dan menutupnya dengan doek lobang steril. 6. Melakukan infiltrasi anestesi lokal pada celah yang akan dilakukan penusukan jarum spinal. 7. Melakukan penusukan jarum spinal sampai keluar LCS 8. Memasukkan obat anestesi lokal secara perlahan. 9. Memastikan blok spinal berjalan baik, target blok yang adekuat untuk sc adalah dari Th 4 -6. 4. Penguji menilai manajemen nyeri pasca anestesi spinal pada pasien ini: • Multimodal analgesi - NSAID
--	--	--

		- Opioid - Paracetamol	
9	Tata letak station	Setting kamar operasi	
10	Kebutuhan Laboran	1 orang sebagai penata (asisten) anestesi	
11	Peralatan yang dibutuhkan	Peralatan kamar operasi - Spinal set - Nampan alat - Duk lobang - Cawan 3 dengan label povidone iodine, alkohol, nacl 0,9% - Korentang - Kassa - Spinocain no 25, 26,27 - Topi dan Masker - Sarung tangan steril 6,5 7 7,5 - Alkohol 70% - Povidone iodine 10% - Sduit 1 cc, 3 cc, 5 cc, 10 cc - Plester - Gunting - Obat anestesi lokal (lidocaine, bupivacaine, ropivacaine) - Obat ephedrine + Sduit dengan label ephedrine - Water for injection	3 set 1 buah 1 buah 1 set 1 buah 5 buah @ 5 buah 1 kotak @10 buah 1 botol 1 botol 2 set 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah
12	Kebutuhan manekin	Manekin Spinal	
12	Penulis	Tim Soal OSCE ATI	
13	Referensi	Morgan & Mikhail's Clinical Anesthesiology 5 th Edition	

**RUBRIK ACTUAL MARK
OSCE STATION ANESTESIA OBSTETRIK**

Aspek yang Dinilai	0	1	2	3	Bobot	Skor
1. Diagnosis dan problem aktual – potensial Problem aktual: 1. Kehamilan 2. hipertermia 3. nyeri akut Problem potensial: 4. Mual muntah 5. aspirasi 6. hipotensi 7. bradikardia 8. high spinal block	Peserta tidak menyebutkan problem aktual dan potensial	-	Peserta menyebutkan problem aktual dan potensial kurang dari 5	Peserta menyebutkan problem aktual dan potensial lebih dari 5	2	
3. Rencana tindakan anestesi. 1. Pasang IV line 2. Rehidrasi cairan 3. Puasa 4. Turunkan suhu tubuh 5. Pemberian obat anti muntah 6. Pemberian antibiotik	Peserta tidak menyebutkan persiapan	-	Peserta menyebutkan persiapan kurang dari 3	Peserta menyebutkan persiapan lebih dari 3	1	
4. Keterampilan klinis SPINAL ANESTESI : 1. Melakukan pemasangan monitor standar dan mengamati tanda vital	Peserta ujian tidak melakukan tindakan spinal anesthesia	Peserta ujian melakukan tahapan tindakan Spinal	Peserta ujian melakukan tahapan tindakan Spinal anestesia	Peserta ujian melakukan tahapan tindakan Spinal anestesia dengan	3	

sebelum tindakan - Memposisikan pasien lateral decubitus kiri atau duduk - Membuat landmark yaitu L3-L4 sejajar dengan aspektus superior krista iliaka (<i>Tuffier's line</i>) dan menentukan titik penusukan. - Cuci tangan dan memakai gaun bedah steril, memakai sarung tangan steril. - Melakukan tindakan aseptik dan antiseptik pada landmark yang sudah ditentukan dan menutupnya dengan doek lobang steril. - Melakukan infiltrasi anestesi lokal pada celah yang akan dilakukan penusukan jarum spinal. - Melakukan penusukan jarum spinal sampai keluar LCS - Memasukkan obat anestesi lokal secara perlahan. - Memastikan blok spinal berjalan baik, target blok yang adekuat untuk sc adalah dari Th 4 -6.		anestesia dengan tidak lengkap dan tidak berurutan serta gagal/tidak keluar cairan LCS	dengan tidak lengkap dan tidak berurutan tapi berhasil keluar cairan LCS	benar, lengkap dan berurutan serta berhasil keluar cairan LCS		
5. Manajemen nyeri pasca anestesi spinal pada pasien ini: - Multimodal analgesi - NSAID - Opioid - Paracetamol	Peserta tidak menyebutkan manajemen nyeri	Peserta menyebutkan 1	-	Peserta menyebutkan lebih dari 1	3	

7. Komunikasi dan Perilaku profesional 1. melakukan setiap tindakan dengan berhati-hati dan teliti sehingga tidak membahayakan pasien dan diri sendiri 2. memperhatikan kenyamanan pasien 3. melakukan tindakan sesuai prioritas 4. menunjukkan rasa hormat kepada pasien 5. mengetahui keterbatasan dengan merujuk atau melakukan konsultasi bila diperlukan	Peserta tidak meminta izin secara lisan dan sama sekali tidak melakukan poin Komunikasi dan Perilaku professional.	Peserta meminta izin secara lisan dan melakukan 1-2 poin perilaku profesionalisme.	Peserta meminta izin secara lisan dan melakukan 3-4 point perilaku profesionalisme.	Peserta melakukan secara lengkap perilaku profesionalisme.	1	
TOTAL SKOR						

SOAL UJIAN OSCE STATION ANESTESIA OBSTETRIK

1	Nomor Station	5
2	Judul Station	Preeklampsia berat
3	Waktu yang dibutuhkan	20 menit
4	Tujuan Station	Menilai kemampuan melakukan Evaluasi Preoperative, Diagnosa dan problem potensial – aktual, rencana tindakan anestesi, Manajemen paska bedah
5	Kompetensi :	Evaluasi Preoperative Diagnosa dan problem potensial - aktual Rencana tindakan anestesi - Keterampilan klinis - Monitoring dan manajemen penyulit Manajemen paska bedah Komunikasi, edukasi dan profesionalisme
6	Kategori	Anestesi obstetri - Neuroanestesi - Anestesi Regional dan Manajemen Nyeri - Anestesi Kardiovaskular - Anestesi Pediatrik - Anestesi Kegawat daruratan - Anestesi Urologi - Anestesi untuk penyakit Endokrin, metabolic dan penyakit – penyakit khusus - ICU - Anestesi pada kepala leher
7	Intruksi untuk peserta ujian	<u>Skenario Klinik :</u> Seorang Perempuan 29 tahun primi gravida direncanakan SC. Indikasi operasi letak sungsang dengan umur kehamilan 39 minggu. Pasien tidak memiliki riwayat penyakit sebelumnya. Tekanan darahnya saat ANC 8 minggu 120/70 mmHg. Sekarang pasien mengeluh nyeri kepala bagian depan, mual dan kakinya membengkak. Instruksi untuk peserta : - Lakukan evaluasi preoperative - Tentukan diagnosis dan persiapan preoperative - Tentukan dan sebutkan Rencana tindakan anestesi - Sebutkan dan tuliskan manajemen paska bedah
8	Instruksi untuk penguji	<u>Skenario Klinik :</u> Seorang Perempuan 29 tahun primi gravida direncanakan SC. Indikasi operasi letak sungsang dengan umur kehamilan 39 minggu. Pasien tidak memiliki riwayat penyakit sebelumnya. Tekanan darahnya saat ANC 8 minggu 120/70 mmHg. Sekarang pasien mengeluh nyeri kepala bagian depan, mual dan kakinya membengkak. Instruksi untuk peserta : Lakukan evaluasi preoperative

		2. Tentukan diagnosis dan persiapan preoperative 3. Tentukan dan sebutkan Rencana tindakan anestesi 4. Sebutkan dan tuliskan manajemen pasca bedah Intruksi penguji : <u>INSTRUKSI UMUM</u> 1. Pastikan identitas peserta ujian pada kartu ujian 2. Tulislah nama dan nomor peserta ujian pada lembar penilaian! 3. Amatilah dan berilah skor (0/1/2/3) atas tugas yang dikerjakan peserta ujian serta skor <i>Global Rating</i> sesuai rubrik penilaian 4. Hindarilah interupsi dan/atau tindakan selain daripada yang diminta dalam instruksi penguji! 5. Berikan informasi/hasil yang dibutuhkan secara lisan/tulisan hanya apabila peserta ujian telah melakukan dan/atau mengusulkan jenis pemeriksaan yang dimaksud (perhatikan instruksi khusus)! 6. Taatilah peraturan serta etika penguji selama menjalankan tugas sebagai penguji OSCE - ATI! <u>INSTRUKSI KHUSUS :</u> 1. Penguji mengamati dan menilai tindakan preoperatif yang dilakukan peserta dan memberikan hasil pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang bila diminta oleh peserta. Peserta menanyakan : Anamnese Alergi (-), Medication (-), Past illness (-), Last meal 1 jam sebelum MRS, Event (-) nyeri kepala bagian depan, mual dan kakinya membengkak. Pemeriksaan Klinis: BB 92 kg, TB 155 cm. Kesadaran Compos mentis GCS14 E3V5M6, pupil isokor 3mm/3mm RC +/- Frekuensi nafas 18-20 x/menit, suara pernafasan vesikuler suara tambahan tidak ada, Tekanan darah 170/120 mmHg, Nadi 112 x/menit, kuat, Jantung : suara jantung normal, Suhu 37°C. VAS Diam 2/10 cm dan VAS saat HIS 6/10 cm. SaO2 95%. Abdomen distensi, defans muscular (+) Produksi urine : 50 cc/3 jam Pemeriksaan penunjang : Hasil Laboratorium : Darah Rutin : Hb 9,8 gr%, Ht 30%, WBC 19 k/μL, Plt 87 gr/dl Faal Hemostasis : PPT10,9 (12,2) , APTT 35,8 (30,7), INR 1,5 Bun (Ureum) : 78 mg/dl, Creatinin 2,1 mg/dl Na 147 mmol/L, Kalium 5 mmol/L ,Cl 119 mmol/L Faal Hati : AST 189, ALT 163, LDH 896, albumin 2,5, globulin 3,42
--	--	--

		Glukosa 98 mg/dl, Urinalisa : Berat jenis 1,020; pH 6,5; Protein +4; glukosa +2; Keton +1; eritrosit +2 Thorak foto : belum dikerjakan EKG : Sinus Takikardia. 2. Penguji menilai Diagnosa dan persiapan preoperative. Diagnosa : Preeklapsia Berat + HELLP Syndrome Persiapan preoperative : 1. Kontrol tekanan darah : turunkan tekanan darah 20% dari nilai awal, target MAP 105 – 125 mm Hg. 2. Pencegahan kejang : pemberian MgSO₄ iv 3. Iv line besar, persiapan darah 4. Monitoring efek samping MgSO₄ : frekuensi nafas, produksi urine dan reflek patella dan bila mungkin periksa kadar MgSo4 setidaknya 4 jam setelah memulai terapi MgSo4. Target konsentrasi 4-6 mEq/L. 5. Monitoring denyut jantung janin 6. Pencegahan aspirasi pneumonia : 30 ml oral non particulated antacid + metocloperamide 10 mg iv + H2 blocker iv 3. Penguji menilai Manajemen anestesi yang dilakukan peserta Pilihan Anestesi : General Anestesi intubasi dengan RSI Rencana Tindakan Anestesi : 1. STATIC, menyiapkan obat anestesi yang diperlukan, mengecek mesin anestesi dan alat monitor pasien, memakai alat pelindung diri (minimal handschoen) 2. Posisi pasien Head Up minimal 30 derajat 3. Tim operator harus sudah siap dgn drapping pasien 4. Induksi dengan agen IV cepat (propofol / etomidate), Muscle relaxan kerja cepat Suksinilkolin 1,5 mg/kgbb atau rocuronium 0,9-1,2 mg/kgbb, bila perlu priming. 5. Cricoid pressure dengan lembut sebelum induksi (sellick's maneuver) 6. Tidak diberikan ventilasi tekanan positif. 7. Siapkan 3 ukuran ETT, memilih pipa endotrakeal dengan ukuran lebih kecil : 6 atau 6,5 mm 8. Mampu melakukan teknik rumatan anestesi umum dengan 2/3 MAC volatile anestesi 9. Opioid diberikan setelah bayi lahir 4. Penguji menilai manajemen paska operative yang disebutkan dan ditulis peserta 1. Pasien di rawat di ICU 2. Pilihan utama analgesia sistemik opioid intravena menggunakan syringe pump 3. Bolus parasetamol. 4. Sebaiknya dihindari penggunaan analgesia epidural karena penderita dengan peningkatan tekanan
--	--	---

		intracranial dan HELLP syndrome 5. Sebaiknya tidak diberikan NSAID untuk mencegah terganggunya agregasi trombosit dan juga karena pasien dengan AKI. 6. Pemberian analgetik opioid intravena. 7. Pemberian obat antihipertensi
9	Denah ruangan	Ruang 3mx4m Meja Operasi Meja Peserta Kursi penguji Meja penguji Meja Alat T.Sampah Meja Peserta Kursi PS
10	Peralatan yang dibutuhkan	Setting ruangan dokter-pasien - Meja dan kursi dokter 1 set - Kursi pasien 1 buah - Meja dan kursi penguji 1 set - Meja peralatan 1 buah - Meja operasi 1 set - Manekin ibu hamil 1 buah - Stetoskop 1 buah - Monitor Pasien 1 buah - Laringoskop 1 buah - Sungkup Muka 1 buah - Ambu Bag 1 buah - ETT 7 6,5 6 1 buah - Plester 1 buah - Sarung tangan non steril - Rekam medis 5 lembar - Tempat sampah tertutup 1 buah - Tissue 1 kotak - Jam dinding 1 buah
11.	Penulis	Tim Item Soal OSCE ATI
12.	Referensi	Morgan: clinical of anesthesiology edisi V

**RUBRIK ACTUAL MARK
OSCE STATION ANESTESIA OBSTETRIK**

I. Rubrik Penilaian

Aspek yang Dinilai	0	1	2	3	Bobot	Nilai
1. Preoperatif Evaluation	Peserta ujian tidak melakukan tindakan Atau melakukan tetapi tidak sesuai perintah Atau melakukan tetapi tidak sesuai masalah klinik pasien atau tidak melakukan pemeriksaan fisik	Kandidat hanya mampu identifikasi 3-4 point dengan tepat, lengkap dan benar dari 6 point tapi tidak lengkap	Peserta mampu identifikasi 5 – 6 point tapi tidak lengkap	Peserta ujian menanyakan dan melakukan pemeriksaan klinis pada: 1.Sistem kardiovaskuler 2.Sistem respirasi 3.Sistem saraf pusat 4.Sistem renal 5.Pemeriksaan penunjang: HELLP syndrome 6. AMPLE	3	
2. Diagnosa Problem potensial - actual	Peserta tidak menyebutkan diagnose dan persiapan preoperative	Peserta hanya mampu menentukan diagnose	Peserta mampu menentukan diagnose namun tidak lengkap persiapan preoperative	Peserta mampu menentukan diagnosa dan persiapan anestesi Diagnosa : Preeklapsia Berat + HELLP Syndrome Persiapan preoperative : 1. Kontrol tekanan darah : 2. Pencegahan kejang : pemberian MGSO4 iv 3. Iv line besar, persiapan darah 4. Monitoring efek samping MgSo4 : 5. Monitoring denyut jantung janin 6. Pencegahan aspirasi pneumonia : 30 ml oral non particulated antacid + metocloperamide 10 mg iv	5	

				+ H2 blocker iv		
3. Rencana tindakan Anestesi	Peserta tidak ampu menentukan diagnose dan Peserta tidak mampu menjelaskan rencana anestesi	Peserta mampu menentukan tindakan anestesi tp tidak lengkap dan menjelaskan rencana anestesi namun tidak lengkap dan runut	Peserta mampu menentukan tindakan anestesi dan menjelaskan rencana anestesi namun tidak lengkap dan runut	Peserta mampu menentukan tindakan anestesi dan menjelaskan rencana anestesi Pilihan Anestesi : General Anestesi intubasi dengan RSI Rencana Tindakan Anestesi : 1. STATIC, menyiapkan obat anestesi yang diperlukan, mengecek mesin anestesi dan alat monitor pasien, memakai alat pelindung diri (minimal handschoen) 2. Posisi pasien Head Up minimal 30 derajat 3. Tim operator harus sudah siap dgn drapping pasien 4. Induksi dengan agen IV cepat (propofol / etomidate), Muscle relaxan kerja cepat Suksinilkolin 1,5 mg/kgbb atau rocuronium 0,9-1,2 mg/kgbb, bila perlu priming. 5. Cricoid pressure dengan lembut sebelum induksi (sellick's maneuver) 6. Tidak diberikan ventilasi tekanan positif. 7. Siapkan 3 ukuran ETT, memilih pipa endotrakeal dengan ukuran lebih kecil : 6 atau 6,5 mm 8. Mampu melakukan teknik	5	

				rumatan anestesi umum dengan 2/3 MAC volatile anestesi 9. Opioid diberikan setelah bayi lahir		
4. Manajemen paska bedah	Peserta tidak mampu menjelaskan manajemen paska bedah	-	Peserta mampu menjelaskan manajemen paska bedah namun tidak lengkap	Peserta mampu menjelaskan manajemen paska bedah dengan lengkap 1. Pasien di rawat di ICU 2. Pilihan utama analgesia sistemik opioid intravena menggunakan syringe pump 3. Bolus parasetamol. 4. Sebaiknya dihindari penggunaan analgesia epidural karena penderita dengan peningkatan tekanan intracranial dan HELLP syndrome 5. Sebaiknya tidak diberikan NSAID untuk mencegah terganggunya agregasi trombosit dan juga karena pasien dengan AKI. 6. Pemberian analgetik opioid intravena. 7. Pemberian obat antihipertensi	2	
5. Komunikasi, edukasi dan profesionalism	Peserta ujian tidak meminta izin secara lisan dan sama sekali	Meminta izin secara lisan dan 1-2 poin berikut : 1. melakukan setiap	Meminta izin secara lisan dan 3 poin berikut: 1. melakukan setiap	Meminta izin secara lisan dan melakukan di bawah ini secara lengkap :	3	

e	tidak melakukan poin berikut: 1. melakukan setiap tindakan dengan berhati-hati dan teliti sehingga tidak membahayakan pasien dan diri sendiri 2. memperhatikan kenyamanan pasien 3. melakukan tindakan sesuai prioritas 4. menunjukkan rasa hormat kepada pasien 5. mengetahui keterbatasan dengan merujuk atau melakukan konsultasi bila diperlukan	2. memperhatikan kenyamanan pasien 3. melakukan tindakan sesuai prioritas 4. menunjukkan rasa hormat kepada pasien 5. mengetahui keterbatasan dengan merujuk atau melakukan konsultasi bila diperlukan	2. memperhatikan kenyamanan pasien 3. melakukan tindakan sesuai prioritas 4. menunjukkan rasa hormat kepada pasien 5. mengetahui keterbatasan dengan merujuk atau melakukan konsultasi bila diperlukan	1. melakukan setiap tindakan dengan berhati-hati dan teliti sehingga tidak membahayakan pasien dan diri sendiri 2. memperhatikan kenyamanan pasien 3. melakukan tindakan sesuai prioritas 4. menunjukkan rasa hormat kepada pasien 5. mengetahui keterbatasan dengan merujuk atau melakukan konsultasi bila diperlukan		
---	--	---	---	--	--	--

II. Global performance

Beri tanda (✓) pada kolom yang disediakan sesuai dengan penilaian Anda secara umum terhadap kemampuan peserta ujian!

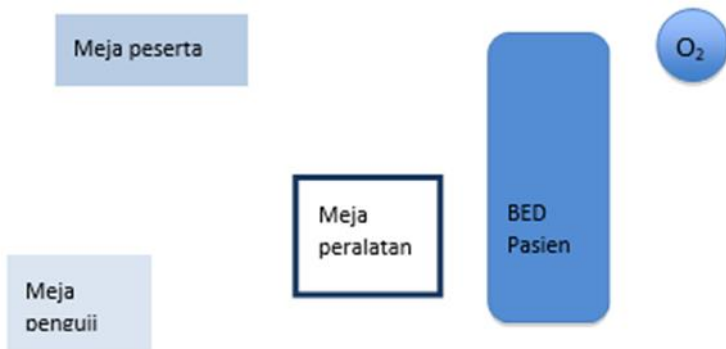
Tidak lulus	Borderline	Lulus	Superior

NEURO ANESTHESIA

SOAL UJIAN OSCE STATION NEUROANESTESI

1.	Nomor station	3
2.	Judul stasion	Cedera Kepala
3.	Waktu yang dibutuhkan	20 menit
4.	Tujuan station	Menilai kemampuan evaluasi preoperative, menegakkan diagnosa, rencana tindakan dan penatalaksanaan, melakukan komunikasi dan edukasi pasien serta berperilaku profesional
5.	Kompetensi	Evaluasi Preoperative Diagnosa dan problem potensial - aktual Rencana tindakan anestesi Keterampilan klinis - Monitoring dan manajemen penyulit - Manajemen paska bedah Komunikasi, edukasi dan profesionalisme
6.	Kategori	- Anestesi obstetri Neuroanestesi - Anestesi Regional dan Manajemen Nyeri - Anestesi Kardiovaskular - Anestesi Pediatrik - Anestesi Kegawat daruratan - Anestesi Urologi - Anestesi untuk penyakit Endokrin, metabolic dan penyakit – penyakit khusus - ICU - Anestesi pada kepala leher
7.	Instruksi untuk peserta ujian	Skenario klinik: Seorang laki – laki berusia 21 tahun berat badan 50 kg masuk ke IGD dengan keluhan penurunan kesadaran dengan airway tidak clear. Sebelumnya pasien mengalami kecelakaan lalu lintas, dengan kesadaran awal GCS 7 (E2 V3 M2) Instruksi untuk peserta: - Lakukan evaluasi preoperative untuk pasien ini! - Tentukan diagnosis kerja usulan pemeriksaan penunjang dan hasil pemeriksaan penunjang kepada penguji dan interprestasikan hasilnya dan pada pasien ini! - Tentukan tatalaksana untuk pasien tersebut!
8.	Instruksi untuk penguji	Skenario klinik: Seorang laki – laki berusia 21 tahun berat badan 50 kg masuk ke IGD dengan keluhan penurunan kesadaran dengan airway tidak clear. Sebelumnya pasien mengalami kecelakaan lalu lintas, dengan kesadaran awal GCS 7 (E2 V3 M2) Instruksi untuk peserta: - Lakukan evaluasi preoperative untuk pasien ini! - Tentukan diagnosis kerja usulan pemeriksaan penunjang dan hasil pemeriksaan penunjang kepada penguji dan interprestasikan hasilnya dan pada pasien ini! - Tentukan tatalaksana untuk pasien tersebut! Instruksi pada penguji <u>INSTRUKSI UMUM</u> - Pastikan identitas peserta ujian pada kartu ujian - Tulislah nama dan nomor peserta ujian pada lembar penilaian!

		3. Amatilah dan berilah skor (0/1/2/3) atas tugas yang dikerjakan peserta ujian serta skor <i>Global Rating</i> sesuai rubrik penilaian 4. Hindarilah interupsi dan/atau tindakan selain daripada yang diminta dalam instruksi penguji! 5. Berikan informasi/hasil yang dibutuhkan secara lisan/tulisan hanya apabila peserta ujian telah melakukan dan/atau mengusulkan jenis pemeriksaan yang dimaksud (perhatikan instruksi khusus)! 6. Taatilah peraturan serta etika penguji selama menjalankan tugas sebagai penguji OSCE - ATII INSTRUKSI KHUSUS : 1. Penguji mengamati dan menilai evaluasi preoperatif yang dilakukan peserta dan memberikan hasil pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang bila diminta oleh peserta: Peserta melakukan anamnesis : Alergi (-), Medication (-), Past illness (-), Last meal 10 jam sebelum MRS, Event (-) Pasien sempat sadar saat dibawa ke IGD kemudian menjadi tidak sadar (lucid interval). Pemeriksaan fisik : Tekanan Darah 150/90 mmHg, Nadi 46x/mnt, frekuensi napas 10x/mnt, napas berat, irreguler. Kesadaran GCS 7 (E2 V3 M2) Eye : dengan rangsang nyeri mata membuka (2), Motorik : dengan rangsang nyeri eskremitas fleksi abnormal (3), Verbal : dengan rangsang nyeri hanya keluar suara mengerang (2), Pupil anisokor 4/2 mm. RC +/- Tidak dijumpai cedera di daerah lainnya 2. Penguji menilai peserta menegaskan dan menilai pemeriksaan penunjang dan interpretasinya. Penguji memberikan pemeriksaan penunjang bila peserta meminta Head CT Scan : Epidural hematoma Diagnosis pasien: Head Injury GCS 7 + EDH (Epidural Hematoma) 3. Penguji menilai tatalaksana pada pasien tersebut. Peserta melakukan tatalaksana. Prinsip – prinsip Neuroanestesi – Airway = jalan nafas harus selalu bebas. – Breathing = ventilasi kendali, normokapnia pada cedera kepala. – Circulation = target normotensi (hindari lonjakan tekanan darah), cairan isoormoler, normovolemia, normoglikemia, tidak ada gangguan drainase vena serebral. – Drugs = hantari obat dan teknik yang meningkatkan tekanan intrakranial – Environment = pertahankan suhu permissive hipoermia (35°C) – Pasien dilakukan intubasi dengan ▪ Berikan oksigen 100 % ▪ Fentanyl dosis 1-3 µg/kg dalam waktu 1 menit ▪ Berikan priming relaksan bila menggunakan relaksan mula kerja lambat ▪ Induksi pentotal 5 mg/kg atau propofol 2-2,5 mg/kg ▪ Pemberian relaksan vecuronium 0,15 mg/kg atau rocuronium 0,6 – 1,2 mg/kg ▪ Pemberian lidokain 1 – 1,5 mg/kg iv 3 menit sebelum atau ulangan agent induksi pentotal atau propofol 30 detik sebelum laringoskopi intubasi – Pertahankan sedasi dan relaksasi – Konsul bedah syaraf untuk tindakan kraniotomi evakuasi perdarahan
--	--	---

9.	Instruksi untuk pasien standar	Nama : sesuai nama PS Jenis kelamin : laki-laki usia : 21 tahun Peran yang harus dilakukan: Keluarga pasien yang membawa pasien ke IGD. Keluhan Utama : pasien kecelakaan, setelah beberapa waktu tidak sadar Riwayat penyakit sekarang: 2 jam mengalami KLLD dengan mobil, pada saat kecelakaan masih sadar kemudian saat di bawa ke IGD menjadi tidak sadar. sempat sadar kemudian kehilangan kesadaran lagi. Riwayat penyakit dahulu : selama ini dalam keadaan sehat Riwayat keluarga : - riwayat kebiasaan : merokok satu bungkus sehari sejak 7 tahun yang lalu
10	Denah ruangan	 The diagram shows a room layout with the following elements: a light blue rectangle labeled 'Meja peserta' (top left), a light blue rectangle labeled 'Meja penguji' (bottom left), a white rectangle with a black border labeled 'Meja peralatan' (center), a tall blue rectangle labeled 'BED Pasien' (right), and a blue circle labeled 'O₂' (top right).
11	Peralatan yang dibutuhkan	- setting ruangan dokter-pasien - meja dan kursi dokter - kursi pasien/keluarga -meja peralatan - bed pemeriksaan (dilengkapi bantal dan selimut) -laryngoskop - stetoskop biaural - pipa endotrakeal -ambu bag -tabung oksigen -plester -kit emergensi -suction -handschoen - monitor - obat – obatan fentanyl, propofol, pentotal, lidocain, relaxan
12	Penulis	Tim Item Soal OSCE ATI
13	Referensi	- Morgan: clinical of anesthesiology edisi V - Dasar – Dasar Neuroanestesi oleh Prof. Dr. Tatang Bisri, dr, SpAn KNA

RUBRIK ACTUAL MARK STATION NEUROANESTESI

I. Rubrik Penilaian

Aspek yang Dinilai	0	1	2	3	Bobot	Skor
1. Evaluasi preoperative	kandidat tidak melakukan anamnesa	kandidat tidak menanyakan lucid interval, tetapi menanyakan 1 dari 2 hal berikut: 1. keluhan utama 2. RPD/RPK	kandidat menanyakan adanya lucid interval dan satu dari keluhan utama/ RPD/RPK	Peserta mampu melakukan evaluasi preoperatif : 1. Peserta melakukan anamnese : a. AMPLE b. lucid interval 2. Pemeriksaan fisik : a. mencuci tangan sebelum dan sesudah pemeriksaan. b. pemeriksaan tanda vital c. pemeriksaan GCS d. pemeriksaan pupil	2	
2. Diagnosa	Peserta tidak mampu menegaskan diagnosa dan Peserta tidak meminta pemeriksaan penunjang	Peserta meminta pemeriksaan penunjang dengan tepat namun tidak tepat menegaskan diagnosa	Peserta tidak meminta pemeriksaan penunjang Namun Tepat menegaskan diagnosa	Peserta mampu menegaskan dan menilai pemeriksaan penunjang dan interpretasinya Head CT Scan : Epidural hematoma Diagnosis pasien: Head Injury GCS 7 + EDH (Epidural Hematom)	2	
3. Rencana tindakan anestesi / Tatalaksana	Peserta tidak melakukan penatalaksanaan cedera kepala	Melakukan penatalaksanaan dengan tepat namun tidak runut dan tidak lengkap	Melakukan penatalaksanaan dengan tepat dan runut namun tidak lengkap	Melakukan penatalaksanaan cedera kepala dengan tepat, lengkap dan runut: – Airway – Breathing – Circulation = target normotensi, isoosmoler,	4	

				normovolemia, normoglikemia, tidak ada gangguan drainase vena serebral. – Drugs = hintari obat dan teknik yang meningkatkan tekanan intrakranial – Environment = pertahankan suhu permissive hipoermia (35°C) – Pasien dilakukan intubasi dengan ▪ Berikan oksigen 100 % ▪ Fentanyl dosis 1-3 µg/kg dalam waktu 1 menit ▪ Berikan priming relasan bila menggunakan relasan mula kerja lambat ▪ Induksi pentotal 5 mg/kg atau propofol 2-2,5 mg/kg ▪ Pemberian relasan vecuronium 0,15 mg/kg atau rocuronium 0,6 – 1,2 mg/kg ▪ Pemberian lidokain 1 – 1,5 mg/kg iv 3 menit sebelum atau ulangan agent induksi pentotal atau propofol 30		
--	--	--	--	---	--	--

				detik sebelum laringoskopi intubasi – Pertahankan sedasi dan relaxasi – Konsul bedah syaraf untuk tindakan kraniotomi evakuasi perdarahan		
4.Komunikasi dan edukasi (konseling) pasien Profesional	Peserta ujian tidak meminta meminta izin secara lisan dan sama sekali tidakn melakukan point berikut: 1. melakukan setiap tindakan dengan berhati-hati dan teliti sehingga tidak membahayakan pasien dan diri sendiri 2. memperhatikan kenyamanan pasien 3. melakukan tindakan sesuai prioritas 4. menunjukkan rasa hormat kepada pasien 5. mengetahui keterbatasan dengan merujuk atau melakukan konsultasi bila	meminta izin secara lisan dan 1-2 point berikut: 1. melakukan setiap tindakan dengan berhati-hati dan teliti sehingga tidak membahayakan pasien dan diri sendiri 2. memperhatikan kenyamanan pasien 3. melakukan tindakan sesuai prioritas 4. menunjukkan rasa hormat kepada pasien 5. mengetahui keterbatasan dengan merujuk atau melakukan konsultasi bila diperlukan	meminta izin secara lisan dan 3-4 point berikut: 1. melakukan setiap tindakan dengan berhati-hati dan teliti sehingga tidak membahayakan pasien dan diri sendiri 2. memperhatikan kenyamanan pasien 3. melakukan tindakan sesuai prioritas 4. menunjukkan rasa hormat kepada pasien 5. mengetahui keterbatasan dengan merujuk atau melakukan konsultasi bila diperlukan	meminta izin secara lisan dan melakukan di bawah ini secara lengkap: 1. melakukan setiap tindakan dengan berhati-hati dan teliti sehingga tidak membahayakan pasien dan diri sendiri 2. memperhatikan kenyamanan pasien 3. melakukan tindakan sesuai prioritas 4. menunjukkan rasa hormat kepada pasien 5. mengetahui keterbatasan dengan merujuk atau melakukan konsultasi bila diperlukan	3	

	diperlukan					
TOTAL SKOR						

II. Global performance

Beri tanda (√) pada kolom yang disediakan sesuai dengan penilaian Anda secara umum terhadap kemampuan peserta ujian!

Tidak lulus	Borderline	Lulus	Superior

SOAL UJIAN OSCE STATION ANESTESIA NEUROANESTESI

1.	Nomor station	4
2.	Judul station	Epidural hematoma-intubasi
3.	Waktu yang dibutuhkan	17 menit
4.	Tujuan station	Menilai kemampuan evaluasi preoperative, menegakkan diagnosa, rencana tindakan dan penatalaksanaan, melakukan komunikasi dan edukasi pasien serta berperilaku profesional
5.	Kompetensi	1. Evaluasi Pra Anestesia 2. Diagnosis Dan Problem Aktual – Potensial 3. Rencana Tindakan Anestesi 4. Keterampilan Klinis 5. Monitoring dan manajemen penyulit 6. Manajemen Pasca Anestesia 7. Komunikasi, Edukasi Dan Profesionalisme
6.	Kategori	1. Anestesia Obstetrik 2. Anestesia Bedah Saraf 3. Anestesia Regional Dan Manajemen Nyeri 4. Anestesia Bedah Toraks 5. Anestesia Pediatrik 6. Anestesia Kegawatdaruratan 7. Anestesia Urologi 8. Anestesia Untuk Penyakit Penyakit Khusus (Endokrin, Metabolik, Penyulit Kardiovaskular) 9. Anestesia Bedah Kepala Leher 10. Anestesia Bedah Rawat Jalan / Luar Kamar Bedah 11. Anestesia Pada Prosedur Invasif Minimal 12. Terapi Intensif
7.	Instruksi untuk peserta ujian	<u>Skenario klinik:</u> Seorang laki – laki berusia 21 tahun berat badan 50 kg masuk ke IGD dengan keluhan penurunan kesadaran karena kecelakaan lalu lintas, sebelumnya pasien compos mentis namun 2 jam kemudian kesadaran menjadi GCS 11 (E3 V3 M5). Pasien didiagnosa dengan Epidural Hematom temporal dextra dan akan dilakukan kraniotomi evakuasi perdarahan. <u>Instruksi untuk peserta:</u> 1. Lakukan evaluasi preoperatif untuk pasien ini! 2. Sebutkan problem aktual potensial pada pasien ini! 3. Lakukan induksi intubasi pada pasien ini!
8.	Instruksi untuk penguji	<u>INSTRUKSI UMUM</u> 1. Pastikan identitas peserta ujian pada kartu ujian 2. Tulislah nama dan nomor peserta ujian pada lembar penilaian! 3. Amatilah dan berilah skor (0/1/2/3) atas tugas yang dikerjakan peserta ujian serta skor <i>Global Rating</i> sesuai rubrik penilaian 4. Hindarilah interupsi dan/atau tindakan selain daripada yang diminta dalam instruksi penguji! 5. Berikan informasi/hasil yang dibutuhkan secara lisan/tulisan hanya apabila peserta ujian telah melakukan dan/atau mengusulkan jenis pemeriksaan

		yang dimaksud (perhatikan instruksi khusus)! 6. Taatilah peraturan serta etika penguji selama menjalankan tugas sebagai penguji OSCE - ATI! INSTRUKSI KHUSUS : 1. Penguji mengamati dan menilai evaluasi preoperatif yang dilakukan peserta dan memberikan hasil pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang bila diminta oleh peserta: Pemeriksaan: Airway clear, Cervical clear Breathing: frekuensi nafas 20 x/menit, SpO2 97 Circulation: Tekanan Darah 150/90 mmHg, Nadi 70x/mnt, tekanan/volume cukup. Disability : Kesadaran GCS 11 (E3 V3 M5) Eye : dengan rangsang verbal mata membuka, Motorik : mampu melokalisir nyeri, Verbal : masih berkata namun tidak jelas, Pupil anisokor 4/2 mm. RC +/- Exposure : Tidak dijumpai cedera di daerah lainnya. Alergi (-), Medication (-), Past illness (-), Last meal 10 jam sebelum masuk Rumah Sakit, Event (-). Pasien sempat sadar saat dibawa ke IGD kemudian menjadi tidak sadar (lucid interval). Pemeriksaan Laboratorium dalam batas normal. Foto cervical normal 2. Penguji menilai problem aktual dan potensial yang di sebutkan peserta Problem aktual: peningkatan tekanan intra kranial Problem potensial: secondary brain injury (penurunan kesadaran, kejang, hipoksia, hiperkarbia, hipertermia, hipovolemia, hipotensi, hipertensi, kematian) 3. Penguji menilai tindakan induksi intubasi yang dilakukan peserta. Prinsip – prinsip Neuroanestesi 1. Airway = jalan nafas harus selalu bebas. 2. Breathing = ventilasi kendali, normokapnia pada cedera kepala. 3. Circulation = target normotensi (hindari lonjakan tekanan darah), cairan isoosmoler, normovolemia, normoglikemia, tidak ada gangguan drainase vena serebral, posisi kepala head up 30° 4. Drugs = hindari obat dan teknik yang meningkatkan tekanan intrakranial 5. Environment = pertahankan suhu permissive hipotermia (35°C) 6. Pasien dilakukan intubasi dengan teknik neuroanestesi a. Berikan oksigen 100 % b. Fentanyl dosis 2-5 µg/kg dalam waktu 1 menit c. Berikan priming relaxan bila menggunakan relaxan mula kerja lambat d. Induksi tiopental 5 mg/kg atau propofol 2-2,5 mg/kg e. Pemberian relaxan vecuronium 0,15 mg/kg atau rocuronium 0,6 – 1,2 mg/kg f. Pemberian lidokain 1 – 1,5 mg/kg IV 3 menit sebelum atau ulangan agent induksi pentotal atau propofol 30 detik sebelum laringoskopi intubasi g. Fiksasi ETT lalu dihubungkan ke mesin anestesi
--	--	---

9	Tata letak ruangan	Model ruang operasi	
11	Kebutuhan Laboran	- Jumlah Laboran : 1 orang - Tugas Laboran : penata anestesi	
12	Peralatan yang dibutuhkan	- Peralatan ruang operasi – Laringoskop blade 3, 4 – ETT 7, 7.0, 7.5, 8.0 – Stetoskop – Tensimeter – Pen light – Thermometer – Sarung tangan tidak steril Sduit berlabel – Pentotal – Propofol – Fentanyl – Lidokain 2% – Rocuronium – Vecuronium – Sduit cuff – Suction cateter – Mesin suction – Oropharing no 3 dan 4 – Sungkup muka no 3,4,5 – AMBU – COLLAR BRACE	@1 buah @ 2 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 box 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah @1 buah @1 buah 1 buah 1BUAH
13	Kebutuhan Manekin	Manekin full body intubasi terpasang collar brace	
14	Penulis	Tim Item Soal OSCE ATI	
15	Referensi	- Morgan & Mikhail's Clinical Anesthesiology 5 th ed. Lange - Dasar – Dasar Neuroanestesi oleh Prof. Dr. Tatang Bisri, dr, SpAn KNA	

**RUBRIK ACTUAL MARK
STATION ANESTESIA NEUROANESTESI**

Aspek yang Dinilai	0	1	2	3	Bobot	Skor
1. Evaluasi preoperative - Primary Survey - AMPLE - Pemeriksaan Penunjang (Foto Cervical dan Laboratorium)	Peserta tidak melakukan evaluasi preoperatif	Peserta hanya melakukan evaluasi pra anestesia,	Peserta mampu melakukan evaluasi pra anestesia, dengan benar namun pemeriksaan penunjang tidak lengkap atau interpretasi tidak benar	Peserta mampu melakukan evaluasi preoperatif dengan lengkap dan benar. -	2	
2. Diagnosa dan problem potensial – aktual - Problem aktual : peningkatan tekanan intra kranial - Problem potensial : secondary brain injury	Peserta tidak menyebutkan problem pasien	-	Peserta mampu menyebutkan salah satu problem pada pasien	Peserta mampu menyebutkan problem potensial dan problem aktual	2	
3. Keterampilan klinis - Airway - Breathing - Circulation - Drugs - Enviroment - Intubasi dengan teknik neuroanestesi	Peserta tidak melakukan penatalaksanaan cedera kepala	Melakukan penatalaksanaan dengan tepat namun tidak runut dan tidak lengkap	Melakukan penatalaksanaan dengan tepat dan runut namun tidak lengkap	Melakukan penatalaksanaan cedera kepala dengan tepat, lengkap dan runut.	4	
7. Komunikasi dan Perilaku profesional 1. melakukan setiap tindakan dengan berhati-hati dan teliti sehingga tidak membahayakan pasien dan diri sendiri 2. memperhatikan kenyamanan pasien 3. melakukan tindakan sesuai prioritas	Peserta ujian tidak meminta izin secara lisan dan sama sekali tidak melakukan	Meminta izin secara lisan dan 1-2 point poin komunikasi dan profesionalisme:	Meminta izin secara lisan dan 3-4 point poin komunikasi dan profesionalisme	Meminta izin secara lisan dan melakukan poin komunikasi dan profesionalisme secara lengkap	2	

4. menunjukkan rasa hormat kepada pasien	point					
5. mengetahui keterbatasan dengan merujuk atau melakukan konsultasi bila diperlukan	profesional.					
TOTAL SKOR						

ANESTESIA REGIONAL DAN MANAJEMEN NYERI

SOAL UJIAN OSCE STATION REGIONAL DAN MANAJEMEN NYERI

1.	No. station	
2.	Judul station	Apendisitis akut
3.	Waktu yang dibutuhkan	20 menit
4.	Tujuan station	Menilai kemampuan evaluasi pra anestesia, diagnosis dan problem aktual–potensial, Keterampilan klinis, komunikasi, edukasi dan profesionalisme
5.	Kompetensi	1. Evaluasi Pra Anestesia 2. Diagnosis Dan Problem Aktual – Potensial 3. Rencana Tindakan Anestesi 4. Keterampilan Klinis 5. Monitoring dan manajemen penyulit 6. Manajemen Pasca Anestesia 7. Komunikasi, Edukasi Dan Profesionalisme
6.	Kategori	1. Anestesia Obstetrik 2. Anestesia Bedah Saraf 3. Anestesia Regional Dan Manajemen Nyeri 4. Anestesia Bedah Toraks 5. Anestesia Pediatrik 6. Anestesia Kegawatdaruratan 7. Anestesia Urologi 8. Anestesia Untuk Penyakit Khusus (Endokrin, Metabolik, Penyulit Kardiovaskular) 9. Anestesia Bedah Kepala Leher 10. Anestesia Bedah Rawat Jalan / Luar Kamar Bedah 11. Anestesia Pada Prosedur Invasif Minimal 12. Terapi Intensif
7.	Instruksi untuk peserta	<u>Skenario Klinik :</u> Seorang Perempuan berusia 25 tahun dengan BB 60 Kg datang ke IGD RS dengan keluhan utama nyeri di perut kanan bawah sejak 3 hari yang lalu pasien juga mengeluhkan mual dan muntah satu hari ini. Pasien didiagnosis Appendicitis akut direncanakan operasi apendektomi. <u>Instruksi Peserta:</u> 1. Lakukan evaluasi pra anestesia terhadap pasien tersebut. 2. Sebutkan problem aktual dan problem potensial terhadap pasien tersebut. 3. Sebutkan persiapan sebelum tindakan anestesi. 4. Lakukan tindakan spinal anestesi pada pasien tersebut.
8.	Instruksi untuk penguji	<u>INSTRUKSI UMUM</u> 1. Pastikan identitas peserta ujian pada kartu ujian 2. Tulislah nama dan nomor peserta ujian pada lembar penilaian! 3. Amatilah dan berilah skor (0/1/2/3) atas tugas yang dikerjakan peserta ujian serta skor <i>Global Rating</i> sesuai rubrik penilaian 4. Hindarilah interupsi dan/atau tindakan selain daripada yang diminta dalam instruksi penguji!

	5. Berikan informasi/hasil yang dibutuhkan secara lisan/tulisan hanya apabila peserta ujian telah melakukan dan/atau mengusulkan jenis pemeriksaan yang dimaksud (perhatikan instruksi khusus)! 6. Taatilah peraturan serta etika penguji selama menjalankan tugas sebagai penguji OSCE - ATI! <u>INSTRUKSI KHUSUS</u> 1. Penguji mengamati dan menilai tindakan pra anestesia yang dilakukan peserta dan memberikan hasil pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang bila diminta oleh peserta. Peserta melakukan pemeriksaan fisik Frekuensi napas 20 x/mnt, Suara pernapasan vesikuler, Suara tambahan tidak dijumpai. Akral Hangat, merah, kering, tekanan darah 100/70 mmHg denyut nadi 90 x/l T/V cukup, turgor baik, temperature 38,5 C. Kesadaran kompos mentis VAS Diam 3 dan bergerak 6 (pada skala 1 - 10 cm). Peserta menanyakan Anamnese Alergi (-), Medication (-), Past illness (-), Last meal 6 jam sebelum masuk rumah sakit, Event (-) nyeri pada perut kanan bawah Riwayat penyakit dahulu: tidak pernah sakit yang serius. Pemeriksaan penunjang Hasil Laboratorium : Darah Rutin : Hb 12 gr/dl, Ht 36% Leukosit 16000/mm³, trombosit 310.000/mm³ Faal Hemostasis : PT 10.9(12.2), APTT 35.8 (30.7), INR 1.5 Na 135 meq/L, Kalium 3.5 meq/L, Cl 110 mmol/L Glukosa : 98 mg/dl. 2. Penguji menilai peserta menyebutkan problem aktual dan potensial pada pasien ini. Problem aktual 1. Nyeri 2. Dehidrasi Potensial problem : 1. Blok Spinal tinggi 2. Resusitasi cairan tidak adekuat 3. Nyeri paska operasi 3. Penguji menilai peserta menyebutkan persiapan sebelum tindakan anestesi. 1) Puasa atau nothing per oral 2) Rehidrasi dengan cairan kristaloid 3) Pemberian antipiretik 4) Menilai kecukupan cairan dengan penilaian vital sign atau dengan tilt test atau pasive leg rising 5) Pemberian analgetik
--	--

		6) Pemberian antibiotik 4. Penguji menilai peserta melakukan keterampilan tindakan spinal anestesi. Teknik Anestesi Spinal 1. Menyiapkan spinal set, memilih jenis jarum spinal yang sesuai, obat regional anestesi dan obat emergensi serta alat pelindung diri, menyiapkan obat anestesi umum yang diperlukan, mengecek mesin anestesi dan alat monitor pasien. 2. Posisi pasien : posisi duduk Left lateral decubitus, sebelumnya diberikan analgesia. 3. Membuat landmark dan menentukan titik puncture. 4. Cuci tangan steril, memakai baju steril dan handschoen. 5. Sterilisasi daerah puncture, tutup dengan duk lobang steril. 6. Infiltrasi lokal anestesi. 7. Puncture spinal anestesi sampai keluar LCS . 8. Barbotase dan memasukkan obat lokal Anestesi. 9. Memposisikan pasien kembali. 10. Menilai keberhasilan blok dengan pinprick dan bromage scale. 5. Penguji menilai komunikasi, edukasi serta perilaku profesionalisme peserta.	
9	Tata letak ruangan	Model kamar operasi	
10	Kebutuhan Laboran	Jumlah Laboran : 1 Tugas Laboran : Sebagai penata anestesi, membantu peserta dalam melakukan persiapan dan tindakan spinal anestesi.	
11	Instruksi Pasien Standar	Nama : sesuai Usia : 25 tahun Jenis Kelamin : perempuan Pekerjaan : Mahasiswi Peran yang harus ditunjukkan : pasien merasa kesakitan, lemah, meringis kesakitan dan mengaduh bila perut bagian kanan bawah ditekan. Keluhan Utama: Nyeri perut kanan bawah sejak 3 hari sebelum masuk rumah sakit. Pasien awalnya tidak terlalu nyeri namun lama kelamaan terasa sakit menjalar dari perut kanan bawah sampai ke ulu hati, 1 hari ini pasien mual dan muntah setiap makan dan makan terakhir 6 jam sebelum masuk rumah sakit. Pasien merasa haus dan lemas.	
13	Peralatan yang dibutuhkan	- Peralatan ruang operasi - Manekin spinal - Jarum spinal 25, 26, 27 - Nampan alat - Duk lobang - Cawan 2 buah dengan label povidone iodine, alkohol, - Korentang	1 set 1 buah @ 5 buah 1 buah 1 buah 1 set 1 buah

		- Kassa - Topi dan Masker - Sarung tangan steril 6,5 7 7,5 - Alkohol 70% - Povidone iodine 10% - S spuit 5 cc, 10 cc - Plester - Gunting - Obat anestesi lokal (lidocaine, bupivacaine, ropivacaine) -	5 buah @1 kotak @10 buah 1 botol 1 botol @ 5 buah 2 set 1 buah 1 buah 1 buah
14	Kebutuhan Manekin	Manekin Spinal 1 buah	
15	Penulis	TIM SOAL OSCE ATI	
16	Referensi	Morgan clinical Anesthesia	

RUBRIC ACTUAL MARK
OSCE STATION ANESTESIA REGIONAL DAN MANAJEMEN NYERI

Aspek yang Dinilai	0	1	2	3	Bobot	Skor
1. Evaluasi Pra anestesi	Kandidat tidak melakukan evaluasi pra anestesi	Peserta ujian hanya melakukan evaluasi pra anestesi yang meliputi : 1. Anamnese AMPLE 2. Pemeriksaan fisik	Peserta ujian melakukan evaluasi pra anestesi secara tidak lengkap	Peserta ujian melakukan evaluasi pra anestesi secara lengkap yang meliputi sesuai poin evaluasi pra anestesi pada instruksi khusus. 1. Anamnese AMPLE 2. Pemeriksaan fisik 3. Pemeriksaan penunjang	2	
2. Problem aktual dan Problem potensial	Peserta ujian tidak menyampaikan problem aktual dan potensial	Peserta hanya mampu menyebutkan problem aktual	Peserta mampu menentukan problem aktual dan problem potensial namun tidak lengkap	Peserta mampu menentukan problem aktual dan potensial dengan lengkap. 1. Nyeri 2. Perdarahan 3. Blok spinal tinggi 4. Resusitasi cairan tidak adekuat 5. Nyeri paska Anestesi.	2	
3. Rencana Tindakan anestesi	Peserta tidak menyebutkan persiapan sebelum tindakan anestesi	Peserta mampu menyebutkan persiapan sebelum tindakan anestesi hanya 3-4 poin	Peserta mampu menyebutkan persiapan sebelum tindakan anestesi hanya 5 poin	Peserta mampu menyebutkan persiapan sebelum tindakan anestesi dengan lengkap . 1) Puasa atau nothing per oral 2) Rehidarasi dengan cairan kristaloid	2	

				3) Pemberian antipiretik 4) Menilai kecukupan cairan dengan penilaian vital sign atau dengan tilt test atau pasive leg rising 5) Pemberian analgetik 6) Pemberian antibiotik		
4. Keterampilan klinis	Peserta tidak mampu menjelaskan tindakan Anestesi yang akan dikerjakan	-	Peserta mampu menjelaskan tindakan anestesi namun tidak lengkap	Peserta ujian melakukan semua tahapan pemberian anestesi dengan benar dan lengkap sesuai poin pada instruksi khusus	3	
5. Komunikasi dan Perilaku profesional	Peserta ujian tidak meminta izin secara lisan dan sama sekali tidak melakukan point profesional.	Meminta izin secara lisan dan 1-2 point berikut: 1. melakukan setiap tindakan dengan berhati-hati dan teliti sehingga tidak membahayakan pasien dan diri sendiri 2. memperhatikan kenyamanan pasien 3. melakukan tindakan sesuai prioritas	Meminta izin secara lisan dan 3-4 point berikut: 1. melakukan setiap tindakan dengan berhati-hati dan teliti sehingga tidak membahayakan pasien dan diri sendiri 2. memperhatikan kenyamanan pasien 3. melakukan tindakan sesuai prioritas 4. menunjukkan rasa hormat kepada pasien	Meminta izin secara lisan dan melakukan di bawah ini secara lengkap: 1. melakukan setiap tindakan dengan berhati-hati dan teliti sehingga tidak membahayakan pasien dan diri sendiri 2. memperhatikan kenyamanan pasien 3. melakukan tindakan sesuai prioritas 4. menunjukkan rasa hormat kepada pasien 5. mengetahui keterbatasan dengan merujuk atau melakukan konsultasi bila diperlukan	1	

		4. menunjukkan rasa hormat kepada pasien 5. mengetahui keterbatasan dengan merujuk atau melakukan konsultasi bila diperlukan	5. mengetahui keterbatasan dengan merujuk atau melakukan konsultasi bila diperlukan			
TOTAL SKOR						

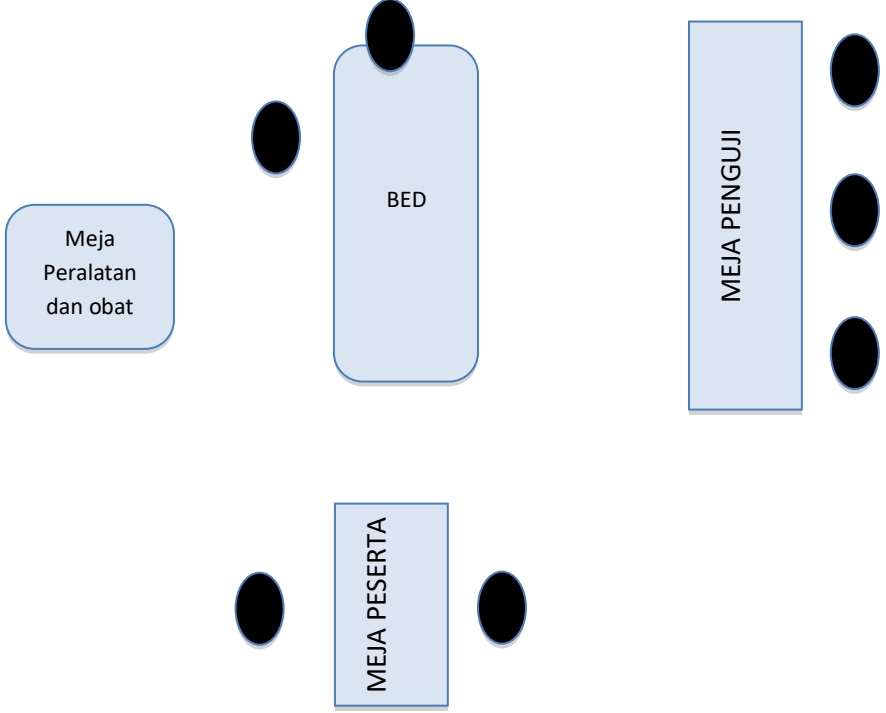
SOAL UJIAN OSCE STATION REGIONAL DAN MANAGEMEN NYERI

COMBINED SPINAL EPIDURAL – KASUS 1

1.	No. station	3
2.	Judul station	Combined Spinal Epidural Anesthesia
3.	Waktu yang dibutuhkan	30 menit
4.	Tujuan station	Menilai kemampuan evaluasi pra anestesia, diagnosis dan problem aktual–potensial, Keterampilan klinis, komunikasi, edukasi dan profesionalisme
5.	Kompetensi	1. Evaluasi Pra Anestesia 2. Diagnosis Dan Problem Aktual – Potensial 3. Rencana Tindakan Anestesi 4. Keterampilan Klinis 5. Monitoring dan manajemen penyulit 6. Manajemen Pasca Anestesia 7. Komunikasi, Edukasi Dan Profesionalisme
6.	Kategori	1. Anestesia Obstetrik 2. Anestesia Bedah Saraf 3. Anestesia Regional Dan Manajemen Nyeri 4. Anestesia Bedah Toraks 5. Anestesia Pediatrik 6. Anestesia Kegawatdaruratan 7. Anestesia Urologi 8. Anestesia Untuk Penyakit Khusus (Endokrin, Metabolik, Penyulit Kardiovaskular) 9. Anestesia Bedah Kepala Leher 10. Anestesia Bedah Rawat Jalan / Luar Kamar Bedah 11. Anestesia Pada Prosedur Invasif Minimal 12. Terapi Intensif
7.	Instruksi untuk peserta	Skenario Klinik : Seorang laki-laki umur 50 tahun dengan BB 50 Kg mengeluhkan nyeri pada lutut sebelah kanan, awalnya rasa nyeri dirasakan sejak 12 bulan terakhir nyeri semakin lama semakin bertambah dan semakin nyeri bila digerakkan atau untuk berjalan. Pasien mengaku pernah terjatuh di lutut sebelah kanan ketika usia 30 tahun saat bermain bola dari riwayat penyakit dahulu tidak didapatkan penyakit yang serius, Oleh TS bedah pasien didiagnosa dengan osteoarthritis. pasien dikonsulkan ke tim anestesi untuk dilakukan tindakan total knee replacement (TKR) . Instruksi untuk peserta: 1. Lakukan preoperatif visit terhadap pasien tersebut 2. Sebutkan problem aktual dan problem, potensial problem, plan anestesi terhadap pasien tersebut 3. Lakukan tindakan anestesi pada pasien tersebut. 4. Manajemen analgesia paska Bedah untuk pasien tersebut

8.	Instruksi untuk penguji	<u>INSTRUKSI UMUM</u> 1. Pastikan identitas peserta ujian pada kartu ujian 2. Tulislah nama dan nomor peserta ujian pada lembar penilaian! 3. Amatilah dan berilah skor (0/1/2/3) atas tugas yang dikerjakan peserta ujian serta skor <i>Global Rating</i> sesuai rubrik penilaian 4. Hindarilah interupsi dan/atau tindakan selain daripada yang diminta dalam instruksi penguji! 5. Berikan informasi/hasil yang dibutuhkan secara lisan/tulisan hanya apabila peserta ujian telah melakukan dan/atau mengusulkan jenis pemeriksaan yang dimaksud (perhatikan instruksi khusus)! 6. Taatilah peraturan serta etika penguji selama menjalankan tugas sebagai penguji OSCE - ATII! <u>INSTRUKSI KHUSUS</u> 1. Penguji mengamati dan menilai tindakan preoperatif yang dilakukan peserta dan memberikan hasil pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang bila diminta oleh peserta. Anamnesis Alergi (-), Medication (-), Past illness (-), Last meal 6 jam sebelum masuk rumah sakit, Event (-) Riwayat penyakit dahulu : tidak pernah sakit yang serius Pemeriksaan Klinis Kesadaran Compos mentis. Frekuensi nafas 18 x/menit, suara pernafasan vesikuler suara tambahan tidak ada Tekanan darah 120/78 mmHg, Nadi 76 x/menit, kuat, Jantung : suara jantung normal, Suhu 37°C. VAS Diam 4 dan bergerak 8 (pada skala 1 - 10) . Pemeriksaan penunjang EKG sinus rhythm 86 x/menit normoaksis Foto thorak Cor dan pulmo dalam batas normal Hasil Laboratorium : Darah Rutin : Hb 10 gr%, Ht 30% Leukosit 9000, trombosit 257.000 Faal Hemostasis : PT 10.9(12.2), APTT 35.8 (30.7), INR 1.5 Na 137 meq/L, Kalium 4.5 meq/L, Cl 119 mmol/L FaalHati : normal Glukosa : 98 mg/dl. 2. Penguji menilai problem potensial, Problem A. Problem 1. Nyeri B. Potensial problem : 1. Blok Spinal tinggi 2. Kegagalan regional 3. Hipotensi 4. Epidural hematoma
----	-------------------------	---

		5. Post dural puncture headache 6. Nyeri Paska anestesi C. Rencana Anestesi : Combine Spinal Epidural (CSE) 3. Penguji menilai keterampilan tindakan anestesi yang dilakukan peserta Teknik Anestesi 1. Menyiapkan perlengkapan general anestesia, obat regional anestesi dan obat emergensi serta alat pelindung diri, menyiapkan obat anestesi umum yang diperlukan, mengecek mesin anestesi dan alat monitor pasien. 2. Posisi pasien : posisi duduk Left lateral decubitus atau posisi duduk, yang sebelumnya diberikan analgesia. 3. Membuat landmark dan menentukan titik puncture, yaitu pada celah antara L3-4. Celah antara L3-4 atau prosesus spinosus L4 tegak lurus dari spina iliaca anterior superior. 4. Cuci tangan steril, memakai baju steril dan handschoen. 5. Sterilisasi daerah puncture, tutup dengan duk lobang steril. 6. Infiltrasi lokal anestesi dengan menggunakan lidocain 2% 7. Puncture dengan menggunakan jarum tuohy pada celah yang telah diberi anestesi lokal hingga jarum tuohy terfiksasi di ligamentum. Penusukan jarum harus sejajar dengan prosesus spinosus atau sedikit membentuk sudut ke arah sefalad, dengan arah bevel ke lateral atau sefalad. Cabut stylet dan hubungkan jarum dengan syringe yang berisi NaCl 0,9% (hanging drop), atau dengan menggunakan teknik LOR dengan udara 8. Setelah ruang epidural teridentifikasi, lepas spuit lalu pasang dan pasang jarum spinal, hingga teridentifikasi LCS/LCS keluar 9. Masukkan obat lokal anestesi spinal : bupivacaine/levobupivacain isobarik 0,5%, aspirasi (+) LCS 10. Cabut jarum spinal sambil mempertahankan jarum epidural sedemikian sehingga tidak ikut tercabut 11. Inseri kateter epidural dan pastikan kateter epidural yang masuk ke ruang epidural sepanjang lebih kurang 4 cm (fiksasi di kulit : kedalaman ruang epidural + 4 cm) 12. Sambungkan kateter dengan filter yang sudah diisi. Aspirasi berkala untuk memastikan kateter tidak masuk ruang subarachnoid atau intravaskuler . Fiksasi kateter, tutup dengan kasa steril/ tegaderm 13. Memposisikan pasien kembali. 14. Menilai keberhasilan blok dengan pinprick dan bromage scale. 4. Penguji meminta peserta untuk menuliskan instruksi analgetik post operasi dengan menggunakan epidural kateter yang telah terpasang 1. Levobupivacaine Isobaric 0,0625 – 0,125 dengan adjuvan Fentanyl 1-2 mcg/ml ATAU morphine 30-50 mcg/ml diberikan kontinyu 4- 8 ml perjam via kateter epidural dengan infusion pump ATAU intermiten 2. Kombinasi dengan Parasetamol/NSAIDs
--	--	---

		5. Penguji menilai komunikasi, edukasi serta perilaku profesionalisme peserta. - Memperkenalkan diri kepada keluarga pasien, dengan menyebutkan nama dan bidang keahlian. - Memberikan informasi kepada pasien serta keluarga pasien dengan rasa hormat, tentang keadaan umum pasien, rencana tindakan operasi yang akan dilakukan, pemeriksaan laboratorium dan radiologi untuk penilaian sebelum dilakukan tindakan anestesi dan operasi - Memberikan penjelasan kepada keluarga pasien secara lengkap tentang rencana tindakan spinal anestesi, problem yang mungkin timbul pada saat atau paska tindakan operasi, serta memberikan penjelasan tentang efek samping maupun resiko yang dapat timbul. - Melakukan tindakan dengan memperhatikan kenyamanan pasien.
9.	Denah ruangan	
10	Instruksi Pasien Standar	Nama : sesuai Usia : 50 tahun Jenis Kelamin : Lk Pekerjaan : tukang bubur keliling Peran yang harus ditunjukkan : pasien merasa kesakitan, lemah, dengan fraktur tertutup kruris sinistra Pertanyaan yang wajib ditanyakan : - Bagaimana keadaan umum pasien? - Apa rencana yang akan dilakukan dokter? - Apa problem yang mungkin timbul atas rencana tindakan dokter? Anamnesa : - Nyeri lebih dari 3 bulan disertai penambahan rasa nyeri saat berjalan atau aktivitas. - Riwayat penyakit dahulu (-)

	Kebutuhan Laboran	Jumlah Laboran : 1 Tugas Laboran : Sebagai peñata anestesi, membantu peserta dalam melakukan persiapan dan tindakan spinal anestesi.	
12	Peralatan yang dibutuhkan	Setting ruangan dokter-pasien - Meja dan kursi dokter - Kursi pasien - Meja dan kursi penguji - Meja peralatan - Meja operasi - Spokan set - Jarum Spinal no. 25,26,27 - Obat local Anestesi (lidocaine, bupivacaine) - Spuit 3 ml - Spuit 5 ml - Stetoskop - Monitor Pasien - Sungkup Muka - Sarung tangan non steril - Tempat sampah - Tissue - Jam dinding - VAS skor - Pen light	1 set 1 buah 3 set 1 buah 1 buah 1 buah 1/1/1 buah 1/1buah 2 buah 2 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah
13	Kebutuhan Manekin	Manekin Spinal 1 buah	
14	Penulis	Tim osce Anestesiologi UNS	
15	Referensi	Morgan clinical Anesthesia	
16	Reviewer		

LEMBAR PENILAIAN

STATION ANESTESI REGIONAL DAN MANAJEMEN NYERI

Aspek yang Dinilai	0	1	2	3	Bobot	Skor
1. Evaluasi Praoperasi	Kandidat tidak melakukan evaluasi pra operasi	Peserta ujian hanya melakukan evaluasi praoperasi yang meliputi : - Anamnesa AMPLE atau - Riwayat penyakit dahulu	Peserta ujian melakukan evaluasi praoperasi secara tidak lengkap dan runut yang meliputi: - Anamnesa AMPLE - Primary survey dan pemeriksaan fisik secara menyeluruh dengan lengkap dan runut	Peserta ujian melakukan evaluasi praoperasi secara lengkap dan runut yang meliputi sesuai poin evaluasi pra operasi pada instruksi khusus	2	
2. Problem aktual dan Problem potensial	Peserta ujian tidak menyampaikan problem aktual dan problem potensial	Peserta hanya mampu menyebutkan problem aktual	Peserta mampu menentukan problem aktual dan problem potensial namun tidak lengkap	Peserta mampu menentukan problem aktual dan potensial problem potensial - Nyeri - Perdarahan - Blok spinal tinggi - Nyeri paska Anestesi.	2	
3. Keterampilan klinis	Peserta tidak mampu menjelaskan tindakan Anestesi		Peserta mampu menjelaskan tindakan anestesi namun tidak lengkap	Peserta ujian melakukan semua tahapan pemberian anestesi dengan benar dan lengkap	2	

	yang akan dikerjakan			sesuai poin pada instruksi khusus		
4. Perencanaan manajemen pasca bedah	Peserta ujian tidak melakukan penulisan instruksi epidural analgsia	Peserta ujian menuliskan instruksi dengan lengkap hanya 1 item aspek : 1. Jenis obat 2. Konsentrasi sediaan obat anestesi lokal / opioid 3. Dosis pemberian	Peserta ujian menuliskan instruksi dengan lengkap hanya 2 item aspek : 1. Jenis obat 2. Konsentrasi sediaan obat anestesi lokal / opioid 3. Dosis pemberian	Peserta ujian menuliskan instruksi dengan lengkap meliputi aspek : 1. Jenis obat 2. Konsentrasi sediaan obat anestesi lokal / opioid 3. Dosis pemberian	3	
5. Komunikasi dan Perilaku profesional	Peserta ujian tidak meminta meminta izin secara lisan dan sama sekali tidakn melakukan point berikut: 1. melakukan setiap tindakan dengan berhati-hati dan teliti sehingga tidak membahayakan pasien dan diri sendiri	Meminta izin secara lisan dan 1-2 point berikut: 1. melakukan setiap tindakan dengan berhati-hati dan teliti sehingga tidak membahayakan pasien dan diri sendiri 2. memperhatikan kenyamanan pasien 3. melakukan tindakan sesuai prioritas	Meminta izin secara lisan dan 3-4 point berikut: 1. melakukan setiap tindakan dengan berhati-hati dan teliti sehingga tidak membahayakan pasien dan diri sendiri 2. memperhatikan kenyamanan pasien 3. melakukan tindakan sesuai prioritas	Meminta izin secara lisan dan melakukan di bawah ini secara lengkap: 1. melakukan setiap tindakan dengan berhati-hati dan teliti sehingga tidak membahayakan pasien dan diri sendiri 2. memperhatikan kenyamanan pasien 3. melakukan tindakan sesuai prioritas	3	

	2. memperhatikan kenyamanan pasien 3. melakukan tindakan sesuai prioritas 4. menunjukkan rasa hormat kepada pasien 5. mengetahui keterbatasan dengan merujuk atau melakukan konsultasi bila diperlukan	4. menunjukkan rasa hormat kepada pasien 5. mengetahui keterbatasan dengan merujuk atau melakukan konsultasi bila diperlukan	4. menunjukkan rasa hormat kepada pasien 5. mengetahui keterbatasan dengan merujuk atau melakukan konsultasi bila diperlukan	4. menunjukkan rasa hormat kepada pasien 5. mengetahui keterbatasan dengan merujuk atau melakukan konsultasi bila diperlukan		
TOTAL SKOR						

II. Global performance

Beri tanda (✓) pada kolom yang disediakan sesuai dengan penilaian Anda secara umum terhadap kemampuan peserta ujian!

Tidak lulus	Borderline	Lulus	Superior

.....,
Penguji,

(.....)

SOAL UJIAN OSCE STATION ANESTESI REGIONAL DAN MANAJEMEN NYERI

CONTINUOUS SPINAL EPIDURAL – KASUS 2

1	Nomor Station	1
2	Judul Station	CSE (Continuous Spinal Epidural Anesthesia)
3	Waktu yang dibutuhkan	20 menit
4	Tujuan Station	Menilai kemampuan melakukan Evaluasi Preoperative, Diagnosa dan problem potensial – aktual, rencana tindakan anestesi, Manajemen paska bedah
5	Kompetensi :	1. Evaluasi Preoperative 2. Diagnosa dan problem potensial - aktual 3. Rencana tindakan anestesi 4. Keterampilan klinis 5. Monitoring dan manajemen penyulit 6. Manajemen paska bedah 7. Komunikasi, edukasi dan profesionalisme
6	Kategori	1. Anestesi obstetri 2. Neuroanestesi 3. Anestesi Regional dan Manajemen Nyeri 4. Anestesi Kardiovaskular 5. Anestesi Pediatrik 6. Anestesi Kegawat daruratan 7. Anestesi Urologi 8. Anestesi untuk penyakit Endokrin, metabolic dan penyakit – penyakit khusus 9. ICU 10. Anestesi pada kepala leher
7	Intruksi untuk peserta ujian	Skenario klinik: Dikonsulkan seorang perempuan berusia 65 tahun berat badan 65 kg diantar ke IGD dengan keluhan tidak bisa berjalan setelah jatuh di kamar mandi. Kaki kanan sakit bila digerakkan. Sebelumnya pasien sehat, tidak ada riwayat hipertensi. Pasien ditangani sejawat ortopaedi. Setelah dilakukan pemeriksaan radiologis didiagnosa fraktur collum femur pasien dipondokkan untuk operasi AMP. Instruksi untuk peserta : 1. Lakukan evaluasi preoperative 2. Tentukan diagnosis dan persiapan preoperative 3. Tentukan dan sebutkan Rencana tindakan anestesi 4. Sebutkan dan tuliskan manajemen paska bedah

8	Instruksi untuk penguji	Skenario klinik: Dikonsulkan seorang perempuan berusia 65 tahun berat badan 65 kg diantar ke IGD dengan keluhan tidak bisa berjalan setelah jatuh di kamar mandi. Kaki kanan sakit bila digerakkan. Sebelumnya pasien sehat, tidak ada riwayat hipertensi. Pasien ditangani sejawat ortopaedi. Setelah dilakukan pemeriksaan radiologis didiagnosa fraktur collum femur pasien dipondokkan untuk operasi AMP. Instruksi untuk peserta : 1. Lakukan evaluasi preoperative 2. Tentukan diagnosis dan persiapan preoperative 3. Tentukan dan sebutkan Rencana tindakan anestesi 4. Sebutkan dan tuliskan manajemen paska bedah Intruksi penguji : <u>INSTRUKSI UMUM</u> 1. Pastikan identitas peserta ujian pada kartu ujian 2. Tulislah nama dan nomor peserta ujian pada lembar penilaian! 3. Amatilah dan berilah skor (0/1/2/3) atas tugas yang dikerjakan peserta ujian serta skor <i>Global Rating</i> sesuai rubrik penilaian 4. Hindarilah interupsi dan/atau tindakan selain daripada yang diminta dalam instruksi penguji! 5. Berikan informasi/hasil yang dibutuhkan secara lisan/tulisan hanya apabila peserta ujian telah melakukan dan/atau mengusulkan jenis pemeriksaan yang dimaksud (perhatikan instruksi khusus)! 6. Taatilah peraturan serta etika penguji selama menjalankan tugas sebagai penguji OSCE - ATI! INSTRUKSI KHUSUS : 1. Penguji mengamati dan menilai tindakan preoperatif yang dilakukan peserta dan memberikan hasil pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang bila diminta oleh peserta. Peserta menanyakan : Anamnese Alergi (-), Medication (-), Past illness (-), Last meal 1 jam sebelum MRS, Event (-) Jatuh di kamar mandi, tidak bisa jalan, kaki kanan sakit bila digerakkan. Riwayat penyakit dahulu : pasien kalau jalan agak jauh napas terasa berat. Pemeriksaan Klinis: BB 65 kg, TB 155 cm. Kesadaran Compos mentis GCS14 E3V5M6, pupil isokor 3mm/3mm RC +/-
---	-------------------------	---

		Frekuensi nafas 18-24 x/menit, suara pernafasan vesikuler suara tambahan tidak ada, Tekanan darah 150/90 mmHg, Nadi 112 x/menit, kuat, Jantung : suara jantung normal, Suhu 37°C. VAS Diam 4/10 cm dan. SaO₂ 95%. Abdomen distensi, defans muscular (+) Produksi urine : 50 cc/3 jam Pemeriksaan penunjang : Hasil Laboratorium : Darah Rutin : Hb 9,8 gr%, Ht 30%, WBC 19 k/μL, Plt 87 gr/dl Faal Hemostasis : PPT10,9 (12,2) , APTT 35,8 (30,7), INR 1,5 Bun (Ureum) : 78 mg/dl, Creatinin 2,1 mg/dl Na 147 mmol/L, Kalium 5 mmol/L ,Cl 119 mmol/L Faal Hati : AST 189, ALT 163, LDH 896, albumin 2,5, globulin 3,42 Glukosa 98 mg/dl, Urinalisa : Berat jenis 1,020; pH 6,5; Protein +4; glukosa +2; Keton +1; eritrosit +2 Thorak foto : belum dikerjakan EKG : Sinus Takikardia. 2. Penguji menilai Diagnosa dan persiapan preoperative. Diagnosa : Preeklapsia Berat + HELLP Syndrome Persiapan preoperative : 1. Kontrol tekanan darah : turunkan tekanan darah 20% dari nilai awal, target MAP 105 – 125 mm Hg. 2. Pencegahan kejang : pemberian MgSO₄ iv 3. Iv line besar, persiapan darah 4. Monitoring efek samping MgSO₄ : frekuensi nafas, produksi urine dan reflek patella dan bila mungkin periksa kadar MgSO₄ setidaknya 4 jam setelah memulai terapi MgSO₄. Target konsentrasi 4-6 mEq/L. 5. Monitoring denyut jantung janin 6. Pencegahan aspirasi pneumonia : 30 ml oral non particulated antacid + metocloperamide 10 mg iv + H₂ blocker iv 3. Penguji menilai Manajemen anestesi yang dilakukan peserta Pilihan Anestesi : General Anestesi intubasi dengan RSI Rencana Tindakan Anestesi : 1. STATIC, menyiapkan obat anestesi yang diperlukan, mengecek mesin anestesi dan
--	--	--

		alat monitor pasien, memakai alat pelindung diri (minimal handschoen) 2. Posisi pasien Head Up minimal 30 derajat 3. Tim operator harus sudah siap dgn drapping pasien 4. Induksi dengan agen IV cepat (propofol / etomidate), Muscle relaxan kerja cepat Suksinilkolin 1,5 mg/kgbb atau rocuronium 0,9-1,2 mg/kgbb, bila perlu priming. 5. Cricoid pressure dengan lembut sebelum induksi (sellick's maneuver) 6. Tidak diberikan ventilasi tekanan positif. 7. Siapkan 3 ukuran ETT, memilih pipa endotrakeal dengan ukuran lebih kecil : 6 atau 6,5 mm 8. Mampu melakukan teknik rumatan anestesi umum dengan 2/3 MAC volatile anestesi 9. Opioid diberikan setelah bayi lahir 4. Penguji menilai manajemen paska operative yang disebutkan dan ditulis peserta 1. Pasien di rawat di ICU 2. Pilihan utama analgesia sistemik opioid intravena menggunakan syringe pump 3. Bolus parasetamol. 4. Sebaiknya dihindari penggunaan analgesia epidural karena penderita dengan peningkatan tekanan intracranial dan HELLP syndrome 5. Sebaiknya tidak diberikan NSAID untuk mencegah terganggunya agregasi trombosit dan juga karena pasien dengan AKI. 6. Disarankan menggunakan PCA karena pemberian dosis opioid intravena lebih mencerminkan kebutuhan pasien.
--	--	--

9	Denah ruangan	
10	Peralatan yang dibutuhkan	Setting ruangan dokter-pasien - Meja dan kursi dokter 1 set - Kursi pasien 1 buah - Meja dan kursi penguji 1 set - Meja peralatan 1 buah - Meja operasi 1 set - Manekin CSE 1 buah - Spinal set 1 buah - Espocan 1 set - Stetoskop 1 buah - Monitor Pasien 1 buah - Laringoskop 1 buah - Sungkup Muka 1 buah - Ambu Bag 1 buah - ETT 7, 7,5 dan 8 1 buah - Plester 1 buah - Sarung tangan non steril - Rekam medis 5 lembar - Tempat sampah tertutup 1 buah

		- Tissue kotak 1 - Jam dinding buah 1

LEMBAR PENILAIAN

STATION ANESTESI REGIONAL DAN MANAJEMEN NYERI

Kandidat Residen : _____

Aspek yang Dinilai	0	1	2	3	Bobot	Nilai
1. Preoperatif Evaluation	Peserta ujian tidak melakukan tindakan Atau melakukan tetapi tidak sesuai perintah Atau melakukan tetapi tidak sesuai masalah klinik pasien atau tidak melakukan pemeriksaan fisik	Kandidat hanya mampu identifikasi 3-4 point dengan tepat, lengkap dan benar dari 6 point tapi tidak lengkap	Peserta mampu identifikasi 5 – 6 point tapi tidak lengkap	Peserta ujian menanyakan dan melakukan pemeriksaan klinis pada: 1.Sistem kardiovaskuler 2.Sistem respirasi 3.Sistem saraf pusat 4.Sistem renal 5.Pemeriksaan penunjang: Faal pembekuan, EKG, Ro. thoraks, Ecocardiografi 6. AMPLE	3	

2. Diagnosa Problem potensial - actual	Peserta menyebutkan diagnose persiapan preoperative	tidak dan	Peserta hanya mampu menentukan diagnose	Peserta mampu menentukan diagnose namun tidak lengkap menjelaskan persiapan preoperative	Peserta mampu menentukan diagnosa dan persiapan anestesi Diagnosa : Fraktur colum femur pro AMP dengan penyulit cardio Persiapan preoperative : 1. Kontrol tekanan darah : 2. Pencegahan nyeri : immobilisasi dan pemberian analgetika. 3. Iv line besar. 4. Monitoring hemodinamik. 5. Penatalaksanaan nyeri paska operasi.	5	
---	---	-----------	---	--	---	----------	--

3. Rencana tindakan Anestesi	Peserta tidak ampu menentukan diagnose dan Peserta tidak mampu menjelaskan rencana anestesi	Peserta mampu menentukan tindakan anestesi tp tidak lengkap dan menjelaskan rencana anestesi namun tidak lengkap dan runut	Peserta mampu menentukan tindakan anestesi dan menjelaskan rencana anestesi namun tidak lengkap dan runut	Peserta mampu menentukan tindakan anestesi dan menjelaskan rencana anestesi Pilihan Anestesi : continues spinal epidural anestesi. Rencana Tindakan Anestesi : 1. STATIC, menyiapkan obat anestesi yang diperlukan, mengecek mesin anestesi dan alat monitor pasien, Menyiapkan spinal set, obat RA dan obat emergency serta alat pelindung diri. 2. Posisi pasien : left lateral decubitus, sebelumnya diberikan analgesi. 3. Membuat landmark dan menentukan titik puncture. 4. Cuci tangan steril. memakai baju steril dan handschoen. 5. Sterilisasi daerah puncure, dreping.	5	
-------------------------------------	--	--	---	---	----------	--

				6. Infiltrasi lokal anastesi. 7. Puncture epidural dengan LOR NaCl atau udara. 8. Pemasangan alat fiksasi, puncture jarum spinal dan injeksi obat. 9. Pemasangan epidural catheter. 10. Fixasi Carheter.		
--	--	--	--	--	--	--

4. Manajemen paska bedah	Peserta tidak mampu menjelaskan manajemen paska bedah	-	Peserta mampu menjelaskan manajemen paska bedah namun tidak lengkap	Peserta mampu menjelaskan manajemen paska bedah dengan lengkap 1. Pasien di rawat di ruang rawat bangsal. 2. Pilihan utama analgesia epidural, bisa kontinu atau intermitten. 3. Penentuan loading dose dan maintenance. 4. Bisa menggunakan ajuvan opioid. 5. Bisa menggunakan NSAID sebagai suplemen. 6. Monitoring hemodinamik	2	
---------------------------------	---	---	---	--	----------	--

5. Komunikasi, edukasi dan profesionalisme	Peserta ujian tidak meminta izin secara lisan dan sama sekali tidak melakukan poin berikut: 1. melakukan setiap tindakan dengan berhati-hati dan teliti sehingga tidak membahayakan pasien dan diri sendiri 2. memperhatikan kenyamanan pasien 3. melakukan tindakan sesuai prioritas 4. menunjukkan rasa hormat kepada pasien mengetahui keterbatasan dengan merujuk atau melakukan konsultasi bila diperlukan	Meminta izin secara lisan dan 1-2 poin berikut : 1. melakukan setiap tindakan dengan berhati-hati dan teliti sehingga tidak membahayakan pasien dan diri sendiri 2. memperhatikan kenyamanan pasien 3. melakukan tindakan sesuai prioritas 4. menunjukkan rasa hormat kepada pasien	Meminta izin secara lisan dan 3 poin berikut: 1. melakukan setiap tindakan dengan berhati-hati dan teliti sehingga tidak membahayakan pasien dan diri sendiri 2. memperhatikan kenyamanan pasien 3. melakukan tindakan sesuai prioritas 4. menunjukkan rasa	Meminta izin secara lisan dan melakukan di bawah ini secara lengkap: 1. melakukan setiap tindakan dengan berhati-hati dan teliti sehingga tidak membahayakan pasien dan diri sendiri 2. memperhatikan kenyamanan pasien 3. melakukan tindakan sesuai prioritas 4. menunjukkan rasa hormat kepada pasien mengetahui keterbatasan dengan merujuk atau melakukan konsultasi bila diperlukan	3	
---	---	--	--	--	----------	--

		mengetahui keterbatasan dengan merujuk atau melakukan konsultasi bila diperlukan	hormat kepada pasien mengetahui keterbatasan dengan merujuk atau melakukan konsultasi bila diperlukan			
--	--	---	--	--	--	--

II. Global performance

Beri tanda (✓) pada kolom yang disediakan sesuai dengan penilaian Anda secara umum terhadap kemampuan peserta ujian!

Tidak lulus	Borderline	Lulus	Superior

.....,
Penguji,

(.....)

SOAL UJIAN OSCE STATION ANESTESI REGIONAL DAN MANAJEMEN NYERI

1.	No. station	11
2.	Judul station	Spinal Anestesia
3.	Waktu yang dibutuhkan	20 menit
4.	Tujuan station	Menilai kemampuan evaluasi pra anestesia, diagnosis dan problem aktual–potensial, Keterampilan klinis, komunikasi, edukasi dan profesionalisme
5.	Kompetensi	1. Evaluasi Pra Anestesia 2. Diagnosis Dan Problem Aktual – Potensial 3. Rencana Tindakan Anestesi 4. Keterampilan Klinis 5. Monitoring dan manajemen penyulit 6. Manajemen Pasca Anestesia 7. Komunikasi, Edukasi Dan Profesionalisme
6.	Kategori	1. Anestesia Obstetrik 2. Anestesia Bedah Saraf 3. Anestesia Regional Dan Manajemen Nyeri 4. Anestesia Bedah Toraks 5. Anestesia Pediatrik 6. Anestesia Kegawatdaruratan 7. Anestesia Urologi 8. Anestesia Untuk Penyakit Khusus (Endokrin, Metabolik, Penyulit Kardiovaskular) 9. Anestesia Bedah Kepala Leher 10. Anestesia Bedah Rawat Jalan / Luar Kamar Bedah 11. Anestesia Pada Prosedur Invasif Minimal 12. Terapi Intensif
7.	Instruksi untuk peserta	Skenario Klinik : Seorang laki-laki umur 25 tahun dengan BB 60 Kg mengalami kecelakaan lalu lintas. Masuk Ke IGD dengan fraktur tertutup kruris Sinistra, akan dilakukan tindakan ORIF. Tidak terdapat cedera kepala. Riwayat kesehatan sebelumnya baik. Instruksi untuk peserta: 1. Lakukan preoperatif visit terhadap pasien tersebut 2. Sebutkan problem aktual dan problem potensial terhadap pasien tersebut 3. Lakukan tindakan spinal anestesi pada pasien tersebut.
8.	Instruksi untuk penguji	<u>INSTRUKSI UMUM</u> 1. Pastikan identitas peserta ujian pada kartu ujian 2. Tulislah nama dan nomor peserta ujian pada lembar penilaian! 3. Amatilah dan berilah skor (0/1/2/3) atas tugas yang dikerjakan peserta ujian serta skor <i>Global Rating</i> sesuai rubrik penilaian 4. Hindarilah interupsi dan/atau tindakan selain daripada yang diminta dalam instruksi penguji! 5. Berikan informasi/hasil yang dibutuhkan secara lisan/tulisan hanya

		apabila peserta ujian telah melakukan dan/atau mengusulkan jenis pemeriksaan yang dimaksud (perhatikan instruksi khusus)! 6. Taatilah peraturan serta etika penguji selama menjalankan tugas sebagai penguji OSCE - ATI! <u>INSTRUKSI KHUSUS</u> 1. Penguji mengamati dan menilai tindakan preoperatif yang dilakukan peserta dan memberikan hasil pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang bila diminta oleh peserta. Peserta melakukan Primary Survey Airway : Clear, C-spine stabil Breathing: Spontan, RR 18x/mnt, SP vesikuler; Suara tambahan Tidak dijumpai Circulation: Akral Hangat, merah, kering; TD : 110//70 mmHg Disability: Sensorium GCS 15; pupil isokor kanan=kiri; diameter 3 mm : 3 mm Exposure: Fraktur tertutup kruris sinistra Peserta menanyakan Anamnese Alergi (-), Medication (-), Past illness (-), Last meal 1 jam sebelum masuk rumah sakit, Event (-) Jatuh dari sepeda motor kaki kiri sakit kalau digerakkan. Riwayat penyakit dahulu : tidak pernah sakit yang serius. Pemeriksaan Klinis Kesadaran Compos mentis. Frekuensi nafas 18 x/menit, Suara pernafasan vesikuler suara tambahan tidak ada Tekanan darah 120/78 mmHg, Nadi 76 x/menit, kuat, Jantung : suara jantung normal, Suhu 37°C. VAS Diam 3 dan bergerak 8 (pada skala 1 - 10 cm) . Pemeriksaan penunjang Hasil Laboratorium : Darah Rutin :Hb 10 gr%, Ht 30% Leukosit 9000, trombosit 257.000 Faal Hemostasis : PT10.9(12.2), APTT 35.8 (30.7), INR 1.5 Na 137 meq/L, Kalium 4.5 meq/L, Cl 119 mmol/L Faal Hati : normal Glukosa : 98 mg/dl. 2. Penguji menilai problem potensial Problem aktual 1. Nyeri 2. Perdarahan Potensial problem : 1. Blok Spinal tinggi 2. Nyeri Paska anestesi 3. Penguji menilai keterampilan tindakan anestesi yang dilakukan peserta Teknik Anestesi 1. Menyiapkan spinal set, memilih jenis jarum spinal yang sesuai, obat regional anestesi dan obat emergensi serta alat pelindung diri, menyiapkan obat anestesi umum yang diperlukan, mengecek
--	--	--

		mesin anestesi dan alat monitor pasien. 2. Posisi pasien : posisi duduk Left lateral decubitus, sebelumnya diberikan analgesia. 3. Membuat landmark dan menentukan titik puncture. 4. Cuci tangan steril, memakai baju steril dan handschoen. 5. Sterilisasi daerah puncture, tutup dengan duk lobang steril. 6. Infiltrasi lokal anestesi. 7. Puncture spinal anestesi sampai keluar LCS . 8. Barbotase dan memasukkan obat lokal Anestesi. 9. Memposisikan pasien kembali. 10. Menilai keberhasilan blok dengan pinprick dan bromage scale. 4. Penguji menilai komunikasi, edukasi serta perilaku profesionalisme peserta. a. Memperkenalkan diri kepada keluarga pasien, dengan menyebutkan nama dan bidang keahlian. b. Memberikan informasi kepada pasien serta keluarga pasien dengan rasa hormat, tentang keadaan umum pasien, rencana tindakan operasi yang akan dilakukan, pemeriksaan laboratorium dan radiologi untuk penilaian sebelum dilakukan tindakan anestesi dan operasi c. Memberikan penjelasan kepada keluarga pasien secara lengkap tentang rencana tindakan spinal anestesi, problem yang mungkin timbul pada saat atau paska tindakan operasi, serta memberikan penjelasan tentang efek samping maupun resiko yang dapat timbul. d. Melakukan tindakan dengan memperhatikan kenyamanan pasien.
9.	Denah ruangan	The diagram illustrates the layout of a clinical room. At the center is a light blue rounded rectangle labeled 'BED'. To the left of the bed is a light blue rounded rectangle labeled 'Meja Peralatan dan obat'. To the right of the bed is a light blue vertical rectangle labeled 'MEJA PENGUJI'. Below the bed is a light blue vertical rectangle labeled 'MEJA PESERTA'. There are several black oval shapes representing people: one at the top center, one to the left of the bed, one at the bottom left, one at the bottom right, and three on the right side next to the 'MEJA PENGUJI'.

10	Instruksi Pasien Standar	Nama : sesuai Usia : 25 tahun Jenis Kelamin : Lk Pekerjaan : Ojek Peran yang harus ditunjukkan :pasien merasa kesakitan, lemah, dengan fraktur tertutup kruris sinistra Pertanyaan yang wajib ditanyakan : - Bagaimana keadaan umum pasien? - Apa rencana yang akan dilakukan dokter? - Apa problem yang mungkin timbul atas rencana tindakan dokter? Anamnesa : - Terjadi kecelakaan 1 jam sebelum masuk rumah sakit - Pasien mengalami kecelakaan setelah menghindari mobil yang datang dari arah berlawanan , Pasien terjatuh setelah menabrak trotoar dan kaki tertimpa motor. Tidak ada cedera kepala, tidak ada mual tidak muntah,tidak terjadi kejang, tidak minum alkohol, tidak merokok, tidak terdapat riwayat penyakit yang serius sebelumnya, makan dan minum terakhir 1 jam yang lalu.	
	Kebutuhan Laboran	Jumlah Laboran : 1 Tugas Laboran : Sebagai peñata anestesi, membantu peserta dalam melakukan persiapan dan tindakan spinal anestesi.	
12	Peralatan yang dibutuhkan	Setting ruangan dokter-pasien - Meja dan kursi dokter - Kursi pasien - Meja dan kursi penguji - Meja peralatan - Meja operasi - Spinal set - Jarum Spinal no. 25,26,27 - Obat local Anestesi (lidocaine, bupivacaine) - S spuit 3 ml - S spuit 5 ml - Stetoskop - Monitor Pasien - Sungkup Muka - Sarung tangan non steril - Tempat sampah - Tissue - Jam dinding - VAS skor - Pen light	1 set 1 buah 3 set 1 buah 1 buah 1 buah 1/1/1 buah 1/1buah 2 buah 2 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah
13	Kebutuhan Manekin	Manekin Spinal1 buah	
14	Penulis		
15	Referensi	Morgan clinical Anesthesia	
16	Reviewer		

LEMBAR PENILAIAN

STATION ANESTESI REGIONAL DAN MANAJEMEN NYERI

Aspek yang Dinilai	0	1	2	3	Bobot	Skor
1. Evaluasi Praoperasi	Kandidat tidak melakukan evaluasi pra operasi	Peserta ujian hanya melakukan evaluasi praoperasi yang meliputi : - Anamnesa AMPLE atau - Primarysurvey	Peserta ujian melakukan evaluasi praoperasi secara tidak lengkap dan runut yang meliputi: - Anamnesa AMPLE - Primary survey dan pemeriksaan fisik secara menyeluruh dengan lengkap dan runut	Peserta ujian melakukan evaluasi praoperasi secara lengkap dan runut yang meliputi sesuai poin evaluasi pra operasi pada instruksi khusus	2	
2. Problem aktual dan Problem potensial	Peserta ujian tidak menyampaikan problem aktual dan problem potensial	Peserta hanya mampu menyebutkan problem aktual	Peserta mampu menentukan problem aktual dan problem potensial namun tidak lengkap	Peserta mampu menentukan problem aktual dan potensial problem potensial - Nyeri - Perdarahan - Blok spinal tinggi - Nyeri paska Anestesi.	2	
3. Keterampilan klinis	Peserta tidak mampu menjelaskan tindakan Anestesi yang akan dikerjakan		Peserta mampu menjelaskan tindakan anestesi namun tidaklengkap	Peserta ujian melakukan semua tahapan pemberian anestesi dengan benar dan lengkap sesuai poin pada instruksi	2	

				husus		
4. Komunikasi dan Perilaku profesional	Peserta ujian tidak meminta meminta izin secara lisan dan sama sekali tidakn melakukan point berikut: 1. melakukan setiap tindakan dengan berhati-hati dan teliti sehingga tidak membahayakan pasien dan diri sendiri 2. memperhatikan kenyamanan pasien 3. melakukan tindakan sesuai prioritas 4. menunjukkan rasa hormat kepada pasien 5. mengetahui keterbatasan dengan merujuk atau	Meminta izin secara lisan dan 1-2 point berikut: 1. melakukan setiap tindakan dengan berhati-hati dan teliti sehingga tidak membahayakan pasien dan diri sendiri 2. memperhatikan kenyamanan pasien 3. melakukan tindakan sesuai prioritas 4. menunjukkan rasa hormat kepada pasien 5. mengetahui keterbatasan dengan merujuk atau melakukan konsultasi bila diperlukan	Meminta izin secara lisan dan 3-4 point berikut: 1. melakukan setiap tindakan dengan berhati-hati dan teliti sehingga tidak membahayakan pasien dan diri sendiri 2. memperhatikan kenyamanan pasien 3. melakukan tindakan sesuai prioritas 4. menunjukkan rasa hormat kepada pasien 5. mengetahui keterbatasan dengan merujuk atau melakukan konsultasi bila diperlukan	Meminta izin secara lisan dan melakukan di bawah ini secara lengkap: 1. melakukan setiap tindakan dengan berhati-hati dan teliti sehingga tidak membahayakan pasien dan diri sendiri 2. memperhatikan kenyamanan pasien 3. melakukan tindakan sesuai prioritas 4. menunjukkan rasa hormat kepada pasien 5. mengetahui keterbatasan dengan merujuk atau melakukan konsultasi bila diperlukan	3	

	melakukan konsultasi bila diperlukan					
TOTAL SKOR						

II. Global performance

Beri tanda (✓) pada kolom yang disediakan sesuai dengan penilaian Anda secara umum terhadap kemampuan peserta ujian!

Tidak lulus	Borderline	Lulus	Superior

.....,
Penguji,

(.....)

ANESTESIA BEDAH THORAKS

SOAL UJIAN OSCE STATION ANESTESIA PADA PROSEDUR BEDAH THORAK

1.	No. station	
2.	Judul station	Thorakotomi / Lobektomi
3.	Waktu yang dibutuhkan	20 menit
4.	Tujuan station	Menilai kemampuan evaluasi Pra anestesia, Diagnosis dan problem aktual – potensial, Keterampilan klinis, Monitoring dan manajemen penyulit, Komunikasi, edukasi dan profesionalisme
5.	Kompetensi	1. Evaluasi Pra Anestesia 2. Diagnosis Dan Problem Aktual – Potensial 3. Rencana Tindakan Anestesi 4. Keterampilan Klinis 5. Monitoring dan manajemen penyulit 6. Manajemen Pasca Anestesia dan Bedah 7. Komunikasi, Edukasi Dan Profesionalisme
6.	Kategori	1. Anestesia Pada Prosedur Bedah Thorak
7.	Instruksi untuk peserta	Skenario Klinik : Seorang wanita 50 tahun datang dengan keluhan batuk darah sejak 10 tahun lalu. Batuk darah dirasakan semakin memberat. Pasien telah menjalani terapi OAT selama 9 bulan di puskesmas namun keluhan tidak berkurang. Pasien tidak pernah mengeluh sesak. Kemudian pasien dikonsulkan ke dokter spesialis pulmonologi dan didiagnosis aspergilosis pulmo sinistra. Pasien diberikan terapi antimikosis dan dikonsulkan ke bagian bedah thorak. Pasien diprogram untuk operasi lobektomi inferior pulmo sinistra. Instruksi untuk peserta: 1. Lakukan evaluasi pre anestesi (anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang). 2. Tegakkan diagnosis pasien dan rencana anestesi pada pasien. 3. Sebutkan problem pasien dan potensial problem pada pasien 4. Lakukan intubasi dengan pipa endotrakheal double lumen 5. Sebutkan komplikasi yang terjadi pada pasien beserta tatalaksananya 6. Bagaimana manajemen pasca operasi pada pasien
8.	Instruksi untuk penguji	<u>INSTRUKSI UMUM</u> 1. Pastikan identitas peserta ujian pada kartu ujian 2. Tulislah nama dan nomor peserta ujian pada lembar penilaian! 3. Amatilah dan berilah skor (0/1/2/3) atas tugas yang dikerjakan peserta ujian serta skor <i>Global Rating</i> sesuai rubrik penilaian 4. Hindarilah interupsi dan/atau tindakan selain daripada yang diminta dalam instruksi penguji! 5. Berikan informasi/hasil yang dibutuhkan secara lisan/tulisan hanya apabila peserta ujian telah melakukan dan/atau mengusulkan jenis pemeriksaan yang dimaksud (perhatikan instruksi khusus)! 6. Taatilah peraturan serta etika penguji selama menjalankan tugas sebagai penguji OSCE - ATI!

		<u>INSTRUKSI KHUSUS</u> 1. Penguji menilai kemampuan peserta untuk evaluasi pra operasi Anamnesis: A : riwayat alergi / asthma (-) M: Pasien mengkonsumsi anti mikosis dan riwayat pengobatan TB P : Pasien pernah didiagnosa TB paru dengan terapi tuntas L : 6 jam yang lalu E : Batuk darah sejak 10 tahun lalu Pemeriksaan Fisik: B1 : Jalan nafas bebas, malampati 1, gigi ompong (-). RR : 14 x/menit, napas spontan adekuat, retraksi (-). Gerak dada simetris. Suara nafas vesikuler Rh -/+ Wheezing -/- SpO2 97% (oksigen 21%) B2 : nadi teraba kuat frekuensi 64 x/menit , tekanan darah 130/90 mmHg, mukosa mulut basah, turgor normal B3 : Compos mentis, status neurologis normal. B4 : Normal, produksi urin 30 cc / jam B5 : normal B6 : normal Pemeriksaan Penunjang: Darah Rutin : Hb 10 gr%, Ht 30%, WBC 13 k/μL, Plt 250 gr/dl Faal Hemostasis : PPT10,9 (12,2) , APTT 35,8 (30,7) Ureum : 40 mg/dl, Creatinin 1,0 mg/dl Na 135 mmol/L, Kalium 4,2 mmol/L ,Cl 100 mmol/L Faal Hati :AST 40, ALT 30, albumin 2,9 Glukosa 90 mg/dl Analisa gas darah: pH 7,35, PaO2 100 mmHg, PaCO2 44 mmHg, HCO3 24, BE -2, AaDO2 20, SpO2 99% nasal kanul 2 lpm EKG : Normo Sinus Ritme Spirometri : Restriktif Ringan Thorax PA : Gambaran aspergillosis lobus inferior paru sinistra 2. Penguji menilai Diagnosis Dan Problem Aktual – Potensial ditegakkan peserta ujian Diagnosa: Aspergillosis pulmo sinistra pro lobektomi Inferior pulmo sinistra status fisik ASA 2 Problem aktual dan potensial: • Restriktif ringan • Obstruksi saluran napas bawah • Desaturasi 3. Penguji menilai rencana tindakan anestesi yang diusulkan / dikerjakan peserta ujian Anestesi umum napas kendali dengan pipa endotrakheal double lumen
--	--	--

		4. Penguji menilai pelaksanaan keterampilan klinis yang diusulkan / dikerjakan peserta ujian Tahapan pemberian anestesi dengan benar dan runut meliputi : 1) Persiapan alat, obat anestesi dan emergensi 2) Monitoring fungsi vital, termasuk EKG, Tekanan darah invasif dengan arterial line, CVC, SpO2, End tidal CO2 3) Preoksigenasi 4) Induksi iv menggunakan obat sedasi dan obat pelumpuh otot 5) Intubasi dengan ETT double lumen kanan ukuran 35. Dilakukan cek penempatan ETT doble lumen (simulasi ventilasi satu paru) 6) Rumatan anestesi dengan obat agent inhalasi tanpa N₂O , narkotik fentanyl 1-2 mcg/kgBB atau morfin 0.1 mg/kgBB, dan obat pelumpuh otot atracurium atau vecuronium atau rocuronium. 7) Rumatan cairan : restriksi cairan dengan prinsip mengganti defisit volume dan cairan rumatan saja. 8) Operasi dimulai dan teknik ventilasi satu paru dilakukan sesuai kebutuhan 9) Saat operasi selesai, diberikan reversal neostigmin dan atropin 10) Anestesi diakhiri, agen inhalasi dihentikan, dan dilakukan penggantian pipa endotrakheal dengan ETT single lumen. 5. Penguji menilai penatalaksanaan pasca operasi yang diusulkan / dikerjakan peserta ujian Tatalaksana pasca operasi: • Dirawat di ICU dengan menggunakan ventilator • Direncanakan weaning bertahap • Manajemen nyeri dengan opioid, pilihan morfin untuk mencegah terjadinya edema pulmo • Antimikosis dilanjutkan 6. Penguji menilai Komunikasi, edukasi dan profesionalismepeserta ujian
9.	Denah ruangan	

11	Kebutuhan Laboran	Jumlah Laboran : 1 Tugas Laboran : Asisten anestesi	
12	Peralatan yang dibutuhkan	Setting ruangan dokter-pasien - Meja dan kursi peserta - Meja dan kursi penguji - Meja peralatan - Meja operasi - Manekin dengan telah terpasang infus - Stetoskop - Monitor Pasien - Stylet untuk ETT double lumen - Laringoskop - Suction - Sungkup Muka - ETT 7,0 - ETT double lumen no 35 (left dan right) - Jelly atau lubrikan - Plester - Mesin anestesi - Vaporizer sevoflurane - Kassa - Klem untuk ventilasi satu paru - Obat induksi dan premedikasi : - Fentanyl - Propofol - Rocuronium - Sulfas Atropine - Adrenalin - Morfin - Sarung tangan non steril - Rekam medis - Tempat sampah tertutup - Jam dinding	1 set 1 set 1 buah 1 set 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 ampul 1 ampul 1 ampul 1 ampul 1 ampul 1 ampul 1 box 5 lembar 1 buah 1 buah
13	Kebutuhan Manekin	1 manekin intubasi dengan paru terlihat	
15	Referensi	Morgan and Michael Clinical Anesthesiology	

RUBRIK ACTUAL MARK

STATION ANESTESIA PADA PROSEDUR BEDAH THORAK

LEMBAR PENILAIAN

Kandidat Residen : _____

Aspek yang Dinilai	0	1	2	3	Bobot	Skor
1. Evaluasi Pra operasi	Kandidat tidak melakukan evaluasi pra operasi	Peserta ujian hanya melakukan evaluasi praoperasi yang meliputi : - Anamnesa AMPLE ATAU - Pemeriksaan fisik B1 – B6	Peserta ujian melakukan evaluasi praoperasi secara tidak lengkap dan runut yang meliputi : - Anamnesa AMPLE - Pemeriksaan fisik B1 – B6 dengan lengkap dan runut	Peserta ujian melakukan evaluasi praoperasi secara lengkap dan runut yang meliputi : Anamnesa AMPLE Anamnesis : A : riwayat alergi / asthma (-) M: Pasien mengkonsumsi anti mikosis dan riwayat pengobatan TB P : Pasien pernah didiagnosa TB paru dengan terapi tuntas L : 6 jam yang lalu E : Batuk darah sejak 10 tahun lalu Pemeriksaanfisik B1 – B6 B1 : Jalan nafas bebas, malampati 1, gigi ompong (-).	3	

				RR : 14 x/menit, napas spontan adekuat, retraksi (-). Gerak dada simetris. Suara nafas vesikuler Rh -/+ Wheezing -/- SpO2 97% (oksigen 21%) B2 : nadi teraba kuat frekuensi 64 x/menit , tekanan darah 130/90 mmHg, mukosa mulut basah, turgor normal B3 : Compos mentis, status neurologis normal. B4 : Normal produksi urin 30 cc / jam B5 : normal B6 : normal		
2. Diagnosa dan problem potensial – aktual	Peserta ujian tidak menyampaikan diagnosa, potensial problem dan pemeriksaan penunjang serta persiapan operasi yang dibutuhkan	Peserta ujian hanya menyampaikan diagnosa saja tanpa menyampaikan potensial problem dan pemeriksaan penunjang serta persiapan operasi yang dibutuhkan	Peserta ujian menyampaikan diagnosa, potensial problem, dan pemeriksaan penunjang serta persiapan operasi yang dibutuhkan namun tidak lengkap	Peserta ujian menyampaikan diagnosa, potensial problem, dan pemeriksaan penunjang serta persiapan operasi yang dibutuhkan secara lengkap dan benar Diagnosa Aspergilosis pulmo sinistra pro lobektomi Inferior pulmo sinistra Problem aktual dan potensial: • Restriktif ringan	2	

				• Obstruksi saluran napas bawah • Desaturasi		
3. Rencana tindakan Anestesi	Peserta ujian tidak menyampaikan rencana tindakan anestesi	-	Peserta ujian menyampaikan rencana tindakan anestesi namun tidak lengkap	Peserta ujian menyampaikan rencana tindakan anestesi secara lengkap: Anestesi umum napas kendali dengan pipa endotrakheal double lumen	2	
4. Keterampilan klinis	Peserta ujian tidak melakukan item tahapan pemberian anestesi nomor 5,7,8,10	Peserta ujian minimal melakukan item tahapan pemberian anestesi nomor 5,7,8,10	Peserta ujian melakukan tahapan pemberian anestesi dengan benar namun tidak runut	Peserta ujian melakukan semua tahapan pemberian anestesi dengan benar dan runut meliputi : 11) Persiapan alat, obat anestesi dan emergensi 12) Monitoring fungsi vital, termasuk EKG, Tekanan darah invasif dengan arterial line, CVC, SpO2, End tidal CO2 13) Preoksigenasi 14) Induksi iv menggunakan obat sedasi dan obat pelumpuh otot 15) Intubasi dengan ETT double lumen kanan ukuran 35. Dilakukan cek penempatan ETT double lumen (simulasi ventilasi satu paru)	5	

				16) Rumatan anestesi dengan obat agent inhalasi tanpa N₂O , narkotik fentanyl 1-2 mcg/kgBB atau morphin 0.1 mg/kgBB, dan obat pelumpuh otot atracurium atau vecuronium atau rocuronium. 17) Rumatan cairan : restriksi cairan dengan prinsip mengganti defisit volume dan cairan rumatan saja. 18) Operasi dimulai dan teknik ventilasi satu paru dilakukan sesuai kebutuhan 19) Saat operasi selesai, diberikan reversal neostigmin dan atropin 20) Anestesi diakhiri, agen inhalasi dihentikan, dan dilakukan penggantian pipa endotrakheal dengan ETT single lumen.		
6.Manajemen Pasca Anestesia	Peserta ujian tidak menyampaikan	Peserta ujian hanya menyampaikan ruangan pasca	Peserta ujian menyampaikan tatalaksana pasca	Peserta ujian menyampaikan tatalaksana pasca anestesia secara lengkap dan benar	3	

	tatalaksana pasca anestesia secara lengkap dan benar	anestesia saja tanpa memberikan tatalaksana paska operasi	anestesia namun tidak lengkap dan benar	• Dirawat di ICU dengan menggunakan ventilator • Direncanakan weaning bertahap • Manajemen nyeri dengan opioid, pilihan morfin untuk mencegah terjadinya edema pulmo • Antimikosis dilanjutkan		
7. Komunikasi dan Perilaku profesional	Peserta ujian tidak meminta meminta izin secara lisan dan sama sekali tidakn melakukan point berikut: 1. melakukan setiap tindakan dengan berhati-hati dan teliti sehingga tidak membahayakan pasien dan diri sendiri 2. memperhatikan kenyamanan pasien 3. melakukan tindakan sesuai prioritas 4. menunjukkan rasa hormat kepada pasien 5. mengetahui keterbatasan dengan merujuk atau melakukan konsultasi bila sesuai	meminta izin secara lisan dan 1-2 point berikut: 1. melakukan setiap tindakan dengan berhati-hati dan teliti sehingga tidak membahayakan pasien dan diri sendiri 2. memperhatikan kenyamanan pasien 3. melakukan tindakan sesuai prioritas 4. menunjukkan rasa hormat kepada pasien 5. mengetahui keterbatasan dengan merujuk atau melakukan konsultasi bila	meminta izin secara lisan dan 3-4 point berikut: 1. melakukan setiap tindakan dengan berhati-hati dan teliti sehingga tidak membahayakan pasien dan diri sendiri 2. memperhatikan kenyamanan pasien 3. melakukan tindakan sesuai prioritas 4. menunjukkan rasa hormat kepada pasien 5. mengetahui keterbatasan dengan merujuk atau melakukan konsultasi bila diperlukan	meminta izin secara lisan dan melakukan di bawah ini secara lengkap:	3	

	prioritas 4. menunjukkan rasa hormat kepada pasien 5. mengetahui keterbatasan dengan merujuk atau melakukan konsultasi bila diperlukan	diperlukan	diperlukan			
TOTAL SKOR						

II. Global performance

Beri tanda (✓) pada kolom yang disediakan sesuai dengan penilaian Anda secara umum terhadap kemampuan peserta ujian!

Tidak lulus	Borderline	Lulus	Superior

.....,

Penguji,

(.....)

ANESTESIA PEDIATRI

SOAL UJIAN OSCE STATION MANAJEMEN PENYULIT PEDIATRIK

1	Nomor Station	
2	Judul Station	Manajemen Anestesi Pediatrik
3	Waktu yang dibutuhkan	20 menit
4	Tujuan Station	Menilai kemampuan melakukan Evaluasi Preoperative, Diagnosa dan problem potensial – aktual, rencana tindakan anestesi, Manajemen Anestesi Pediatrik
5	Kompetensi :	1. Evaluasi Preoperative 2. Diagnosa dan problem potensial - aktual 3. Rencana tindakan anestesi 4. Keterampilan klinis 5. Monitoring dan manajemen penyulit 6. Manajemen paska bedah dan anestesi 7. Komunikasi, edukasi dan profesionalisme
6	Kategori	Anestesi Pediatrik
7	Intruksi untuk peserta ujian	<u>Skenario Klinik :</u> Anak usia 7 tahun, berat badan 40 kg, tinggi badan 110 cm, direncanakan akan operasi adenotonsilektomi elektif dengan riwayat asma. Intruksi untuk peserta : 1. Lakukan evaluasi preoperative 2. Sebutkan diagnosa dan problem potensial – aktual 3. Sebutkan dan lakukan rencana tindakan anestesi 4. Sebutkan Manajemen paska tindakan bedah
8	Intruksi untuk penguji	<u>Skenario Klinik :</u> Anak usia 7 tahun, berat badan 40 kg, tinggi badan 110 cm, direncanakan akan operasi adenotonsilektomi elektif. Memiliki riwayat alergi dan asma. Intruksi untuk peserta : 1. Lakukan evaluasi preoperative 2. Sebutkan diagnosa dan problem potensial – aktual 3. Sebutkan dan lakukan rencana tindakan anestesi 4. Sebutkan Manajemen paska tindakan bedah dan anestesi Intruksi penguji : <u>INSTRUKSI UMUM</u> 1. Pastikan identitas peserta ujian pada kartu ujian 2. Tulislah nama dan nomor peserta ujian pada lembar penilaian! 3. Amatilah dan berilah skor (0/1/2/3) atas tugas yang dikerjakan peserta ujian serta skor <i>Global Rating</i> sesuai rubrik penilaian 4. Hindarilah interupsi dan/atau tindakan selain daripada yang diminta dalam instruksi penguji!

		5. Berikan informasi/hasil yang dibutuhkan secara lisan/tulisan hanya apabila peserta ujian telah melakukan dan/atau mengusulkan jenis pemeriksaan yang dimaksud (perhatikan instruksi khusus)! 6. Taatilah peraturan serta etika penguji selama menjalankan tugas sebagai penguji OSCE - ATII INSTRUKSI KHUSUS : 1. Penguji mengamati dan menilai tindakan preoperatif yang dilakukan peserta dan memberikan hasil pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang bila diminta oleh peserta. Peserta menanyakan : Anamnese Alergi (+) dingin dan makanan laut, Pengobatan (+) salbutamol spray, Riwayat penyakit dahulu (+) asma, serangan terakhir 3 bulan yang lalu membaik dengan pemberian spray Makan terakhir : puasa 6 jam sebelum operasi Riwayat penyakit sekarang : tidur mendengkur, suka mengantuk di kelas, sesak malam (+), bernafas lewat mulut Pemeriksaan Klinis: BB 40 kg, TB 110 cm. Kesadaran Compos mentis GCS15 E4V5M6, Tanda vital : Tekanan darah 90/50 mmHg, Nadi 90 x/menit, kuat angkat, Frekuensi nafas 25 x/menit, Suhu 37°C Pupil isokor 3mm/3mm RC +/- Mulut: Mallampati 3 Leher: tidak teraba limfonodi, TMD = 2 jari dewasa Auskultasi paru : suara pernafasan vesikuler suara tambahan tidak ada Jantung : bunyi jantung I-II normal, Abdomen: supel, hepar lien tidak teraba Ekstremitas : dalam batas normal Pemeriksaan penunjang : Hasil Laboratorium : Darah Rutin : Hb 12 gr%, Ht 36%, WBC 8 k/μL, Plt 300 gr/dl PPT 10,9 (11,2) , APTT 35,8 (36,7) Ureum : 49 mg/dl, Creatinin 0,3 mg/dl Na 135 mmol/L, Kalium 4,0 mmol/L , Cl 99 mmol/L Albumin 3,5 Glukosa 90 mg/dl,
--	--	---

		Thorak foto : CTR<50% C/P dbn EKG : Sinus Ritme 90x/menit 2. Diagnosa dan problem potensial – aktual. Diagnosa : • Adenotonsilitis kronis • Obesitas • Asma terkontrol • Obstructive Sleep Apneu Problem aktual dan potensial : - difficult airway management - serangan asma - lambat bangun - perdarahan pasca bedah Persiapan preoperative : 1. Premedikasi untuk pasien alergi dengan antihistamin dan steroid 2. Persiapan intubasi sulit 3. Penguji menilai Manajemen anestesi yang dilakukan peserta Pilihan Anestesi : General Anestesi intubasi Rencana Tindakan Anestesi : 1. STATIC, menyiapkan obat anestesi yang diperlukan, mengecek mesin anestesi dan alat monitor pasien, memakai alat pelindung diri (minimal handschoen) 2. Siapkan 3 ukuran ETT, memilih pipa endotrakeal dengan ukuran lebih kecil 3. Induksi yang dalam dengan agen IV cepat (propofol / etomidate), analgetik (fentanyl), dan Muscle relaxan non histamine release dengan Vecuronium 4. Diberikan ventilasi tekanan positif, bila sudah dalam dan rilex 5. mengambil laryngoskop dengan tangan kiri, membuka mulut penderita dengan ekstensi kepala, menyusuri lidah dari kanan ke kiri hingga tampak epiglotis dan plica vocalis 6. insersi pipa endotracheal 7. kembangkan cuff, 8. auskultasi untuk simetrisasi suara napas, 9. fiksasi 10. Mampu melakukan teknik rumatan anestesi umum dengan volatile anestesi halothane 4. Penguji menilai manajemen pasca operative yang disebutkan dan ditulis peserta 1. Ekstubasi dilakukan pada saat pasien nafas
--	--	---

		adekuat dan sadar penuh 2. Pasien di rawat di PACU 3. Monitoring tanda vital dan saturasi oksigen dan kemungkinan munculnya komplikasi perdarahan, serangan asma pasca operasi 4. Bila perlu diberikan inhibitor kolinesterase dan nalokson 5. Pilihan utama analgesia sistemik non opioid dengan parasetamol	
9		Ruang 3mx4m 	
10	Pasien simulasi	Pengantar pasien (ibu pasien)	
11	Peralatan yang dibutuhkan	Setting ruangan dokter-pasien - Meja dan kursi dokter - Kursi pasien - Meja dan kursi penguji - Meja peralatan - Meja operasi - Manekin dengan telah terpasang infus - Stetoskop - Monitor Pasien	1 set 1 buah 1 set 1 buah 1 set 1 buah 1 buah 1 buah

		- Stylet - Laringoskop - Laryngeal Mask Airway - Suction - Sungkup Muka - ETT 5,5; 6,0; 6,5 - Plester - Mesin anestesi - Vaporizer halothane - Vaporizer isoflurane - Obat induksi dan premedikasi : - Dexamethasone - Diphenhydramine - Fentanyl - Propofol - Thiopenthal - Atracurium - Rocuronium - Prostigmin - Naloxone - Paracetamol - Sulfas Atropine - Adrenalin - Aminophylline - Sarung tangan non steril - Rekam medis - Tempat sampah tertutup - Tissue - Jam dinding	1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 3 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 ampul 1 ampul 1 ampul 1 ampul 1 ampul 1 ampul 1 ampul 1 ampul 1 ampul 1 botol 1 ampul 1 ampul 1 ampul 1 set 5 lembar 1 buah 1 kotak 1 buah
	Referensi	1. PEDIATRIC ANESTHESIOLOGY: COMPREHENSIVE BOARD REVIEW	A

LEMBAR PENILAIAN
STATION MANAJEMEN PENYULIT PEDIATRIK

Kandidat Residen : _____

Aspek yang Dinilai	0	1	2	3	Bobot	Nilai
1. Preoperatif Evaluation	Peserta ujian tidak melakukan tindakan Atau melakukan tetapi tidak sesuai perintah Atau melakukan tetapi tidak sesuai masalah klinik pasien atau tidak melakukan pemeriksaan fisik	Kandidat hanya mampu identifikasi 2 point dengan tepat, lengkap dan benar dari 2 point tapi tidak lengkap	Peserta mampu identifikasi 4 point tapi tidak lengkap	1. Peserta ujian anamnesa pada ibu pasien : Anamnese Alergi (+) dingin dan makanan laut, Pengobatan (+) salbutamol spray, Riwayat penyakit dahulu (+) asma, serangan terakhir 3 bulan yang lalu membaik dengan pemberian spray Makan terakhir : puasa 6 jam sebelum operasi Riwayat penyakit sekarang : tidur mendengkur, suka mengantuk di kelas, sesak malam (+), bernafas lewat mulut 2. Peserta ujian mampu melakukan pemeriksaan klinis secara lengkap terutama penyulit : Obesitas, malampati 3 3. Premedikasi untuk pasien alergi dengan antihistamin dan steroid 4. Persiapan intubasi sulit : STATICS, LMA	3	
2. Diagnosa	Peserta tidak menyebutkan	Peserta hanya mampu menentukan salah satu	Peserta mampu menentukan diagnose	Peserta mampu menentukan diagnosa dan problem	5	

Problem potensial - actual	diagnose dan problem actual/potensial	diagnose atau problem actual/potensial	dan problem actual/potensial namun tidak lengkap	actual/potensial 1. Diagnosa : • Adenotonsilitis kronis • Obesitas • Asma terkontrol • Obstructive Sleep Apneu 2. Problem aktual dan potensial: - difficult airway management - serangan asma - lambat bangun - perdarahan pasca bedah		
3. Rencana tindakan Anestesi dan keterampilan klinis	Peserta tidak mampu menentukan tindakan anestesi dan menjelaskan rencana anestesi Dan melakukan pilihan anestesi	Peserta mampu menentukan tindakan anestesi tapi tidak dapat menjelaskan rencana anestesi	Peserta mampu menentukan tindakan anestesi dan menjelaskan rencana anestesi namun tidak lengkap	Peserta mampu menentukan tindakan anestesi dan menjelaskan rencana anestesi dan melakukan pilihan anestesi : General Anestesi intubasi Rencana Tindakan Anestesi : 1. STATIC, menyiapkan alat dan obat anestesi yang diperlukan, mengecek mesin anestesi dan alat monitor pasien, memakai alat pelindung diri (minimal handschoen) 2. Siapkan 3 ukuran ETT, memilih pipa endotrakeal dengan ukuran lebih kecil 3. Induksi yang dalam dengan agen IV cepat (propofol), analgetik (fentanyl), dan Muscle relaxan non histamine release (rocuronium) 4. Diberikan ventilasi tekanan positif, bila sudah dalam dan	5	

				rilex 5. mengambil laryngoskop dengan tangan kiri, membuka mulut penderita tanpa ekstensi kepala, menyusuri lidah dari kiri ke kanan hingga tampak epiglotis dan plica vocalis 6. insersi pipa endotracheal 7. kembangkan cuff, 8. auskultasi untuk simetrisasi suara napas, 9. fiksasi 10. Mampu melakukan teknik rumatan anestesi umum dengan volatile anestesi		
4. Manajemen paska bedah	Peserta tidak mampu menjelaskan manajemen paska bedah	Peserta hanya mampu menjelaskan 1-2 manajemen paska bedah	Peserta mampu menjelaskan 3-5 manajemen paska bedah namun tidak lengkap	Peserta mampu menjelaskan manajemen paska bedah dengan lengkap 1. Ekstubasi dilakukan pada saat pasien nafas adekuat dan sadar penuh 2. Pasien di rawat di PACU 3. Monitoring tanda vital dan saturasi serta kemungkinan munculnya komplikasi perdarahan dan serangan asma pasca operasi 4. Bila perlu diberikan inhibitor kolinesterase dan nalokson 5. Pilihan utama analgesia sistemik non opioid dengan parasetamol	2	

5. Komunikasi, edukasi dan profesionalisme	Peserta ujian tidak meminta izin secara lisan dan sama sekali tidak melakukan poin berikut: 1. melakukan setiap tindakan dengan berhati-hati dan teliti sehingga tidak membahayakan pasien dan diri sendiri 2. memperhatikan kenyamanan pasien 3. melakukan tindakan sesuai prioritas 4. menunjukkan rasa hormat kepada pasien mengetahui keterbatasan dengan merujuk atau melakukan konsultasi bila diperlukan	Meminta izin secara lisan dan 1-2 poin berikut : 1. melakukan setiap tindakan dengan berhati-hati dan teliti sehingga tidak membahayakan pasien dan diri sendiri 2. memperhatikan kenyamanan pasien 3. melakukan tindakan sesuai prioritas 4. menunjukkan rasa hormat kepada pasien mengetahui keterbatasan dengan merujuk atau melakukan konsultasi bila diperlukan	Meminta izin secara lisan dan 3 poin berikut: 1. melakukan setiap tindakan dengan berhati-hati dan teliti sehingga tidak membahayakan pasien dan diri sendiri 2. memperhatikan kenyamanan pasien 3. melakukan tindakan sesuai prioritas 4. menunjukkan rasa hormat kepada pasien mengetahui keterbatasan dengan merujuk atau melakukan konsultasi bila diperlukan	Meminta izin secara lisan dan melakukan di bawah ini secara lengkap: 1. melakukan setiap tindakan dengan berhati-hati dan teliti sehingga tidak membahayakan pasien dan diri sendiri 2. memperhatikan kenyamanan pasien 3. melakukan tindakan sesuai prioritas 4. menunjukkan rasa hormat kepada pasien mengetahui keterbatasan dengan merujuk atau melakukan konsultasi bila diperlukan	3	
--	--	---	--	---	---	--

II. Global performance

Beri tanda (√) pada kolom yang disediakan sesuai dengan penilaian Anda secara umum terhadap kemampuan peserta ujian!

Tidak lulus	Borderline	Lulus	Superior

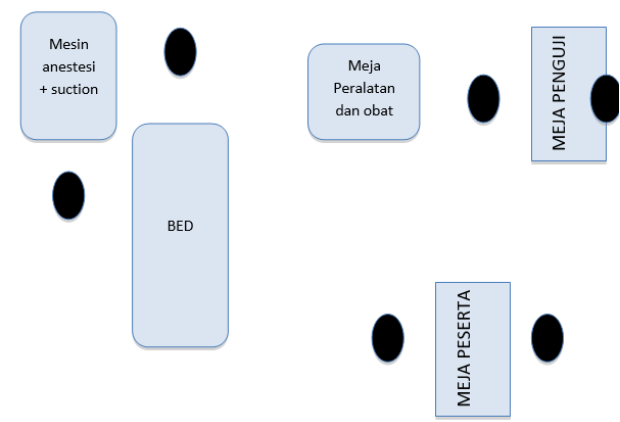
.....,
Penguji,

(.....)

SOAL UJIAN OSCE STATION MANAJEMEN PENYULIT PEDIATRIK

1.	Nomor station	1
2.	Judul stasion	<i>Anestesi umum pada Pediatri</i>
3.	Waktu yang dibutuhkan	20 menit
4.	Tujuan station	Menilai kemampuan Preoperative evaluation, Diagnosa, problem potensial – actual, Rencana tindakan anestesi, Keterampilan klinis dan Komunikasi, edukasi dan profesionalisme.
5.	Kompetensi	1. Evaluasi Preoperative 2. Diagnosa dan problem potensial - aktual 3. Rencana tindakan anestesi 4. Keterampilan klinis 5. Monitoring dan manajemen penyulit 6. Manajemen paska bedah 7. Komunikasi, edukasi dan profesionalisme
6.	Kategori	1. Anestesi obstetri 2. Neuroanestesi 3. Anestesi Regional dan Manajemen Nyeri 4. Anestesi Kardiovaskular 5. Anestesi Pediatrik 6. Anestesi Kegawat daruratan 7. Anestesi Urologi 8. Anestesi untuk penyakit Endokrin, metabolic dan penyakit – penyakit khusus 9. ICU 10. Anestesi pada kepala leher
7.	Instruksi untuk peserta ujian	Bayi laki-laki usia 5 bulan, berat badan 5 kg. Didiagnosa dengan HIL Duplex ireponibilis akan dilakukan tindakan Laparatomi cito. Instruksi untuk peserta : 1. Lakukan evaluasi preoperatif terhadap pasien tersebut 2. Sebutkan diagnosa, Problem potensial dan aktual terhadap pasien tersebut 3. Sebutkan persiapan anestesi pada pasien tersebut 4. Lakukan manajemen anestesi pada pasien tersebut
8.	Instruksi untuk penguji	Bayi laki-laki usia 5 bulan, berat badan 5 kg. Didiagnosa dengan HIL Duplex ireponibilis akan dilakukan tindakan Laparatomi cito. Instruksi untuk peserta : 1. Lakukan evaluasi preoperatif terhadap pasien tersebut 2. Sebutkan diagnosa, Problem potensial dan aktual terhadap pasien tersebut 3. Sebutkan persiapan anestesi pada pasien tersebut 4. Lakukan manajemen anestesi pada pasien tersebut Instruksi pada penguji <u>INSTRUKSI UMUM</u> 1. Pastikan identitas peserta ujian pada kartu ujian 2. Tulislah nama dan nomor peserta ujian pada lembar penilaian!

		3. Amatilah dan berilah skor (0/1/2/3) atas tugas yang dikerjakan peserta ujian serta skor <i>Global Rating</i> sesuai rubrik penilaian 4. Hindarilah interupsi dan/atau tindakan selain daripada yang diminta dalam instruksi penguji! 5. Berikan informasi/hasil yang dibutuhkan secara lisan/tulisan hanya apabila peserta ujian telah melakukan dan/atau mengusulkan jenis pemeriksaan yang dimaksud (perhatikan instruksi khusus)! 6. Taatilah peraturan serta etika penguji selama menjalankan tugas sebagai penguji OSCE - ATI! <u>INSTRUKSI KHUSUS</u> 1. Penguji mengamati dan menilai evaluasi preoperatif yang dilakukan peserta dan memberikan hasil pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang bila diminta oleh peserta. Peserta ujian menanyakan : – Riwayat alergi, riwayat medikasi sebelumnya → tidak ada – Riwayat kelahiran (normal), last meal (8 jam ASI), ispa (tidak ada) – Riwayat penyakit terdahulu tidak ada – Event: muntah terus menerus warna hijau dan benjolan di inguinal tidak dapat dimasukkan sejak 6 jam SMRS – Pemeriksaan fisik : letargi dan iritabel, Temp 38,8 C, Skor FLACC 6 – airway clear, Frekuensi nafas 40 x/menit, suara pernafasan vesikuler, TD : 60/30 mmHg, Nadi 130x/menit teraba lemah, Murmur (-), ubun-ubun tampak cekung, abdomen distended, Mukosa tampak kering, CRT 4 detik – lokalis : HIL duplex ireponibel – Pemeriksaan penunjang : Darah Rutin : Hb 14; Ht 45; AL 17000; AT 165000; Elektrolit : Na 130; K 2,8; Cl 100 Foto Thorax : Normal 2. Penguji mengamati dan menilai Problem potensial dan problem actual Diagnosa : Bayi laki-laki 5 bulan berat badan 5 kg dengan diagnosa HIL Duplex Ireponibel pro laparotomi rencana General anestesi RSI status fisik ASA 3E Problem actual : Infant, Dehidrasi, lambung penuh, nyeri Problem Potensial : Syok, Gangguan keseimbangan elektrolit, aspirasi, desaturasi, laringospasme 3. Penguji mengamati dan menilai persiapan anestesi pada pasien tersebut Persiapan Anestesi: - Informed consent - Paska operasi sedia PICU - Puasa dilanjutkan - Pemasangan OGT untuk dekompresi lambung - Berikan analgetik paracetamol 100 mg (dosis 20 mg/kg) intravena - Pasang kateter urine (bila diminta peserta ujian) → urine output 3 cc/jam - Pemasang iv line → lakukan rehidrasi pada pasien: Pasien dalam kondisi dehidrasi sedang → defisit cairan 100 cc/kg (500 cc): rehidrasi bertahap dengan cairan ringer laktat
--	--	---

		20-30 cc/kg dalam waktu 30 menit- 1jam → cek tanda vital hemodinamik dan urine output; bila belum stabil ulangi rehidrasi. Bila telah stabil berikan cairan 10 cc/kg/jam hingga urine output >1 cc/kg/jam 4. Manajemen Anestesi 1. Premedikasi : Dexamethason 0,1 – 0,5 mg/kg, Metoclopramide 0,15 mg/kg, Ranitidine 0,25-1 mg/kg 2. Rehidrasi dilanjutkan dan lakukan aspirasi OGT untuk mengosongkan isi lambung 3. Persiapan ruangan dengan pemasangan warmer 4. Cuci tangan dan pakai APD 5. Lakukan RSI dengan teknik 7P: 1) Preparasi mesin, alat,dan obat 2) Preoksigenasi dengan oksigen 100% selama 3 menit 3) Pretreatment dengan Atropin 0,02 mg/kg, Fentanyl 2 mcg/kg 4) Paralisis with induction dengan Ketamin 2 mg/kg + Rocuronium 1,2 mg/kg 5) Positioning dan sellick manuver 6) Placement with proof 7) Post intubation management 6. Maintenance Anestesi: • Ventilasi kendali dengan udara tekan 50% dalam oksigen dengan agen anestesi menggunakan Sevofluran 2-3 vol%. • Maintenance analgetik (fentanyl) dan agen pelumpuh otot (rocuronium) sesuai kebutuhan 7. Post operasi: • Pasien diekstubasi sadar penuh • Paska operasi dirawat di ICU • Analgetik paska operasi Paracetamol 100 mg/8 jam (20mg/kg/8jam)
9.	Instruksi untuk pasien standar	-
10	Denah ruangan	 Setting Ruang Poli/ Ruang operasi
11	Peralatan yang dibutuhkan	- Setting ruangan dokter pasien - Meja dan kursi dokter 1 set - Kursi pasien 1 buah - Meja dan kursi penguji 1 set

		- Rekam medis 1 buah - Blanko pemeriksaan 1 buah - penunjang 1 buah - Tempat sampah medis 1 buah - tertutup 1 buah - Tempat sampah nonmedis 1 buah - Meja peralatan 1 buah - Bed Pasien 1 buah - Wastafel atau simulasi 1 buah - wastafel 1 buah - Mesin anestesi 1 buah - Monitor 1 buah - Mesin suction 1 buah - Stetoskop 1 buah - Laringoscope 1 buah - Precordial stethoscope 1 buah - Penlight 1 buah - Tissue 1 buah - Jam dinding (dipasang di 1 buah - tembok agar dapat dilihat 1 buah - peserta) 1 buah - Ballpoint 1 buah - Sarung tangan (glove) - Manequine intubasi pediatric - alkohol 70%, kasa atau - kapas, - plester - gunting - nier bekken (bengkok) - Sulfast Atropin 0,25 mg (4 - ampul) - Lidocaine 2 % (3 ampul) - Efedrin 50 mg (1 ampul) - Midazolam 5 mg (1 ampul) - Fentanyl 100 mcg / - Remifentanyl / Morphine 10 - mg / Pethidin 100mg / (2 - ampul) - Propofol 200 mg (1 ampul) - Ketamin 100mg/10cc (sput) - Rocuronium 50 mg atau - atracurium 50 mg (1 ampul), - atau vecuronium 10 mg (1 - ampul). - Neostigmin 0.5 mg/ml - Paracetamol 1 g - ETT 2,5 3 3,5 - Suction cath no sesuai - dengan umur - NG tube no sesuai dengan - umur - Transfusion set atau pediatric - set - Iv cath no disesuaikan - dengan umur
--	--	--

		- Opsite infus - 3 way stop cock - Isoflurane / Sevoflurane (1 botol) - Laringoskop 1 buah - Oropharing 1 buah - Sungkup muka - Jackson Rees breathing circuit
12	Penulis	Tim Item Soal OSCE ATI
13	Referensi	Morgan: clinical of anesthesiology edisi V

RUBRIK ACTUAL MARK STATION PEDIATRIK

I. Rubrik Penilaian

Aspek yang Dinilai	0	1	2	3	Bobot	Skor
1.Preoperatif Evaluation	Peserta ujian tidak melakukan tindakan Atau melakukan tetapi tidak sesuai perintah Atau melakukan tetapi tidak sesuai masalah klinik pasien atau tidak melakukan pemeriksaan fisik	Peserta ujian menyebutkan 2 dari 3 point namun tidak lengkap	Peserta ujian menyebutkan 2 dari 3 point dengan lengkap	Peserta ujian menanyakan dan melakukan pemeriksaan klinis terhadap: 1. Anamnesis secara AMPLE 2. Pemeriksaan fisik :keadaan umum dan tanda vital serta derajat dehidrasi 3. Pemeriksaan penunjang : Laboratorium dan Radiologi	2	
2.Diagnosa Problem potensial - actual	Peserta tidak melakukan diagnosa dan tidak menyebutkan problem	Peserta hanya menyebutkan diagnosa dan tidak menyebutkan problem	Peserta hanya menyebutkan diagnosa dan dan problem aktual	Peserta ujian menyebutkan dengan lengkap: Diagnosa : Bayi laki-laki 5 bulan berat badan 5 kg dengan diagnosa HIL Duplex Ireponibel pro laparotomi rencana General anestesi RSI status fisik ASA 3E Problem actual : Infant, Dehidrasi, lambung penuh, nyeri Problem Potensial : Syok, Gangguan keseimbangan elektrolit, aspirasi, desaturasi, laringspasme	2	
3.Persiapan Anestesi	Peserta ujian tidak melakukan tindakan Atau melakukan tetapi tidak sesuai perintah Atau melakukan tetapi tidak	Peserta ujian hanya melakukan 3 dari 7 point	Peserta ujian hanya melakukan 5 dari 7 point	Peserta ujian melakukan semua Persiapan Anestesi: - Informed consent - Paska operasi sedia PICU - Puasa dilanjutkan - Pemasangan OGT untuk dekompresi lambung	3	

	sesuai masalah klinik pasien			- Berikan analgetik paracetamol 20 mg/kg (iv) - Pasang kateter urine (bila diminta peserta ujian) → urine output 3 cc/jam - Pemasang iv line → lakukan rehidrasi pada pasien: Pasien dalam kondisi dehidrasi sedang → defisit cairan 100 cc/kg (500 cc): rehidrasi bertahap dengan cairan ringer laktat 20-30 cc/kg dalam waktu 30 menit- 1jam → cek tanda vital hemodinamik dan urine output; bila belum stabil ulangi rehidrasi. Bila telah stabil berikan cairan 10 cc/kg/jam hingga urine output >1 cc/kg/jam		
4.Keterampilan klinis	Peserta ujian tidak melakukan tindakan Atau melakukan tetapi tidak sesuai perintah Atau melakukan tetapi tidak sesuai masalah klinik pasien	Peserta ujian hanya melakukan point 1-5 saja	Peserta ujian melakukan point 1-7 namun tidak lengkap	Peserta ujian melakukan semua tindakan dengan benar dan lengkap 1. Premedikasi : Dexamethason 0,1 – 0,5 mg/kg, Metoclopramide 0,15 mg/kg, Ranitidine 0,25-1 mg/kg 2. Rehidrasi dilanjutkan dan lakukan aspirasi OGT untuk mengosongkan isi lambung 3. Persiapan ruangan dengan pemasangan warmer 4. Cuci tangan dan pakai APD 5. Lakukan RSI dengan teknik 7P: 1) Preparasi mesin, alat,dan obat 2) Preoksigenasi dengan oksigen 100% selama 3 menit 3) Pretreatment dengan Atropin 0,02 mg/kg, Fentanyl 2 mcg/kg 4) Paralisis with induction dengan Ketamin 2 mg/kg +	3	

				Rocuronium 1,2 mg/kg 5) Positioning dan sellick manuver 6) Placement with proof 7) Post intubation management 6. Maintenance Anestesi: - Ventilasi kendali dengan udara tekan 50% dalam oksigen dengan agen anestesi menggunakan Sevofluran 2-3 vol%. - Maintenance analgetik (fentanyl) dan agen pelumpuh otot (rocuronium) sesuai kebutuhan 7. Post operasi: - Pasien diekstubasi sadar penuh - Paska operasi dirawat di ICU - Analgetik paska operasi Paracetamol 100 mg/8 jam (20mg/kg/8jam)		
5.Komunikasi, edukasi dan profesionalisme	Peserta ujian tidak meminta izin secara lisan dan sama sekali tidak melakukan poin berikut: - melakukan setiap tindakan dengan berhati-hati dan teliti sehingga tidak membahayakan pasien dan diri sendiri - memperhatikan kenyamanan pasien - melakukan tindakan sesuai prioritas - menunjukkan rasa hormat kepada pasien - mengetahui keterbatasan dengan merujuk atau melakukan konsultasi bila diperlukan	Meminta izin secara lisan dan 1-2 poin berikut : - melakukan setiap tindakan dengan berhati-hati dan teliti sehingga tidak membahayakan pasien dan diri sendiri - memperhatikan kenyamanan pasien - melakukan tindakan sesuai prioritas - menunjukkan rasa hormat kepada pasien - mengetahui keterbatasan dengan merujuk atau melakukan konsultasi bila diperlukan	Meminta izin secara lisan dan 3 poin berikut: - melakukan setiap tindakan dengan berhati-hati dan teliti sehingga tidak membahayakan pasien dan diri sendiri - memperhatikan kenyamanan pasien - melakukan tindakan sesuai prioritas - menunjukkan rasa hormat kepada pasien - mengetahui keterbatasan dengan merujuk atau melakukan konsultasi bila diperlukan	Meminta izin secara lisan dan melakukan di bawah ini secara lengkap: - melakukan setiap tindakan dengan berhati-hati dan teliti sehingga tidak membahayakan pasien dan diri sendiri - memperhatikan kenyamanan pasien - melakukan tindakan sesuai prioritas - menunjukkan rasa hormat kepada pasien - mengetahui keterbatasan dengan merujuk atau melakukan konsultasi bila diperlukan	3	

	keterbatasan dengan merujuk atau melakukan konsultasi bila diperlukan					
TOTAL SKOR						

II. Global performance
 Beri tanda (√) pada kolom yang disediakan sesuai dengan penilaian Anda secara umum terhadap kemampuan peserta ujian!

Tidak lulus	Borderline	Lulus	Superior

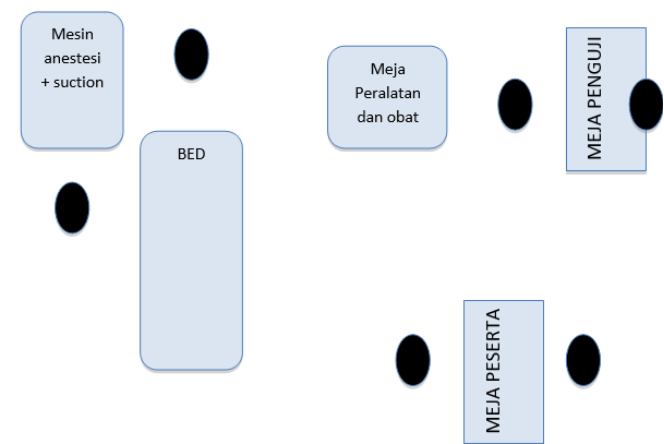
.....
 Penguji,

(.....)

SOAL UJIAN OSCE STATION MANAJEMEN PENYULIT PEDIATRIK

1.	Nomor station	1
2.	Judul stasion	<i>Anestesi umum pada Labiopalatoschizis</i>
3.	Waktu yang dibutuhkan	20 menit
4.	Tujuan station	Menilai kemampuan Preoperative evaluation, Diagnosa, problem potensial – actual, Rencana tindakan anestesi, Keterampilan klinis dan Komunikasi, edukasi dan profesionalisme.
5.	Kompetensi	1. Evaluasi Preoperative 2. Diagnosa dan problem potensial - aktual 3. Rencana tindakan anestesi 4. Keterampilan klinis 5. Monitoring dan manajemen penyulit 6. Manajemen paska bedah 7. Komunikasi, edukasi dan profesionalisme
6.	Kategori	1. Anestesi obstetri 2. Neuroanestesi 3. Anestesi Regional dan Manajemen Nyeri 4. Anestesi Kardiovaskular 5. Anestesi Pediatrik 6. Anestesi Kegawat daruratan 7. Anestesi Urologi 8. Anestesi untuk penyakit Endokrin, metabolic dan penyakit – penyakit khusus 9. ICU 10. Anestesi pada kepala leher
7.	Instruksi untuk peserta ujian	Seorang bayi perempuan berusia 3 bulan, berat badan 6 kg. Didiagnosa dengan Labiopalatoschizis akan dilakukan tindakan Labioplasty. Instruksi untuk peserta : 1. Lakukan evaluasi preoperatif terhadap pasien tersebut 2. Sebutkan Problem potensial dan aktual terhadap pasien tersebut 3. Sebutkan persiapan anestesi pada pasien tersebut 4. Lakukan tindakan intubasi pada pasien tersebut
8.	Instruksi untuk penguji	Seorang bayi perempuan berusia 3 bulan, berat badan 6 kg. Didiagnosa dengan Labiopalatoschizis akan dilakukan tindakan Labioplasty. Instruksi untuk peserta : 1. Lakukan evaluasi preoperatif terhadap pasien tersebut 2. Sebutkan Problem potensial dan aktual terhadap pasien tersebut 3. Sebutkan persiapan anestesi pada pasien tersebut 4. Lakukan tindakan intubasi pada pasien tersebut Instruksi pada penguji <u>INSTRUKSI UMUM</u>

	1. Pastikan identitas peserta ujian pada kartu ujian 2. Tulislah nama dan nomor peserta ujian pada lembar penilaian! 3. Amatilah dan berilah skor (0/1/2/3) atas tugas yang dikerjakan peserta ujian serta skor <i>Global Rating</i> sesuai rubrik penilaian 4. Hindarilah interupsi dan/atau tindakan selain daripada yang diminta dalam instruksi penguji! 5. Berikan informasi/hasil yang dibutuhkan secara lisan/tulisan hanya apabila peserta ujian telah melakukan dan/atau mengusulkan jenis pemeriksaan yang dimaksud (perhatikan instruksi khusus)! 6. Taatilah peraturan serta etika penguji selama menjalankan tugas sebagai penguji OSCE - ATI! <u>INSTRUKSI KHUSUS</u> 1. Penguji mengamati dan menilai evaluasi preoperatif yang dilakukan peserta dan memberikan hasil pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang bila diminta oleh peserta. Peserta ujian menanyakan : – Riwayat kelahiran, makan minum, ispa, tersedak dan sianosis – Riwayat penyakit terdahulu tidak ada – Pemeriksaan fisik : airway clear, Frekuensi nafas 26 x/menit, suara pernafasan vesikuler, Nadi 130 x/menit, Murmur (-), Menangis kuat, Temp 36,8 C – Pemeriksaan penunjang : Darah Rutin : Normal , Foto Thorax : Normal – Informed concent :Tindakan anestesi yang akan dilakukan dan komplikasinya 2. Penguji mengamati dan menilai Problem potensial dan problem actual Problem actual : Difficult Airway Management Problem Potensial : Laringospasm, Bradicardia, Desaturasi 3. Penguji mengamati dan menilai persiapan anestesi pada pasien tersebut Rencana Anestesi : – Puasa 6 jam – Anestesi : General Anestesi sleep apnu atau sleep non apnu – Tehnik Anestesi : Semi Open ETT 2,5 3 3,5 – Premedikasi : Dexamethason 0,1 – 0,5 mg/kg, Atropin 0,01 – 0,02 mg/kg, minimal 0,1 mg – Pelumpuh otot : Atracurium 0,5 mg/kg, Rocuronium 0,6 – 1,2 mg/kg, Vecuronium 0,1 mg/mg – Induksi : Intravena agent, Inhalation agent (Slow Induction) – Pemeliharaan : O2 NO2 Sevoflurane/ Isoflurane/ Halothan – Monitoring : Tanda Vital setiap 5 menit, kedalaman anestesi, perdarahan 4. Penguji mengamati dan menilai tindakan intubasi pada bayi 1. Mencuci tangan dan menggunakan sarung tangan 2. Menyiapkan alat (STATICS), bantal intubasi, alat bantu nafas (Guedel, stylet, dll), memeriksa kondisi mesin anestesi dan mempersiapkan obat-obatan 3. Monitor tanda – tanda vital (Irama ECG, Tekanan darah,
--	--

		Nadi, saturasi oksigen, Respirasi rate) 4. Memeriksa ulang kondisi kemudahan intubasi (Mallampatti, Jarak mento-hyoid, gerak leher) 5. Diberikan (diinstruksikan) obat premedikasi 6. Pasien supine, sniffing position, kepala pasien setinggi processus xiphoideus 7. Gunakan Jacson Rees, buka O₂ 6L/menit untuk preoksigenasi 8. Diberikan (diinstruksikan) obat induksi, bila induksi dengan inhalasi maka FGF = O₂ : N₂O = 3 : 3 L/menit, dipastikan ventilasi positif bisa dilakukan 9. Diberikan (diinstruksikan) obat pelumpuh otot 10. Menunggu onset obat pelumpuh otot sambil dilakukan preoksigenasi 11. Memegang laringoskop dengan tangan kiri, melakukan ekstensi kepala dan memasukkan blade kedalam mulut dari sisi kanan menyisir lidah ke kiri 12. Melihat pita suara secara avue, dan memasukkan ETT dengan tangan kanan dengan smooth 13. Mengembangkan cuff, memastikan suara paru kiri sama dengan kanan 14. Melakukan fiksasi ETT dengan baik 15. Mencuci tangan
9.	Instruksi untuk pasien standar	Ibu pasien yang membawa anaknya ke poli rumah sakit Nama ibu : Ani Nama anak : Wati Usia anak : 3 bulan Berat badan : 6 kg Allo Anamnesis : – Riwayat kelahiran : lahir normal, ditolong bidan, berat badan lahir 2900 gr. – Riwayat penyakit terdahulu : ispa (batuk, pilek), tidak dijumpai – Pasien minum asi, bila minum tidak tersedak
10	Denah ruangan	 Setting Ruang Poli/ Ruang operasi
11	Peralatan yang dibutuhkan	- Setting ruangan dokter pasien - Meja dan kursi dokter 1 set - Kursi pasien 1 buah

		- Meja dan kursi penguji 1 set - Rekam medis 1 buah - Blanko pemeriksaan 1 buah - penunjang 1 buah - Tempat sampah medis 1 buah - tertutup 1 buah - Tempat sampah nonmedis 1 buah - Meja peralatan 1 buah - Bed Pasien 1 buah - Wastafel atau simulasi 1 buah - wastafel 1 buah - Mesin anestesi 1 buah - Monitor 1 buah - Mesin suction 1 buah - Stetoskop 1 buah - Laringoscope 1 buah - Precordial stethoscope 1 buah - Penlight 1 buah - Tissue 1 buah - Jam dinding (dipasang di 1 buah - tembok agar dapat dilihat 1 buah - peserta) 1 buah - Ballpoint 1 buah - Sarung tangan (glove) - Manequine intubasi pediatric - alkohol 70%, kasa atau - kapas, - plester - gunting - nier bekken (bengkok) - Sulfast Atropin 0,25 mg (4 - ampul) - Lidocaine 2 % (3 ampul) - Efedrin 50 mg (1 ampul) - Midazolam 5 mg (1 ampul) - Fentanyl 100 mcg / - Remifentanyl / Morphine 10 - mg / Pethidin 100mg / (2 - ampul) - Propofol 200 mg (1 ampul) - Rocuronium 50 mg atau - atracurium 50 mg (1 ampul), - atau vecuronium 10 mg (1 - ampul). - Neostigmin 0.5 mg/ml - Paracetamol 1 g - ETT 2,5 3 3,5 - Suction cath no sesuai - dengan umur - NG tube no sesuai dengan - umur - Transfusion set atau pediatric - set - Iv cath no disesuaikan - dengan umur
--	--	---

		- Opsite infus - 3 way stop cock - Isoflurane / Sevoflurane (1 botol) - Laringoskop 1 buah - Oropharing 1 buah - Sungkup muka - Jackson Rees breathing circuit
12	Penulis	Tim Item Soal OSCE ATI
13	Referensi	Morgan: clinical of anesthesiology edisi V

RUBRIK ACTUAL MARK
STATION PEDIATRIK

I. Rubrik Penilaian

Aspek yang Dinilai	0	1	2	3	Bobot	Skor
1.Preoperatif Evaluation	Peserta ujian tidak melakukan tindakan Atau melakukan tetapi tidak sesuai perintah Atau melakukan tetapi tidak sesuai masalah klinik pasien atau tidak melakukan pemeriksaan fisik	Peserta ujian menyebutkan 2 dari 4 point	Peserta ujian menyebutkan 3 dari 4 point	Peserta ujian menanyakan dan melakukan pemeriksaan klinis terhadap: 1. Riwayat kelahiran, makan minum, ispa dan tersedak 2. Riwayat penyakit terdahulu 3. Pemeriksaan fisik : airway clear, RR 26 x/i vesikuler, Nadi 130 x/i, Menangis kuat, Temp 36,8 C 4. Pemeriksaan penunjang : Darah Rutin : Normal Foto Thorax : Normal	2	
2.Diagnosa Problem potensial - actual	Peserta tidak menyebutkan problem	--	Peserta menyebutkan hanya salah satu problem	Problem aktual : Difficult Airway Management Problem Potensial : Laringospasm, Bradicardia, Desaturasi	2	
3.Rencana tindakan Anestesi	Peserta ujian tidak melakukan tindakan Atau melakukan tetapi tidak sesuai perintah Atau melakukan tetapi tidak sesuai masalah klinik pasien	--	Peserta menjelaskan rencana anestesi yang sesuai masalah klinik pasien Tetapi Tidak lengkap	Peserta menjelaskan rencana anestesi sesuai masalah klinik pasien. Rencana Anestesi : – Puasa 6 jam – Anestesi : General Anestesi sleep apnu atau sleep non apnu – Tehnik Anestesi : Semi Closed ETT 2,5 3 3,5 – Premedikasi : Dexamethason 0,1 – 0,5 mg/kg, Atropin 0,01 – 0,02 mg/kg, minimal 0,1 mg – Pelumpuh otot : Atracurium 0,5 mg/kg, Rocuronium 0,6 – 1,2 mg/kg, Vecuronium 0,1	3	

				mg/mg – Induksi : Intravena agent, Inhalation agent – Pemeliharaan : O ₂ NO ₂ Sevoflurane, Isoflurane, Halothan – Monitoring : Tanda Vital setiap 5 menit, kedalaman anestesi, perdarahan		
4. Keterampilan klinis	Peserta ujian tidak melakukan tindakan Atau melakukan tetapi tidak sesuai perintah Atau melakukan tetapi tidak sesuai masalah klinik pasien	--	Peserta ujian melakukan tindakan yang sesuai masalah klinik pasien Tetapi Tidak lengkap	Peserta ujian melakukan tindakan yang sesuai masalah klinik pasien Intubasi : 1. Mencuci tangan dan menggunakan sarung tangan 2. Menyiapkan alat (STATICS), 3. Monitor tanda – tanda vital 4. Memeriksa ulang kondisi kemudahan intubasi 5. Diberikan obat premedikasi 6. Pasien supine, sniffing position, kepala pasien setinggi processus xiphoideus 7. Gunakan Jacson Rees, buka O ₂ 6L/menit untuk preoksigenasi 8. Diberikan (diinstruksikan) obat induksi, bila induksi dengan inhalasi maka FGF = O ₂ : N ₂ O = 3 : 3 L/menit, dipastikan ventilasi positif bisa dilakukan 9. Diberikan (diinstruksikan) obat pelumpuh otot 10. Menunggu onset obat pelumpuh otot sambil dilakukan preoksigenasi 11. Memegang laringoskop dengan tangan kiri, melakukan ekstensi kepala dan memasukkan blade kedalam mulut dari sisi kanan menyisir lidah ke kiri 12. Melihat pita suara secara avue,	3	

				dan memasukkan ETT dengan tangan kanan dengan smooth 13. Mengembangkan cuff, memastikan suara paru kiri sama dengan kanan 14. Melakukan fiksasi ETT dengan baik 15. Mencuci tangan		
5.Komunikasi, edukasi dan profesionalisme	Peserta ujian tidak meminta izin secara lisan dan sama sekali tidak melakukan poin berikut: 1. melakukan setiap tindakan dengan berhati-hati dan teliti sehingga tidak membahayakan pasien dan diri sendiri 2. memperhatikan kenyamanan pasien 3. melakukan tindakan sesuai prioritas 4. menunjukkan rasa hormat kepada pasien 5. mengetahui keterbatasan dengan merujuk atau melakukan konsultasi bila diperlukan	Meminta izin secara lisan dan 1-2 poin berikut : 1. melakukan setiap tindakan dengan berhati-hati dan teliti sehingga tidak membahayakan pasien dan diri sendiri 2. memperhatikan kenyamanan pasien 3. melakukan tindakan sesuai prioritas 4. menunjukkan rasa hormat kepada pasien 5. mengetahui keterbatasan dengan merujuk atau melakukan konsultasi bila diperlukan	Meminta izin secara lisan dan 3 poin berikut: 1. melakukan setiap tindakan dengan berhati-hati dan teliti sehingga tidak membahayakan pasien dan diri sendiri 2. memperhatikan kenyamanan pasien 3. melakukan tindakan sesuai prioritas 4. menunjukkan rasa hormat kepada pasien 5. mengetahui keterbatasan dengan merujuk atau melakukan konsultasi bila diperlukan	Meminta izin secara lisan dan melakukan di bawah ini secara lengkap: 1. melakukan setiap tindakan dengan berhati-hati dan teliti sehingga tidak membahayakan pasien dan diri sendiri 2. memperhatikan kenyamanan pasien 3. melakukan tindakan sesuai prioritas 4. menunjukkan rasa hormat kepada pasien 5. mengetahui keterbatasan dengan merujuk atau melakukan konsultasi bila diperlukan	3	
TOTAL SKOR						

II. Global performance

Beri tanda (✓) pada kolom yang disediakan sesuai dengan penilaian Anda secara umum terhadap kemampuan peserta ujian!

Tidak lulus	Borderline	Lulus	Superior

.....,
Penguji,

(.....)

SOAL UJIAN OSCE STATION MANAJEMEN PENYULIT PEDIATRIK

1.	Nomor station	7
2.	Judul stasion	Anestesi Pediatrik – Anestesi Pada Trakheoesofageal fistula
3.	Waktu yang dibutuhkan	17 menit
4.	Tujuan station	Menilai kemampuan Evaluasi Pra Anestesia, Diagnosis Dan Problem Aktual – Potensial, Rencana Tindakan Anestesi, Keterampilan Klinis, melakukan komunikasi dan edukasi pasien serta berperilaku profesional
5.	Kompetensi	Evaluasi Pra Anestesia Diagnosis Dan Problem Aktual – Potensial Rencana Tindakan Anestesi Keterampilan Klinis - Monitoring dan manajemen penyulit - Manajemen Pasca Anestesia Komunikasi, Edukasi Dan Profesionalisme
6.	Kategori	- Anestesia Obstetrik - Anestesia Bedah Saraf - Anestesia Regional Dan Manajemen Nyeri - Anestesia Bedah Toraks Anestesia Pediatrik - Anestesia Kegawatdaruratan - Anestesia Urologi - Anestesia Untuk Penyakit Khusus (Endokrin, Metabolik, Penyulit Kardiovaskular) - Anestesia Bedah Kepala Leher - Anestesia Bedah Rawat Jalan / Luar Kamar Bedah - Anestesia Pada Prosedur Invasif Minimal - Terapi Intensif
7.	Instruksi untuk peserta ujian	<u>SKENARIO KLINIK:</u> Bayi usia 5 hari berat badan 3 kg akan direncanakan operasi repair Trakheoesofageal fistula type C. <u>INSTRUKSI PESERTA:</u> - Lakukan evaluasi pra anestesi untuk pasien ini! - Tentukan problem aktual dan problem potensial durante operasi untuk pasien ini! - Tentukan tatalaksana pra operasi untuk pasien ini - Lakukan tata laksana induksi anestesi pada pasien ini!
8.	Instruksi untuk penguji	<u>INSTRUKSI UMUM</u> - Pastikan identitas peserta ujian pada kartu ujian - Tulislah nama dan nomor peserta ujian pada lembar penilaian! - Amatilah dan berilah skor (0/1/2/3) atas tugas yang dikerjakan peserta ujian serta skor <i>Global Rating</i> sesuai rubrik penilaian - Hindarilah interupsi dan/atau tindakan selain daripada yang diminta dalam instruksi penguji! - Berikan informasi/hasil yang dibutuhkan secara lisan/tulisan hanya apabila peserta ujian telah melakukan dan/atau mengusulkan jenis pemeriksaan yang dimaksud (perhatikan instruksi khusus)!

	6. Taatilah peraturan serta etika penguji selama menjalankan tugas sebagai penguji OSCE - ATI! <u>INSTRUKSI KHUSUS :</u> 1. Penguji mengamati dan menilai evaluasi pra anestesia yang dilakukan peserta dan memberikan hasil pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang bila diminta oleh peserta. Anamnese : Alergi (-), Medication (-), Past illness (-), Last meal pasien dipuaskan, Event (-) Pasien lahir aterm spontan pervaginam. Sejak lahir pasien tidak dapat minum susu, ngiler, dan sering tersedak. Tidak ada riwayat "biru" (cyanosis) bila menangis, riwayat kuning (-) Riwayat buang air besar meconial (+) Buang air kecil (+) normal Pemeriksaan fisik : Tanda Vital : Kesadaran <i>Alert</i>, Tekanan Darah 65/40 mmHg, Laju Nadi 140x/mnt, frekuensi nafas 45x/mnt, suhu 36,5°C, nyeri (-) Kepala : nafas cuping hidung (+), <i>drooling</i> (+), terpasang orogastric tube Leher: Tidak ada kelainan Toraks : retraksi (-), <i>vertebra</i> normal, suara nafas vesikuler (+/+) Rhonki (-/-) Wheezing (-/-), suara jantung normal, murmur(-) Abdomen : abdomen sedikit distensi, <i>anorectal</i> dalam batas normal Ekstremitas : akral hangat, sianosis (-) Sistem muskuloskeletal : <i>Vertebra</i> normal, <i>ekstrimitas atas dan bawah</i> normal Pemeriksaan Penunjang: • Darah Rutin: Hb 13 gr%, Ht 41%, WBC 18000/mm³, Plt 350.000/mm³ • Faal Hemostasis: PPT12,0 (12,2), APTT 30,8 (30,7) • Bun (Ureum): 30 mg/dl, Creatinin 0,4 mg/dl • Na 136 mmol/L, Kalium 3,8 mmol/L, Cl 99 mmol/L • Faal Hati: AST 30, ALT 22, albumin 4,0 • Glukosa 120 mg/dl • AGD : pH 7.31; pCO₂ 41; pO₂ 137 HCO₃ 20.2 BE -6.2 • Ro Thorax : Terlampir • Echocardiography : dalam batas normal Pemeriksaan VACTERL: Melakukan anamnesa, pemeriksaan fisik, dan penunjang terkait kelainan VACTERL : • Vertebra • Anus • Cardiac • Trachea • Esophagus • Renal • Limb
--	--

		2. Penguji menilai peserta menyebutkan problem aktual dan problem potensial durante operasi dengan lengkap dan benar. Aktual problem: 1. Neonatus 2. Posisi lateral dekubitus 3. Penekanan parenkim paru Potensial problem: 1. Aspirasi 2. Hipoksia / desaturasi akibat penekanan paru 3. Dislodge ETT akibat posisi pembedahan 4. Hypothermia 3. Penguji menilai peserta menyebutkan tatalaksana pra operasi untuk pasien dengan tepat dan benar. Prinsip – prinsip tata laksana pra operasi trakeoesophageal fistula 1. Pasien dipuasakan 2. Pasien diposisikan <i>upright</i> (kepala lebih tinggi) 3. Lendir mulut dan oropharing dihisap secara berkala 4. Pemberian antibiotik bila didapatkan pneumonia 4. Tata laksana induksi anestesi pada pasien dengan TEF 1. Persiapan STATIC, menyiapkan obat anestesi yang diperlukan, mengecek mesin anestesi dan alat monitor pasien, memakai alat pelindung diri (minimal handschoen) 2. Melakukan suction aktif lendir di mulut dan oropharing dan melalui orogastric tube 3. Pasien diposisikan upright (kepala lebih tinggi) (Penguji menginstruksikan laboran memberikan bantal untuk memposisikan kepala lebih tinggi bila peserta menyebutkan posisi intubasi kepala lebih tinggi / head up) 4. Melakukan intubasi secara awake atau dengan pemberian sedasi 5. ETT diposisikan diantara karina dan fistula di insersikan 5. Penguji menilai profesionalisme peserta.
9	Tata letak ruangan	Model ruang Operasi
10	Kebutuhan Laboran	Jumlah Laboran: 1 Tugas: Sebagai perawat, membantu peserta dalam melakukan persiapan dan tindakan intubasi. Memberikan bantal untuk memposisikan kepala lebih tinggi bila peserta menyebutkan posisi intubasi kepala lebih tinggi (head up)
11	Peralatan yang dibutuhkan	- Peralatan ruang operasi - Mesin anestesi atau peraga mesin anestesi - Manequine bayi full body yang dapat diintubasi 1 buah - Bantal untuk memposisikan kepala manekin lebih tinggi 1 buah - Laringoskop blade 0, 1, @1 buah - ETT 2.5; 3.0; 3.5 @ 1 buah

		- Stetoskop 1 buah - Tensimeter infant 1 buah - Pen light 1 buah - Thermometer 1 buah - Nasogastric tube no,8/10 @1 buah - Sarung tangan tidak steril 1 box - Sput berlabel - Pentotal 1 buah - Propofol 1 buah - Fentanyl 1 buah - Lidokain 2% 1 buah - Rocuronium 1 buah - Sput cuff 1 buah - - Suction cateter no 6, 8 @1 buah - Mesin suction 1 buah - Oropharing no 00 dan 0 @1 buah - Sungkup muka no 1 @1 buah - AMBU infant 1 buah - Jackson Reese 1 buah
12	Kebutuhan manekuin	Manekuin bayi full body terpasang orogastric tube no 6/8 yang dapat di intubasi
13	Penulis	Tim OSCE ATI
14	Reviwer	Tim Review OSCE ATI
15	Referensi	- Morgan: clinical of anesthiology edisi V - Smith Anesthesia for Infant and children eight edition

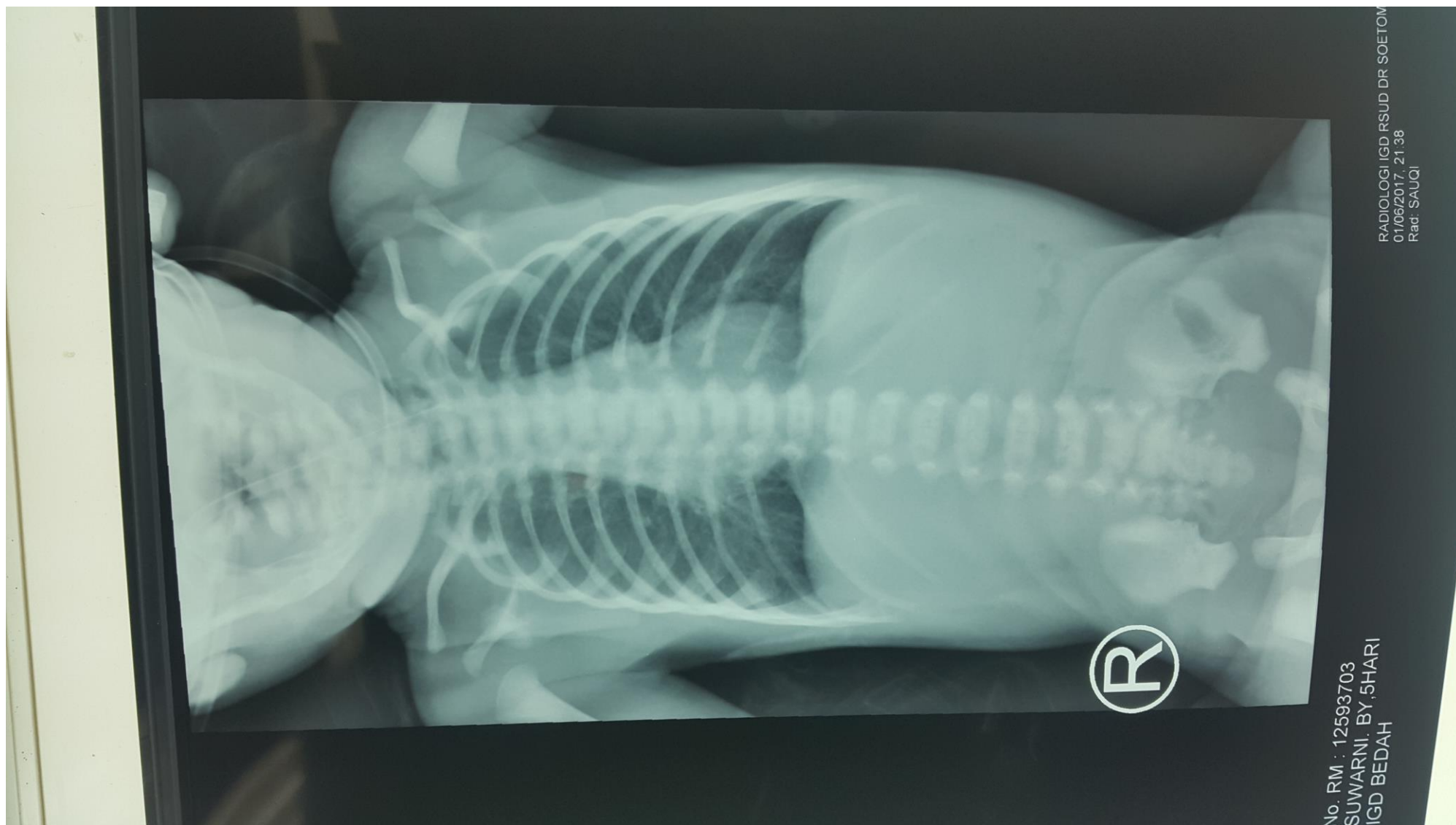
**RUBRIK ACTUAL MARK
STATION ANESTESI PEDIATRIK**

I. Rubrik Penilaian

Aspek yang Dinilai	0	1	2	3	Bobot	Skor
1. Evaluasi pra anestesia Peserta mampu melakukan evaluasi pra anestesia dengan benar dan lengkap yang meliputi: 1. Melakukan anamnese AMPLE dan pemeriksaan fisik 2. Melakukan pemeriksaan khusus kelainan VACTERL	Peserta tidak mampu melakukan poin 1 dan 2 evaluasi pra anestesia dengan benar dan lengkap	Peserta hanya mampu melakukan poin 1 evaluasi pra anestesia, namun tidak lengkap	Peserta mampu melakukan poin 1 evaluasi pra anestesia, dengan benar dan lengkap namun tidak melakukan poin 2 evaluasi pra anestesia, dengan benar dan lengkap	Peserta mampu melakukan poin 1 dan 2 evaluasi pra anestesia dengan benar dan lengkap	2	
2. Diagnosis Dan Problem Aktual – Potensial Peserta mampu menyebutkan problem aktual dan potensial selama tindakan anestesi : Aktual problem: 1. Neonatus 2. Posisi lateral dekubitus 3. Penekanan parenkim paru Potensial problem: 1. Aspirasi 2. Hipoksia / desaturasi akibat penekanan paru 3. Dislodge ETT akibat posisi pembedahan 4. Hypothermia	Peserta tidak mampu problem aktual dan potensial selama tindakan anestesi.	Peserta hanya mampu menyebutkan 1 - 3 item problem aktual dan potensial selama tindakan anestesi.	Peserta hanya mampu menyebutkan 4 - 6 item problem aktual dan potensial selama tindakan anestesi.	Peserta mampu menyebutkan 7 poin problem aktual dan potensial durante tindakan anestesi :	2	

3. Rencana Tindakan Anestesi Peserta menyebutkan prinsip tata laksana pra operasi trakeoesophageal fistula yang meliputi: 1. Pasien dipuasakan 2. Pasien diposisikan <i>upright</i> (kepala lebih tinggi) 3. Lendir mulut dan oropharing dihisap secara berkala 4. Pemberian antibiotik bila didapatkan pneumonia	Peserta tidak mampu menyebutkan tatalaksana pra operasi untuk pasien dengan tepat dan benar	Peserta hanya mampu menyebutkan 1 poin tatalaksana pra operasi untuk pasien dengan tepat dan benar	Peserta hanya mampu menyebutkan 2 - 3 poin tatalaksana pra operasi untuk pasien dengan tepat dan benar	Peserta menyebutkan empat poin tatalaksana pra operasi untuk pasien dengan tepat dan benar	2	
4. Keterampilan klinis Peserta melakukan tata laksana induksi anestesi pada pasien dengan TEF meliputi : 1. Persiapan STATIC, menyiapkan obat anestesi yang diperlukan, 2. Melakukan suction aktif lendir di mulut dan oropharing dan melalui orogastric tube 3. Pasien diposisikan upright (kepala lebih tinggi) 4. Melakukan intubasi secara awake atau dengan pemberian sedasi 5. ETT diposisikan diantara karina dan fistula di insersikan	Peserta tidak melakukan tata laksana induksi anestesi pada pasien dengan TEF dengan lengkap	Peserta melakukan 1 - 2 poin tata laksana induksi anestesi pada pasien dengan TEF dengan lengkap	Peserta melakukan 3 - 4 poin tata laksana induksi anestesi pada pasien dengan TEF dengan lengkap	Peserta melakukan 5 poin tata laksana induksi anestesi pada pasien dengan TEF dengan lengkap	3	
7. Komunikasi dan edukasi (konseling) pasien Profesional Meminta izin secara lisan dan melakukan di bawah ini secara lengkap:	Peserta ujian tidak meminta izin secara lisan dan sama sekali tidak	Meminta izin secara lisan dan 1-2 point	Meminta izin secara lisan dan 3-4 point.	Meminta izin secara lisan dan melakukan di komunikasi, edukasi dan	1	

1. melakukan setiap tindakan dengan berhati-hati dan teliti sehingga tidak membahayakan pasien dan diri sendiri 2. memperhatikan kenyamanan pasien 3. melakukan tindakan sesuai prioritas 4. menunjukkan rasa hormat kepada pasien 5. mengetahui keterbatasan dengan merujuk atau melakukan konsultasi bila diperlukan	melakukan poin profesionalisme			profesionalisme ini secara lengkap.		
TOTAL SKOR						



SOAL UJIAN OSCE STATION MANAJEMEN PENYULIT PEDIATRIK

VOLVULUS (INTUBASI) – KASUS 1

1.	Nomor station	10
2.	Judul station	Volvulus pada anak - intubasi
3.	Waktu yang dibutuhkan	17 menit
4.	Tujuan station	Menilai kemampuan, menganalisa problem aktual – potensial, Rencana tindakan anestesi, Keterampilan klinis dan Komunikasi, edukasi dan profesionalisme.
5.	Kompetensi	Evaluasi Pra Anestesia Diagnosis Dan Problem Aktual – Potensial Rencana Tindakan Anestesi Keterampilan Klinis - Monitoring dan manajemen penyulit - Manajemen Pasca Anestesia Komunikasi, Edukasi Dan Profesionalisme
6.	Kategori	- Anestesia Obstetrik - Anestesia Bedah Saraf - Anestesia Regional Dan Manajemen Nyeri - Anestesia Bedah Toraks Anestesia Pediatrik - Anestesia Kegawatdaruratan - Anestesia Urologi - Anestesia Untuk Penyakit Khusus (Endokrin, Metabolik, Penyulit Kardiovaskular) - Anestesia Bedah Kepala Leher - Anestesia Bedah Rawat Jalan / Luar Kamar Bedah - Anestesia Pada Prosedur Invasif Minimal - Terapi Intensif
7.	Instruksi untuk peserta ujian	<u>Skenario klinik</u> : Anak laki-laki umur 3 bulan Berat Badan 5 kg didiagnosis Volvulus akan dilakukan operasi darurat. <u>Instruksi peserta</u> : - Lakukan evaluasi pra anestesi pada pasien tersebut! - Sebutkan problem aktual dan potensial pada pasien ini! - Sebutkan persiapan anestesi pada pasien ini! - Lakukan tindakan intubasi pada pasien ini!
8.	Instruksi untuk penguji	<u>INSTRUKSI UMUM</u> - Pastikan identitas peserta ujian pada kartu ujian - Tulislah nama dan nomor peserta ujian pada lembar penilaian! - Amatilah dan berilah skor (0/1/2/3) atas tugas yang dikerjakan peserta ujian serta skor <i>Global Rating</i> sesuai rubrik penilaian - Hindarilah interupsi dan/atau tindakan selain daripada yang diminta dalam instruksi penguji! - Berikan informasi/hasil yang dibutuhkan secara lisan/tulisan hanya apabila peserta ujian telah melakukan dan/atau mengusulkan jenis pemeriksaan yang dimaksud (perhatikan instruksi khusus)! - Taatilah peraturan serta etika penguji selama menjalankan tugas sebagai penguji OSCE - ATI! <u>INSTRUKSI KHUSUS</u> - Penguji mengamati dan menilai evaluasi pra anestesi yang dilakukan peserta dan memberikan hasil pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang bila diminta oleh peserta. Anamnesis: A : riwayat alergi / asthma (-)

		M : - P : - L : makan minum terakhir 12 jam E : Muntah setiap minum ASI sejak 1 hari ini, sejak 12 jam terakhir pasien tidak mau menetek, tampak lemas Vital sign : frekuensi napas 40 x/menit, denyut nadi 160 x/menit teraba kuat tekanan darah 60/40 mmHg, suhu 38⁰ C Sistem respirasi : Jalan nafas bebas, retraksi (-), gerak dada simetris, suara nafas vesikuler, ronkhi -/- wheezing -/-, SpO2 97% (oksigen 21%) Sistem kardiovaskuler : akral dingin, capillary refill time >2 detik, mata cekung, bibir kering, turgor menurun, Sistem syaraf pusat : kesadaran somnolen Sistem Urogenital : Pasien belum buang air kecil sejak 4 jam yang lalu Sistem digestif : abdomen <i>slight distended</i>, bising usus meningkat – Pemeriksaan penunjang : Darah Rutin : Normal, Serum elektrolit : Natrium 130 mEq/L, Kalium 3.0 mEq/L, Chlorida 90 mEq/L Pemeriksaan penunjang lain dalam batas normal 2. Penguji menilai peserta menyebutkan problem aktual – potensial Problem aktual : dehidrasi, pasien pediatrik Problem Potensial : aspirasi, laringospasm, desaturasi, Bradicardia 3. Penguji menilai peserta menyebutkan persiapan anestesi pada pasien. Persiapan Anestesia : 1. Puasa 2. Pemasangan NGT dan suction aktif 3. Rehidrasi cepat dengan Kristaloid 20 ml/kg selama 30 – 60 menit dan dapat diulang bila belum ada perbaikan hemodinamik. Dilanjutkan dengan rehidrasi lambat 4. Pemasangan kateter urin 5. Anestesia : General Anestesia sleep apnu atau sleep non apnu 4. Penguji mengamati dan menilai tindakan intubasi yang dilakukan peserta. Intubasi pada pediatrik : 1. Peserta memakai sarung tangan non steril 2. Peserta menyiapkan peralatan intubasi (STATICS): a. laringoskop dan stetoskop b. ETT dengan 3 ukuran (ID 4, 4,5 dan 5) c. Oropharyngeal airway d. plester e. Introducer f. Connector g. Suction berfungsi baik 3. Peserta menyiapkan obat anestesi yang diperlukan 4. Pasien memposisikan pasien <i>head up position</i> minimal 30° 5. Memberikan preoksigenasi dengan O2 100% selama 3 – 5 menit 6. Peserta menggunakan obat hipnotik – sedatif untuk induksi dengan agen intravena, pelumpuh otot kerja cepat (Rocuronium 1,2 mg/kgbb, tidak menggunakan Suksinilkolin)
--	--	--

		7. Peserta tidak memberikan ventilasi tekanan positif 8. Peserta melakukan intubasi setelah pelumpuh otot bekerja 9. Peserta menyambungkan connector ETT dengan sirkuit anestesi 10. Peserta melakukan konfirmasi posisi ETT 11. Fiksasi plester	
9	Instruksi untuk pasien standar	Nama ibu : Sesuai PS Nama anak : Budi Jenis kelamin : laki – laki Usia anak : 3 bulan Berat badan : 5 kg Anamnese Muntah setiap minum ASI sejak 1 hari ini, sejak 12 jam terakhir pasien tidak mau menetek, tampak lemas. Anaknya juga mempunyai riwayat Riwayat alergi / asthma (-). makan minum terakhir 12 jam yang lalu. Bayi cenderung mengantuk tidak mau menghisap ASI. Tidak kontak lg dengan ibunya. Belum ada buang air kecil 4 jam ini. Tangan bayi dingin. Kepala demam. Peran : PS memerankan ibu duduk di kursi pasien dan menampilkan ekspresi cemas dan bertanya bagaimana kondisi anaknya.	
10	Tata letak station	Model Kamar operasi	
11	Peralatan yang dibutuhkan	- peralatan kamar operasi - Manequine intubasi infant - Laringoskop blade 1 - ETT 2.5, 3.0, 3.5, Sputit berlabel - Sulfast Atropin 0,25 mg - Midazolam 5 mg - Fentanyl / Remifentanyl / Morphine / Pethidin - Propofol - Relaxan - Suction cath no 10 - Oropharing no 1 dan 2 - Sungkup muka no 1, 2 - Jackson Rees breathing circuit	1 set 1 buah 1 buah @ 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah @1 buah @1 buah 1 buah
12	Kebutuhan manikin	Manekin infant untuk intubasi	
13	Penulis	Tim Soal OSCE ATI	
14	Referensi	Morgan clinical Anesthesia	

**RUBRIC ACTUAL MARK
STATION PEDIATRIK**

Aspek yang Dinilai	0	1	2	3	Bobot	Skor
1. Preoperatif Evaluation	Peserta ujian tidak melakukan pemeriksaan pra anestesi	Peserta ujian hanya melakukan 1 (satu) item pemeriksaan pra anestesi	Peserta ujian hanya melakukan 2 (dua) item pemeriksaan pra anestesi	Peserta ujian melakukan pemeriksaan pra anestesi yang meliputi 1. Anamnesa AMPLE 2. Pemeriksaan fisik 3. Pemeriksaan penunjang	2	
2. Diagnosa Problem aktual potensial	Peserta tidak menyebutkan problem	Peserta menyebutkan hanya menyebutkan minimal 2 item dari problem	Peserta menyebutkan hanya menyebutkan minimal 3 item dari problem	Peserta dapat menyebutkan minimal 5 problem pada pasien. Problem aktual : 1. Dehidrasi 2. pasien pediatrik Problem Potensial : 3. aspirasi, 4. laringospasm, 5. desaturasi, 6. Bradicardia	2	
3. Rencana tindakan Anestesi	Peserta ujian tidak melakukan tindakan Atau melakukan tetapi tidak sesuai perintah Atau melakukan tetapi tidak sesuai masalah klinik pasien	peserta ujian dapat menyebutkan minimal 2 item dari rencana tindakan anestesi	peserta ujian dapat menyebutkan minimal 3 item dari rencana tindakan anestesi	peserta ujian dapat menyebutkan minimal 4 item dari rencana tindakan anestesi Rencana Anestesi : 1. Puasa 2. Pemasangan NGT dan suction aktif 3. Rehidrasi cepat dengan Kristaloid 20 ml/kg selama 30 – 60 menit dan dapat diulang bila belum ada perbaikan hemodinamik. Dilanjutkan dengan rehidrasi lambat	2	

				4. Pemasangan kateter urin 5. Anestesi : General Anestesi sleep apnu atau sleep non apnu		
4. Keterampilan klinis	Peserta ujian tidak melakukan tindakan Atau melakukan tetapi tidak sesuai perintah Atau melakukan tetapi tidak sesuai masalah klinik pasien	--	Peserta melakukan tindakan anestesi dengan tidak lengkap atau lengkap namun tidak runut (termasuk di dalamnya poin nomor 2,5,6,7,10)	Peserta mampu melakukan tindakan intubasi dengan lengkap dan runut 1. Peserta memakai sarung tangan non steril 2. Peserta menyiapkan peralatan intubasi (STATICS) 3. Peserta menyiapkan obat anestesi yang diperlukan 4. Pasien memposisikan pasien <i>head up position</i> minimal 30° 5. Memberikan preoksigenasi dengan O2 100% selama 3 – 5 menit 6. Peserta menggunakan obat hipnotik – sedatif untuk induksi dengan agen intravena, pelumpuh otot kerja cepat (Rocuronium 1,2 mg/kgbb, tidak menggunakan Suksinilkolin) 7. Peserta tidak memberikan ventilasi tekanan positif 8. Peserta melakukan intubasi setelah	3	

				pelumpuh otot bekerja 9. Peserta menyambungkan connector ETT dengan sirkuit anestesi 10. Peserta melakukan konfirmasi posisi ETT 11. Fiksasi plester		
7. Komunikasi, edukasi dan profesionalisme	Peserta ujian tidak meminta izin secara lisan dan sama sekali tidak melakukan poin berikut: 1. melakukan setiap tindakan dengan berhati-hati dan teliti sehingga tidak membahayakan pasien dan diri sendiri 2. memperhatikan kenyamanan pasien 3. melakukan tindakan sesuai prioritas 4. menunjukkan rasa hormat kepada pasien mengetahui keterbatasan dengan merujuk atau melakukan konsultasi bila diperlukan	Meminta izin secara lisan dan 1-2 poin berikut : 1. melakukan setiap tindakan dengan berhati-hati dan teliti sehingga tidak membahayakan pasien dan diri sendiri 2. memperhatikan kenyamanan pasien 3. melakukan tindakan sesuai prioritas 4. menunjukkan rasa hormat kepada pasien mengetahui keterbatasan dengan merujuk atau melakukan konsultasi bila diperlukan	Meminta izin secara lisan dan 3 poin berikut: 1. melakukan setiap tindakan dengan berhati-hati dan teliti sehingga tidak membahayakan pasien dan diri sendiri 2. memperhatikan kenyamanan pasien 3. melakukan tindakan sesuai prioritas 4. menunjukkan rasa hormat kepada pasien mengetahui keterbatasan dengan merujuk atau melakukan konsultasi bila diperlukan	Meminta izin secara lisan dan melakukan di bawah ini secara lengkap : 1. melakukan setiap tindakan dengan berhati-hati dan teliti sehingga tidak membahayakan pasien dan diri sendiri 2. memperhatikan kenyamanan pasien 3. melakukan tindakan sesuai prioritas 4. menunjukkan rasa hormat kepada pasien mengetahui keterbatasan dengan merujuk atau melakukan konsultasi bila diperlukan	1	
TOTAL SKOR						

SOAL UJIAN OSCE STATION MANAJEMEN PENYULIT PEDIATRIK

VOLVULUS (INTUBASI) – KASUS 2

1.	Nomor station	2
2.	Judul station	Volvulus pada anak - intubasi
3.	Waktu yang dibutuhkan	17 menit
4.	Tujuan station	Menilai kemampuan, menganalisa problem aktual – potensial, Rencana tindakan anestesi, Keterampilan klinis dan Komunikasi, edukasi dan profesionalisme.
5.	Kompetensi	Evaluasi Pra Anestesia Diagnosis Dan Problem Aktual – Potensial Rencana Tindakan Anestesi Keterampilan Klinis - Monitoring dan manajemen penyulit - Manajemen Pasca Anestesia Komunikasi, Edukasi Dan Profesionalisme
6.	Kategori	- Anestesia Obstetrik - Anestesia Bedah Saraf - Anestesia Regional Dan Manajemen Nyeri - Anestesia Bedah Toraks Anestesia Pediatrik - Anestesia Kegawatdaruratan - Anestesia Urologi - Anestesia Untuk Penyakit Khusus (Endokrin, Metabolik, Penyulit Kardiovaskular) - Anestesia Bedah Kepala Leher - Anestesia Bedah Rawat Jalan / Luar Kamar Bedah - Anestesia Pada Prosedur Invasif Minimal - Terapi Intensif
7.	Instruksi untuk peserta ujian	<u>SKENARIO KLINIK :</u> Bayi laki-laki umur 3 bulan Berat Badan 5 kg didiagnosis Volvulus akan dilakukan operasi darurat. <u>INSTRUKSI PESERTA :</u> - Lakukan evaluasi pra anestesi pada pasien tersebut! - Sebutkan problem aktual dan potensial pada pasien ini! - Sebutkan persiapan dan rencana tindakan anestesi pada pasien ini! - Lakukan tindakan intubasi pada pasien ini!
8.	Instruksi untuk penguji	<u>INSTRUKSI UMUM</u> - Pastikan identitas peserta ujian pada kartu ujian - Tulislah nama dan nomor peserta ujian pada lembar penilaian! - Amatilah dan berilah skor (0/1/2/3) atas tugas yang dikerjakan peserta ujian serta skor <i>Global Rating</i> sesuai rubrik penilaian - Hindarilah interupsi dan/atau tindakan selain daripada yang diminta dalam instruksi penguji! - Berikan informasi/hasil yang dibutuhkan secara lisan/tulisan hanya apabila peserta ujian telah melakukan dan/atau mengusulkan jenis pemeriksaan yang dimaksud (perhatikan instruksi khusus)! - Taatilah peraturan serta etika penguji selama menjalankan tugas sebagai penguji OSCE - ATI! <u>INSTRUKSI KHUSUS</u> - Penguji mengamati dan menilai evaluasi pra anestesi yang dilakukan peserta dan memberikan hasil pemeriksaan fisik dan

		pemeriksaan penunjang bila diminta oleh peserta. Dan penguji memberikan lembar anamnesis kepada peserta. Anamnesis: A : riwayat alergi / asthma (-) M : - P : - L : makan minum terakhir 12 jam E : Muntah setiap minum ASI sejak 1 hari ini, sejak 12 jam terakhir pasien tidak mau menetek, tampak lemas Vital sign : frekuensi napas 40 x/menit, denyut nadi 160 x/menit tidak kuat angkat, tekanan darah 60/40 mmHg, suhu 38⁰ C Sistem respirasi : Jalan nafas bebas, retraksi (-), gerak dada simetris, suara nafas vesikuler, ronkhi -/- wheezing -/-, SpO2 97% (oksigen 21%) Sistem kardiovaskuler : akral dingin, capillary refill time >2 detik, mata cekung, bibir kering, turgor menurun, Sistem syaraf pusat : kesadaran somnolen Sistem Urogenital : Pasien belum buang air kecil sejak 4 jam yang lalu Sistem digestif : abdomen <i>slight distended</i>, bising usus meningkat – Pemeriksaan penunjang : Darah Rutin : Normal, Serum elektrolit : Natrium 140 mEq/L, Kalium 3.0 mEq/L, Chlorida 90 mEq/L Pemeriksaan penunjang lain dalam batas normal 2. Penguji menilai peserta menyebutkan problem aktual – potensial Problem aktual : dehidrasi, pasien pediatrik Problem Potensial : aspirasi, laringospasm, desaturasi, Bradicardia 3. Penguji menilai peserta menyebutkan persiapan anestesi pada pasien. Persiapan Anestesia : 1. Puasa 2. Pemasangan NGT dan suction aktif 3. Rehidrasi cepat dengan Kristaloid 20 ml/kg selama 30 – 60 menit dan dapat diulang bila belum ada perbaikan hemodinamik. Dilanjutkan dengan rehidrasi lambat 4. Pemasangan kateter urin 5. Anestesia : General Anestesia sleep apnu atau sleep non apnu 4. Penguji mengamati dan menilai tindakan intubasi yang dilakukan peserta. Intubasi pada pediatrik : 1. Peserta memakai sarung tangan non steril 2. Peserta menyiapkan peralatan intubasi (STATICS): a. laringoskop dan stetoskop b. ETT dengan 3 ukuran (ID 2.5, 3 dan 3.5) c. Oropharyngeal airway d. plester e. Introducer
--	--	--

		f. Connector g. Suction berfungsi baik 3. Peserta menyiapkan obat anestesi yang diperlukan 4. Memberikan preoksigenasi dengan O2 100% selama 3 – 5 menit 5. Peserta menggunakan obat hipnotik – sedatif untuk induksi dengan agen intravena, pelumpuh otot kerja cepat (Rocuronium 1,2 mg/kgbb, tidak menggunakan Suksinilkolin) 6. Peserta tidak memberikan ventilasi tekanan positif 7. Peserta melakukan intubasi setelah pelumpuh otot bekerja 8. Peserta menyambungkan connector ETT dengan sirkuit anestesi 9. Peserta melakukan konfirmasi posisi ETT 10. Fiksasi plester	
9	Tata letak station	Model Kamar operasi	
10	Kebutuhan Laboran	1 orang sebagai penata (asisten) anestesi	
11	Peralatan yang dibutuhkan	- peralatan kamar operasi - Manequine intubasi infant - Laringoskop blade 1 - ETT 2.5, 3.0, 3.5, Sputit berlabel - Sulfast Atropin 0,25 mg - Midazolam 5 mg - Fentanyl / Remifentanyl / Morphine / Pethidin - Propofol - Relaxan - Suction cath no 10 - Oropharing no 1 dan 2 - Sungkup muka no 1, 2 - Jackson Rees breathing circuit	1 set 1 buah 1 buah @ 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah @1 buah @1 buah 1 buah
12	Kebutuhan manikin	Manekin infant untuk intubasi	
13	Penulis	Tim Soal OSCE ATI	
14	Referensi	Morgan clinical Anesthesia	

**RUBRIC ACTUAL MARK
STATION PEDIATRIK**

Aspek yang Dinilai	0	1	2	3	Bobot	Skor
1. Preoperatif Evaluation 1. Anamnesa AMPLE 2. Pemeriksaan fisik 3. Pemeriksaan penunjang	Peserta ujian tidak melakukan pemeriksaan pra anestesi	Peserta ujian hanya melakukan 1 (satu) item pemeriksaan pra anestesi	Peserta ujian hanya melakukan 2 (dua) item pemeriksaan pra anestesi	Peserta ujian melakukan pemeriksaan pra anestesi dengan lengkap.	2	
2. Diagnosa Problem aktual potensial Problem aktual: 1. Dehidrasi 2. Pasien pediatrik Problem Potensial: 1. Aspirasi, 2. Laringospasm, 3. Desaturasi, 4. Bradicardia	Peserta tidak menyebutkan problem	Peserta menyebutkan hanya menyebutkan minimal 2 item dari problem	Peserta menyebutkan hanya menyebutkan minimal 3 item dari problem	Peserta dapat menyebutkan minimal 5 problem pada pasien.	2	
3. Rencana tindakan Anestesi Rencana Anestesi: 1. Puasa 2. Pemasangan NGT dan suction aktif 3. Rehidrasi cepat dengan Kristaloid 20 ml/kg selama 30 – 60 menit dan dapat diulang bila belum ada perbaikan hemodinamik. Dilanjutkan dengan rehidrasi lambat 4. Pemasangan kateter urin	Peserta ujian tidak melakukan tindakan Atau melakukan tetapi tidak sesuai perintah Atau melakukan tetapi tidak sesuai masalah klinik pasien	peserta ujian dapat menyebutkan minimal 2 item dari rencana tindakan anestesi	peserta ujian dapat menyebutkan minimal 3 item dari rencana tindakan anestesi	peserta ujian dapat menyebutkan minimal 4 item dari rencana tindakan anestesi	2	

5. Anestesi: General Anestesi sleep apnu atau sleep non apnu						
4. Keterampilan klinis GA intubasi: 1. Peserta memakai sarung tangan non steril 2. Peserta menyiapkan peralatan intubasi (STATICS) 3. Peserta menyiapkan obat anestesi yang diperlukan 4. Memberikan preoksigenasi dengan O2 100% selama 3 – 5 menit 5. Peserta menggunakan obat hipnotik – sedatif untuk induksi dengan agen intravena, pelumpuh otot kerja cepat (Rocuronium 1,2 mg/kgbb, tidak menggunakan Suksinilkolin) 6. Peserta tidak memberikan ventilasi tekanan positif 7. Peserta melakukan intubasi setelah pelumpuh otot bekerja 8. Peserta menyambungkan connector ETT dengan sirkuit anestesi 9. Peserta melakukan konfirmasi posisi ETT 10. Fiksasi plester	Peserta ujian tidak melakukan tindakan Atau melakukan tetapi tidak sesuai perintah Atau melakukan tetapi tidak sesuai masalah klinik pasien	--	Peserta melakukan tindakan anestesi dengan tidak lengkap atau lengkap namun tidak runut	Peserta mampu melakukan tindakan intubasi dengan lengkap dan runut	3	
7. Komunikasi, edukasi dan profesionalisme 1. melakukan setiap tindakan dengan berhati-hati dan teliti	Peserta ujian tidak meminta izin secara lisan dan sama sekali tidak melakukan	Meminta izin secara lisan dan 1-2 poin Komunikasi, edukasi dan profesionalisme.	Meminta izin secara lisan dan 3 poin Komunikasi, edukasi dan	Meminta izin secara lisan dan melakukan Komunikasi, edukasi dan	1	

sehingga tidak membahayakan pasien dan diri sendiri 2. memperhatikan kenyamanan pasien 3. melakukan tindakan sesuai prioritas 4. menunjukkan rasa hormat kepada pasien mengetahui keterbatasan dengan merujuk atau melakukan konsultasi bila diperlukan	Komunikasi, edukasi dan profesionalisme.		profesionalisme.	profesionalisme secara lengkap.		
TOTAL SKOR						

LAMPIRAN SOAL

Lembar anamnesis:

Jenis kelamin : laki – laki

Usia anak : 3 bulan Berat badan : 5 kg

Anamnese

Muntah setiap minum ASI sejak 1 hari ini, sejak 12 jam terakhir pasien tidak mau menetek, tampak lemas. Anaknya juga mempunyai riwayat Riwayat alergi / asthma (-). makan minum terakhir 12 jam yang lalu.

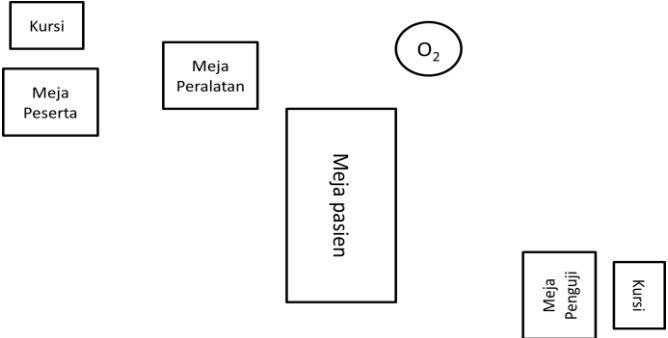
Bayi cenderung mengantuk tidak mau menghisap ASI. Tidak kontak lg dengan ibunya. Belum ada buang air kecil 4 jam ini. Tangan bayi dingin. Kepala demam.

ANESTESIA BEDAH UROLOGI

SOAL UJIAN OSCE STATION ANESTESIA BEDAH UROLOGI

1	Nomor Station	
2	Judul Station	TURP
3	Waktu yang dibutuhkan	20 menit
4	Tujuan Station	Menilai kemampuan diagnosis dan problem potensial – aktual, manajemen paska bedah, serta kemampuan komunikasi, edukasi dan profesionalisme
5	Kompetensi :	1. Evaluasi Preamestesi 2. Diagnosis dan problem potensial - aktual 3. Rencana tindakan anestesi 4. Keterampilan klinis 5. Monitoring dan manajemen penyulit 6. Manajemen paska bedah 7. Komunikasi, edukasi dan profesionalisme
6	Kategori	1. Anestesia Obstetrik 2. Anestesia Bedah Saraf 3. Anestesia Regional Dan Manajemen Nyeri 4. Anestesia Bedah Toraks 5. Anestesia Pediatrik 6. Anestesia Kegawatdaruratan 7. Anestesia Urologi 8. Anestesia Untuk Penyakit Penyakit Khusus (Endokrin, Metabolik, Penyulit Kardiovaskular) 9. Anestesia Bedah Kepala Leher 10. Anestesia Bedah Rawat Jalan / Luar Kamar Bedah 11. Anestesia Pada Prosedur Invasif Minimal 12. Terapi Intensif
7	Intruksi untuk peserta ujian	Skenario Klinik : Seorang laki-laki berusia 69 tahun, dibawa ke ruang pulih setelah menjalani operasi TURP selama 90 menit dalam anestesi umum. Dua puluh menit kemudian, pasien telah sadar namun tampak gelisah dan mengeluh sakit kepala. Dari penilaian preanestesi diketahui bahwa pasien ini dengan ASA II geriatri. Instruksi untuk peserta : 1. Lakukan evaluasi pasien ini 2. Tentukan pemeriksaan penunjang, diagnosis banding dan diagnosis utama 3. Sebutkan manajemen diagnosis pada kasus ini
8	Instruksi untuk penguji	Intruksi penguji : INSTRUKSI UMUM 1. Pastikan identitas peserta ujian pada kartu ujian 2. Tulislah nama dan nomor peserta ujian pada lembar penilaian! 3. Amatilah dan berilah skor (0/1/2/3) atas tugas yang dikerjakan peserta ujian serta skor <i>Global Rating</i> sesuai rubrik penilaian 4. Hindarilah interupsi dan/atau tindakan selain

		daripada yang diminta dalam instruksi penguji! 5. Berikan informasi/hasil yang dibutuhkan secara lisan/tulisan hanya apabila peserta ujian telah melakukan dan/atau mengusulkan jenis pemeriksaan yang dimaksud (perhatikan instruksi khusus)! 6. Taatilah peraturan serta etika penguji selama menjalankan tugas sebagai penguji OSCE - ATI! INSTRUKSI KHUSUS : 1. Penguji mengamati dan menilai apa yang dievaluasi oleh peserta ujian: a. Airway clear b. Frekuensi napas 40 x/menit, SpO2 92% dengan simpel mask 10 l/menit c. Tekanan darah 140/90 mmHg, denyut nadi 60 x/menit d. Kesadaran CM (gelisah) e. Suhu aksila 35,5 °C f. Kualitas nadi: isi dan tegangan cukup g. Vena jugularis: tidak distensi h. Paru: ronkhi basah di basal paru i. Jantung: tidak ada S₃ gallop j. Abdomen: distensi tidak ada, lemas, nyeri tekan tidak ada k. Akral dingin 2. Penguji menilai peserta menentukan: a. Diagnosis banding 1. Perdarahan 2. Sindroma TURP 3. Perforasi <i>bladder</i> 4. Infark miokard 5. Sepsis 6. DIC (<i>Disseminated Intravascular Coagulation</i>) b. Pemeriksaan penunjang untuk menyingkirkan diagnosis banding 1. Pemeriksaan dari irigasi <i>bladder</i> Dari kateter urin terlihat aliran irigasi lancar dan berwarna merah muda, jernih 2. Laboratorium • Hb: 13 g/dl (11,4-15 g/dl) • Ht: 39 % (35-45 %) • Trombosit: 399.000/μl (189-436.000/μl) • Glukosa darah: 189 mg/dl (<200 mg/dl) • Na: 120 mEq/l (135-155 mEq/l) • K: 4,3 mEq/l (3,5-5,5 mEq/l) • Cl: 104 mmol/l (96-106 mmol/l) • PT: 15 detik, kontrol 13 detik (12-18 detik) • INR: 1,5 (1,2-1,7) • aPTT: 40, kontrol 30,6 (27-42) • Analisis Gas Darah pH 7,35 (7,35-7,45),
--	--	---

		pCO₂ 35 (35-45), pO₂ 72 (80-100), HCO₃ 18 (21-28) - Kultur darah: sedang berjalan - EKG 12 lead: tidak ada tanda-tanda iskemia - Rontgen thoraks: ada tanda-tanda kongesti paru c. Penguji menilai peserta menentukan diagnosis yaitu sindroma TURP - Penguji menilai manajemen sindroma TURP: - Melakukan intubasi dan oksigenasi - Restriksi cairan dan pemberian <i>loop diuretic</i> (furosemid 20 mg intravena) - Pemberian salin hipertonik (3-5%) - Pemantauan kejang - Perawatan ICU	
9	Denah ruangan	Setting ruang pulih 	
10	Peralatan yang dibutuhkan	Setting Ruang Pulih: - Meja dan kursi peserta - Meja dan kursi penguji - Meja peralatan - Tempat tidur pasien - Stetoskop - Sarung tangan non steril - Tensimeter - Termometer - <i>Penlight</i> - Tempat Sampah - Manekin dewasa - Simple mask dewasa - O₂	- 1 buah - 1 set - 1 buah - 1 buah - 1 buah - 1 buah - 1 buah - 1 buah - 1 buah - 1 buah - 1 buah - 1 buah
11	Penulis	- Zulkifli - Mayang Indah Lestari	
12	Referensi	Butterworth J, Mackey DC. Wasnick JD. Morgan & Mikhail's Clinical Anesthesiology. 2013. Mc Graw Hill Education: New York.	

LEMBAR PENILAIAN
STATION ANESTESI BEDAH UROLOGI

Kandidat Residen : _____

Aspek yang Dinilai	0	1	2	3	Bobot	Nilai
1. Melakukan evaluasi	Peserta tidak melakukan evaluasi	-	Peserta melakukan evaluasi tidak lengkap	Peserta melakukan evaluasi dengan lengkap: 1. Airway clear 2. Frekuensi napas 40 x/menit, SpO2 92% dengan simpel mask 10 l/menit 3. Tekanan darah 140/90 mmHg, denyut nadi 60 x/menit 4. Kesadaran CM (gelisah) 5. Suhu aksila 35,5 °C 6. Kualitas nadi: isi dan tegangan cukup 7. Vena jugularis: tidak distensi 8. Paru: ronkhi basah di basal paru 9. Jantung: tidak ada S ₃ gallop 10. Abdomen: distensi tidak ada, lemas, nyeri tekan tidak ada 11. Akral dingin	2	
2. Pemeriksaan penunjang, diagnosis banding dan diagnosis utama	Peserta tidak menyebutkan diagnosis banding, pemeriksaan penunjang, dan diagnosis	Peserta tidak menyebutkan diagnosis dengan benar namun menyebutkan minimal dua diagnosis banding dan dua pemeriksaan penunjang	Peserta menyebutkan diagnosis dengan benar dan minimal dua diagnosis banding dan dua pemeriksaan penunjang	Peserta menyebutkan diagnosis banding, pemeriksaan penunjang, dan diagnosis dengan lengkap: 1. Diagnosis banding a. Perdarahan b. Sindroma TURP c. Perforasi <i>bladder</i> d. Infark miokard e. Sepsis	3	

				f. DIC (<i>Disseminated Intravascular Coagulation</i>) 2. Pemeriksaan penunjang untuk menyingkirkan diagnosis banding a. Pemeriksaan dari irigasi <i>bladder</i> b. Laboratorium • Hb, Ht, dan Trombosit: • Glukosa darah • Na, K, Cl • PT, aPTT, INR • Analisis Gas Darah • Kultur darah: sedang berjalan c. EKG 12 lead d. Rontgen thoraks 3. Penguji menilai peserta menentukan diagnosis yaitu sindroma TURP		
3. Manajemen pasca anestesi	Peserta tidak menyebutkan manajemen sindroma TURP	-	Peserta menyebutkan manajemen sindroma TURP tidak lengkap	Peserta menyebutkan manajemen sindroma TURP dengan lengkap 1. Melakukan intubasi dan oksigenasi 2. Restriksi cairan dan pemberian <i>loop diuretic</i> (furosemid 20 mg intravena) 3. Pemberian salin hipertonik (3-5%) 4. Pemantauan kejang 5. Perawatan ICU	3	
4. Komunikasi, Edukasi Dan Profesionalisme	Peserta ujian tidak meminta izin secara lisan dan	meminta izin secara lisan dan 1-2 point berikut: 1. melakukan setiap	meminta izin secara lisan dan 3-4 point berikut: 1. melakukan setiap	meminta izin secara lisan dan melakukan di bawah ini secara lengkap: 1. melakukan setiap tindakan	2	

	sama sekali tidak melakukan point berikut: 1. melakukan setiap tindakan dengan berhati-hati dan teliti sehingga tidak membahayakan pasien dan diri sendiri 2. memperhatikan kenyamanan pasien 3. melakukan tindakan sesuai prioritas 4. menunjukkan rasa hormat kepada pasien 5. mengetahui keterbatasan dengan merujuk atau melakukan konsultasi bila diperlukan	tindakan dengan berhati-hati dan teliti sehingga tidak membahayakan pasien dan diri sendiri 2. memperhatikan kenyamanan pasien 3. melakukan tindakan sesuai prioritas 4. menunjukkan rasa hormat kepada pasien 5. mengetahui keterbatasan dengan merujuk atau melakukan konsultasi bila diperlukan	tindakan dengan berhati-hati dan teliti sehingga tidak membahayakan pasien dan diri sendiri 2. memperhatikan kenyamanan pasien 3. melakukan tindakan sesuai prioritas 4. menunjukkan rasa hormat kepada pasien 5. mengetahui keterbatasan dengan merujuk atau melakukan konsultasi bila diperlukan	dengan berhati-hati dan teliti sehingga tidak membahayakan pasien dan diri sendiri 2. memperhatikan kenyamanan pasien 3. melakukan tindakan sesuai prioritas 4. menunjukkan rasa hormat kepada pasien 5. mengetahui keterbatasan dengan merujuk atau melakukan konsultasi bila diperlukan		
--	--	--	--	---	--	--

II. Global performance

Beri tanda (✓) pada kolom yang disediakan sesuai dengan penilaian Anda secara umum terhadap kemampuan peserta ujian!

Tidak lulus	Borderline	Lulus	Superior

.....,
Penguji,

(.....)

SOAL UJIAN OSCE STATION PEMASANGAN HEMODIALISA CATHETER

1	Nomor Station	
2	Judul Station	CHRONIC KIDNEY DISEASE DENGAN PEMASANGAN HEMODIALISA CATHETER
3	Waktu yang dibutuhkan	30 menit
4	Tujuan Station	1. Menilai kemampuan evaluasi preoperatif 2. Menilai kemampuan menentukan diagnosa, problem aktual – potensial, dan persiapan preoperatif 3. Menilai kemampuan menagalisis indikasi pemasangan kateter hemodialisa 4. Menilai kemampuan tindakan anestesi dan keterampilan klinis Pemasangan kateter hemodialisa 5. Menilai kemampuan komunikasi, edukasi, dan profesionalisme
5	Kompetensi :	1. Evaluasi preoperatif 2. Menentukan diagnosa, problem aktual – potensial, dan persiapan preoperatif 3. Evaluasi indikasi pemasangan kateter hemodialisa 4. Tindakan anestesi dan keterampilan klinis pemasangan kateter hemodialisa 5. Komunikasi, edukasi, dan profesionalisme
6	Kategori	1. Anestesi obstetri 2. Neuroanestesi 3. Anestesi Regional dan Manajemen Nyeri 4. Anestesi Kardiovaskular 5. Anestesi Pediatrik 6. Anestesi Kegawat daruratan 7. Anestesi Urologi 8. Anestesi untuk penyakit Endokrin, metabolic dan penyakit – penyakit khusus 9. ICU 10. Anestesi pada kepala leher 11. Airway Management
7	Intruksi untuk peserta ujian	Skenario Klinik : Seorang laki-laki 50 tahun datang ke UGD dengan keluhan sesak nafas sejak 1 jam SMRS dan bertambah berat dan bengkak di wajah dan kedua kaki dan tangan. dengan riwayat penyakit dahulu : riwayat penyakit ginjal. Instruksi untuk peserta :

		1.Lakukan evaluasi preoperatif . 2.Tentukan diagnosis, problem aktual-potensial, dan persiapan preoperatif . 3.Tentukan rencana tindakan, indikasi, tindakan tersebut 4.Lakukan tindakan tersebut
8	Instruksi untuk penguji	<u>Skenario Klinik :</u> Pasien datang ke igD dengan keluhan sesak nafas 1ang dirasakan sesak 1 hari sejak masuk rumah sakit. sesak dirasakan terus menerus, memberat saat diluat tiduran atau beraktifitas dan berkurang saat istirahat dengan posisi setengah duduk. Jika pasien minum terlalu banyak sering terjadi sesak. selain itu pasien juga mengeluh seluruh badan terasa lemas pusing disertai bengkak pada wajah, kedua lengan dan tungkai. Pasien juga mengeluhkan batuk berdahak warna kuning tanpa disertai demam dan tanpa darah sejak 3 hari SMRS. Pasien mempunyai Riwayat penyakit ginjal. <u>INSTRUKSI UMUM</u> 1. Pastikan identitas peserta ujian pada kartu ujian 2. Tulislah nama dan nomor peserta ujian pada lembar penilaian! 3. Amatilah dan berilah skor (0/1/2/3) atas tugas yang dikerjakan peserta ujian serta skor <i>Global Rating</i> sesuai rubrik penilaian 4. Hindarilah interupsi dan/atau tindakan selain daripada yang diminta dalam instruksi penguji! 5. Berikan informasi/hasil yang dibutuhkan secara lisan/tulisan hanya apabila peserta ujian telah melakukan dan/atau mengusulkan jenis pemeriksaan yang dimaksud (perhatikan instruksi khusus)! 6. Taatilah peraturan serta etika penguji selama menjalankan tugas sebagai penguji OSCE - ATI! <u>INSTRUKSI KHUSUS :</u> 1. Penguji mengamati dan menilai evaluasi preoperatif yang dilakukan peserta dan memberikan hasil pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang bila diminta oleh peserta. Peserta menanyakan : Anamnesa A : alergi: (-) M: Medikasi: (-) P: Past illness: (-) L: last meal: 6 jam SMRS E: event: sesak nafas

		Pemeriksaan Klinis: BB 85 kg, TB 160 cm, BMI 33,2 kg/m² Kesadaran Compos mentis GCS15 E4V5M6 A: buka mulut 2 jari, malampati 2, leher pendek, TMD < 6 cm, gerak leher bebas. B: RR: 30x/menit SpO2: 94% udara bebas, suara dasar vesikuler di kedua lapang paru, rbk+/, rbh +/+ C: Tekanan darah 193/72 mmHg, Nadi 102 x/menit, kuat, Jantung : suara jantung normal, batas jantung kiri bawah SIC VI 3 cm lateral Linea midclavicular sinistra. Suhu 37,4°C, CRT < 2 detik Mata: konjungtiva anemis (+/+) Abdomen: supel, nyeri tekan(-), defans (-) Ekstremitas: pitting oedem ekstremitas superior et inferior Produksi urine : 10 cc/jam <u>Pemeriksaan penunjang :</u> Hb: 7,8 Ht: 23,6 Lekosit: 25,8 Eritrosit: 1,5 Trombosit: 261 Albumin: 2,7 Pt: 14,1 Aptt: 36,7 Inr : 1,100 Natrium : 135 Kalium: 6,4 Clorida: 109 Ureum: 105 Kreatinin : 14 <u>AGD:</u> pH : 7,258 BE : -5,9 PCO2 50,4 Po2 97,1 Hco3 16,5 TCO2 21,9 O2 saturasi:95 Thorak foto : CTR>50% , tampak oedem pulmo, corakan bronkovaskular meningkat EKG : Sinus takikardi HR 108, hipertrofi ventrikel kiri 2. Diagnosis, problem aktual – potensial, persiapan preoperatif Diagnosis anesthesiologi: laki-laki, 50 tahun
--	--	---

		obesitas, dengan gagal ginjal kronis dan oedem pulmo, asidosis respiratorik mixed metabolik pro cito hemodialisa (di ruang operasi) Problem aktual: - gagal ginjal kronis - obesitas derajat I - kemungkinan jalan napas sulit - oedem pulmo - asidosis respiratorik mixed metabolik Problem potensial: - gagal pemasangan hd cath - desaturasi Persiapan preoperatif: 1. Informed consent pasien dan keluarga pasien 2. Pasang iv line mikro, 3. Persiapan pemasangan hd cath, alat, obat emergency, 3. penguji menilai indikasi pemasangan kateter hemodialisa Indikasi absolute • Keadaan umum buruk dan gejala klinisnya nyata seperti mual, dan muntah, diare • Perikarditis uremik • Ensefalopati atau neuropati uremik • Udem paru akut dengan overhydration refrakter terhadap Diuretika (tidak bias ditanggulangi dengan obat diuretika) • Kreatinin >10mg % • Ureum darah lebih > 200 mg/dl atau kenaikan ureum darah lebih dari 100 mg/dl per hari (hiperkatanolisme) • Hiperkalemia (K serum > 6mEq/L) • Asidosis dengan bikarbonat serum kurang dari 10 mEq/L atau pH < 7,35 • Anuria berkepanjangan (>5 hari) 4. Penguji menilai ketrampilan pemasangan HD cath yang dilakukan peserta Rencana Tindakan Anestesi : 1. STATICS, menyiapkan obat anestesi yang diperlukan, mengecek mesin anestesi dan alat monitor pasien, memakai alat pelindung diri (minimal handschoen) 2. Persiapan intubasi sulit: LMA, needle krikotiroidotomi, transtrakeal jet insufflation, fiberoptik/bronkoskopi/video laringoskop (bila
--	--	--

		ada) - Siapkan 3 ukuran ETT: 6,5 ; 7,0 ; 7,5 mm - Siapkan alat HD cath dan obat emergency, - Posisikan pasien dalam keadaan berbaring, bila masih sesak dapat diposisikan pasien dalam keadaan head up 30 derajat. - Lakukan ganjal pada bahu kanan atau bahu kiri pasien - Operator melakukan cuci steril dan memakai baju steril - Lakukan tindakan aseptik dan antiseptik pada daerah subclavia kanan - Tutup dengan doek steril - Lakukan tindakan lokal anestesi pada daerah puncture - Tusuk dengan jarum 18 G ke arah antitragus kontralateral ataupun ke arah jugular notch, hingga teraspirasi darah vena , masukkan guide wire, perlebar insersi dengan mess, cabut jarum 18 G, perlebar dengan dilator - Masukkan kateter hd cath dengan gentle. - Tarik guide wire, aspirasi darah vena dari kedua lumen, dengan menggunakan nacl 500 ml dan heparin 5000 iu. Pastikan aliran kedua lumen lancar. - Tutup kedua lumen - Fiksasi kateter hd cath dengan hecting. - Tutup dengan kasa steril. - Pemasangan hd cath selesai - Lakukan foto thoraks PA post pemasangan Kateter Hemodialisa
9		Ruang 3mx4m Meja Operasi Meja Peserta Kursi Meja penguji Meja T.Sampah Kursi PS Meja Peserta
10	Peralatan yang dibutuhkan	Setting ruangan dokter-pasien - Meja dan kursi dokter 1 set - Kursi pasien 1 buah - Meja dan kursi penguji 1 set - Meja peralatan 1 buah

		- Meja operasi 1 set - Manekin 1 buah - Monitor Pasien 1 buah - Mesin anestesi 1 unit - Stetoskop 1 buah - Laringoskop 1 buah - ETT 7,5;7,0; 6,5 @1 buah - Guedel/mayo 3 ukuran @ 1 buah - Plester 1 buah - Stilet 1 buah - Sungkup Muka 1 buah - Ambu Bag 1 buah - Suction/kanul/konektor @ 1 unit - HD catheter 1 buah - Iv catheter no 14G/16G/18G/20G @ 1 buah - Sduit 10/5/3 @ 1 buah - LMA no. 3/4/5 @ 1 buah - Sarung tangan non steril - Sarung tangan steril 2 buah - Rekam medis /informed consent @ 2 lembar - Tempat sampah tertutup 1 buah - Tissue 1 kotak - Jam dinding 1 buah
	Referensi	Morgan, Clinical Anesthesiology

LEMBAR PENILAIAN

STATION ANESTESI PEMASANGAN KATETER HEMODIALISA

Kandidat Residen : _____

Aspek yang Dinilai	0	1	2	3	Bobot	Nilai
1. Evaluasi preoperatif	Peserta ujian tidak melakukan tindakan Atau melakukan tetapi tidak sesuai perintah Atau melakukan tetapi tidak sesuai masalah klinik pasien atau tidak melakukan pemeriksaan fisik	Kandidat hanya mampu identifikasi 5-6 point dari 8 point	Peserta mampu identifikasi 8 point tapi tidak lengkap, tidak sistematis.	1. Anamnesa (1 poin) - A : alergi: (-) - M: Medikasi: (-) - P: Past illness: (-) - L: last meal: 6 jam SMRS - E: event: GAGAL GINJAL KRONIK 2. Pemeriksaan Klinis: • BB 85 kg, TB 160 cm, BMI 33 kg/m² (1 poin) • Kesadaran Compos mentis GCS15 E4V5M6 • A: buka mulut 2 jari, malampati 2, leher pendek, TMD < 6 cm, gerak leher bebas. (1 poin) • B: RR: 30x/menit SpO2: 95% udara bebas, suara dasar vesikuler di kedua lapang paru, ronkhi basah basal kedua lapang paru (1 poin) - C: Tekanan darah 193/72 mmHg, Nadi 102 x/menit, kuat, Jantung : suara jantung normal, batas jantung kiri bawah SIC VI 3 cm	3	

				lateral Linea midclavicular sinistra. (1 poin) • Abdomen: supel, nyeri tekan (-) (1 poin) • Produksi urine : 10 cc/jam (1 poin) 3. Pemeriksaan penunjang : (1 poin) <u>Hasil Laboratorium :</u> Hb: 10,5 Ht: 30,7 Lekosit: 25,8 Eritrosit: 3,5 Trombosit: 261 Ureum: 105 Kreatinin : 14 AGD: pH : 7,258 PCO2 47,4 Po2 97,1 Hco3 20,5 TCO2 21,9 O2 saturasi:95 Thorak foto : CTR>50% , tampak oedem pulmo, corakan bronkovaskular meningkat EKG : Sinus takikardi HR 108, hipertrofi ventrikel kiri		
2. Diagnosis, Problem	Peserta tidak menyebutkan diagnosis, problem	Peserta hanya mampu menentukan diagnosis	Peserta mampu menentukan diagnosis, problem aktual-	Peserta mampu menentukan diagnosis, problem aktual-potensial, dan persiapan preoperatif	5	

aktual – potensial, dan persiapan preoperatif	aktual-potensial, dan persiapan preoperatif		potensial, dan persiapan preoperative, namun tidak lengkap	Diagnosis anestesiologi: laki-laki, 50 tahun obesitas, dengan gagal ginjal kronis dan oedem pulmo, asidosis respiratorik belum terkompensasi pro cito hemodialisa (di ruang operasi) Problem aktual: - gagal ginjal kronis - obesitas derajat I - kemungkinan jalan napas sulit - oedem pulmo - asidosis respiratorik mixed metabolik Problem potensial: - gagal pemasangan hd cath - desaturasi Persiapan preoperatif: 1. Informed consent pasien dan keluarga pasien 2. Pasang iv line mikro, 3. Persiapan pemasangan hd cath, alat, obat emergency,		
4. Menilai rencana tindakan indikasi	Peserta tidak mampu menjelaskan indikasi pemasangan hd cath	Peserta mampu menentukan dan menjelaskan indikasi pemasangan HD cath namun tidak lengkap dan runut	Peserta mampu menentukan dan menjelaskan rencana lengkap dan runut	5. indikasi pemasangan kateter hemodialisa Indikasi absolute • Keadaan umum buruk dan gejala klinisnya nyata seperti mual, dan muntah, diare • Perikarditis uremik • Ensefalopati atau neuropati		

				uremik • Udem paru akut dengan overhydration refrakter terhadap Diuretika (tidak bias ditanggulangi dengan obat diuretika) • Kreatinin >10mg % • Ureum darah lebih > 200 mg/dl atau kenaikan ureum darah lebih dari 100 mg/dl per hari (hiperkatanolisme) • Hiperkalemia (K serum > 6mEq/L) • Asidosis dengan bikarbonat serum kurang dari 10 mEq/L atau pH < 7,35 • Anuria berkepanjangan (>5 hari)		
4.Rencana tindakan Anestesi dan keterampilan klinis	Peserta tidak mampu menjelaskan rencana anestesi dan tidak mampu melakukan tindakan anestesi	Peserta mampu menentukan dan menjelaskan rencana anestesi namun tidak lengkap dan runut dan tidak melakukan keterampilan klinis pemasangan hd catheter	Peserta mampu menentukan dan menjelaskan rencana anestesi, keterampilan klinis pemasangan hd catheteri, namun dengan lengkap dan runut	Peserta mampu menentukan dan menjelaskan rencana anestesi, dan keterampilan klinis pemasangan hd catheter secara lengkap dan runut. Rencana Tindakan Anestesi : 1. Lakukan informed consent pemasangan hd cath 2. STATICS, menyiapkan obat anestesi yang diperlukan, mengecek mesin anestesi dan alat monitor pasien, memakai alat pelindung diri (minimal	5	

				handschoen) 3. Persiapan intubasi sulit: LMA, needle krikotiroidotomi, transtrakeal jet insuflation, fiberoptik/bronkoskopi/video laringoskop (bila ada) 4. Siapkan 3 ukuran ETT: 6,5 ; 7,0 ; 7,5 mm 5. Siapkan alat HD cath dan obat emergency, 6. Posisikan pasien dalam keadaan berbaring, bila masih sesak dapat diposisikan pasien dalam keadaan head up 30 derajat. 7. Lakukan ganjal pada bahu kanan atau bahu kiri pasien 8. Operator melakukan cu 9. Lakukan tindakan aseptik dan antiseptik pada daerah subclavia kanan 10. Tutup dengan doek steril 11. Lakukan tindakan lokal anestesi pada daerah puncture 12. Tusuk dengan jarum 18 G ke arah antitragus kontralateral ataupun ke arah jugular notch, hingga teraspirasi darah vena , masukkan guide wire, perlebar insersi dengan mess, cabut jarum 18 G, perlebar dengan dilator 13. Masukkan kateter hd cath dengan gentle. 14. Tarik guide wire, aspirasi darah vena dari kedua lumen, dengan menggunakan nacl 500 ml dan		
--	--	--	--	---	--	--

				heparin 5000 iu. Pastikan aliran kedua lumen lancar. 15. Tutup kedua lumen 16. Fiksasi kateter hd cath dengan hecting. 17. Tutup dengan kasa steril. 18. Pemasangan hd cath selesai 19. Dilakukan foto thoraks PA		
5. Komunikasi, edukasi dan profesionalisme	Peserta ujian tidak meminta izin secara lisan dan sama sekali tidak melakukan poin berikut: 1. melakukan setiap tindakan dengan berhati-hati dan teliti sehingga tidak membahayakan pasien dan diri sendiri 2. memperhatikan kenyamanan pasien 3. melakukan tindakan sesuai prioritas 4. menunjukkan rasa hormat kepada pasien mengetahui	Meminta izin secara lisan dan 1-2 poin berikut : 1. melakukan setiap tindakan dengan berhati-hati dan teliti sehingga tidak membahayakan pasien dan diri sendiri 2. memperhatikan kenyamanan pasien 3. melakukan tindakan sesuai prioritas 4. menunjukkan rasa hormat kepada pasien mengetahui keterbatasan dengan merujuk atau melakukan konsultasi	Meminta izin secara lisan dan 3 poin berikut: 1. melakukan setiap tindakan dengan berhati-hati dan teliti sehingga tidak membahayakan pasien dan diri sendiri 2. memperhatikan kenyamanan pasien 3. melakukan tindakan sesuai prioritas 4. menunjukkan rasa hormat kepada pasien mengetahui keterbatasan dengan merujuk atau melakukan konsultasi	Meminta izin secara lisan dan melakukan di bawah ini secara lengkap : 1. melakukan setiap tindakan dengan berhati-hati dan teliti sehingga tidak membahayakan pasien dan diri sendiri 2. memperhatikan kenyamanan pasien 3. melakukan tindakan sesuai prioritas 4. menunjukkan rasa hormat kepada pasien mengetahui keterbatasan dengan merujuk atau melakukan konsultasi bila diperlukan	3	

	keterbatasan dengan merujuk atau melakukan konsultasi bila diperlukan	bila diperlukan	bila diperlukan			
--	---	-----------------	-----------------	--	--	--

II. Global performance

Beri tanda (✓) pada kolom yang disediakan sesuai dengan penilaian Anda secara umum terhadap kemampuan peserta ujian!

Tidak lulus	Borderline	Lulus	Superior

.....,

Penguji,

(.....)

ANESTESIA ENDOKRIN METABOLIK DAN PENYAKIT KHUSUS

SOAL UJIAN OSCE STATION ENDOKRIN

1	Nomor Station	
2	Judul Station	HIPERTIROID PADA OPERASI DARURAT /NGT
3	Waktu yang dibutuhkan	20 menit
4	Tujuan Station	Menilai kemampuan melakukan Evaluasi Preoperative, Diagnosa dan problem potensial – aktual, dan keterampilan klinis
5	Kompetensi :	1. Evaluasi Preoperative 2. Diagnosa dan problem potensial – aktual 3. Rencana tindakan anestesi 4. Keterampilan klinis 5. Monitoring 6. Manajemen paska bedah 7. Komunikasi, edukasi dan profesionalisme
6	Kategori	1. Anestesi obstetri 2. Neuroanestesi 3. Anestesi Regional dan Manajemen Nyeri 4. Anestesi Kardiovaskular 5. Anestesi Pediatrik 6. Anestesi Kegawat daruratan 7. Anestesi Urologi 8. Anestesi untuk penyakit Endokrin, metabolic dan penyakit – penyakit khusus 9. ICU 10. Anestesi pada kepala leher
7	Intruksi untuk peserta ujian	<u>Skenario Klinik :</u> Seorang Perempuan 32 tahun post KLL direncanakan tindakan operasi cito ORIF pada fraktur terbuka pada lengan kiri bawah. Pasien dengan riwayat penyakit tyroid. Operasi dilakukan dengan General Anestesi. Lakukan pemasangan NGT pada pasien tersebut. Instruksi untuk peserta : 1. Evaluasi Preoperative 2. Diagnosa dan problem potensial – aktual 3. Rencana tindakan anestesi 4. Keterampilan klinis 5. Monitoring 6. Manajemen paska bedah 7. Komunikasi, edukasi dan profesionalisme
8	Instruksi untuk penguji	<u>Skenario Klinik :</u> Seorang Perempuan 32 tahun post KLL direncanakan tindakan operasi cito ORIF pada fraktur terbuka pada lengan kiri bawah. Pasien dengan riwayat penyakit tyroid. Operasi dilakukan dengan General Anestesi. Lakukan pemasangan NGT pada pasien tersebut. Instruksi untuk peserta : 1. Evaluasi Preoperative 2. Diagnosa dan problem potensial – aktual 3. Rencana tindakan anestesi

		4. Keterampilan klinis 5. Monitoring 6. Manajemen paska bedah 7. Komunikasi, edukasi dan profesionalisme Intruksi penguji : <u>INSTRUKSI UMUM</u> 1. Pastikan identitas peserta ujian pada kartu ujian 2. Tulislah nama dan nomor peserta ujian pada lembar penilaian! 3. Amatilah dan berilah skor (0/1/2/3) atas tugas yang dikerjakan peserta ujian serta skor <i>Global Rating</i> sesuai rubrik penilaian 4. Hindarilah interupsi dan/atau tindakan selain daripada yang diminta dalam instruksi penguji! 5. Berikan informasi/hasil yang dibutuhkan secara lisan/tulisan hanya apabila peserta ujian telah melakukan dan/atau mengusulkan jenis pemeriksaan yang dimaksud (perhatikan instruksi khusus)! 6. Taatilah peraturan serta etika penguji selama menjalankan tugas sebagai penguji OSCE - ATI! INSTRUKSI KHUSUS : 1. Penguji mengamati dan menilai tindakan preoperatif yang dilakukan peserta dan memberikan hasil pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang bila diminta oleh peserta. Peserta menanyakan : Anamnese Symptoms - Dyspnea on effort (+1) - Palpitationes (+2) - Tiredness (+2) - Excessive sweating (+3) - Nervousness (+2) - Appetite increased (+3) - Weight decreased (+3) sudah dikelola bagian penyakit dalam dgn terapi: PTU 2x100mg Propanolol 3x50mg Pemeriksaan Klinis: BB 39 kg, TB 157 cm. Kesadaran Compos mentis GCS15 E4V5M6, Exophthalmus, pupil isokor 3mm/3mm RC +/- Leher: teraba benjolan sebesar telur ayam, mobile Frekuensi nafas 18-20 x/menit, suara pernafasan vesikuler suara tambahan tidak ada, Tekanan darah 140/90 mmHg, Nadi 105 x/menit, kuat, Jantung : suara jantung normal, Suhu 37,5°C. Abdomen: dbn Produksi urine : 40 cc/jam Sign - Palpable thyroid (ada +3) - Exophthalmus (ada +2) - Hands moist (ada +1) - Pulse rate more than 90/min (ada +3) Pemeriksaan penunjang :
--	--	---

		Hasil Laboratorium : Darah Rutin : Hb 12,8 gr%, Ht 30%, WBC 9 k/μL, Plt 276 gr/dl Faal Hemostasis : PPT10,9 (12,2) , APTT 35,8 (30,7), INR 1,5 Glukosa 98 mg/dl, Bun (Ureum) : 48 mg/dl, Creatinin 1,1 mg/dl Na 137 mmol/L, Kalium 4,5 mmol/L ,Cl 109 mmol/L Faal Hati :AST 35, ALT 43, LDH 296, albumin 2,7, globulin 3,42 Hormon tiroid: T3 150 ng/dl (70-190), T4 19,3 ng/dl (5-12), fT4 0,95 ng/dl (0,7-1,55), TSH 0,3 μIU/ml (0,5-6) Thorak foto : CTR<50% C/P dbn Cervical foto: tidak ada deviasi trakea, dbn EKG : Sinus Takikardia. 2. Diagnosa dan problem potensial – aktual. Diagnosa : hipertiroid/ pro ORIF dengan hipertiroid Problem aktual potensial: - kemungkinan munculnya badai tiroid - difficult airway management Persiapan preoperative : 1. Prinsip penatalaksanaannya adalah mencegah terjadinya “badai tiroid”. - propanolol intravena 0,5 mg ditingkatkan secara bertahap sampai dengan nadi dibawah 100 kali/menit. - propylthiouracil 200-400 mg setiap 6 jam atau methimazole 20-40 mg setiap 6 jam - Intravenous dexamethason 2 mg setiap 6 jam atau hydrocortison 40 mg setiap 6 jam - Potasium Iodide 5 tetes per-oral setiap 6 jam atau Lugol 30 tetes per-oral setiap 6 jam 2. Iv line besar, persiapan darah 3. Persiapan intubasi sulit : LMA, PDT, fiberoptik/bronkoskopi 4. Premedikasi : midazolam 0,05-0,1mg/kgBB 5. Pencegahan aspirasi pneumonia : 30 ml oral non particulated antacid + metocloperamide 10 mg iv + H2 blocker iv 3. Penguji menilai Manajemen anestesi yang dilakukan peserta • Pemasangan NGT ➤ Persiapan pemasangan NGT: 1. Informed consent pasien 2. Penjelasan prosedur pemeriksaan, indikasi,
--	--	--

		kontraindikasi/komplikasi 3. Persiapan diri : memakai sarung tangan / APD 4. Persiapan alat : menyiapkan alat-alat yang dibutuhkan, NGT, spuit, jelly, stetoskop 5. Memperhatikan sterilitas saat pemeriksaan ➤ Pemasangan NGT : 1. Ukur panjang selang dari mulut melewati telinga terus ke arah perut bagian depan dan lubang terahir dibawah processus xhipoid. 2. Memasukkan bagian pangkal selang ke dalam air 3. Mengolesi selang dengan jelly 4. Minta pasien untuk menundukkan kepala dan dengan gentle memasukkan selang kedalam hidung selang sambil meminta pasien untuk menelan sampai dengan ukuran. 5. Konfirmasi pemasangan NGT dengan memasukkan udara 10-20 ml dengan spuit cateter tip sambil didengarkan di regio epigastric dg stetoskop.
9		Ruang 3mx4m Kursi penguji Meja penguji Meja Operasi Meja Alat T.Sampah Meja Peserta Kursi PS Meja Peserta
10	Peralatan yang dibutuhkan	Setting ruangan dokter-pasien - Meja dan kursi dokter 1 set - Kursi pasien 1 buah - Meja dan kursi penguji 1 set - Meja peralatan 1 buah - Meja operasi /brankard 1 set - Manekin 1 buah - Moulage tumor 1 buah - Stetoskop 1 buah - Monitor Pasien 1 buah - Laringoskop 1 buah - Sungkup Muka 1 buah - Ambu Bag 1 buah

		- ETT 7 6,5 6 1 buah - NGT uk 16,18 1 buah - Plester 1 buah - Sarung tangan non steril - Rekam medis 5 lembar - Tempat sampah tertutup 1 buah - Tissue 1 kotak - Jam dinding 1 buah
11	Referensi	Morgan, Clinical Anesthesiology

LEMBAR PENILAIAN

STATION ANESTESI ENDOKRIN - HIPERTYROID

Kandidat Residen : _____

Aspek yang Dinilai	0	1	2	3	Bobot	Nilai
1. Preoperatif Evaluation	Peserta ujian tidak melakukan tindakan Atau melakukan tetapi tidak sesuai perintah Atau melakukan tetapi tidak sesuai masalah klinik pasien atau tidak melakukan pemeriksaan fisik	Kandidat hanya mampu identifikasi 3-4 point dengan tepat, lengkap dan benar	Peserta mampu identifikasi 5 – 6 point dengan tepat	Peserta mampu identifikasi >6 point dengan tepat Peserta ujian menanyakan dan melakukan pemeriksaan klinis pada: Anamnese Symptoms - Dyspnea on effort (+1) - Palpitationes (+2) - Tiredness (+2) - Excessive sweating (+3) - Nervousness (+2) - Appetite increased (+3) - Weight decreased (+3) Pemeriksaan Fisik: BB 39 kg, TB 157 cm. Kesadaran Compos mentis GCS15 E4V5M6, - Exophtalmus, pupil isokor 3mm/3mm RC +/- - Leher: teraba benjolan sebesar telur ayam, mobile Frekuensi nafas 18-20 x/menit, suara pernafasan vesikuler suara tambahan tidak ada, Tekanan darah 140/90 mmHg, Nadi 105 x/menit, kuat, Jantung : suara jantung normal, Suhu 37,5°C.	3	

				Abdomen: dbn Produksi urine : 40 cc/jam Sign - Palpable thyroid (ada +3) - Exophthalmus (ada +2) - Hands moist (ada +1) - Pulse rate more than 90/min (ada +3) Pemeriksaan penunjang : Hasil Laboratorium : Darah Rutin : Hb 12,8 gr%, Ht 30%, WBC 9 k/μL, Plt 276 gr/dl Faal Hemostasis : PPT10,9 (12,2) , APTT 35,8 (30,7), INR 1,5 Glukosa 98 mg/dl, Bun (Ureum) : 48 mg/dl, Creatinin 1,1 mg/dl Na 137 mmol/L, Kalium 4,5 mmol/L ,Cl 109 mmol/L Faal Hati :AST 35, ALT 43, LDH 296, albumin 2,7, globulin 3,42 - Hormon tiroid: T3 150 ng/dl (70-190), T4 19,3 ng/dl (5-12), fT4 0,95 ng/dl (0,7-1,55), TSH 0,3 μU/ml (0,5-6) Thorak foto : CTR<50% C/P dbn Cervical foto: tidak ada deviasi trakea, dbn EKG : Sinus Takikardia.		
2. Diagnosa Problem	Peserta tidak menyebutkan diagnose dan	Peserta hanya mampu menentukan diagnose	Peserta mampu menentukan diagnose namun tidak lengkap	Peserta mampu menentukan diagnosa dan persiapan anestesi Diagnosa : hipertiroid/ pro	5	

potensial actual	- persiapan preoperative		menjelaskan preoperative	persiapan	amputasi dengan hipertiroid Problem aktual potensial: - kemungkinan munculnya badai tiroid - difficult airway management Persiapan preoperative : 1. Prinsip penatalaksanaannya adalah mencegah terjadinya “badai tiroid”. - propranolol intravena 0,5 mg ditingkatkan secara bertahap sampai dengan nadi dibawah 100 kali/menit. - propylthiouracil 200-400 mg setiap 6 jam atau methimazole 20-40 mg setiap 6 jam - Intravenous dexamethason 2 mg setiap 6 jam atau hydrocortison 40 mg setiap 6 jam - Potasium Iodide 5 tetes per-oral setiap 6 jam atau Lugol 30 tetes per-oral setiap 6 jam 2. Iv line besar, persiapan darah 3. Persiapan intubasi sulit : LMA, PDT, fiberoptik/bronkoskopi 4. Premedikasi : midazolam 0,05-0,1mg/kgBB 5. Pencegahan aspirasi pneumonia : 30 ml oral non particulated antacid + metocloperamide 10 mg iv + H2 blocker iv		
---------------------	--------------------------------	--	-----------------------------	-----------	---	--	--

3. Keterampilan klinis	Peserta tidak mampu menentukan diagnose dan Peserta tidak mampu menjelaskan rencana anestesi	Peserta mampu menentukan tindakan anestesi tp tidak lengkap dan menjelaskan rencana anestesi namun tidak lengkap dan runut dan tidak melakukan	Peserta mampu menentukan tindakan anestesi dan menjelaskan rencana anestesi namun tidak lengkap dan runut dan melakukan	Peserta mampu melakukan persiapan dan pemasangan NGT Persiapan: 1. Informed consent pasien 2. Penjelasan prosedur pemeriksaan, indikasi, kontraindikasi/komplikasi 3. Persiapan diri : memakai sarung tangan / APD 4. Persiapan alat : menyiapkan alat-alat yang dibutuhkan, NGT, spuit, jelly, stetoskop Pemasangan: 1. Ukur panjang selang dari mulut melewati telinga terus ke arah perut bagian depan dan lubang terahir dibawah processus xhipoid. 2. Memasukkan bagian pangkal selang ke dalam air 3. Mengolesi selang dengan jelly 4. Minta pasien untuk menundukkan kepala dan dengan gentle	5	
-------------------------------	--	--	---	---	----------	--

				memasukkan selang kedalam hidung selang sambil meminta pasien untuk menelan sampai dengan ukuran. 5. Konfirmasi pemasangan NGT dengan memasukkan udara 20 ml dengan spuit cateter tip sambil didengarkan di regio epigastric dg stetoskop.		
4. Komunikasi, edukasi dan profesionalisme	Peserta ujian tidak meminta izin secara lisan dan sama sekali tidak melakukan poin berikut: 1. melakukan setiap tindakan dengan berhati-hati dan teliti sehingga tidak membahayakan pasien dan diri sendiri 2. memperhatikan kenyamanan pasien 3. melakukan tindakan sesuai prioritas 4. menunjukkan rasa hormat kepada pasien mengetahui keterbatasan dengan	Meminta izin secara lisan dan 1-2 poin berikut : 1. melakukan setiap tindakan dengan berhati-hati dan teliti sehingga tidak membahayakan pasien dan diri sendiri 2. memperhatikan kenyamanan pasien 3. melakukan tindakan sesuai prioritas 4. menunjukkan rasa hormat kepada pasien mengetahui keterbatasan dengan merujuk atau melakukan konsultasi bila diperlukan	Meminta izin secara lisan dan dan 3 poin berikut: 1. melakukan setiap tindakan dengan berhati-hati dan teliti sehingga tidak membahayakan pasien dan diri sendiri 2. memperhatikan kenyamanan pasien 3. melakukan tindakan sesuai prioritas 4. menunjukkan rasa hormat kepada pasien mengetahui keterbatasan dengan merujuk atau melakukan konsultasi bila diperlukan	Meminta izin secara lisan dan melakukan di bawah ini secara lengkap: 1. melakukan setiap tindakan dengan berhati-hati dan teliti sehingga tidak membahayakan pasien dan diri sendiri 2. memperhatikan kenyamanan pasien 3. melakukan tindakan sesuai prioritas 4. menunjukkan rasa hormat kepada pasien mengetahui keterbatasan dengan merujuk atau melakukan konsultasi bila diperlukan	3	

	merujuk atau melakukan konsultasi bila diperlukan					
--	---	--	--	--	--	--

II. Global performance

Beri tanda (✓) pada kolom yang disediakan sesuai dengan penilaian Anda secara umum terhadap kemampuan peserta ujian!

Tidak lulus	Borderline	Lulus	Superior

.....,

Penguji,

(.....)

SOAL UJIAN OSCE STATION ENDOKRIN

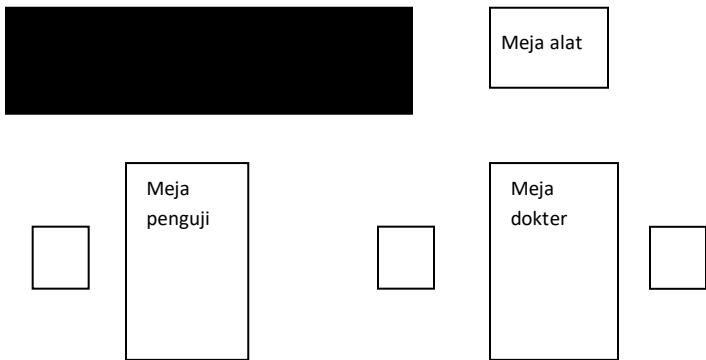
1.	Judul station	Ketoasidosis diabetik
2	Waktu yang dibutuhkan	15menit
3	Tujuan station	Menilai kemampuan anamnesis, pemeriksaan fisik, usulan pemeriksaan penunjang, menegakkan diagnosis kerja, penatalaksanaan farmakologi dan non farmakologi
4	Kompetensi	1. Kemampuan anamnesis 2. Kemampuan pemeriksaan fisik 3. Usulan pemeriksaan penunjang diagnosis 4. Penegakan diagnosis/ diagnosis banding 5. Pemberian terapi awal 6. Komunikasi dan edukasi pasien 7. Perilaku professional
5	Area kompetensi	Ketrampilan klinis
6	Level kompetensi	4A
7	Kategori	1. CVS 2. Respiratory system 3. Neuro-behaviour 4. Gastrointestinal system 5. Reproductive system 6. Musculoskeletal system 7. Endocrine & Metabolic 8. Hematology/Oncology 9. Genitourinary system 10. Head & Neck 11. Special Sensory 12. Phsyciatry
8	Instruksi untuk peserta ujian	SKENARIO KLINIK : Seorang pasien 20 tahun datang diantar keluarganya ke UGD dengan keluhan lemas. TUGAS: 1. Lakukan anamnesis 2. Lakukan pemeriksaan fisik 3. Usulkan pemeriksaan penunjang untuk menegakkan diagnosis 4. Tentukan diagnosis kerja dan diagnosis banding 5. Berikan penatalaksanaan pada pasien ini
9	Instruksi untuk penguji	SKENARIO KLINIK : Seorang pasien 20 tahun datang diantar keluarganya ke UGD dengan keluhan lemas. TUGAS:

		1. Lakukan anamnesis 2. Lakukan pemeriksaan fisik 3. Usulkan pemeriksaan penunjang untuk menegakkan diagnosis 4. Tentukan diagnosis kerja 5. Berikan penatalaksanaan pada pasien ini INSTRUKSI PENGUJI 1. Penguji mengamati dan menilai penampilan peserta berdasarkan lembar penilaian 2. Penguji tidak boleh melakukan interupsi ataupun bertanya kepada peserta selain yang ditentukan 3. Penguji memberikan informasi hasil pemeriksaan fisik setelah peserta melakukan pemeriksaan 4. Penguji memberikan hasil pemeriksaan penunjang sesuai usulan peserta ujian 1. Anamnesis Riwayat penyakit sekarang : • Keluhan utama : lemas • Sejak kapan : 3 hari • Perjalanan penyakit : 3 hari sebelum masuk RS pasien mengeluh lemas, lemas dirasakan terus menerus, semakin lama semakin memberat dan di seluruh tubuh. Lemas membuat pasien tidak dapat bekerja. muntah (-), mual (+), keringat dingin (-) BAK dirasa lebih sering dibanding kondisi biasanya, nyeri saat buang air kecil (-), anyang anyangan (-) nafsu makan menurun (-) BAB tidak ada keluhan • Keluhan lain terkait keluhan utama : Sesak nafas Mual (+) tanpa disertai muntah Kaki kanan sering kesemutan (+) • Hal-hal yang memperberat keluhan : Lemah diperberat dengan aktivitas seperti berjalan • Hal-hal yang meringankan keluhan : rasa lemas berkurang bila digunakan untuk istirahat • Riwayat pengobatan sekarang : Lupa menyuntikkan insulin Riwayat penyakit dahulu :
--	--	--

		• Riwayat sakit kencing manis (+) diketahui sejak usia 6 tahun, • Menggunakan suntikan insulin R 18-0-18 unit • Riwayat hipertensi (-) • Riwayat badan kegemukan (-) • Riwayat mondok tahun 2013: dirawat di RS karena gejala yang sama • Riwayat mondok tahun 2014: dirawat di RS sebanyak 2x karena gejala yang sama Riwayat penyakit keluarga : • Riwayat orang tua sakit gula pada ibu penderita Riwayat sosial : • Penderita bekerja sebagai pelayan toko. Biaya pengobatan ditanggung oleh BPJS 2. Pemeriksaan fisik KU : tampak lemah, kesadaran somnolen, nafas cepat dan dalam T : 120/80 mmHg, pernafasan : 24 x/ menit nadi : 100 x/menit suhu : 37,9°C Status gizi : normoweight Kepala : Rambut mudah rontok (-), turgor dahi kurang Kulit : Turgor kulit kurang Mata : Konjungtiva palpebra pucat (-/-), sklera ikterik (-/-) Hidung : Nafas cuping (-/-) Telinga : Sekret (-), nyeri tekan tragus (-/-) Mulut : Bibir kering, mukosa mulut kering, nafas berbau buah-buahan Tenggorok : Sekret (-),faring hiperemis (-) Leher : Trakea ditengah, JVP R + 0 cm, pembesaran nll (-) Dada : Bentuk normal Paru- paru I : simetris statis dinamis Pa : stem fremitus kanan = kiri Pe : sonor seluruh lapangan paru Au : SD vesikuler (+/+), Suara tambahan (-/-) Jantung :
--	--	---

		I : Normal Pa : Normal Pe : Normal Au : HR 100 x/menit, BJ I-II reguler, bising (-), gallop (-) Abdomen I : Normal Au : BU (+) N Pe : timpani, PS (+)N, PA (-), area trouble timpani Pa : supel, Hepar & Lien tak teraba Extremitas Kaki kanan sering kesemutan (+) 3. Hasil pemeriksaan penunjang (laboratorium) (Hasil dibacakan HANYA jika peserta mengusulkan pemeriksaan tersebut) Hematologi rutin Hb : 13,9 gr% Ht : 41 % Lekosit : 11.000 / uL Trombosit : 250.000/uL Pemeriksaan Kadar Gula GDS : 380 mg/dL Pemeriksaan Kimia lain Ureum : 20 mg/dL (N : 15 – 39 mg/dL) Kreatinin : 0,85 mg/dL (N : 0,6 – 1,3 mg/dL) Elektrolit : Na : 140 mmol/L (N : 136-145 mmol/L) K : 3,0 mmol/L (N : 3,5 – 5,1 mmol/L) Cl : 110 mmol/L (N : 98 – 107 mmol/L) Pemeriksaan urin : Warna : kuning, jernih BJ : 1,025 pH : 5,0 Aceton : positif (3) Reduksi : positif (4) 4. Diagnosis kerja :
--	--	---

		Ketoasidosis diabetik Diagnosis banding hiperosmolar nonketotik koma (HONK) 5. Rencana penatalaksanaan • NaCl 0,9% 2 liter dalam 1 jam pertama dilanjutkan NaCl 1 liter 1 jam kedua dilanjutkan NaCl 0,9% 500 cc 1 jam ketiga • Observasi GDS setelah 1 jam, jika masih > 250 mg/dl diberikan insulin 10 unit • Lakukan rujukan
10	Instruksi untuk pasien simulasi	Anamnesis dengan pasien Nama : sesuai PS Usia : 20 tahun Jenis kelamin : perempuan Pekerjaan : Pelayan toko Status pernikahan : belum menikah Pendidikan terakhir : D1 Riwayat penyakit sekarang : • Keluhan utama : lemas • Sejak kapan : 3 hari • Perjalanan penyakit : 3 hari sebelum masuk RS pasien mengeluh lemas, lemas dirasakan terus menerus, semakin lama semakin memberat dan di seluruh tubuh. Lemas membuat pasien tidak dapat bekerja. muntah (-), mual (+), keringat dingin (-) BAK dirasa lebih sering dibanding kondisi biasanya, nyeri saat buang air kecil (-), anyang anyangan (-), nafsu makan menurun (-) BAB tidak ada keluhan • Keluhan lain terkait keluhan utama : Sesak nafas Mual (+) tanpa disertai muntah Kaki kanan sering kesemutan (+) • Hal-hal yang memperberat keluhan : Lemas diperberat dengan aktivitas seperti berjalan • Hal-hal yang meringankan keluhan : rasa lemas berkurang bila digunakan untuk istirahat • Riwayat pengobatan sekarang : Lupa menyuntikkan insulin

		Riwayat penyakit dahulu : • Riwayat sakit kencing manis (+) diketahui sejak usia 6 tahun, • Menggunakan suntikan insulin R 18-0-18 unit • Riwayat hipertensi (-) • Riwayat badan kegemukan (-) • Riwayat mondok tahun 2013: dirawat di RS karena gejala yang sama • Riwayat mondok tahun 2014: dirawat di RS sebanyak 2x karena gejala yang sama Riwayat penyakit keluarga : • Riwayat orang tua sakit gula pada ibu penderita Riwayat sosial : • Penderita bekerja sebagai pelayan toko. Biaya pengobatan ditanggung oleh BPJS
11	Peralatan yang dibutuhkan Cantumkan semua peralatan dan jumlah yang dibutuhkan untuk semua peserta ujian. Termasuk bagaimana tata ruang yang sesuai dengan station	- Setting ruangan dokter pasien - Meja dan kursi dokter 1 buah - Kursi pasien 1 buah - Meja dan kursi penguji 1 buah - Bed pasiendanselimut 1 buah - Meja alat 1 buah - Tensi meter 1 buah - Stetoskop 1 buah - Termometer 1 buah - Klem 1 buah (jika dibutuhkan) 
12	Penulis Tulislah dengan lengkap:	Dr. MeitaHendrianingtyas, SpPK, MSi Med FK UNDIP-Semarang

	a. nama dan gelar penulis soal b. bagian dan institusi penulis	

SOAL UJIAN OSCE STATION ENDOKRIN

1	Nomor Station	
2	Judul Station	TYROID
3	Waktu yang dibutuhkan	20 menit
4	Tujuan Station	Menilai kemampuan melakukan Evaluasi Preoperative, Diagnosa dan problem potensial – aktual, rencana tindakan anestesi, Manajemen paska bedah
5	Kompetensi :	1. Evaluasi Preoperative 2. Diagnosa dan problem potensial - aktual 3. Rencana tindakan anestesi 4. Keterampilan klinis 5. Monitoring dan manajemen penyulit 6. Manajemen paska bedah 7. Komunikasi, edukasi dan profesionalisme
6	Kategori	1. Anestesi obstetri 2. Neuroanestesi 3. Anestesi Regional dan Manajemen Nyeri 4. Anestesi Kardiovaskular 5. Anestesi Pediatrik 6. Anestesi Kegawat daruratan 7. Anestesi Urologi 8. Anestesi untuk penyakit Endokrin, metabolic dan penyakit – penyakit khusus 9. ICU 10. Anestesi pada kepala leher
7	Intruksi untuk peserta ujian	<u>Skenario Klinik :</u> Seorang Perempuan 35 tahun direncanakan tindakan operasi total tyrodektomi Intruksi untuk peserta : 1. Evaluasi Preoperative 2. Diagnosa dan problem potensial - aktual 3. Rencana tindakan anestesi 4. Keterampilan klinis 5. Manajemen paska bedah 6. Komunikasi, edukasi dan profesionalisme
8	Intruksi untuk penguji	<u>Skenario Klinik :</u> Seorang Perempuan 35 tahun direncanakan tindakan operasi total tyrodektomi Intruksi untuk peserta : 1. Evaluasi Preoperative 2. Diagnosa dan problem potensial - aktual 3. Rencana tindakan anestesi 4. Keterampilan klinis 5. Monitoring dan manajemen penyulit 6. Manajemen paska bedah

		7. Komunikasi, edukasi dan profesionalisme Intruksi penguji : INSTRUKSI UMUM 1. Pastikan identitas peserta ujian pada kartu ujian 2. Tulislah nama dan nomor peserta ujian pada lembar penilaian! 3. Amatilah dan berilah skor (0/1/2/3) atas tugas yang dikerjakan peserta ujian serta skor <i>Global Rating</i> sesuai rubrik penilaian 4. Hindarilah interupsi dan/atau tindakan selain daripada yang diminta dalam instruksi penguji! 5. Berikan informasi/hasil yang dibutuhkan secara lisan/tulisan hanya apabila peserta ujian telah melakukan dan/atau mengusulkan jenis pemeriksaan yang dimaksud (perhatikan instruksi khusus)! 6. Taatilah peraturan serta etika penguji selama menjalankan tugas sebagai penguji OSCE - ATI! INSTRUKSI KHUSUS : 1. Penguji mengamati dan menilai tindakan preoperatif yang dilakukan peserta dan memberikan hasil pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang bila diminta oleh peserta. Peserta menanyakan : Anamnese berdebar debar(+), TREMOR (+) Alergi (-), pada saat tidur mengorok(+) Makan minum terakhir 8 jam yl , sudah 1 bulan sering BAB encer sebelum MRS, sudah dikelola bagian penyakit dalam Pemeriksaan Klinis: BB 52 kg, TB 157 cm. Kesadaran Compos mentis GCS15 E4V5M6, Exophthalmus, pupil isokor 3mm/3mm RC +/- Leher: terdapat benjolan sebesar bola tennis dan pergerakan dari leher terbatas. Frekuensi nafas 18-20 x/menit, suara pernafasan vesikuler suara tambahan tidak ada, Tekanan darah 160/90 mmHg, Nadi 105 x/menit, kuat, Jantung : suara jantung normal, Suhu 37°C. Abdomen: dbn Produksi urine : 60 cc/jam Pemeriksaan penunjang : Hasil Laboratorium : Darah Rutin : Hb 10,8 gr%, Ht 30%, WBC 9 k/μL, Plt 287 gr/dl Faal Hemostasis : PPT10,9 (12,2) , APTT 35,8 (30,7), INR 1,5 Bun (Ureum) : 30 mg/dl, Creatinin 1,1 mg/dl Na 147 mmol/L, Kalium 4,3 mmol/L ,Cl 100 mmol/L Faal Hati :AST 39, ALT 43, LDH 296, albumin 3,8, globulin 3,42 Hormon tiroid: T3 75 ng/dl (70-190), T4 19,3 ng/dl (5-12), fT4 0,95 ng/dl (0,7-1,55), TSH 8,1 μU/ml /normal Glukosa 98 mg/dl,
--	--	---

		Thorak foto : CTR<50% C/P dbn Cervical foto: deviasi ke lateral dan penyempitan pada trakhea EKG : Sinus Takikardia. 2. Diagnosa dan problem potensial – aktual. Diagnosa : EUTHYROID pro TT Problem aktual potensial: - difficult airway management - kemungkinan badai tiroid - kemungkinan komplikasi bull neck dan laringomalasia Persiapan preoperative : 1. Pastikan euvolemia dengan rehidrasi terlebih dahulu 2. Kontrol tekanan darah : turunkan tekanan darah 20% 3. Monitoring Tanda Vital 4. Iv line besar min no 18, persiapan darah 5. Persiapan intubasi sulit: stilet, Mc Coy, LMA, glidescope, cricotyroidotomi, PDT, fiberoptik/bronkoskopi 3. Penguji menilai Manajemen anestesi yang dilakukan peserta Pilihan Anestesi : General Anestesi intubasi dengan non apneu Rencana Tindakan Anestesi : 1. Menyiapkan obat anestesi yang diperlukan, mengecek mesin anestesi dan alat monitor pasien, memakai alat pelindung diri (minimal handschoen) 2. Persiapan intubasi sulit: stilet, Mc Coy, LMA 3. Siapkan 3 ukuran ETT, memilih pipa endotracheal dengan ukuran lebih kecil : 6 atau 6,5 mm 4. Induksi dengan agen IV cepat (propofol / etomidate), analgetik (fentanyl), di dalamkan dengan agen inhalasi 5. Diberikan ventilasi tekanan positif, bila sudah dalam dan rilex 6. Intubasi: mengambil laryngoskop dengan tangan kiri, membuka mulut penderita tanpa ekstensi kepala, menyusuri lidah dari kiri ke kanan hingga tampak epiglotis dan plica vocalis 7. insersi pipa endotracheal dgn stilet 8. kembangkan cuff, 9. auskultasi untuk simetrisasi suara napas 10. fiksasi
--	--	---

9		Ruang 3mx4m Meja Operasi Meja Peserta Kursi penguji Meja penguji Meja Alat T.Sampah Meja Peserta Kursi PS
10	Peralatan yang dibutuhkan	Setting ruangan dokter-pasien - Meja dan kursi dokter 1 set - Kursi pasien 1 buah - Meja dan kursi penguji 1 set - Meja peralatan 1 buah - Meja operasi 1 set - Manekin 1 buah - Moulage tumor 1 buah - Stetoskop 1 buah - Monitor Pasien 1 buah - Laringoskop 1 buah - Sungkup Muka 1 buah - Ambu Bag 1 buah - ETT 7,5 6 1 buah - Plester 1 buah - Sarung tangan non steril - Rekam medis 5 lembar - Tempat sampah tertutup 1 buah - Tissue 1 kotak - Jam dinding 1 buah
11	Refeensi	Morgan, Clinical Anesthesiology

LEMBAR PENILAIAN
STATION ANESTESI ENDOKRIN - TYROID

Kandidat Residen : _____

Aspek yang Dinilai	0	1	2	3	Bobot	Nilai
1. Preoperatif Evaluation	Peserta ujian tidak melakukan tindakan Atau melakukan tetapi tidak sesuai perintah Atau melakukan tetapi tidak sesuai masalah klinik pasien atau tidak melakukan pemeriksaan fisik	Kandidat hanya mampu identifikasi 3-4 point dengan tepat, lengkap dan benar dari 6 point tapi tidak lengkap	Peserta mampu identifikasi 5 – 6 point tapi tidak lengkap	Anamnese - berdebar debar(+), - TREMOR (+) - Alergi asma(-), - Makan minum terakhir 8 jam yl , - sudah 1 bulan sering BAB encer - sebelum MRS, sudah dikelola bagian penyakit dalam Pemeriksaan Klinis: BB 52 kg, TB 157 cm. Kesadaran Compos mentis GCS15 E4V5M6, - Exophtalmus, pupil isokor 3mm/3mm RC +/- - Leher: terdapat benjolan sebesar bola tennis Frekuensi nafas 18-20 x/menit, suara pernafasan vesikuler suara tambahan tidak ada, Tekanan darah 160/90 mmHg, - Nadi 105 x/menit, kuat, Jantung : suara jantung normal, Suhu 37°C. Abdomen: dbn Produksi urine : 60 cc/jam Pemeriksaan penunjang : Hasil Laboratorium :	3	

				Darah Rutin : Hb 10,8 gr%, Ht 30%, WBC 9 k/μL, Plt 287 gr/dl Faal Hemostasis : PPT10,9 (12,2) , APTT 35,8 (30,7), INR 1,5 Bun (Ureum) : 78 mg/dl, Creatinin 2,1 mg/dl Na 147 mmol/L, Kalium 4,3 mmol/L ,Cl 100 mmol/L Faal Hati :AST 39, ALT 43, LDH 296, albumin 2,8, globulin 3,42 - Hormon tiroid: T3 75 ng/dl (70-190), T4 19,3 ng/dl (5-12), fT4 0,95 ng/dl (0,7-1,55), TSH 8,1 μIU/ml Glukosa 98 mg/dl, - Thorak foto : CTR<50% C/P dbn - Cervical foto: deviasi trakhea ke lateral - EKG : Sinus Takikardia.		
2. Diagnosa Problem potensial actual	Peserta tidak menyebutkan diagnose dan persiapan preoperative	Peserta hanya mampu menentukan diagnose	Peserta mampu menentukan diagnose namun tidak lengkap menjelaskan persiapan preoperative	Peserta mampu menentukan diagnosa dan persiapan anestesi Diagnosa : euthyroid Persiapan preoperative: 1 Kontrol tekanan darah : turunkan tekanan darah 20% dari nilai awal, target MAP 105 – 125 mm Hg. 2 Iv line besar, persiapan darah 3 Monitoring denyut jantung 4 Pencegahan aspirasi pneumonia : 30 ml oral non particulated antacid + metocloperamide 10 mg iv + H2 blocker iv 5 Persiapan intubasi sulit: LMA, PDT, fiberoptik/bronkoskopi	5	

3. Rencana tindakan Anestesi dan keterampilan klinis	Peserta tidak ampu menentukan diagnose dan Peserta tidak mampu menjelaskan rencana anestesi	Peserta mampu menentukan tindakan anestesi tp tidak lengkap dan menjelaskan rencana anestesi namun tidak lengkap dan runut dan tidak melakukan	Peserta mampu menentukan tindakan anestesi dan menjelaskan rencana anestesi namun tidak lengkap dan runut dan melakukan	Peserta mampu menentukan tindakan anestesi dan menjelaskan rencana anestesi Dan melakukan PilihanAnestesi : General Anestesi intubasi dengan sadar Rencana Tindakan Anestesi : 1. STATIC, menyiapkan obat anestesi yang diperlukan, mengecek mesin anestesi dan alat monitor pasien, memakai alat pelindung diri (minimal handschoen) 2. Persiapan intubasi sulit: LMA, PDT, fiberoptik/bronkoskopi 3. Siapkan 3 ukuran ETT, memilih pipa endotrakeal dengan ukuran lebih kecil : 6 atau 6,5 mm 4. Induksi yang dalam dengan agen IV cepat (propofol / etomidate), analgetik (fentanyl), dan bila ada Muscle relaxan kerja cepat Suksinilkolin 1,5 mg/kgbb 5. Diberikan ventilasi tekanan positif, bila sudah dalam dan rilex 6. mengambil laryngoskop dengan tangan kiri, membuka mulut penderita tanpa ekstensi kepala, menyusuri lidah dari kiri ke kanan hingga tampak epiglottis dan plica vocalis 7. insersi pipa endotracheal 8. kembangkan cuff, 9. auskultasi untuk simetrisasi suara napas, 10. fiksasi 11. Mampu melakukan teknik	5	
---	--	--	--	--	----------	--

				rumatan anestesi umum dengan 2/3 MAC volatile anestesi		
4. Manajemen paska bedah	Peserta tidak mampu menjelaskan manajemen paska bedah	-	Peserta mampu menjelaskan manajemen paska bedah namun tidak lengkap	Peserta mampu menjelaskan manajemen paska bedah dengan lengkap 1. Pasien di rawat di ICU 2. Monitoring hemodinamik dan kemungkinan munculnya komplikasi 3. Pilihan utama analgesia sistemik opioid intravena menggunakan syringe pump 4. Bolus parasetamol dan NSAID bila tidak ada kontraindikasi 5. Disarankan menggunakan PCA karena pemberian dosis opioid intravena lebih mencerminkan kebutuhan pasien.	2	
5. Komunikasi, edukasi dan profesionalisme	Peserta ujian tidak meminta izin secara lisan dan sama sekali tidak melakukan poin berikut: 1. melakukan setiap tindakan dengan berhati-hati dan teliti sehingga tidak membahayakan pasien dan diri sendiri 2. memperhatikan kenyamanan pasien 3. melakukan tindakan sesuai prioritas	Meminta izin secara lisan dan 1-2 poin berikut : 1. melakukan setiap tindakan dengan berhati-hati dan teliti sehingga tidak membahayakan pasien dan diri sendiri 2. memperhatikan kenyamanan pasien 3. melakukan tindakan sesuai prioritas 4. menunjukkan rasa hormat kepada pasien	Meminta izin secara lisan dan 3 poin berikut: 1. melakukan setiap tindakan dengan berhati-hati dan teliti sehingga tidak membahayakan pasien dan diri sendiri 2. memperhatikan kenyamanan pasien 3. melakukan tindakan sesuai prioritas 4. menunjukkan rasa hormat kepada pasien	Meminta izin secara lisan dan melakukan di bawah ini secara lengkap : 1. melakukan setiap tindakan dengan berhati-hati dan teliti sehingga tidak membahayakan pasien dan diri sendiri 2. memperhatikan kenyamanan pasien 3. melakukan tindakan sesuai prioritas 4. menunjukkan rasa hormat kepada pasien mengetahui keterbatasan dengan merujuk atau melakukan konsultasi bila diperlukan	3	

	4. menunjukan rasa hormat kepada pasien mengetahui keterbatasan dengan merujuk atau melakukan konsultasi bila diperlukan	mengetahui keterbatasan dengan merujuk atau melakukan konsultasi bila diperlukan	mengetahui keterbatasan dengan merujuk atau melakukan konsultasi bila diperlukan			
--	--	--	--	--	--	--

II. Global performance

Beri tanda (v) pada kolom yang disediakan sesuai dengan penilaian Anda secara umum terhadap kemampuan peserta ujian!

Tidak lulus	Borderline	Lulus	Superior

.....,
Penguji,

(.....)

ANESTESIA BEDAH KEPALA LEHER

SOAL UJIAN OSCE STATION KEPALA LEHER

1	Nomor Station	5
2	Judul Station	Pascaoperasi <i>functional endoscopic sinus surgery</i> (FESS)
3	Waktu yang dibutuhkan	20 menit
4	Tujuan Station	Menilai kemampuan evaluasi problem aktual-potensial, rencana tindakan anestesi, keterampilan klinis, serta komunikasi, edukasi dan profesionalisme
5	Kompetensi	1. Evaluasi Pra Anestesia 2. Diagnosis Dan Problem Aktual – Potensial 3. Rencana Tindakan Anestesi 4. Keterampilan Klinis 5. Monitoring dan manajemen penyulit 6. Manajemen Pasca Anestesi 7. Komunikasi, Edukasi Dan Profesionalisme
6	Kategori	1. Anestesia Obstetrik 2. Anestesia Bedah Saraf 3. Anestesia Regional Dan Manajemen Nyeri 4. Anestesia Bedah Toraks 5. Anestesia Pediatrik 6. Anestesia Kegawatdaruratan 7. Anestesia Urologi 8. Anestesia Untuk Penyakit Khusus (Endokrin, Metabolik, Penyulit Kardiovaskular) 9. Anestesia Bedah Kepala Leher 10. Anestesia Bedah Rawat Jalan / Luar Kamar Bedah 11. Anestesia Pada Prosedur Invasif Minimal 12. Terapi Intensif
7	Intruksi untuk peserta ujian	<u>SKENARIO KLINIK :</u> Seorang laki-laki berusia 50 tahun, dibawa ke ruang pulih setelah menjalani operasi <i>functional endoscopic sinus surgery</i> (FESS). Pasien batuk berdarah dan tampak sesak napas. Tanda vital kesadaran CM, tekanan darah 130/90 mmHg, denyut nadi 124 x/menit, frekuensi napas 30 x/menit, SpO2 92% dengan sungkup muka sederhana 6 l/menit. Pasien ini didiagnosis dengan perdarahan pascaoperasi sinus, ASA IIE. Pasien direncanakan tindakan hemostasis di kamar operasi. <u>INSTRUKSI UNTUK PESERTA :</u> 1. Tentukan problem aktual-potensial yang dihadapi! 2. Sebutkan rencana tindakan anestesi! 3. Lakukan tindakan anestesi!
8	Instruksi untuk penguji	<u>INSTRUKSI UMUM</u> 1. Pastikan identitas peserta ujian pada kartu ujian 2. Tulislah nama dan nomor peserta ujian pada lembar penilaian! 3. Amatilah dan berilah skor (0/1/2/3) atas tugas yang dikerjakan peserta ujian serta skor <i>Global Rating</i> sesuai rubrik penilaian

		4. Hindarilah interupsi dan/atau tindakan selain daripada yang diminta dalam instruksi pengujian! 5. Berikan informasi/hasil yang dibutuhkan secara lisan/tulisan hanya apabila peserta ujian telah melakukan dan/atau mengusulkan jenis pemeriksaan yang dimaksud (perhatikan instruksi khusus)! 6. Taatilah peraturan serta etika pengujian selama menjalankan tugas sebagai pengujian OSCE - ATI! INSTRUKSI KHUSUS : 1. Pengujian menilai peserta menentukan problem aktual–potensial yang dihadapi. Problem aktual-potensial: <table border="1"> <tr> <th>No.</th><th>Problem aktual</th><th>Problem potensial</th></tr> <tr> <td>1</td><td>Perdarahan dari sinus</td><td> • Gangguan patensi jalan napas • Hipoperfusi jaringan • Hemodinamik tidak stabil perianestesi • Pneumonitis aspirasi </td></tr> </table> 2. Pengujian menilai peserta menyebutkan rencana tindakan anestesi Persiapan preanestesi dan preinduksi: 1. Perdarahan di mulut dibersihkan (<i>suction</i>) 2. Pasien diposisikan <i>head up</i> 3. Memastikan jalur infus berukuran besar 4. Lakukan <i>crossmatched</i> darah 5. Menilai status volume 6. Pasien direncanakan dengan anestesi umum dengan <i>rapid sequence induction</i> (RSI) atau <i>awake intubation</i> dan ekstubasi sadar (<i>awake extubation</i>) 3. Pengujian menilai tindakan anestesi yang dilakukan peserta 1. Jika peserta melakukan anestesi RSI sebagai berikut: 1. Peserta menyiapkan peralatan intubasi (STATICS): a. Scope: laryngoscope dan stetoscope b. Tube: ETT dengan 3 ukuran (6,5/7/7,5) c. Airway: Oropharyngeal airway d. Tapes e. Introducer f. Connector g. Suction berfungsi baik 2. Peserta menyiapkan obat anestesi yang diperlukan 3. Peserta memakai alat pelindung diri (minimal <i>handschoen</i>) 4. Pasien memposisikan pasien <i>head up position</i> minimal 30° 5. Peserta menggunakan obat hipnotik - sedatif untuk induksi dengan agen intravena, pelumpuh otot kerja cepat (suksinilkolin 1,5 mg/kgbb atau rocuronium 0,9-1,2 mg/kgbb, bila perlu <i>priming</i>).	No.	Problem aktual	Problem potensial	1	Perdarahan dari sinus	• Gangguan patensi jalan napas • Hipoperfusi jaringan • Hemodinamik tidak stabil perianestesi • Pneumonitis aspirasi
No.	Problem aktual	Problem potensial						
1	Perdarahan dari sinus	• Gangguan patensi jalan napas • Hipoperfusi jaringan • Hemodinamik tidak stabil perianestesi • Pneumonitis aspirasi						

		6. Asisten melakukan <i>cricoid pressure (sellick's maneuver)</i> 7. Peserta tidak memberikan ventilasi tekanan positif 8. Peserta melakukan intubasi setelah pelumput otot bekerja 9. Asisten mengembangkan cuff ETT namun masih melakukan <i>sellick's maneuver</i> 10. Peserta menyambungkan connector ETT dengan sirkuit anestesi 11. Asisten melepaskan penekanan cricoid 12. Peserta melakukan konfirmasi posisi ETT 13. Peserta melakukan fiksasi dengan tape 2. Jika peserta melakukan <i>awake intubation</i> sebagai berikut: 1. Peserta menyiapkan peralatan intubasi (STATICS): a. Scope: laryngoscope dan stetoscope b. Tube: ETT dengan 3 ukuran (6,5/7/7,5) c. Airway: Oropharyngeal airway d. Tapes e. Introducer f. Connector g. Suction berfungsi baik 2. Peserta menyiapkan obat anestesi yang diperlukan 3. Peserta memakai alat pelindung diri (minimal <i>handschoen</i>) 4. Pasien memposisikan pasien <i>head up position</i> minimal 30° 5. Peserta melakukan intubasi 6. Asisten mengembangkan cuff ETT 7. Peserta melakukan konfirmasi posisi ETT 8. Peserta melakukan fiksasi dengan tape 9. Peserta memasukkan obat-obat anestesi yang disiapkan 3. Peserta mampu melakukan teknik rumatan anestesi umum. 4. Peserta melakukan ekstubasi sadar.	
9	Tata letak station	Setting kamar operasi	
10	Kebutuhan laboran	Jumlah Laboran : 1 Tugas Laboran : Sebagai penata anestesi, membantu peserta dalam melakukan persiapan dan tindakan anestesi.	
11	Peralatan yang dibutuhkan	Setting Kamar operasi: - Stetoskop - Laringoskop Blade 3, 4 - ETT 7,5; 7; 6,5 - Oropharyngeal Airway 3, 4, 5 - Plester - Gunting - Introducer/ Stylet untuk dewasa - Mesin <i>Suction</i> - Kateter <i>suction</i> nomer 12	- 1 buah - 1 buah - 1 buah - 1 buah - 1 buah - 1 buah - 1 buah - 1 buah - 1 set - 1 buah

		- Sungkup No. 3, 4 - Spuit 10 cc untuk mengembangkan cuff ETT - Sarung tangan non steril - Bantal Intubasi - Spuit yang berlabel fentanyl, propofol, thiopental, lidocain, Rocuronium - Jelly untuk intubasi - <i>Penlight</i> - Manekin intubasi	- 1 buah - 1 buah - 1 box - 1 buah - Masing-masing 1 buah - 1 tube - 1 buah - 1 buah
12	Kebutuhan manekin	Manekin intubasi dewasa	
13	Penulis	Tim Soal OSCE ATI	
14	Referensi	Butterworth J, Mackey DC. Wasnick JD. Morgan & Mikhail's Clinical Anesthesiology. 2013. Mc Graw Hill Education: New York.	

RUBRIK PENILAIAN

Station Anestesi Bedah Kepala Leher

Aspek yang Dinilai	0	1	2	3	Bobot	Nilai						
1. Menentukan problem aktual-potensial yang dihadapi	Peserta tidak mampu menentukan problem aktual dan problem potensial	Peserta mampu menentukan problem aktual dan satu problem potensial atau hanya mampu menyebutkan problem potensial	Peserta mampu menentukan problem aktual dan dua problem potensial	Peserta mampu menentukan problem aktual-potensial secara lengkap Problem aktual-potensial: <table><tr><td>No.</td><td>Problem aktual</td><td>Problem potensial</td></tr><tr><td>1</td><td>Perdarahan dari sinus</td><td>1. Gangguan patensi jalan napas 2. Hipoperfusi jaringan 3. Hemodinamik tidak stabil perianestesi 4. Pneumonitis aspirasi</td></tr></table>	No.	Problem aktual	Problem potensial	1	Perdarahan dari sinus	1. Gangguan patensi jalan napas 2. Hipoperfusi jaringan 3. Hemodinamik tidak stabil perianestesi 4. Pneumonitis aspirasi	2	
No.	Problem aktual	Problem potensial										
1	Perdarahan dari sinus	1. Gangguan patensi jalan napas 2. Hipoperfusi jaringan 3. Hemodinamik tidak stabil perianestesi 4. Pneumonitis aspirasi										
2. Sebutkan rencana anestesi	Peserta tidak mampu menyebutkan rencana anestesi	Peserta mampu menyebutkan minimal 2 item	Peserta mampu menyebutkan minimal 4 item	Peserta mampu menyebutkan rencana anestesi secara lengkap: 1. Perdarahan di mulut dibersihkan (<i>suction</i>) 2. Pasien diposisikan <i>head up</i> 3. Memastikan jalur infus berukuran besar 4. Lakukan <i>crossmatched</i> darah 5. Menilai status volume 6. Pasien direncanakan dengan anestesi umum dengan <i>rapid sequence induction</i> (RSI) atau <i>awake</i>	2							

				<i>intubation</i> dan ekstubasi sadar (<i>awake extubation</i>)		
3. Melakukan tindakan anestesi	Peserta tidak melakukan tindakan anestesi	-	Peserta tidak melakukan tindakan anestesi dengan lengkap	Peserta melakukan tindakan anestesi secara lengkap: 1. Jika peserta melakukan anestesi RSI sebagai berikut: a. Peserta menyiapkan peralatan intubasi (STATICS):dan obat serta memakai alat pelindung diri b. Pasien memposisikan pasien <i>head up position</i> minimal 30° c. Peserta menggunakan obat-obat anestesi d. Asisten melakukan <i>cricoid pressure (sellick's maneuver)</i>, tidak memberikan ventilasi tekanan positif dan melakukan intubasi setelah pelumpuh otot bekerja e. Asisten mengembangkan cuff ETT namun masih melakukan <i>sellick's maneuver</i>, menyambungkan connector ETT dengan sirkuit anestesi dan melepaskan penekanan cricoid f. Peserta melakukan konfirmasi posisi ETT dan fiksasi dengan tape 2. Jika peserta melakukan <i>awake intubation</i> sebagai berikut: a. Peserta menyiapkan peralatan intubasi (STATICS dan obat anestesi yang diperlukan	4	

				b. Peserta memakai alat pelindung diri (minimal <i>handschoen</i>) c. Pasien memposisikan pasien <i>head up position</i> minimal 30° d. Peserta melakukan intubasi, mengembangkan cuff ETT dan melakukan konfirmasi posisi ETT e. Peserta melakukan fiksasi dengan tape f. Peserta memasukkan obat-obat anestesi yang disiapkan 3. Peserta mampu melakukan teknik rumatan anestesi umum. 4. Peserta melakukan ekstubasi sadar.		
4. Komunikasi, Edukasi Dan Profesionalisme	Peserta ujian tidak meminta meminta izin secara lisan dan sama sekali tidak melakukan point berikut: 1. melakukan setiap tindakan dengan berhati-hati dan teliti sehingga tidak membahayakan pasien dan diri sendiri 2. memperhatikan kenyamanan pasien	meminta izin secara lisan dan 1-2 point berikut: 1. melakukan setiap tindakan dengan berhati-hati dan teliti sehingga tidak membahayakan pasien dan diri sendiri 2. memperhatikan kenyamanan pasien 3. melakukan tindakan sesuai prioritas 4. menunjukkan rasa hormat kepada pasien	meminta izin secara lisan dan 3-4 point berikut: 1. melakukan setiap tindakan dengan berhati-hati dan teliti sehingga tidak membahayakan pasien dan diri sendiri 2. memperhatikan kenyamanan pasien 3. melakukan tindakan sesuai prioritas 4. menunjukkan rasa hormat kepada pasien	meminta izin secara lisan dan melakukan di bawah ini secara lengkap: 1. melakukan setiap tindakan dengan berhati-hati dan teliti sehingga tidak membahayakan pasien dan diri sendiri 2. memperhatikan kenyamanan pasien 3. melakukan tindakan sesuai prioritas 4. menunjukkan rasa hormat kepada pasien 5. mengetahui keterbatasan dengan merujuk atau melakukan konsultasi bila diperlukan	2	

	3. melakukan tindakan sesuai prioritas 4. menunjukkan rasa hormat kepada pasien 5. mengetahui keterbatasan dengan merujuk atau melakukan konsultasi bila diperlukan	5. mengetahui keterbatasan dengan merujuk atau melakukan konsultasi bila diperlukan	5. mengetahui keterbatasan dengan merujuk atau melakukan konsultasi bila diperlukan			
--	---	---	---	--	--	--

II. Global performance

Beri tanda (✓) pada kolom yang disediakan sesuai dengan penilaian Anda secara umum terhadap kemampuan peserta ujian!

Tidak lulus	Borderline	Lulus	Superior

.....,

Penguji,

(.....)

ANESTESIA BEDAH RAWAT JALAN (LUAR KAMAR BEDAH)

SOAL UJIAN OSCE STATION BEDAH RAWAT JALAN

1.	No. station	1
2.	Judul station	Anestesi pada Operasi Mata – pemasangan LMA
3.	Waktu yang dibutuhkan	17 menit
4.	Tujuan station	Menilai kemampuan problem aktual potensial, keterampilan klinis, manajemen pasca anestesi, dan komunikasi, edukasi dan profesionalisme
5.	Kompetensi	1. Evaluasi Pra Anestesia 2. Diagnosis dan Problem Aktual – Potensial 3. Rencana Tindakan Anestesi 4. Keterampilan Klinis 5. Monitoring dan manajemen penyulit 6. Manajemen Pasca Anestesia 7. Komunikasi, Edukasi dan Profesionalisme
6.	Kategori	1. Anestesia Obstetrik 2. Anestesia Bedah Saraf 3. Anestesia Regional Dan Manajemen Nyeri 4. Anestesia Bedah Toraks 5. Anestesia Pediatrik 6. Anestesia Kegawatdaruratan 7. Anestesia Urologi 8. Anestesia Untuk Penyakit Khusus (Endokrin, Metabolik, Penyulit Kardiovaskular) 9. Anestesia Bedah Kepala Leher 10. Anestesia Bedah Rawat Jalan / Luar Kamar Bedah 11. Anestesia Pada Prosedur Invasif Minimal 12. Terapi Intensif
7.	Instruksi untuk peserta	<u>SKENARIO KLINIK:</u> Seorang laki-laki usia 76 tahun berat badan 65 kg, tinggi badan 165cm, dengan direncanakan untuk bedah rawat jalan untuk tindakan pemasangan <i>Intraocular Lense</i> (IOL). Pasien tidak memiliki riwayat refluks, riwayat hipertensi terkontrol. Pasien akan dilakukan anestesi umum atas permintaan pasien. <u>INSTRUKSI PESERTA :</u> 1. Sebutkan problem aktual potensial! 2. Lakukan induksi anestesi umum dan pemasangan <i>Laryngeal Mask Airway</i> (LMA)! 3. Sebutkan kriteria pemulangan pasien bedah rawat jalan berdasarkan <i>Post-anesthesia Discharge Scoring System</i> (PADSS)! 4. Sebutkan edukasi pasca anestesi pasien ini!
8.	Instruksi untuk penguji	<u>INSTRUKSI UMUM</u> 1. Pastikan identitas peserta ujian pada kartu ujian sesuai dengan identitas pada komputer! 2. Tulislah 5 digit terakhir dari nomor peserta ujian pada lembar nilai tulis!

		- Amatilah dan berilah skor (0/1/2/3) atas tugas yang dikerjakan peserta ujian serta skor <i>Global Rating</i> sesuai rubrik penilaian pada lembar nilai tulis dan komputer! - Hindarilah interupsi dan/atau tindakan selain daripada yang diminta dalam instruksi penguji! - Berikan informasi/hasil yang dibutuhkan secara lisan/tulisan hanya apabila peserta ujian telah melakukan dan/atau mengusulkan jenis pemeriksaan yang dimaksud (perhatikan instruksi khusus)! - Taatilah peraturan serta etika penguji selama menjalankan tugas sebagai penguji UK OSCE! <u>INSTRUKSI KHUSUS</u> Penguji memberikan lampiran data pasien kepada peserta ujian. - Penguji mengamati dan menilai problem aktual potensial operasi mata yang disampaikan peserta: Problem aktual: - Hipertensi - Geriatri Problem potensial: - Hemodinamik tidak stabil. - Peningkatan tekanan intraokuler. - Refleks okulkardiak. - Penggunaan obat-obatan mata yang memiliki efek sistemik. - Penguji mengamati peserta melakukan induksi anestesia umum dan pemasangan <i>Laryngeal Mask Airway (LMA)</i>: - Mempersiapkan alat dan obat. - Memeriksa kesiapan alat- alat intubasi ETT. - Melakukan pemasangan monitor standar dan mengamati tanda vital. - Memilih ukuran LMA yang sesuai (LMA no 4). - Memeriksa kebocoran pada LMA. - Memastikan ujung <i>cuff</i> yang dideflasi tidak boleh berkerut atau tertekuk. - Memberikan lubrikasi pada sisi posterior <i>cuff</i>. - Pemberian premedikasi. - Melakukan induksi anestesi dan memastikan kedalaman anestesi sebelum memasang LMA. - Memposisikan pasien dalam <i>sniffing position</i>. - Memasukkan LMA melalui palatum durum menuju ke hipofaring sampai terasa tahanan. - Melakukan inflasi <i>cuff</i> dengan volume udara yang sesuai. - Memeriksa apakah terdapat obstruksi atau tidak. - Memastikan tidak terjadi kebocoran dengan <i>leak test</i>. - Melakukan fixasi. - Penguji menilai peserta menyebutkan kriteria pemulangan pasien bedah rawat jalan berdasarkan <i>Post-anesthesia Discharge Scoring System (PADSS)</i> dan instruksi pasca anestesi yang
--	--	---

		disampaikan peserta:																																		
		Tabel <i>Post-anesthesia Discharge Scoring System (PADSS)</i>.																																		
		<table><tr><td rowspan="3">Tanda vital</td><td>2</td><td>sekitar 20% dari nilai prabedah</td></tr><tr><td>1</td><td>20 - 40% dari nilai prabedah</td></tr><tr><td>0</td><td>40% dari nilai prabedah</td></tr><tr><td rowspan="3">Pergerakan</td><td>2</td><td>mampu berdiri/tidak ada pusing</td></tr><tr><td>1</td><td>dengan bantuan</td></tr><tr><td>0</td><td>tidak ada pergerakan/pusing</td></tr><tr><td rowspan="3">Mual/muntah</td><td>2</td><td>minimal</td></tr><tr><td>1</td><td>sedang</td></tr><tr><td>0</td><td>berat</td></tr><tr><td rowspan="2">Nyeri dapat ditoleransi</td><td>2</td><td>ya</td></tr><tr><td>1</td><td>tidak</td></tr><tr><td rowspan="3">Perdarahan dari luka operasi</td><td>2</td><td>minimal</td></tr><tr><td>1</td><td>sedang</td></tr><tr><td>0</td><td>berat</td></tr></table>		Tanda vital	2	sekitar 20% dari nilai prabedah	1	20 - 40% dari nilai prabedah	0	40% dari nilai prabedah	Pergerakan	2	mampu berdiri/tidak ada pusing	1	dengan bantuan	0	tidak ada pergerakan/pusing	Mual/muntah	2	minimal	1	sedang	0	berat	Nyeri dapat ditoleransi	2	ya	1	tidak	Perdarahan dari luka operasi	2	minimal	1	sedang	0	berat
Tanda vital	2	sekitar 20% dari nilai prabedah																																		
	1	20 - 40% dari nilai prabedah																																		
	0	40% dari nilai prabedah																																		
Pergerakan	2	mampu berdiri/tidak ada pusing																																		
	1	dengan bantuan																																		
	0	tidak ada pergerakan/pusing																																		
Mual/muntah	2	minimal																																		
	1	sedang																																		
	0	berat																																		
Nyeri dapat ditoleransi	2	ya																																		
	1	tidak																																		
Perdarahan dari luka operasi	2	minimal																																		
	1	sedang																																		
	0	berat																																		
		Total nilai 10. Bila nilai sama dengan atau lebih dari 9, pasien dinyatakan bisa dipulangkan																																		
		4. Penguji menilai peserta menyebutkan edukasi pasca anestesi yang disampaikan peserta.																																		
		Edukasi pasca anestesi:																																		
		a. Pasien pulang ditemani oleh orang dewasa yang bertanggungjawab.																																		
		b. Tidak boleh mengendarai kendaraan bermotor dan menjalankan mesin.																																		
		c. Memberikan instruksi pasca anestesi tertulis apa yang harus dilakukan dan siapa yang bisa dihubungi jika terjadi kegawatan dan kapan kontrol kembali (jika perlu).																																		
9	Tata letak station	Model ruang operasi																																		
10	Kebutuhan Laboran	Jumlah Laboran : 1 Tugas Laboran : Sebagai penata anestesi untuk membantu peserta dalam melakukan tindakan anestesi																																		
11	Peralatan yang dibutuhkan	Model ruang operasi - Mesin anestesi dan sirkuit anestesi - Stetoskop - LMA No. 3/ 4 - <i>Oropharyngeal Airway</i> 3/ 4/ 5 - Plester - Gunting - Mesin <i>suction</i>	1 buah 1 buah @ 1 buah @ 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah																																	

		- Kateter <i>suction</i> No. 10/ 12 - Sungkup No. 3/ 4 - Sarung tangan non steril - Bantal intubasi - Sduit berlabel obat anestesi (propofol/ midazolam/ tiopental/ fentanil/ atrakurium/ rokuronium/ lidokain) - Sduit berlabel obat emergensi (sulfas atropin/ adrenalin) - Sduit 20 cc - Ambu bag - Laringoskop <i>blade</i> 3, 4 - ETT No. 7/ 7,5/ 8	@ 1 buah @ 1 buah 1 kotak 1 buah @ 1 buah @ 1 buah 1 buah 1 buah @ 1 buah @ 1 buah
12	Kebutuhan Manekin	Manikin intubasi dewasa	
13	Penulis	Tim Soal OSCE ATI	
14	Referensi	Morgan Clinical Anesthesia	

RUBRIK PENILAIAN
ANESTESIA BEDAH RAWAT JALAN / LUAR KAMAR BEDAH

Aspek yang Dinilai	0	1	2	3	Bobot	Sko r
1. Diagnosis dan Problem Aktual – Potensial Problem aktual: 1. Hipertensi 2. Geriatri Problem potensial: 1. Hemodinamik tidak stabil. 2. Peningkatan tekanan intraokuler. 3. Refleks okulkardiak. 4. Penggunaan obat-obatan mata yang memiliki efek sistemik	Peserta tidak mampu menyebutkan problem potensial	Peserta mampu menyebutkan minimal 1 problem aktual dan 1 problem potensial Atau Hanya menyebutkan problem aktual Atau Hanya menyebutkan problem potensial	Peserta mampu menyebutkan 2 problem aktual Dan 2 problem potensial	Peserta mampu menyebutkan problem aktual dan potensial dengan lengkap	2	
4. Keterampilan Klinis Tindakan anestesi umum dengan Laryngeal Mask Airway (LMA): 1. Mempersiapkan alat dan obat. 2. Memeriksa kesiapan alat- alat intubasi ETT. 3. Melakukan pemasangan monitor standar dan mengamati tanda vital.	Peserta tidak ujian melakukan tahapan tindakan GA LMA dengan	-	Peserta ujian melakukan tahapan tindakan GA LMA dengan benar, tidak	Peserta ujian melakukan tahapan tindakan GA LMA dengan benar,	4	

4. Memilih ukuran LMA yang sesuai (LMA no 4). 5. Memeriksa kebocoran pada LMA. 6. Memastikan ujung <i>cuff</i> yang dideflasi tidak boleh berkerut atau tertekuk. 7. Memberikan lubrikasi pada sisi posterior <i>cuff</i>. 8. Pemberian premedikasi. 9. Melakukan induksi anestesi dan memastikan kedalaman anestesi sebelum memasang LMA. 10. Memposisikan pasien dalam <i>sniffing position</i>. 11. Memasukkan LMA melalui palatum durum menuju ke hipofaring sampai terasa tahanan. 12. Melakukan inflasi <i>cuff</i> dengan volume udara yang sesuai. 13. Memeriksa apakah terdapat obstruksi atau tidak. 14. Memastikan tidak terjadi kebocoran dengan <i>leak test</i>. 15. Melakukan fixasi benar, lengkap dan runut lengkap. lengkap dan runut														
6. Manajemen Pasca Anestesia Tabel <i>Post-anesthesia Discharge Scoring System</i> (PADSS). <table><tr><td rowspan="3">Tanda vital</td><td>2</td><td>sekitar 20% dari nilai prabedah</td></tr><tr><td>1</td><td>20 - 40% dari nilai prabedah</td></tr><tr><td>0</td><td>40% dari nilai prabedah</td></tr><tr><td rowspan="3">Pergerakan</td><td>2</td><td>mampu berdiri/tidak ada pusing</td></tr><tr><td>1</td><td>dengan bantuan</td></tr><tr><td>0</td><td>tidak ada pergerakan/pusing</td></tr></table> Peserta tidak mampu menyampaikan n pada penguji bagaimana kriteria pemulangan pasien bedah rawat jalan berdasarkan <i>Post-anesthesia Discharge Scoring System</i> - Peserta mampu menyampaikan pada penguji bagaimana kriteria pemulangan pasien bedah rawat jalan berdasarkan <i>Post-anesthesia Discharge Scoring System</i> (PADSS) dengan tidak lengkap Peserta mampu menyampaikan n pada penguji bagaimana kriteria pemulangan pasien bedah rawat jalan berdasarkan <i>Post-anesthesia Discharge Scoring System</i> 3	Tanda vital	2	sekitar 20% dari nilai prabedah	1	20 - 40% dari nilai prabedah	0	40% dari nilai prabedah	Pergerakan	2	mampu berdiri/tidak ada pusing	1	dengan bantuan	0	tidak ada pergerakan/pusing
Tanda vital		2	sekitar 20% dari nilai prabedah											
		1	20 - 40% dari nilai prabedah											
	0	40% dari nilai prabedah												
Pergerakan	2	mampu berdiri/tidak ada pusing												
	1	dengan bantuan												
	0	tidak ada pergerakan/pusing												

Mual/muntah Nyeri dapat ditoleransi Perdarahan dari luka operasi	2	minimal	(PADSS).			(PADSS) dengan lengkap.		
	1	sedang						
	0	berat						
	2	ya						
	1	tidak						
	2	minimal						
	1	sedang						
	0	berat						
Total nilai 10. Bila nilai sama dengan atau lebih dari 9 ,pasien dinyatakan bisa dipulangkan								
7. Komunikasi edukasi dan Perilaku profesional Edukasi paska anestesi: 1. Pasien pulang ditemani oleh orang dewasa yang bertanggungjawab. 2. Tidak boleh mengendarai kendaraan bermotor dan menjalankan mesin. 3. Memberikan instruksi pasca anestesi tertulis apa yang harus dilakukan dan siapa yang bisa dihubungi jika terjadi kegawatan dan kapan kontrol kembali (jika perlu			Peserta ujian tidak menyebutkan edukasi paska anestesi.	Peserta ujian menyebutkan 1 poin edukasi paska anestesi dengan lengkap	Peserta ujian menyebutkan 2 poin edukasi paska anestesi dengan lengkap	Peserta ujian menyebutkan edukasi paska anestesi dengan lengkap.	1	
TOTAL SKOR								

laki-laki usia 76 tahun berat badan 65 kg, tinggi badan 165cm

Anamnesis

Allergies = tidak ada

Medications = tidak ada

Past medical history = Riwayat penyakit dahulu tidak pernah sakit yang serius

Last meal = dipuasakan 6 jam sebelum operasi

Events = penglihatan buram sejak 2 bulan pra operasi

Pemeriksaan fisik

Tanda vital

- Laju napas 20 x/menit
- Tekanan darah 170/70 mmHg
- Laju nadi 90 x/menit, tekanan/volume cukup
- Temperatur 36.5°C

Pemeriksaan fisik dalam batas normal

Pemeriksaan penunjang

Hasil laboratorium

- Darah rutin
- Hb 12 gr/dl
- Ht 36 %
- Leukosit 7800/mm²
- Trombosit 310.000/mm²

Faal hemostasis

- PT 10.9 (12.2)
- APTT 35.8 (30.7)
- INR 1.5

Darah kimia

- Na 140 meq/L
- Kalium 3.8 meq.L
- Cl 100 mmol/L
- Glukosa 98 mg/dl

EKG

- Dalam batas normal

SOAL UJIAN OSCE STATION

ANESTESIA BEDAH RAWAT JALAN / LUAR KAMAR BEDAH

1.	No. Station	7
2.	Judul Station	Tumor Payudara
3.	Waktu Yang Dibutuhkan	20 menit
4.	Tujuan Station	Menilai Kemampuan Evaluasi Pra Anestesia, Diagnosis dan Problem Aktual – Potensial, Komunikasi, Edukasi dan Profesionalisme.
5.	Kompetensi	Evaluasi Pra Anestesia Diagnosis dan Problem Aktual – Potensial - Rencana Tindakan Anestesi - Keterampilan Klinis - Monitoring dan Manajemen Penyulit - Manajemen Pasca Anestesia Komunikasi, Edukasi dan Profesionalisme
6.	Kategori	- Anestesia Obstetrik - Anestesia Bedah Saraf - Anestesia Regional Dan Manajemen Nyeri - Anestesia Bedah Toraks - Anestesia Pediatrik - Anestesia Kegawatdaruratan - Anestesia Urologi - Anestesia Untuk Penyakit Khusus (Endokrin, Metabolik, Penyulit Kardiovaskular) - Anestesia Bedah Kepala Leher 10. Anestesia Bedah Rawat Jalan / Luar Kamar Bedah - Anestesia Pada Prosedur Invasif Minimal - Terapi Intensif
7.	Instruksi Untuk Peserta	<u>SKENARIO KLINIK:</u> Seorang wanita usia 24 tahun direncanakan operasi elektif insisi biopsi tumor payudara kanan. Pasien dengan keluhan benjolan di payudara kanan dan kiri sejak 2 tahun yang membesar perlahan-lahan sehingga sekarang berukuran kurang lebih 5x5 cm (kanan) dan 2x3 cm (kiri), mulai terasa nyeri dan mengganggu. Operasi diperkirakan selama 1 jam. <u>INSTRUKSI UNTUK PESERTA:</u> - Lakukan identifikasi dan evaluasi pra anestesia pada pasien ini. - Lakukan identifikasi problem aktual – potensial yang mungkin terjadi pada pasien ini. - Lakukan <i>informed consent</i> pada pasien tentang rencana tindakan anestesi dan mendapatkan persetujuan tindakan dari pasien.
8.	Instruksi Untuk Penguji	<u>INSTRUKSI UMUM</u> - Pastikan identitas peserta ujian pada kartu ujian. - Tulislah nama dan nomor peserta ujian pada lembar penilaian! - Amatilah dan berilah skor (0/1/2/3) atas tugas yang dikerjakan peserta

	ujian serta skor <i>Global Rating</i> sesuai rubrik penilaian. - Hindarilah interupsi dan/atau tindakan selain daripada yang diminta dalam instruksi penguji! - Berikan informasi/hasil yang dibutuhkan secara lisan/tulisan hanya apabila peserta ujian telah melakukan dan/atau mengusulkan jenis pemeriksaan yang dimaksud (perhatikan instruksi khusus)! - Taatilah peraturan serta etika penguji selama menjalankan tugas sebagai penguji OSCE - ATI! <u>INSTRUKSI KHUSUS</u> Penguji mengamati dan menilai tindakan pra anestesia yang dilakukan peserta dan memberikan hasil pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang (hanya bila diminta oleh peserta!) Penguji menilai kemampuan peserta untuk melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik: Anamnesis : Alergi obat ibuprofen, antalgin, asam mefenamat, ketorolak. Medication : Nebulizer ventolin 3 bulan lalu. Past illness : Riwayat asma, terakhir kambuh 3 bulan yang lalu dengan terapi nebulizer ventolin. Last Meal : 10 jam sebelum operasi, Event : (-) Vital Sign : Tensi 130/80mmHg, HR 68 x/menit, RR 12-14x/menit, Temp 36.5°C VAS Diam 0/100 mm dan VAS bergerak 0/100 mm. BB 50kg, TB 170cm. Airway : LEMON SCORE BAIK (Look externally, Evaluate, Mallampati, Obstruction, Neck mobility) Paru-paru : Vesikuler +/+, Ronkhi -/-, Wheezing -/ Pemeriksaan fisik lain : dalam batas normal Hasil Lab : Darah Rutin : Hb 12.8gr%, Hct 36.5, WBC 6100 gr%, Plt 169000 gr%. Kandidat mampu melakukan identifikasi problem actual-potensial: Problem aktual: Kecemasan karena pasien wanita muda Seorang penyanyi. Problem potensial : Asma kambuh, alergi obat, gangguan pada pita suara, nyeri pasca operasi, PONV Peserta ujian saat melakukan tugas <i>informed consent</i>, harus melakukan dengan serius. - Diagnosis kerja - Dasar diagnosis dan kondisi pasien - Tindakan anestesi yang akan dilakukan - Prosedur tindakan - Tujuan tindakan - Resiko tindakan - Efek samping obat - Komplikasi tindakan
--	--

		9. Alternatif dan resiko 10. Memberikan kesempatan kepada pasien dan atau keluarga untuk bertanya 11. Memberikan umpan balik yang baik atas pertanyaan pasien dan atau keluarga 12. Memperkenalkan diri dan mengucapkan salam
9	Denah Ruang	
10	Instruksi Pasien Standar	Nama : Sesuai Jenis Kelamin : Wanita Usia : 24 tahun Pekerjaan : Penyanyi profesional Status Pernikahan : Gadis Alamat : Bandung Keluhan utama : Benjolan di payudara Riwayat Penyakit Sekarang • Benjolan di payudara kanan dan kiri sejak 2 tahun yang lalu yang membesar perlahan-lahan sehingga sekarang berukuran kurang lebih 5x5 cm (kanan) dan 2x3 cm (kiri). • Riwayat Penyakit dahulu : Asma, terakhir kambuh 3 bulan yang lalu dengan terapi nebulizer ventolin. Saat ini tidak ada keluhan. • Riwayat Alergi : ✓ Obat : Ibuprofen, Antalgin, Asam Mefenamat, Ketorolak. ✓ Makanan : Tidak ada ✓ Debu / dingin : Tidak ada Riwayat Keluarga • Ibu pasien menderita kencing manis dan tekanan darah tinggi • Riwayat stroke di keluarga: tidak ada Riwayat Pengobatan: Nebulizer Ventolin untuk asma Riwayat Operasi : Tidak pernah. Riwayat kebiasaan • Merokok : Tidak pernah • Berolah raga : Jarang • Minum kopi / alkohol/ obat herbal: -/-/- • Makan 2x sehari terdiri dari nasi, sayur, tahu dan tempe. Daging/telur jarang. Buah-buahan kadang-kadang dikonsumsi. • Kadang-kadang juga konsumsi makanan kecil : pisang goreng, ketela goreng, kacang goreng atau panganan tradisional lain.

		Riwayat Sosial : Seorang penyanyi profesional Peran yang harus dilakukan pasien dalam keadaan duduk, tampak cemas, berdiskusi dengan dokter dan menanyakan masalah jenis tindakan anestesi yang aman untuk kelanjutan profesinya sebagai penyanyi. HAL YANG WAJIB DISAMPAIKAN PASIEN STANDAR : “Dok, saya tidak mau ada masalah dengan pita suara saya dan tidak mau ada lecet di wajah setelah operasi”	
11	Kebutuhan Laboran	Jumlah Laboran : 1 orang Tugas Laboran : Berperan sebagai pasien standar	
12	Peralatan Yang Dibutuhkan	Setting Ruangan Dokter- Pasien - Meja dan kursi dokter - Kursi pasien - Meja dan kursi penguji - Meja peralatan - Tempat tidur pemeriksaan (dilengkapi bantal dan selimut) - Sarung tangan - Stetoskop - Termometer raksa untuk aksila - Spigmomanometer raksa - Tempat sampah tertutup - Tissue - Jam dinding	- 1 set - 1 buah - 3 set - 1 buah - 1 set - 1 buah - 1 buah - 1 buah - 1 buah - 1 buah - 1 kotak - 1 buah
13	Kebutuhan Manekin	-	
14	Penulis	-	
15	Referensi	Morgan, GE; Mikhail, MS; Murray, MJ; 2006	

RUBRIK ACTUAL MARK

SOAL UJIAN OSCE STATION ANESTESIA BEDAH RAWAT JALAN / LUAR KAMAR BEDAH

Aspek yang Dinilai	0	1	2	3	Bobot	Skor
1. Evaluasi Pra Anestesia	Peserta hanya mampu identifikasi 0-1 point dari 8 point	Peserta hanya mampu identifikasi 2-4 point dengan tepat dari 8 point	Peserta hanya mampu identifikasi 5-7 point dengan tepat dan jelas dari 8 point	Peserta mampu identifikasi 8 point sbb dengan tepat dan jelas Keluhan Utama Alergi obat: ibuprofen, antalgin, asam mefenamat, ketorolac Medication: nebulizer ventolin 3 bulan lalu Past illness: riwayat asma, terakhir kumat ringan 3 bulan lalu dengan terapi nebulizer ventolin Last meal: 10 jam sebelum operasi, Event (-) Pemeriksaan tanda vital lengkap termasuk skala nyeri Paru-paru : tidak ada wheezing Pemeriksaan airway : LEMON SCORE baik	2	
2. Diagnosa dan Problem Aktual – Potensial	Kandidat hanya bisa identifikasi 1 problem dari 6 point	Kandidat hanya mampu melakukan identifikasi 2 -3 problem dari 6 point	Kandidat mampu melakukan identifikasi 3-4 problem dari 6 point	Kandidat mampu melakukan identifikasi seluruh problem yaitu: Kecemasan karena pasien wanita muda	2	

				seorang penyanyi. 2. Asma kambuh 3. Alergi obat 4. Gangguan pada pita suara 5. Masalah nyeri pasca operasi 6. PONV		
3. Komunikasi, Edukasi dan Profesionalisme	Kandidat hanya mampu melakukan 1-3 point dari 12 point	Kandidat hanya mampu melakukan 4-7 point dari 12 point	Kandidat hanya mampu melakukan 8-11 point dari 12 point	Kandidat mampu menjelaskan kepada pasien dan atau keluarganya hal sbb : 1. Diagnosis kerja 2. Dasar diagnosis dan kondisi pasien 3. Tindakan Anestesi yang akan dilakukan 4. Prosedure tindakan 5. Tujuan Tindakan 6. Resiko Tindakan 7. Efek samping obat 8. Komplikasi Tindakan 9. Alternatif dan Resiko 10. Memberikan kesempatan kepada pasien dan atau keluarga untuk bertanya 11. Memberikan umpan balik yang baik atas pertanyaan pasien dan atau keluarga 12. Memperkenalkan diri dan mengucapkan salam	4	

TOTAL SKOR	
-------------------	--

II. Global performance

Beri tanda (√) pada kolom yang disediakan sesuai dengan penilaian Anda secara umum terhadap kemampuan peserta ujian!

Tidak lulus	Borderline	Lulus	Superior

.....,

Penguji,

(.....)

ANESTESIA PADA PROSEDUR INVASIF MINIMAL

SOAL UJIAN OSCE STATION ANESTESIA PADA PROSEDUR INVASIF MINIMAL

1	Nomor Station	
2	Judul Station	KRIKOTIROIDOTOMI
3	Waktu yang dibutuhkan	20 menit
4	Tujuan Station	1. Menilai kemampuan evaluasi preoperatif 2. Menilai kemampuan menentukan diagnosa, problem aktual – potensial, dan persiapan preoperatif 3. Menilai kemampuan tindakan anestesi dan keterampilan klinis krikotiroidotomi 4. Menilai kemampuan manajemen paska bedah 5. Menilai kemampuan komunikasi, edukasi, dan profesionalisme
5	Kompetensi :	1. Evaluasi preoperatif 2. Menentukan diagnosa, problem aktual – potensial, dan persiapan preoperatif 3. Tindakan anestesi dan keterampilan klinis krikotiroidotomi 4. Manajemen paska bedah 5. Komunikasi, edukasi, dan profesionalisme
6	Kategori	1. Anestesi obstetri 2. Neuroanestesi 3. Anestesi Regional dan Manajemen Nyeri 4. Anestesi Kardiovaskular 5. Anestesi Pediatrik 6. Anestesi Kegawat daruratan 7. Anestesi Urologi 8. Anestesi untuk penyakit Endokrin, metabolic dan penyakit – penyakit khusus 9. ICU 10. Anestesi pada kepala leher 11. Airway Management
7	Intruksi untuk peserta ujian	<u>Skenario Klinik :</u> Seorang laki-laki 35 tahun datang ke UGD dengan keluhan nyeri perut kanan bawah sejak 6 jam SMRS. Dari pemeriksaan fisik dan penunjang oleh TS bedah didapatkan diagnosa appendisitis akut yang direncanakan tindakan operasi appendektomi cito. Instruksi untuk peserta : 1. Lakukan evaluasi preoperatif . 2. Tentukan diagnosis, problem aktual-potensial, dan persiapan preoperatif . 3. Tentukan rencana tindakan anestesi, kemungkinan komplikasi dan penanganannya. 4. Tentukan manajemen paska bedah
8	Instruksi untuk penguji	<u>Skenario Klinik :</u>

		Seorang laki-laki 35 tahun datang ke UGD dengan keluhan nyeri perut kanan bawah sejak 6 jam SMRS. Dari pemeriksaan fisik dan penunjang oleh TS bedah didapatkan diagnosa appendisitis akut yang direncanakan tindakan operasi appendiktomi cito. Pasien direncanakan untuk tindakan anestesi umum dengan intubasi endotrakea. Saat diintubasi ternyata mengalami kesulitan dan pasien jatuh ke dalam situasi <i>can not intubate, can not ventilate</i>. Sehingga dilakukan tindakan krikotiroidotomi emergensi. Peserta harus menjelaskan langkah-langkah dalam algoritme intubasi sulit sampai tindakan <i>emergency invasive airway access</i> dengan needle krikotiroidotomi. INSTRUKSI UMUM 1. Pastikan identitas peserta ujian pada kartu ujian 2. Tulislah nama dan nomor peserta ujian pada lembar penilaian! 3. Amatilah dan berilah skor (0/1/2/3) atas tugas yang dikerjakan peserta ujian serta skor <i>Global Rating</i> sesuai rubrik penilaian 4. Hindarilah interupsi dan/atau tindakan selain daripada yang diminta dalam instruksi penguji! 5. Berikan informasi/hasil yang dibutuhkan secara lisan/tulisan hanya apabila peserta ujian telah melakukan dan/atau mengusulkan jenis pemeriksaan yang dimaksud (perhatikan instruksi khusus)! 6. Taatilah peraturan serta etika penguji selama menjalankan tugas sebagai penguji OSCE - ATI! INSTRUKSI KHUSUS : 1. Penguji mengamati dan menilai evaluasi preoperatif yang dilakukan peserta dan memberikan hasil pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang bila diminta oleh peserta. Peserta menanyakan : Anamnesa A : alergi: (-) M: Medikasi: (-) P: Past illness: (-) L: last meal: 6 jam SMRS E: event: appendisitis akut Pemeriksaan Klinis: BB 83 kg, TB 157 cm, BMI 83 kg/m² Kesadaran Compos mentis GCS15 E4V5M6 A: buka mulut 3 jari, malampati 3, leher pendek, TMD > 6 cm, gerak leher bebas. Tampak benjolan di leher sebelah kanan, diameter 5 cm, tidak ada tanda-tanda radang. B: RR: 18x/menit SpO2: 99% udara bebas, suara dasar vesikuler di kedua lapang paru, tidak ada suara tambahan C: Tekanan darah 123/72 mmHg, Nadi 88 x/menit, kuat, Jantung : suara jantung normal, Suhu 37°C, CRT < 2 detik Abdomen: datar, nyeri tekan perut kanan bawah, defans (+) Produksi urine : 60 cc/jam Pemeriksaan penunjang :
--	--	--

		Hasil Laboratorium : Darah Rutin : Hb 12,8 gr%, Ht 36%, WBC 18 k/μL, Plt 287 gr/dl Faal Hemostasis : PT10,9 (12,2) , APTT 29,8 (30,7), INR 0,9 Bun (Ureum) : 34 mg/dl, Creatinin 0,9 mg/dl Na 137 mmol/L, Kalium 4,3 mmol/L ,Cl 100 mmol/L Glukosa 98 mg/dl, Thorak foto : CTR<50% C/P dbn EKG : Sinus rhytme HR 88, normoaksis 2. Diagnosis, problem aktual – potensial, persiapan preoperatif Diagnosis anesthesiologi: laki-laki, 35 tahun dengan apendisitis akut pro laparotomi apendiktomi cito dengan status fisik ASA II, rencana GA intubasi oral, respirasi kontrol. Problem aktual: - akut abdomen - obesitas derajat I - kemungkinan jalan napas sulit Problem potensial: - gagal intubasi-gagal ventilasi - desaturasi - nyeri pasca operasi Persiapan preoperatif: 1. Informed consent pasien dan keluarga pasien 2. Pasang iv line besar, rehidrasi, pastikan euolemia 3. Pencegahan aspirasi pneumonia : 30 ml oral non particulated antacid + metocloperamide 10 mg iv + H2 blocker iv 4. Persiapan intubasi sulit: LMA, needle krikotiroidotomi, transtrakeal jet insuflation, fiberoptik/bronkoskopi/video laringoskop (bila ada) 3. Penguji menilai Manajemen anestesi yang dilakukan peserta PilihanAnestesi : General Anestesi intubasi oral dengan teknik RSI Rencana Tindakan Anestesi : 1. STATICS, menyiapkan obat anestesi yang diperlukan, mengecek mesin anestesi dan alat monitor pasien, memakai alat pelindung diri (minimal handschoen) 2. Persiapan intubasi sulit: LMA, needle krikotiroidotomi, transtrakeal jet insuflation, fiberoptik/bronkoskopi/video laringoskop (bila ada) 3. Siapkan 3 ukuran ETT: 6,5 ; 7,0 ; 7,5 mm 4. Induksi dengan teknik RSI 5. mengambil laryngoskop dengan tangan kiri, membuka mulut penderita tanpa ekstensi kepala, menyusuri lidah dari kiri ke kanan hingga tampak epiglottis dan plica vocalis →3x usaha gagal →nyatakan gagal intubasi 6. panggil bantuan, Ventilasi dengan sungkup → tidak adekuat →desaturasi (SpO2 88%) (pertimbangkan bangun pasien, kembalikan ke pernapasan spontan) 7. pasang LMA →LMA tidak adekuat →pasien desaturasi (SpO2 79%)
--	--	--

		8. putus <i>emergency invasive airway access</i> → needle krikotiroidotomi 9. insersi iv catheter no 16/14 G yang dihubungkan dengan syringe di membran krikotiroid. Titik insersi di midline, arah jarum 45 derajat ke kaudal. 10. Aspirasi udara 11. Masukkan kateter, cabut jarum 12. Aspirasi udara kembali untuk memastikan kateter tetap berada di dalam trakea. Fiksasi dengan adekuat. 13. Sambungkan dengan jet insuflasi atau bila tidak ada sambungkan dengan ambu bag/breathing circuit dengan menggunakan spuit 3 cc + konektor ET 7,0 14. lakukan ventilasi sementara, konsul ke bagian terkait untuk jalan napas definitif trakeostomi. 15. Pertimbangkan untuk menunda operasi, lanjutkan dengan GA melalui trakeostomi. 4. Penguji menilai manajemen paska operatif yang disebutkan dan ditulis peserta 1. Informed consent 2. Pasien di rawat di ICU 3. Monitoring hemodinamik dan kemungkinan munculnya komplikasi 4. Pilihan utama analgesia sistemik opioid intravena menggunakan syringe pump 5. Bolus parasetamol. 6. Disarankan menggunakan PCA karena pemberian dosis opioid intravena lebih mencerminkan kebutuhan pasien.
9		Ruang 3mx4m Kursi penguji Meja penguji Meja Operasi Meja Alat T.Sampah Kursi PS Meja Peserta Kursi Peserta
10	Peralatan yang dibutuhkan	Setting ruangan dokter-pasien - Meja dan kursi dokter 1 set - Kursi pasien 1 buah - Meja dan kursi penguji 1 set - Meja peralatan 1 buah - Meja operasi 1 set - Manekin 1 buah

		- Monitor Pasien 1 buah - Mesin anestesi 1 unit - Stetoskop 1 buah - Laringoskop 1 buah - ETT 7,5;7,0; 6,5 @1 buah - Guedel/mayo 3 ukuran @ 1 buah - Plester 1 buah - Stilet 1 buah - Sungkup Muka 1 buah - Ambu Bag 1 buah - Suction/kanul/konektor @ 1 unit - Iv catheter no 14G/16G/18G/20G @ 1 buah - Spuit 10/5/3 @ 1 buah - LMA no. 3/4/5 @ 1 buah - Sarung tangan non steril - Rekam medis /informed consent @ 2 lembar - Tempat sampah tertutup 1 buah - Tissue 1 kotak - Jam dinding 1 buah
11	Refeensi	Morgan, Clinical Anesthesiology

LEMBAR PENILAIAN
STATION ANESTESI KRIKOTIROIDOTOMI

Kandidat Residen : _____

Aspek yang Dinilai	0	1	2	3	Bobot	Nilai
1. Evaluasi preoperatif	Peserta ujian tidak melakukan tindakan Atau melakukan tetapi tidak sesuai perintah Atau melakukan tetapi tidak sesuai masalah klinik pasien atau tidak melakukan pemeriksaan fisik	Kandidat hanya mampu identifikasi 5-6 point dari 8 point	Peserta mampu identifikasi 8 point tapi tidak lengkap, tidak sistematis.	1. Anamnesa (1 poin) - A : alergi: (-) - M: Medikasi: (-) - P: Past illness: (-) - L: last meal: 8 jam SMRS - E: event: appendisitis akut 2. Pemeriksaan Klinis: • BB 83 kg, TB 157 cm, BMI 83 kg/m² (1 poin) • Kesadaran Compos mentis GCS15 E4V5M6 • A: buka mulut 3 jari, malampati 3, leher pendek, TMD > 6 cm, gerak leher bebas. (1 poin) • B: RR: 18x/menit SpO2: 99% udara bebas, suara dasar vesikuler di kedua lapang paru, tidak ada suara tambahan (1 poin) • C: Tekanan darah 123/72 mmHg, Nadi 88 x/menit, kuat, Jantung : suara jantung normal, Suhu 37°C., CRT < 2 detik (1 poin) • Abdomen: datar, nyeri tekan perut kanan bawah, defans (+) (1 poin) • Produksi urine : 60 cc/jam (1 poin) 3. Pemeriksaan penunjang : (1 poin)	3	

				<u>Hasil Laboratorium</u> : Darah Rutin : Hb 12,8 gr%, Ht 36%, WBC 18 k/μL, Plt 287 gr/dl Faal Hemostasis : PT10,9 (12,2) , APTT 29,8 (30,7), INR 0,9 Bun (Ureum) : 34 mg/dl, Creatinin 0,9 mg/dl Na 137 mmol/L, Kalium 4,3 mmol/L, Cl 100 mmol/L Glukosa 98 mg/dl <u>Thorak foto</u> : CTR<50% C/P dbn <u>EKG</u> : Sinus rhytme HR 88, normoaksis		
2. Diagnosis, Problem aktual – potensial, dan persiapan preoperatif	Peserta tidak menyebutkan diagnosis, problem aktual-potensial, dan persiapan preoperatif	Peserta hanya mampu menentukan diagnosis	Peserta mampu menentukan diagnosis, problem aktual-potensial, dan persiapan preoperative, namun tidak lengkap	Peserta mampu menentukan diagnosis, problem aktual-potensial, dan persiapan preoperatif Diagnosis anesthesiologi: laki-laki, 35 tahun dengan apendisitis akut pro laparotomi apendiktomi cito dengan status fisik ASA II, rencana GA intubasi oral, respirasi kontrol. Problem aktual: - akut abdomen - obesitas derajat I - kemungkinan jalan napas sulit Problem potensial - gagal intubasi-gagal ventilasi - desaturasi - nyeri pasca operasi Persiapan preoperatif : 1. Informed consent pasien dan keluarga pasien 2. Pasang iv line besar, rehidrasi, pastikan euvolemia 3. Pencegahan aspirasi pneumonia : 30	5	

				ml oral non particulated antacid + metocloperamide 10 mg iv + H2 blocker iv 4. Persiapan intubasi sulit: LMA, needle krikotiroidotomi, transtrakeal jet insuflation, fiberoptik/bronkoskopi/video laringoskop (bila ada)		
3. Rencana tindakan Anestesi dan keterampilan klinis	Peserta tidak mampu menjelaskan rencana anestesi	Peserta mampu menentukan dan menjelaskan rencana anestesi namun tidak lengkap dan runut dan tidak melakukan keterampilan klinis krikotiroidotomi	Peserta mampu menentukan dan menjelaskan rencana anestesi, algoritma intubasi sulit, dan keterampilan klinis krikotiroidotomi, namun tidak lengkap dan runut	Peserta mampu menentukan dan menjelaskan rencana anestesi, algoritma intubasi sulit, dan keterampilan klinis krikotiroidotomi secara lengkap dan runut. Pilihan Anestesi : General Anestesi intubasi oral dengan teknik RSI Rencana Tindakan Anestesi : 1. STATICS, menyiapkan obat anestesi yang diperlukan, mengecek mesin anestesi dan alat monitor pasien, memakai alat pelindung diri (minimal handschoen) 2. Persiapan intubasi sulit: LMA, needle krikotiroidotomi, transtrakeal jet insuflation, fiberoptik/bronkoskopi/video laringoskop (bila ada) 3. Siapkan 3 ukuran ETT: 6,5 ; 7,0 ; 7,5 mm 4. Induksi dengan teknik RSI 5. mengambil laryngoskop dengan tangan kiri, membuka mulut penderita tanpa ekstensi kepala, menyusuri lidah dari kiri ke kanan hingga tampak epiglotis dan plica	5	

				vocalis → 3x usaha gagal →nyatakan gagal intubasi 6. panggil bantuan, ventilasi dengan sungkup → tidak adekuat →desaturasi (SpO2 88%) (pertimbangkan bangunkan pasien, kembalikan ke pernapasan spontan) 7. pasang LMA →LMA tidak adekuat →pasien desaturasi (SpO2 79%) 8. putus emergency invasive airway access → needle krikotiroidotomi 9. keterampilan klinis needle krikotiroidotomi • insersi iv catheter no 14/16 G yang dihubungkan dengan syringe, di membran krikotiroid. Titik insersi di midline, arah jarum 45 derajat ke kaudal. • Aspirasi udara (jarum berada di intratrakea) • Masukan kateter, cabut jarum • Aspirasi udara kembali untuk memastikan kateter tetap berada di dalam trakea. • Fiksasi dengan adekuat. • Sambungkan dengan jet insuflasi atau bila tidak ada sambungkan dengan ambu bag/breathing circuit dengan menggunakan spuit 3 cc + konektor ET 7,0 10. lakukan ventilasi sementara, konsul ke bagian terkait untuk jalan napas definitif trakeostomi. 11. Pertimbangkan untuk menunda		
--	--	--	--	---	--	--

				operasi, lanjutkan dengan GA melalui trakeostomi.		
4. Manajemen paska bedah	Peserta tidak mampu menjelaskan manajemen paska bedah	-	Peserta mampu menjelaskan manajemen paska bedah namun tidak lengkap	Peserta mampu menjelaskan manajemen paska bedah dengan lengkap 1. Informed consent 2. Pasien di rawat di ICU 3. Monitoring hemodinamik dan kemungkinan munculnya komplikasi 4. Pilihan utama analgesia sistemik opioid intravena menggunakan syringe pump 5. Bolus parasetamol. 6. Disarankan menggunakan PCA karena pemberian dosis opioid intravena lebih mencerminkan kebutuhan pasien.	2	
5. Komunikasi, edukasi dan profesionalisme	Peserta ujian tidak meminta izin secara lisan dan sama sekali tidak melakukan poin berikut: 1. melakukan setiap tindakan dengan berhati-hati dan teliti sehingga tidak membahayakan pasien dan diri sendiri 2. memperhatikan kenyamanan pasien 3. melakukan tindakan sesuai	Meminta izin secara lisan dan 1-2 poin berikut : 1. melakukan setiap tindakan dengan berhati-hati dan teliti sehingga tidak membahayakan pasien dan diri sendiri 2. memperhatikan kenyamanan pasien 3. melakukan tindakan sesuai prioritas 4. menunjukkan rasa	Meminta izin secara lisan dan 3 poin berikut: 1. melakukan setiap tindakan dengan berhati-hati dan teliti sehingga tidak membahayakan pasien dan diri sendiri 2. memperhatikan kenyamanan pasien 3. melakukan tindakan sesuai prioritas 4. menunjukkan rasa	Meminta izin secara lisan dan melakukan di bawah ini secara lengkap : 1. melakukan setiap tindakan dengan berhati-hati dan teliti sehingga tidak membahayakan pasien dan diri sendiri 2. memperhatikan kenyamanan pasien 3. melakukan tindakan sesuai prioritas 4. menunjukkan rasa hormat kepada pasien mengetahui keterbatasan dengan merujuk atau melakukan konsultasi bila diperlukan	3	

	prioritas 4. menunjukkan rasa hormat kepada pasien mengetahui keterbatasan dengan merujuk atau melakukan konsultasi bila diperlukan	hormat kepada pasien mengetahui keterbatasan dengan merujuk atau melakukan konsultasi bila diperlukan	hormat kepada pasien mengetahui keterbatasan dengan merujuk atau melakukan konsultasi bila diperlukan			
--	--	---	---	--	--	--

II. Global performance

Beri tanda (v) pada kolom yang disediakan sesuai dengan penilaian Anda secara umum terhadap kemampuan peserta ujian!

Tidak lulus	Borderline	Lulus	Superior

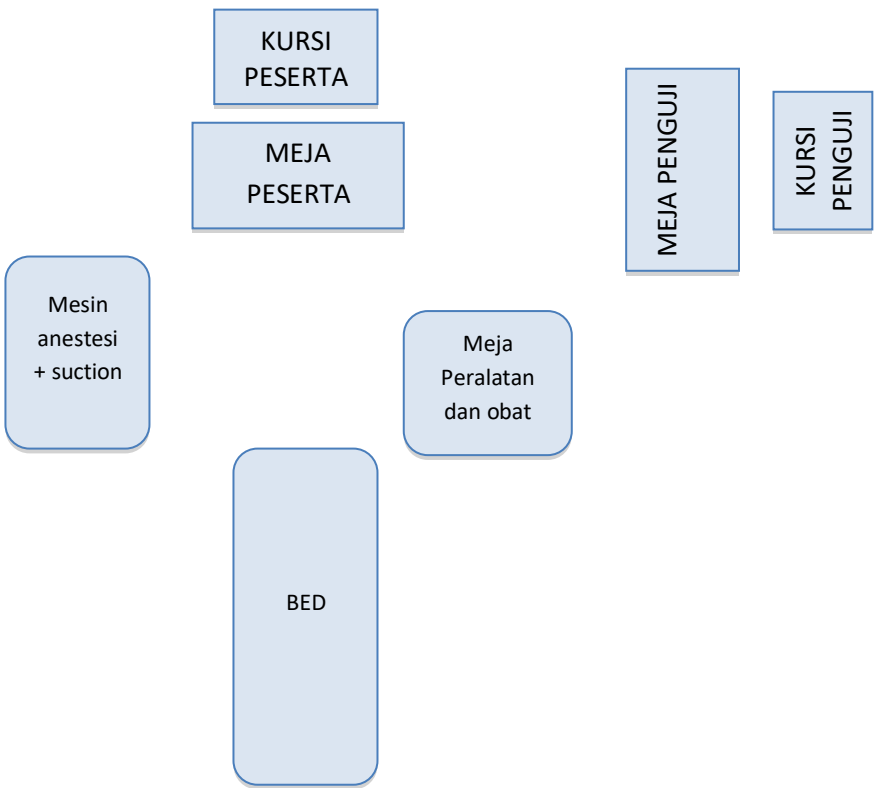
.....,
Penguji,

(.....)

SOAL UJIAN OSCE STATION ANESTESIA PADA PROSEDUR INVASIF MINIMAL

1.	No. station	
2.	Judul station	Laparoskopi appendiktomi
3.	Waktu yang dibutuhkan	20 menit
4.	Tujuan station	Menilai kemampuan evaluasi Pra anestesia, Diagnosis dan problem aktual – potensial, Keterampilan klinis, Monitoring dan manajemen penyulit, Komunikasi, edukasi dan profesionalisme
5.	Kompetensi	1. Evaluasi Pra Anestesia 2. Diagnosis Dan Problem Aktual – Potensial 3. Rencana Tindakan Anestesi 4. Keterampilan Klinis 5. Monitoring dan manajemen penyulit 6. Manajemen Pasca Anestesia 7. Komunikasi, Edukasi Dan Profesionalisme
6.	Kategori	1. Anestesia Pada Prosedur Invasif Minimal
7.	Instruksi untuk peserta	Skenario Klinik : Seorang laki-laki 34 tahun datang dengan keluhan nyeri perut kanan bawah sejak 2 hari lalu. Pasien juga mengeluhkan demam, mual serta nafsu makan menurun. Pasien minum paracetamol 500 mg di rumah dan merasa demam berkurang. Pasien memeriksakan diri ke dokter spesialis bedah dan didiagnosa dengan Appendisitis akut yang akan dilakukan operasi laparoskopi appendiktomi. Pasien memiliki berat badan 110 kg, tinggi badan 170 cm. Instruksi untuk peserta: 1. Lakukan evaluasi pre anestesi (anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang). 2. Tegakkan diagnosis pasien dan problem aktual dan potensial pada pasien. 3. Sebutkan rencana anestesi pada pasien 4. Durante operasi saat monitoring didapatkan ET CO ₂ 60 mmHg, bagaimana tatalaksananya
8.	Instruksi untuk penguji	<u>INSTRUKSI UMUM</u> 1. Pastikan identitas peserta ujian pada kartu ujian 2. Tulislah nama dan nomor peserta ujian pada lembar penilaian! 3. Amatilah dan berilah skor (0/1/2/3) atas tugas yang dikerjakan peserta ujian serta skor <i>Global Rating</i> sesuai rubrik penilaian 4. Hindarilah interupsi dan/atau tindakan selain daripada yang diminta dalam instruksi penguji! 5. Berikan informasi/hasil yang dibutuhkan secara lisan/tulisan hanya apabila peserta ujian telah melakukan dan/atau mengusulkan jenis pemeriksaan yang dimaksud (perhatikan instruksi khusus)! 6. Taatilah peraturan serta etika penguji selama menjalankan tugas sebagai penguji OSCE - ATI!

	<u>INSTRUKSI KHUSUS</u> 1. Penguji menilai kemampuan peserta untuk evaluasi pra operasi Anamnesis : A : riwayat alergi / asthma (-) M: Pasien meng konsumsi paracetamol 3x500mg P : pasien tidak pernah menderita penyakit kongenital ataupun kronis, riwayat tidur mengorok (+) L : 6 jam yang lalu E : nyeri perut kanan bawah sejak 2 hari lalu. Pasien juga mengeluhkan demam, mual serta nafsu makan menurun Pemeriksaan fisik B1 : Jalan nafas bebas, malampati 2, gigi ompong (-). RR 16 x/menit, napas spontan adekuat, retraksi (-). Suara nafas vesikuler Rh -/- Wheezing -/- SpO2 96% (oksigen 21%) B2 : nadi teraba kuat frekuensi 92 x/menit, tekanan darah 130/90 mmHg, mukosa mulut basah, turgor normal B3 : pasien tampak tenang B4 : Normal B5 : abdomen supel, bising usus normal, Nyeri tekan Mc Burney (+), Roving sign (+) B6 : Normal, suhu 37.5 C 2. Penguji menilai Diagnosis Dan Problem Aktual – Potensial ditegakkan peserta ujian Diagnosa : Laki-laki 34 tahun dengan appendisitis akut pro appendiktomi laparoskopi Problem actual dan potensial: • Obesitas • Infeksi • Nyeri • Hiperkapnea • Gangguan ventilasi dan hemodinamik karena posisi Trendelenburg 3. Penguji menilai rencana tindakan anestesi yang diusulkan / dikerjakan peserta ujian Anestesi umum napas kendali dengan intubasi 4. Penguji menilai pelaksanaan keterampilan klinis yang diusulkan / dikerjakan peserta ujian 1) Persiapan alat, obat anestesi dan emergensi 2) Monitoring fungsi vital yang meliputi EKG, Tekanan darah, SpO2, End tidal CO2 3) Preoksigenasi 4) Induksi insuflasi menggunakan sevoflurane atau induksi iv menggunakan obat sedasi dan obat pelumpuh otot 5) Intubasi dengan ETT no 7.5 6) Rumatan anestesi dengan obat agent inhalasi, narkotik fentanyl 1-2 mcg/kgBB, dan obat pelumpuh otot atracurium atau vecuronium atau rocuronium. 7) Rumatan cairan dengan kristaloid 8) Diberikan reversal neostigmin dan atropin
--	--

		9) Anestesi diakhiri, agent inhalasi dihentikan, dan ekstubasi dilakukan setelah pasien bernafas spontan dan adekuat 5. Penguji menilai penatalaksanaan monitoring / manajemen penyulit yang diusulkan / dikerjakan peserta ujian 1) Menginformasikan kepada operator untuk menghentikan operasi sementara karena terjadi asidosis respiratorik 2) Meningkatkan minute volume dengan cara hiperventilasi atau menaikkan volume tidal, pemberian PEEP dan modifikasi I : E rasio untuk menurunkan kadar CO₂ (melihat monitor End Tidal CO₂) 3) Mempersilakan operator untuk melanjutkan operasi bila nilai End Tidal CO₂ telah normal 6. Penguji menilai Komunikasi, edukasi dan profesionalisme peserta ujian	
9.	Denah ruangan		
11	Kebutuhan Laboran	Jumlah Laboran : 1 Tugas Laboran : Asisten anestesi	
12	Peralatan yang dibutuhkan	Setting ruangan dokter-pasien - Meja dan kursi dokter - Meja dan kursi penguji - Meja peralatan - Meja operasi - Manekin dengan telah terpasang infus	1 set 1 set 1 buah 1 buah 1 buah

		- Stetoskop - Monitor Pasien - Monitor End Tidal CO₂ - Stetoskop - Stylet - Laringoskop - Suction - Sungkup Muka - ETT 7,5 - Plester - Mesin anestesi dengan ventilator - Obat induksi dan premedikasi : - Midazolam - Fentanyl - Propofol - Atracurium - Rocuronium - Prostigmin - Naloxone - Sulfas Atropine - Adrenalin - Sarung tangan non steril - Rekam medis - Tempat sampah tertutup - Tissue - Jam dinding	1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 ampul 1 ampul 1 ampul 1 ampul 1 ampul 1 ampul 1 ampul 1 ampul 1 ampul 1 ampul 1 box 5 lembar 1 buah 1 kotak 1 buah
13	Kebutuhan Manekin	1 manekin intubasi	
15	Referensi	Morgan and Mikhael Clinical Anesthesiology	

RUBRIK ACTUAL MARK

STATION ANESTESIA PADA PROSEDUR INVASIF MINIMAL

LEMBAR PENILAIAN

Kandidat Residen : _____

Aspek yang Dinilai	0	1	2	3	Bobot	Skor
1. Evaluasi Pra operasi	Kandidat tidak melakukan evaluasi pra operasi	Peserta ujian hanya melakukan evaluasi praoperasi yang meliputi : - Anamnesa AMPLE ATAU - Pemeriksaan fisik B1 – B6	Peserta ujian melakukan evaluasi praoperasi secara tidak lengkap dan runut yang meliputi : - Anamnesa AMPLE - Pemeriksaan fisik B1 – B6 dengan lengkap dan runut	Peserta ujian melakukan evaluasi praoperasi secara lengkap dan runut yang meliputi : Anamnesa AMPLE Anamnesis : A : riwayat alergi / asthma (-) M: Pasien meng konsumsi paracetamol 3x500mg P : pasien tidak pernah menderita penyakit kongenital ataupun kronis, riwayat tidur mengorok (+), OSA (+) L : 6 jam yang lalu E : nyeri perut kanan bawah sejak 2 hari lalu. Pasien juga mengeluhkan demam, mual serta nafsu makan menurun Pemeriksaanfisik B1 – B6 B1 : Jalan nafas bebas,	3	

				malampati 2, gigi ompong (-). RR 16 x/menit, napas spontan adekuat, retraksi (-). Suara nafas vesikuler Rh -/- Wheezing -/- SpO2 96% (oksigen 21%) B2 : nadi teraba kuat frekuensi 92 x/menit , tekanan darah 130/90 mmHg, mukosa mulut basah, turgor normal B3 : pasien tampak tenang B4 : Normal produksi urin 30 cc / jam B5 : abdomen supel, bising usus normal, Nyeri tekan Mc Burney (+), Rovsing sign (+) B6 : Normal, suhu 37.5 C		
2. Diagnosa dan problem potensial – aktual	Peserta ujian tidak menyampaikan diagnosa, potensial problem dan pemeriksaan penunjang serta persiapan operasi yang dibutuhkan	Peserta ujian hanya menyampaikan diagnosa saja tanpa menyampaikan potensial problem dan pemeriksaan penunjang serta persiapan operasi yang dibutuhkan	Peserta ujian menyampaikan diagnosa, potensial problem, dan pemeriksaan penunjang serta persiapan operasi yang dibutuhkan namun tidak lengkap	Peserta ujian menyampaikan diagnosa, potensial problem, dan pemeriksaan penunjang serta persiapan operasi yang dibutuhkan secara lengkap dan benar Diagnosa : Laki-laki 34 tahun dengan appendisitis akut pro appendiktomi laparoskop Problem actual dan potensial:	3	

				• Obesitas • Infeksi • Nyeri • Hiperkapnea • Gangguan ventilasi dan hemodinamik karena posisi Trendelenburg		
3. Rencana tindakan Anestesi	Peserta ujian tidak menyampaikan rencana tindakan anestesi	-	Peserta ujian menyampaikan rencana tindakan anestesi namun tidak lengkap	Peserta ujian menyampaikan rencana tindakan anestesi secara lengkap Anestesi umum napas kendali dengan intubasi	2	
4. Keterampilan klinis	Peserta ujian tidak melakukan item tahapan pemberian anestesi nomor 2, 4, 5,6, 9	Peserta ujian minimal melakukan item tahapan pemberian anestesi nomor 2, 4, 5,6, 9	Peserta ujian melakukan tahapan pemberian anestesi dengan benar namun tidak runut	Peserta ujian melakukan semua tahapan pemberian anestesi dengan benar dan runut meliputi: 1) Persiapan alat, obat anestesi dan emergensi 2) Monitoring fungsi vital yang meliputi EKG, Tekanan darah, SpO2, End tidal CO2 3) Preoksigenasi 4) Induksi insuflasi menggunakan sevoflurane atau induksi iv menggunakan obat sedasi dan obat pelumpuh otot 5) Intubasi dengan ETT	3	

				no 7.5 6) Rumatan anestesi dengan obat agent inhalasi, narkotik fentanyl 1-2 mcg/kgBB, dan obat pelumpuh otot atracurium atau vecuronium atau rocuronium. 7) Rumatan cairan dengan kristaloid 8) Diberikan reversal neostigmin dan atropin 9) Anestesi diakhiri, agent inhalasi dihentikan, dan ekstubasi dilakukan setelah pasien bernafas spontan dan adekuat		
5. Monitoring dan manajemen penyulit	Peserta ujian tidak melakukan penatalaksanaan kegawatan	Peserta ujian melakukan penatalaksanaan kegawatan 1 item	Peserta ujian melakukan penatalaksanaan kegawatan 2 item	Peserta ujian melakukan semua item penatalaksanaan kegawatan yang meliputi : 1) Menginformasikan kepada operator untuk menghentikan operasi sementara karena terjadi asidosis respiratorik 2) Meningkatkan minute volume dengan cara hiperventilasi atau	5	

				menaikkan volume tidal, pemberian PEEP dan modifikasi I : E rasio untuk menurunkan kadar CO₂ (melihat monitor End Tidal CO₂) 3) Mempersilakan operator untuk melanjutkan operasi bila nilai End Tidal CO₂ telah normal		
7. Komunikasi dan Perilaku profesional	Peserta ujian tidak meminta meminta izin secara lisan dan sama sekali tidak melakukan point berikut: 1. melakukan setiap tindakan dengan berhati-hati dan teliti sehingga tidak membahayakan pasien dan diri sendiri 2. memperhatikan kenyamanan pasien 3. melakukan tindakan sesuai prioritas 4. menunjukkan rasa hormat kepada pasien 5. mengetahui keterbatasan	meminta izin secara lisan dan 1-2 point berikut: 1. melakukan setiap tindakan dengan berhati-hati dan teliti sehingga tidak membahayakan pasien dan diri sendiri 2. memperhatikan kenyamanan pasien 3. melakukan tindakan sesuai prioritas 4. menunjukkan rasa hormat kepada pasien 5. mengetahui keterbatasan	meminta izin secara lisan dan 3-4 point berikut: 1. melakukan setiap tindakan dengan berhati-hati dan teliti sehingga tidak membahayakan pasien dan diri sendiri 2. memperhatikan kenyamanan pasien 3. melakukan tindakan sesuai prioritas 4. menunjukkan rasa hormat kepada pasien 5. mengetahui keterbatasan	meminta izin secara lisan dan melakukan di bawah ini secara lengkap: 1. melakukan setiap tindakan dengan berhati-hati dan teliti sehingga tidak membahayakan pasien dan diri sendiri 2. memperhatikan kenyamanan pasien 3. melakukan tindakan sesuai prioritas 4. menunjukkan rasa hormat kepada pasien 5. mengetahui keterbatasan dengan merujuk atau melakukan konsultasi bila diperlukan	3	

	kenyamanan pasien 3. melakukan tindakan sesuai prioritas 4. menunjukkan rasa hormat kepada pasien 5. mengetahui keterbatasan dengan merujuk atau melakukan konsultasi bila diperlukan	dengan merujuk atau melakukan konsultasi bila diperlukan	dengan merujuk atau melakukan konsultasi bila diperlukan			
TOTAL SKOR						

II. Global performance

Beri tanda (✓) pada kolom yang disediakan sesuai dengan penilaian Anda secara umum terhadap kemampuan peserta ujian!

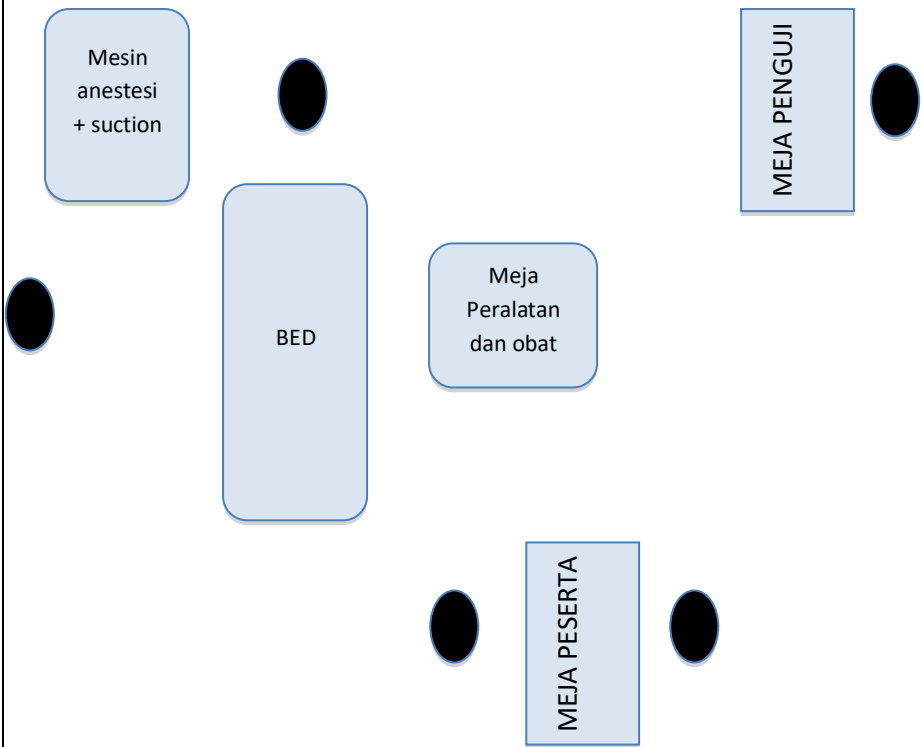
Tidak lulus	Borderline	Lulus	Superior

.....,
Penguji,

(.....)

SOAL UJIAN OSCE STATION ANESTESIA PADA PROSEDUR INVASIF MINIMAL

1.	No. station	
2.	Judul station	Pneumothorax ec laparoscopy
3.	Waktu yang dibutuhkan	20 menit
4.	Tujuan station	Menilai kemampuan evaluasi Pra anestesia, Diagnosis dan problem aktual – potensial, Keterampilan klinis, Monitoring dan manajemen penyulit, Komunikasi, edukasi dan profesionalisme
5.	Kompetensi	1. Evaluasi Pra Anestesia 2. Diagnosis Dan Problem Aktual – Potensial 3. Rencana Tindakan Anestesi 4. Keterampilan Klinis 5. Monitoring dan manajemen penyulit 6. Manajemen Pasca Anestesia 7. Komunikasi, Edukasi Dan Profesionalisme
6.	Kategori	1. Anestesia Pada Prosedur Invasif Minimal
7.	Instruksi untuk peserta	Skenario Klinik : Seorang wanita 33 tahun datang dengan keluhan benjolan di perut sejak 2 tahun yang lalu. Benjolan dirasakan makin membesar dan nyeri terutama saat haid. Riwayat kehamilan (-) dengan riwayat Haid tidak teratur. Pasien memeriksakan diri ke dokter spesialis OBGYN dan didiagnosa dengan kista coklat ovarium yang akan dilakukan operasi kistektomi laparoscopy. Instruksi untuk peserta: 1. Lakukan evaluasi pre anestesi (anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang). 2. Tegakkan diagnosis pasien dan rencana anestesi pada pasien. 3. Sebutkan problem pasien dan potensial problem pada pasien Lima menit setelah operator melakukan insersi trocar dan insuflasi CO₂, tekanan darah pasien turun secara tiba-tiba menjadi 70/35 mmHg, nadi 116x/menit, SpO₂ 82%, dan ET CO₂ 46 mmHg. Alarm mesin anestesi menyala dan terbaca sebagai peningkatan <i>airway pressure</i>. Dari pemeriksaan ETT clear tanpa obstruksi. Suara dasar vesikuler paru kanan hilang dan perkusi hemithoraks kanan didapatkan hipersonor 4. Sebutkan komplikasi yang terjadi pada pasien beserta tatalaksananya 5. Bagaimana manajemen paska operasi pada pasien
8.	Instruksi untuk penguji	<u>INSTRUKSI UMUM</u> 1. Pastikan identitas peserta ujian pada kartu ujian 2. Tulislah nama dan nomor peserta ujian pada lembar penilaian! 3. Amatilah dan berilah skor (0/1/2/3) atas tugas yang dikerjakan peserta ujian serta skor <i>Global Rating</i> sesuai rubrik penilaian 4. Hindarilah interupsi dan/atau tindakan selain daripada yang diminta dalam instruksi penguji! 5. Berikan informasi/hasil yang dibutuhkan secara lisan/tulisan hanya apabila peserta ujian telah melakukan dan/atau mengusulkan jenis pemeriksaan yang dimaksud (perhatikan instruksi khusus)! 6. Taatilah peraturan serta etika penguji selama menjalankan tugas sebagai penguji OSCE - ATI!

		<u>INSTRUKSI KHUSUS</u> 1. Penguji mengamati dan menilai penampilan peserta berdasarkan lembar penilaian. 2. Penguji menilai kemampuan peserta untuk evaluasi pra operasi 3. Penguji menilai Diagnosis Dan Problem Aktual – Potensial ditegakkan peserta ujian 4. Penguji menilai rencana tindakan anestesi yang diusulkan / dikerjakan peserta ujian 5. Penguji menilai pelaksanaan keterampilan klinis yang diusulkan / dikerjakan peserta ujian 6. Penguji menilai penatalaksanaan monitoring / manajemen penyulit yang diusulkan / dikerjakan peserta ujian 7. Penguji menilai penatalaksanaan pasca operasi yang diusulkan / dikerjakan peserta ujian 8. Penguji menilai Komunikasi, edukasi dan profesionalisme peserta ujian	
9.	Denah ruangan		
10	Instruksi Pasien Standar	Nama Usia Jenis Kelamin Pekerjaan Peran yang harus ditunjukkan Pertanyaan yang wajib ditanyakan Anamnesa	
11	Kebutuhan Laboran	Jumlah Laboran : 1 Tugas Laboran : Asisten anestesi	
12	Peralatan yang	Perlengkapan set intubasi (STATICS) dan obat GA	Emergency drugs Set Emergency

	dibutuhkan	Mesin Anestesi dan alat monitor	
13	Kebutuhan Manekin	1 manekin	
14	Penulis		
15	Referensi		
16	Reviewer		

RUBRIK ACTUAL MARK

SOAL UJIAN OSCE STATION ANESTESIA PADA PROSEDUR INVASIF MINIMAL

LEMBAR PENILAIAN

Kandidat Residen : _____

Aspek yang Dinilai	0	1	2	3	Bobot	Skor
1. Evaluasi Pra operasi	Kandidat tidak melakukan evaluasi pra operasi	Peserta ujian hanya melakukan evaluasi praoperasi yang meliputi : - Anamnesa AMPLE ATAU - Pemeriksaan fisik B1 – B6	Peserta ujian melakukan evaluasi praoperasi secara tidak lengkap dan runut yang meliputi : - Anamnesa AMPLE - Pemeriksaan fisik B1 – B6 dengan lengkap dan runut	Peserta ujian melakukan evaluasi praoperasi secara lengkap dan runut yang meliputi : Anamnesa AMPLE Anamnesis : A : riwayat alergi / asthma (-) M: Pasien tidak meng konsumsi obat P : pasien tidak pernah menderita penyakit kongenital ataupun kronis L : 6 jam yang lalu E : benjolan di perut sejak 2 tahun yang lalu. Benjolan dirasakan makin membesar dan nyeri terutama saat haid. Pemeriksaanfisik B1 – B6 B1 : Jalan nafas bebas, malampati 1,	2	

				gigi ompong (-). RR 12 x/menit, napas spontan adekuat, retraksi (-). Suara nafas vesikuler Rh -/- Wheezing -/- SpO2 100% (oksigen 21%) B2 : nadi teraba kuat frekuensi 72 x/menit , tekanan darah 120/70 mmHg, mukosa mulut basah, turgor normal B3 : pasien tampak tenang B4 : produksi urin 30 cc / jam B5 : abdomen supel, bising usus normal, teraba massa suprapubik B6 : suhu 36.6 C		
2. Diagnosa dan problem potensial – aktual	Peserta ujian tidak menyampaikan diagnosa, potensial problem dan pemeriksaan penunjang serta persiapan operasi yang dibutuhkan	Peserta ujian hanya menyampaikan diagnosa saja tanpa menyampaikan potensial problem dan pemeriksaan penunjang serta persiapan operasi yang dibutuhkan	Peserta ujian menyampaikan diagnosa, potensial problem, dan pemeriksaan penunjang serta persiapan operasi yang dibutuhkan namun tidak lengkap	Peserta ujian menyampaikan diagnosa, potensial problem, dan pemeriksaan penunjang serta persiapan operasi yang dibutuhkan secara lengkap dan benar • Diagnosa Wanita 33 tahun dengan kista coklat ovarium pro	2	

				kistektomi laparoscopy status fisik ASA 1 plan GAET • Potensial problem Hiperkarbia Pneumothorax Emfisema subkutan • Penunjang untuk screening problem • Laboratorium: Hemoglobin, hematokrit, Analisa gas darah • EKG • Sedia darah jika diperlukan		
3. Rencana tindakan Anestesi	Peserta ujian tidak menyampaikan rencana tindakan anestesi	Peserta ujian hanya menyampaikan rencana tindakan anestesi	Peserta ujian menyampaikan rencana tindakan anestesi namun tidak lengkap	Peserta ujian menyampaikan rencana tindakan anestesi secara lengkap • General Anestesi dengan respirasi kontrol		
4. Keterampilan klinis	Peserta ujian tidak melakukan item tahapan pemberian anestesi nomor 2, 4, 5,6, 9	Peserta ujian minimal melakukan item tahapan pemberian anestesi nomor 2, 4, 5,6, 9	Peserta ujian melakukan tahapan pemberian anestesi dengan benar namun tidak runut	Peserta ujian melakukan semua tahapan pemberian anestesi dengan benar dan runut meliputi : 1. Persiapan alat dan obat anestesi dan emergensi 2. Monitoring fungsi vital yang meliputi ECG, Tekanan darah, SpO2,	2	

				End tidal CO2 3. Preoksigenasi 4. Induksi insuflasi menggunakan sevoflurane atau induksi iv menggunakan obat sedasi dan obat pelumpuh otot 5. Intubasi dengan ETT no 7.5 6. Rumatan anestesi dengan obat agent inhalasi, narkotik fentanyl 1-2 mcg/kgBB atau morfin 0.1 mg/kgBB, dan obat pelumpuh otot atracurium atau vecuronium atau rocuronium. 7. Rumatan cairan dengan RL 6 – 8 ml/kgBB/jam 8. Diberikan reversal neostigmin dan atropin 9. Anestesi diakhiri, agent inhalasi dihentikan, dan ekstubasi dilakukan setelah pasien bernafas spontan dan adekuat 10. Pemberian analgetik pasca operasi berupa NSAID (misalnya		
--	--	--	--	---	--	--

				paracetamol iv 10 – 15 mg/kgBB; metamizol iv 10 mg/kgBB) atau Opioid sistemik		
5. Monitoring dan manajemen penyulit	Peserta ujian tidak melakukan penatalaksanaan kegawatan jalan yang meliputi item 2 dan 3	Peserta ujian melakukan penatalaksanaan kegawatan item 2 dan 3	Peserta ujian melakukan penatalaksanaan kegawatan minimal 3 item yang didalamnya mencakup item no 2,3, dan 4	Peserta ujian melakukan semua item penatalaksanaan kegawatan yang meliputi : 1. Menginformasikan kepada operator mengenai terjadinya pneumothorax dan meminta untuk menghentikan operasi dan deflasi peritoneum 2. Dilakukan needle thoracosentesis id ICS 2 linea midclavicularis kanan dengan iv cath ukuran 14G. 3. Konsul Bedah untuk pemasangan WSD 4. Paska operasi pasien dirawat di ICU	4	
6.Manajemen Pasca Anestesia	Peserta ujian tidak menyampaikan tatalaksana pasca anestesia secara lengkap dan benar	Peserta ujian hanya menyampaikan ruangan pasca anestesia saja tanpa meberikan tatalaksana paska operasi	Peserta ujian menyampaikan tatalaksana pasca anestesia namun tidak lengkap dan benar	Peserta ujian menyampaikan tatalaksana pasca anestesia secara lengkap dan benar • Paska operasi pasien dirawat di ICU		

				• Mode ventilator : CPAP PEEP 3-5, FiO2 30-50% • Weaning bertahap • Kontrol fungsi WSD • Manajemen nyeri dapat diberikan Morfin 10-20 mcg/kgBB/jam atau kombinasi dengan NSAID • Antibiotik spesifik gram negatif		
7. Komunikasi dan Perilaku profesional	Peserta ujian tidak meminta meminta izin secara lisan dan sama sekali tidak melakukan point berikut: 1. melakukan setiap tindakan dengan berhati-hati dan teliti sehingga tidak membahayakan pasien dan diri sendiri 2. memperhatikan kenyamanan pasien 3. melakukan tindakan sesuai	meminta izin secara lisan dan 1-2 point berikut: 1. melakukan setiap tindakan dengan berhati-hati dan teliti sehingga tidak membahayakan pasien dan diri sendiri 2. memperhatikan kenyamanan pasien 3. melakukan tindakan sesuai prioritas 4. menunjukkan rasa hormat kepada pasien 5. mengetahui keterbatasan	meminta izin secara lisan dan 3-4 point berikut: 1. melakukan setiap tindakan dengan berhati-hati dan teliti sehingga tidak membahayakan pasien dan diri sendiri 2. memperhatikan kenyamanan pasien 3. melakukan tindakan sesuai prioritas 4. menunjukkan rasa hormat kepada pasien	meminta izin secara lisan dan melakukan di bawah ini secara lengkap: 1. melakukan setiap tindakan dengan berhati-hati dan teliti sehingga tidak membahayakan pasien dan diri sendiri 2. memperhatikan kenyamanan pasien 3. melakukan tindakan sesuai prioritas 4. menunjukkan rasa hormat kepada pasien 5. mengetahui		

	prioritas 4. menunjukkan rasa hormat kepada pasien 5. mengetahui keterbatasan dengan merujuk atau melakukan konsultasi bila diperlukan	dengan merujuk atau melakukan konsultasi bila diperlukan	5. mengetahui keterbatasan dengan merujuk atau melakukan konsultasi bila diperlukan	keterbatasan dengan merujuk atau melakukan konsultasi bila diperlukan		
TOTAL SKOR						

II. Global performance

Beri tanda (√) pada kolom yang disediakan sesuai dengan penilaian Anda secara umum terhadap kemampuan peserta ujian!

Tidak lulus	Borderline	Lulus	Superior

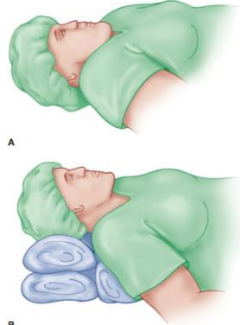
.....,
Penguji,

(.....)

SOAL UJIAN OSCE STATION ANESTESIA PADA PROSEDUR INVASIF MINIMAL

1.	No. station	
2.	Judul station	Laparoskopi appendiktomi obesitas (Intubasi)
3.	Waktu yang dibutuhkan	20 menit
4.	Tujuan station	Menilai kemampuan evaluasi pra anestesia, diagnosis dan problem aktual – potensial, keterampilan klinis, monitoring dan manajemen penyulit, serta komunikasi, edukasi dan profesionalisme
5.	Kompetensi	1. Evaluasi Pra Anestesi 2. Diagnosis dan Problem Aktual – Potensial 3. Rencana Tindakan Anestesi 4. Keterampilan Klinis 5. Monitoring dan manajemen penyulit 6. Manajemen Pasca Anestesi 7. Komunikasi, Edukasi dan Profesionalisme
6.	Kategori	1. Anestesia Obstetrik 2. Anestesia Bedah Saraf 3. Anestesia Regional dan Manajemen Nyeri 4. Anestesia Bedah Toraks 5. Anestesia Pediatrik 6. Anestesia Kegawatdaruratan 7. Anestesia Urologi 8. Anestesia Untuk Penyakit Khusus (Endokrin, Metabolik, Penyulit Kardiovaskular) 9. Anestesia Bedah Kepala Leher 10. Anestesia Bedah Rawat Jalan / Luar Kamar Bedah 11. Anestesia Pada Prosedur Invasif Minimal 12. Terapi Intensif
7.	Instruksi untuk peserta	Skenario Klinik: Seorang laki-laki 34 tahun, didiagnosis dengan appendisitis akut yang akan dilakukan operasi laparoskopi appendiktomi emergensi. Instruksi untuk peserta: 1. Lakukan evaluasi pre anestesi! 2. Sebutkan problem aktual - potensial pada kasus! 3. Lakukan manajemen anestesi pada kasus tersebut berupa anestesi umum dengan intubasi! 4. Durante operasi didapatkan kecenderungan denyut jantung menurun, sebutkan tatalaksana yang harus dilakukan?
8.	Instruksi untuk penguji	<u>INSTRUKSI UMUM</u> 1. Pastikan identitas peserta ujian pada kartu ujian 2. Tulislah nama dan nomor peserta ujian pada lembar penilaian! 3. Amatilah dan berilah skor (0/1/2/3) atas tugas yang dikerjakan peserta ujian serta skor <i>Global Rating</i> sesuai rubrik penilaian 4. Hindarilah interupsi dan/atau tindakan selain daripada yang diminta dalam instruksi penguji!

	5. Berikan informasi/hasil yang dibutuhkan secara lisan/tulisan hanya apabila peserta ujian telah melakukan dan/atau mengusulkan jenis pemeriksaan yang dimaksud (perhatikan instruksi khusus)! 6. Taatilah peraturan serta etika penguji selama menjalankan tugas sebagai penguji OSCE - ATI! <u>INSTRUKSI KHUSUS</u> 1. Penguji menilai kemampuan peserta untuk evaluasi pra operasi Anamnesis : A : riwayat alergi (-) M: pasien mengonsumsi paracetamol 3x500mg P : pasien tidak pernah menderita kronis, riwayat tidur mengorok (+) L : 6 jam yang lalu E : nyeri perut kanan bawah (VAS 7) sejak 2 hari lalu. Pasien juga mengeluhkan demam, mual serta nafsu makan menurun. Pemeriksaan fisik BB 110 kg, TB 170 cm, IMT: 38,1 Airway: gigi ompong (-), melakukan penilaian LEMON sebagai berikut: 1. LEMON a. L=Look externally • Tidak ada kelainan b. E=Evaluate the 3-3-2 rule: • Buka mulut 3 jari • <i>Hyoid/mental distance</i> 3 jari • <i>Thyroid-to-mouth distance</i> 2 jari c. M=Mallampati → Mallampati score 2 d. O=Obstruction → OSA (obstruktif sleep apneu) e. N=Neck mobility → fleksi-defleksi tidak terbatas 2. Periksa “Overbite” : tidak mampu untuk memprotrusi mandibular sehingga rahang bawah tidak dapat maju melewati rahang atas Respirasi: 16 x/menit, napas spontan adekuat, retraksi (-). Suara nafas vesikuler Rh -/- Wheezing -/- SpO2 96% (oksigen 21%) Kardiovaskular : laju nadi 92 x/menit (teraba kuat), tekanan darah 130/90 mmHg Suhu: 37.5 °C Abdomen: abdomen supel, bising usus normal, Nyeri tekan Mc Burney (+), Rovsing sign (+) Pemeriksaan penunjang: Darah Rutin: Leukositosis 2. Penguji menilai problem aktual–potensial yang disampaikan oleh peserta: Problem aktual: 1. Obesitas 2. Infeksi 3. Nyeri Problem potensial: 4. Difficult airway 5. Hiperkapnia
--	---

		6. Gangguan ventilasi dan hemodinamik karena posisi Trendelenburg 7. Refleks vagal 3. Penguji menilai tindakan anestesi umum dengan intubasi: 1) Persiapan alat (termasuk peralatan jalan napas sulit), obat anestesi dan emergensi 2) Monitoring fungsi vital yang meliputi EKG, Tekanan darah, SpO₂, End tidal CO₂ 3) Pasien diposisikan <i>ramp / stacking position</i>:  FIGURE 41-2 Optimal positioning for obese patients with a short neck. A: The normal supine position often prevents extension of the head and makes endotracheal intubation difficult. B: Elevation of the shoulder allows some neck flexion with more optimal extension of the head at the atlantooccipital joint, facilitating intubation. 4) Preoksigenasi dengan Oksigen 100% 5) Induksi dilanjutkan dengan inhalasi anestesi 6) Intubasi dengan ETT No 7.5 7) Rumatan anestesi dengan obat inhalasi anestesi, narkotik dan obat pelumpuh otot 8) Manajemen cairan intraoperasi 9) Diberikan reversal neostigmin dan atropin 10) Obat inhalasi dihentikan 11) Ekstubasi dilakukan setelah pasien bernafas spontan dan adekuat 4. Penguji menilai penatalaksanaan monitoring / manajemen penyulit yang diusulkan / dikerjakan peserta ujian 1) Menginformasikan kepada operator untuk menghentikan operasi sementara karena terjadi bradikardi 2) Menurunkan tekanan gas insuflasi 3) Memberikan vagolitik (sulfas atropine)
9.	Denah ruangan	
11	Kebutuhan Laboran	Jumlah Laboran : 1 Tugas Laboran : Asisten anestesi
12	Peralatan yang dibutuhkan	Setting ruangan dokter-pasien - Meja dan kursi dokter - Meja dan kursi penguji - Meja peralatan - Meja operasi - Manekin dengan telah terpasang infus - Stetoskop - Monitor Pasien - Monitor End Tidal CO₂
		1 set 1 set 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah

		- Stetoskop - Stylet - Laringoskop - Suction - Sungkup Muka - ETT 7,5 - Plester - Mesin anestesi dengan ventilator - Obat induksi dan premedikasi : - Midazolam - Fentanyl - Propofol - Atracurium - Rocuronium - Prostigmin - Naloxone - Sulfas Atropine - Adrenalin - Sarung tangan non steril - Rekam medis - Tempat sampah tertutup - Tissue - Jam dinding	1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 ampul 1 ampul 1 ampul 1 ampul 1 ampul 1 ampul 1 ampul 1 ampul 1 ampul 1 box 5 lembar 1 buah 1 kotak 1 buah
13	Kebutuhan Manekin	1 manekin intubasi	
15	Referensi	1. Modul KATI 2017 2. Butterworth JF, Mackey DC, Wasnick JD, Morgan & Mikhail's Clinical Anesthesiology. 5th Ed. New York: McGraw Hill; 2013	

RUBRIK ACTUAL MARK

STATION ANESTESIA PADA PROSEDUR INVASIF MINIMAL

LEMBAR PENILAIAN

Kandidat Residen : _____

Aspek yang Dinilai	0	1	2	3	Bobot	Skor
1. Evaluasi Pra operasi	Kandidat tidak melakukan evaluasi pra operasi	-	Melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang namun TIDAK lengkap.	Melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang secara lengkap.		
2. Diagnosa dan problem potensial – aktual	Peserta tidak mampu menyebutkan problem potensial	Peserta hanya mampu menyebutkan 1-2 dari 6 problem aktual - potensial	Peserta hanya mampu menyebutkan 3-5 dari 6 problem aktual-potensial	Peserta menyebutkan seluruh item aktual - potensial problem yaitu: Problem aktual: 1. Obesitas 2. Infeksi 3. Nyeri Problem potensial: 4. Difficult airway 5. Hiperkapnia Gangguan ventilasi dan hemodinamik karena posisi Trendelenburg		
4. Keterampilan klinis	Peserta tidak melakukan tindakan anestesi berupa Persiapan alat dan prosedur		Peserta mampu melakukan tindakan anestesi berupa Persiapan alat dan prosedur anestesi umum intubasi dengan	Peserta mampu melakukan tindakan anestesi berupa Persiapan alat dan prosedur anestesi umum intubasi dengan penyulit obesitas secara lengkap dan runut	3	

	anestesi umum intubasi dengan penyulit obesitas		penyulit obesitas secara tidak lengkap dan runut			
5. Monitoring dan manajemen penyulit	Peserta ujian tidak melakukan penatalaksanaan kegawatan	Peserta ujian melakukan penatalaksanaan kegawatan 1 dari 3 item	Peserta ujian melakukan penatalaksanaan kegawatan 2 dari 3 item	Peserta ujian melakukan semua item penatalaksanaan kegawatan yang meliputi : 1) Menginformasikan kepada operator untuk menghentikan operasi sementara karena terjadi bradikardi 2) Menurunkan tekanan gas insuflasi 3) Memberikan vagolitik (sulfas atropine)	5	
7. Komunikasi dan Perilaku profesional	Peserta ujian tidak meminta meminta izin secara lisan dan sama sekali tidak melakukan point berikut: 1. melakukan setiap tindakan dengan berhati-hati dan teliti sehingga tidak membahayakan	meminta izin secara lisan dan 1-2 point berikut: 1. melakukan setiap tindakan dengan berhati-hati dan teliti sehingga tidak membahayakan pasien dan diri sendiri 2. memperhatikan kenyamanan pasien 3. melakukan tindakan sesuai prioritas	meminta izin secara lisan dan 3-4 point berikut: 1. melakukan setiap tindakan dengan berhati-hati dan teliti sehingga tidak membahayakan pasien dan diri sendiri 2. memperhatikan kenyamanan pasien 3. melakukan tindakan sesuai prioritas	meminta izin secara lisan dan melakukan di bawah ini secara lengkap: 1. melakukan setiap tindakan dengan berhati-hati dan teliti sehingga tidak membahayakan pasien dan diri sendiri 2. memperhatikan kenyamanan pasien 3. melakukan tindakan sesuai prioritas 4. menunjukkan rasa hormat kepada pasien 5. mengetahui keterbatasan dengan merujuk atau	3	

	an pasien dan diri sendiri 2. memperhatikan kenyamanan pasien 3. melakukan tindakan sesuai prioritas 4. menunjukkan rasa hormat kepada pasien 5. mengetahui keterbatasan dengan merujuk atau melakukan konsultasi bila diperlukan	4. menunjukkan rasa hormat kepada pasien 5. mengetahui keterbatasan dengan merujuk atau melakukan konsultasi bila diperlukan	4. menunjukkan rasa hormat kepada pasien 5. mengetahui keterbatasan dengan merujuk atau melakukan konsultasi bila diperlukan	melakukan konsultasi bila diperlukan		
TOTAL SKOR						

II. Global performance

Beri tanda (✓) pada kolom yang disediakan sesuai dengan penilaian Anda secara umum terhadap kemampuan peserta ujian!

Tidak lulus	Borderline	Lulus	Superior

.....,
Penguji,

(.....)

ANESTHESIA EMERGENCY

SOAL UJIAN OSCE STATION ANESTESIA KEGAWATDARURATAN

1.	Nomor station	
2.	Judul station	Anestesiologi dan Terapi Intensif - Digestive and emergency
3.	Waktu yang dibutuhkan	20 menit
4.	Tujuan station	Menilai kemampuan dalam melakukan tindakan pemasangan CVC subclavia.
5.	Kompetensi	1. Evaluasi Preoperative 2. Diagnosa dan problem potensial – aktual 3. Rencana tindakan anestesi 4. Keterampilan klinis 5. Monitoring 6. Manajemen paska bedah 7. Komunikasi, edukasi dan profesionalisme
6.	Kategori	Digestive and emergency
8.	Instruksi untuk peserta ujian	<u>Skenario klinik:</u> Seorang pria dewasa usia 60 tahun datang ke UGD rujukan puskesmas dengan peritonitis dengan syok. Tanda vital : TD 70/30, N 140 x/m, suhu 39,5°C, rr 28x/mnt. <u>Tugas :</u> - Lakukan informed consent pada pasien/ keluarga tentang tindakan pemasangan CVC subclavia - Lakukan tindakan pemasangan CVC subclavia
9.	Instruksi untuk penguji	<u>Skenario klinik:</u> Seorang pria dewasa usia 60 tahun datang ke UGD rujukan puskesmas dengan peritonitis dengan syok. Tanda vital : TD 70/30, N 140 x/m, suhu 39,5°C, rr 28x/mnt. <u>Tugas :</u> - Lakukan informed consent pada pasien/ keluarga tentang tindakan pemasangan CVC subclavia - Lakukan tindakan pemasangan CVC subclavia <u>Instruksi :</u> • Penguji mengamati kandidat dalam melakukan informed consent tindakan pemasangan CVC subclavia. • Penguji mengamati kandidat dalam melakukan tindakan pemasangan CVC subclavia. • Penguji tidak diperbolehkan melakukan interupsi ataupun bertanya kepada peserta selain yang ditentukan
10	Instruksi untuk pasien	• Pasien simulasi adalah keluarga yang

	simulasi	bertanggung jawab dari pasien yang menerima informed consent dari kandidat. • Pasien simulasi menyetujui tindakan informed consent
11	Peralatan yang dibutuhkan	- Setting ruang UGD - Meja dan kursi dokter 1 buah - Kursi pasien 2 buah - Meja dan kursi penguji 1 buah - Lembar kertas jawaban - Manekin CVC - Asisten - 1 orang keluarga pasien - CVC catheter 1 (CVC dalam keadaan sudah dibukakan disiapkan oleh asisten) - Infus set - Tranfusi set - RL 5 fl - NaCl 5 fl - S spuit 3 cc 10 - S spuit 5 cc 10 - Lidocain - Tiang infus - Duck steril - Hecting set (jarum, needle holder, benang, pinset, klem, gunting) - Kassa - Plester
12	Assisten	Assisten : - Membantu kandidat dalam tindakan pemasangan CVC - Mempersiapkan hecting set, - Menyiapkan Cairan dan infus set (sudah dalam keadaan terpasang pada tiang infus) - Membantu menyambung CVC dengan selang infus setelah terpasang - Membantu kandidat dalam hecting
13	Penulis	dr. Taufik Eko Nugroho SpAn MSiMed Bagian Anestesiologi dan Terapi Intensif FK UNDIP – RSDK Semarang
14	Referensi	Morgan, Clinical Anesthesiology

LEMBAR PENILAIAN

STATION ANESTESI DIGESTIV EMERGENCY/CVC SUBCLAVIA

Kandidat Residen : _____

Aspek yang Dinilai	0	1	2	3	Bobot	Nilai
1. Keterampilan klinis	Peserta tidak bisa melakukan tindakan anestesi sama sekali	-	Peserta mampu melakukan tindakan anestesi tp tidak lengkap	Kandidat melakukan: - Cuci tangan - Pakai handscoen - Disinfeksi - Tutup dengan doek steril - Landmark dan posisi pasien utk memudahkan insersi CVC Kandidat melakukan dengan lengkap dan urut 7 hal dari : - Infiltrasi lokal anestesi - Insersi jarum CVC - Aspirasi darah - Memasukkan wire - Dilatasi - Memasukkan CVC (mempertahankan posisi wire) - Mengambil wire - Tes aspirasi - Fixasi - Sambungkan dengan infus set - Evaluasi cvc paska pemasangan dengan foto thorax	5	
4. Komunikasi, edukasi dan profesionalisme	Peserta ujian tidak meminta izin secara lisan dan sama sekali tidak melakukan poin	Meminta izin secara lisan dan 1-2 poin berikut : 1. melakukan setiap tindakan dengan	Meminta izin secara lisan dan 3 poin berikut: 1. melakukan setiap tindakan dengan	Meminta izin secara lisan dan melakukan di bawah ini secara lengkap : 1. melakukan setiap tindakan dengan berhati-hati dan teliti	3	

	berikut: 1. melakukan setiap tindakan dengan berhati-hati dan teliti sehingga tidak membahayakan pasien dan diri sendiri 2. memperhatikan kenyamanan pasien 3. melakukan tindakan sesuai prioritas 4. menunjukkan rasa hormat kepada pasien mengetahui keterbatasan dengan merujuk atau melakukan konsultasi bila diperlukan	berhati-hati dan teliti sehingga tidak membahayakan pasien dan diri sendiri 2. memperhatikan kenyamanan pasien 3. melakukan tindakan sesuai prioritas 4. menunjukkan rasa hormat kepada pasien mengetahui keterbatasan dengan merujuk atau melakukan konsultasi bila diperlukan	berhati-hati dan teliti sehingga tidak membahayakan pasien dan diri sendiri 2. memperhatikan kenyamanan pasien 3. melakukan tindakan sesuai prioritas 4. menunjukkan rasa hormat kepada pasien mengetahui keterbatasan dengan merujuk atau melakukan konsultasi bila diperlukan	sehingga tidak membahayakan pasien dan diri sendiri 2. memperhatikan kenyamanan pasien 3. melakukan tindakan sesuai prioritas 4. menunjukkan rasa hormat kepada pasien 5. menjelaskan prosedur tindakan kepada pasien/keluarga dan segala efek samping yg mungkin timbul mengetahui keterbatasan dengan merujuk atau melakukan konsultasi bila diperlukan		
--	---	---	---	--	--	--

II. Global performance

Beri tanda (v) pada kolom yang disediakan sesuai dengan penilaian Anda secara umum terhadap kemampuan peserta ujian!

Tidak lulus	Borderline	Lulus	Superior

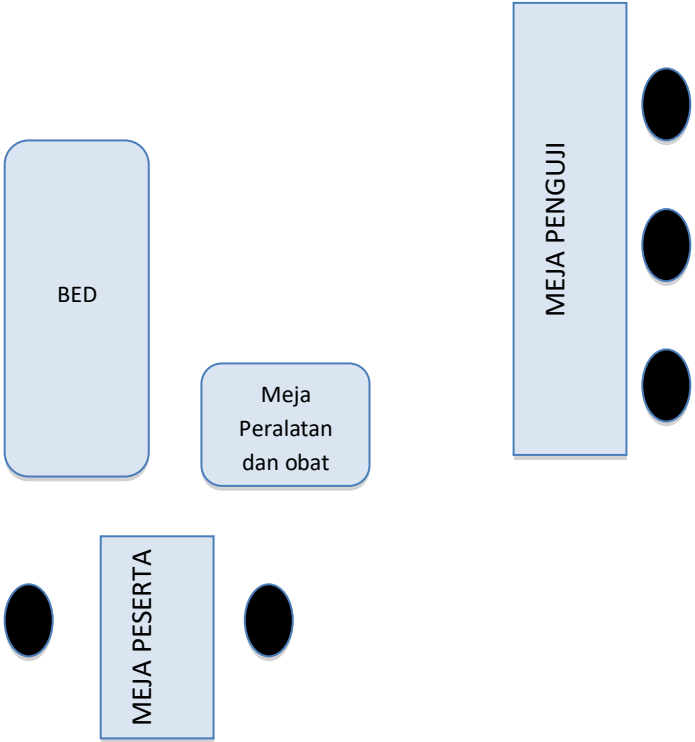
.....,
Penguji,

(.....)

SOAL UJIAN OSCE STATION PEMASANGAN CVC

1.	No. station	8
2.	Judul station	Pemasangan CVC subklavia
3.	Waktu yang dibutuhkan	20 menit
4.	Tujuan station	Menilai kemampuan dalam tindak ananestesi, Keterampilan klinis, Komunikasi, Edukasi dan Profesionalisme
5.	Kompetensi	1. Evaluasi Pra Anestesia 2. Diagnosis Dan Problem Aktual – Potensial 3. Rencana Tindakan Anestesi 4. Keterampilan Klinis 5. Monitoring dan manajemen penyulit 6. Manajemen Paska Anestesia 7. Komunikasi, Edukasi Dan Profesionalisme
6.	Kategori	1. Anestesia Obstetrik 2. Anestesia Bedah Saraf 3. Anestesia Regional Dan Manajemen Nyeri 4. Anestesia Bedah Toraks 5. Anestesia Pediatrik 6. Anestesia Kegawatdaruratan 7. Anestesia Urologi 8. Anestesia Untuk Penyakit Penyakit Khusus (Endokrin, Metabolik, Penyulit Kardiovaskular) 9. Anestesia Bedah Kepala Leher 10. Anestesia Bedah Rawat Jalan / Luar Kamar Bedah 11. Anestesia Pada Prosedur Invasif Minimal 12. Terapi Intensif
7.	Instruksi untuk peserta	Skenario Klinik : Seorang laki-laki usia 40 tahun BB 50 Kg datang ke IGD rujukan puskesmas dengan keluhan nyeri perut. Dari pemeriksaan fisik kesadaran apatis, frekwensi nafas 28x/menit, SP bronchial; ST ronchi kering, dengan non rebreathing mask 8 liter/menit, tekanan darah 70/40 mmHg, Nadi 140 x/menit, Temperature 39⁰ C. Pasien di diagnosa septik syok et causa peritonitis. Instruksi untuk peserta: 1. Sebutkan tahapan EGDТ 2. Lakukan tindakan pemasangan CVC subklavia
8.	Instruksi untuk penguji	<u>INSTRUKSI UMUM</u> 1. Pastikan identitas peserta ujian pada kartu ujian 2. Tulislah nama dan nomor peserta ujian pada lembar penilaian! 3. Amatilah dan berilah skor (0/1/2/3) atas tugas yang dikerjakan peserta ujian serta skor <i>Global Rating</i> sesuai rubrik penilaian 4. Hindarilah interupsi dan/atau tindakan selain daripada yang diminta dalam instruksi penguji! 5. Berikan informasi/hasil yang dibutuhkan secara lisan/tulisan hanya apabila peserta ujian telah melakukan dan/atau mengusulkan jenis pemeriksaan yang dimaksud (perhatikan instruksi khusus)!

		6. Taatilah peraturan serta etika penguji selama menjalankan tugas sebagai penguji OSCE - ATI! <u>INSTRUKSI KHUSUS</u> A. Penguji Menilai Peserta dalam melakukan EGD 1 Tindakan yang harus diselesaikan dalam waktu kurang dari 3 jam. - Cek laktat - Kultur darah - Pemberian Antibiotik broadspektrum - Pemberian cairan 30 ml/kgBB 2 Tindakan yang harus diselesaikan dalam waktu kurang dari 6 jam. - Gunakan vasopresor jika terdapat hipotensi persisten setelah pemberian cairan inisial. - Pasang cvc dan ukur cvp → target >8 mmHg - Pemeriksaan ScvO₂ - Ulang pemeriksaan laktat jika pemeriksaan laktat sebelumnya meningkat B. Penguji Menilai Peserta dalam melakukan pemasangan CVC 1 Mempersiapkan alat cvc set, tiang infus, ambu bag, obat emergensi 2 Memberikan salam, memperkenalkan diri dan menjelaskan tindakan yang akan dilakukan 3 Memasang alat monitor pada pasien dan monitor tanda-tanda vital pasien 4 Cuci Tangan dan memakai sarung tangan Steril 5 Identifikasi marker 6 Desinfeksi area yang sudah diidentifikasi 7 Pemasangan kain steril bolong 8 Dilakukan anestesi lokal pada area cvc 9 Penusukan jarum Y sambil dilakukan aspirasi 10 Aspirasi (+) dilakukan pemasangan guidewire 11 Jarum Y dicabut kemudian dimasukan dilator 12 Dilator dicabut kemudian insersi cvc sampai kedalaman yang telah ditentukan 13 Tes aspirasi (+), tes aliran balik (+) 14 Fiksasi dengan jahitan dan tutup dengan kassa steril 15 Mencuci tangan 16 Permintaan foto thoraks setelah pemasangan cvc
--	--	---

	Denah ruangan		
10	Instruksi Pasien Standar	-	
	Kebutuhan Laboran	Jumlah Laboran : 1 Tugas Laboran : Sebagai asisten, membantu kandidat dalam tindakan pemasangan CVC, mempersiapkan hecting set, menyiapkan cairan dan infus set (sudah dalam keadaan terpasang pada tiang infus), membantu menyambung CVC dengan selang infus setelah terpasang, membantu kandidat dalam hecting	
12	Peralatan yang dibutuhkan	Setting ruangUGD – Meja dan kursi dokter – Meja dan kursi penguji – CVC set – Infus set – Ringer laktat – Spuit 3 cc – Spuit 5 cc – Lidocain – Tianginfus – Kain steril bolong – Kassa – Plester – Ambu bag – Laringoskope – Epinefrin – Sulfas atropine	1 set 3 set 1 set 1 buah 5 flsh 5 buah 5 buah 2 ampul 1 buah 1 buah 10 buah 1 buah 1 buah 1 buah 2 ampul 2 ampul

		- Betadine - Alkohol - Monitor - Sarung Tangan steril no 7 / 7.5	1 botol 1 botol 1 buah 1/1 buah
13	Kebutuhan Manekin	ManekinCVC	
14	Penulis		
15	Referensi	SSC 2012	
16	Reviewer		

LEMBAR PENILAIAN

STATION ANESTESI DIGESTIV EMERGENCY/CVC SUBCLAVIA

Kandidat Residen : _____

Aspek yang Dinilai	0	1	2	3	Bobot	Skor
1. Rencana Tindakan Anestesi	Peserta ujian tidak bisa melakukan tindakan EGDТ sama sekali		Peserta mamapu melakukan tindakan EGDТ namun tidak lengkap	Peserta mampu melakukan tindakan EGDТ dengan lengkap	2	
2. Keterampilan Klinik	Peserta tidak mampu menjelaskan tindakan Anestesi yang akan dikerjakan		Peserta mampu menjelaskan tindakan anestesi namun tidak lengkap	Peserta ujian melakukan semua tahapan pemberian anestesi dengan benar sesuai poin pada instruksi khusus	3	
3. Komunikasi dan Perilaku profesional	Peserta ujian tidak meminta izin secara lisan dan sama sekali tidak melakukan point berikut: 1. melakukan setiap tindakan dengan berhati-hati dan teliti sehingga tidak membahayakan pasien dan diri sendiri 2. memperhatikan kenyamanan pasien	Meminta izin secara lisan dan 1-2 point berikut: 1. melakukan setiap tindakan dengan berhati-hati dan teliti sehingga tidak membahayakan pasien dan diri sendiri 2. memperhatikan kenyamanan pasien 3. melakukan tindakan	Meminta izin secara lisan dan 3-4 point berikut: 1. melakukan setiap tindakan dengan berhati-hati dan teliti sehingga tidak membahayakan pasien dan diri sendiri 2. memperhatikan kenyamanan pasien 3. melakukan tindakan sesuai prioritas 4. menunjukkan rasa hormat kepada pasien 5. mengetahui keterbatasan dengan merujuk atau	Meminta izin secara lisan dan melakukan di bawah ini secara lengkap: 1. melakukan setiap tindakan dengan berhati-hati dan teliti sehingga tidak membahayakan pasien dan diri sendiri 2. memperhatikan kenyamanan pasien 3. melakukan tindakan sesuai prioritas 4. menunjukkan rasa hormat kepada pasien 5. mengetahui keterbatasan dengan	2	

	3. melakukan tindakan sesuai prioritas 4. menunjukkan rasa hormat kepada pasien 5. mengetahui keterbatasan dengan merujuk atau melakukan konsultasi bila diperlukan	4. sesuai prioritas menunjukkan rasa hormat kepada pasien 5. mengetahui keterbatasan dengan merujuk atau melakukan konsultasi bila diperlukan	melakukan konsultasi bila diperlukan	merujuk atau melakukan konsultasi bila diperlukan		
TOTAL SKOR						

II. Global performance

Beri tanda (✓) pada kolom yang disediakan sesuai dengan penilaian Anda secara umum terhadap kemampuan peserta ujian!

Tidak lulus	Borderline	Lulus	Superior

.....,
Penguji,

(.....)

SOAL UJIAN OSCE STATION PEMASANGAN CVC

1.	No. Station	
2.	Judul station	Kegawatdaruratan anestesi – pemasangan CVC
3.	Waktu yang dibutuhkan	17 menit
4.	Tujuan station	Menilai kemampuan dalam tindakan anestesi, Keterampilan klinis, Komunikasi, Edukasi dan Profesionalisme
5.	Kompetensi	Evaluasi Pra Anestesia - Diagnosis Dan Problem Aktual – Potensial - Rencana Tindakan Anestesi Keterampilan Klinis - Monitoring dan manajemen penyulit Manajemen Paska Anestesia Komunikasi, Edukasi Dan Profesionalisme
6.	Kategori	- Anestesia Obstetrik - Anestesia Bedah Saraf - Anestesia Regional Dan Manajemen Nyeri - Anestesia Bedah Toraks - Anestesia Pediatrik Anestesia Kegawatdaruratan - Anestesia Urologi - Anestesia Untuk Penyakit Penyakit Khusus (Endokrin, Metabolik, Penyulit Kardiovaskular) - Anestesia Bedah Kepala Leher - Anestesia Bedah Rawat Jalan / Luar Kamar Bedah - Anestesia Pada Prosedur Invasif Minimal - Terapi Intensif
7.	Instruksi untuk peserta	<u>Skenario Klinik :</u> Laki-laki usia 24 tahun berat badan 65 Kg datang ke IGD dengan keluhan nyeri perut setelah kecelakaan motor. Dari pemeriksaan fisik kesadaran somnolen, laju napas 30x/menit SpO₂ 80 dengan udara bebas, tekanan darah 75/50 mmHg, laju nadi 140 x/menit. Pasien didiagnosa dengan trauma abdomen dengan syok hipovolemi. <u>Instruksi peserta:</u> - Lakukan survey primer pada pasien ini! - Lakukan tindakan pemasangan CVC <i>subclavia</i>! - Sebutkan tindakan yang harus dilakukan setelah pemasangan CVC pada pasien ini!
8.	Instruksi untuk penguji	<u>INSTRUKSI UMUM</u> - Pastikan identitas peserta ujian pada kartu ujian - Tulislah nama dan nomor peserta ujian pada lembar penilaian! - Amatilah dan berilah skor (0/1/2/3) atas tugas yang dikerjakan peserta ujian serta skor <i>Global Rating</i> sesuai rubrik penilaian - Hindarilah interupsi dan/atau tindakan selain daripada yang diminta dalam instruksi penguji! - Berikan informasi/hasil yang dibutuhkan secara lisan/tulisan hanya apabila peserta ujian telah melakukan dan/atau mengusulkan jenis pemeriksaan yang dimaksud (perhatikan instruksi khusus)! - Taatilah peraturan serta etika penguji selama menjalankan tugas

		sebagai penguji OSCE! <u>INSTRUKSI KHUSUS</u> 1. Penguji menilai peserta melakukan survey primer . Airway: bebas, memasang <i>collar brace</i> . Breathing: suara napas vesikuler, laju napas 30 x/menit, SpO ₂ 97% dengan <i>Non Rebreathing</i> 8 lpm. Circulation: Laju nadi 140 x/menit, tekanan/volume lemah, tekanan darah 75/36 mmHg. Disability: <i>respons to pain</i> . Exposure and Environment: jejas di perut, perut tegang dan ada nyeri tekan. 2. Penguji menilai kemampuan peserta dalam melakukan tindakan pemasangan <i>CVC subclavia</i> secara benar dan runut. Pemasangan <i>CVC subclavia</i> : 1. Mempersiapkan alat <i>cvc</i> set, tiang infus, ambu bag, obat emergensi. 2. Memberikan salam, memperkenalkan diri dan menjelaskan tindakan yang akan dilakukan. 3. Memasang alat monitor pada pasien dan monitor tanda-tanda vital pasien. 4. Cuci Tangan dan memakai sarung tangan steril. 5. Identifikasi marker. 6. Desinfeksi area yang sudah diidentifikasi. 7. Pemasangan kain steril yang berlubang. 8. Dilakukan anestesi lokal pada area <i>cvc</i> . 9. Penusukan jarum <i>cvc</i> sambil dilakukan aspirasi. 10. Aspirasi (+) dilakukan pemasangan <i>guidewire</i> . 11. Jarum <i>cvc</i> dicabut kemudian dimasukan dilator. 12. Dilator dicabut kemudian insersi <i>cvc</i> sampai kedalaman yang telah ditentukan. 13. Tes aspirasi (+), tes aliran balik (+). 14. Fiksasi dengan jahitan dan tutup dengan kassa steril. 15. Mencuci tangan 16. Permintaan foto toraks setelah pemasangan <i>cvc</i> . 3. Penguji menilai peserta menyebutkan tindakan yang dilakukan setelah pemasangan <i>cvc</i> pada pasien ini. 1. Resusitasi cairan. 2. Pengukuran CVP. 3. Monitoring dan evaluasi komplikasi pemasangan <i>cvc</i> . 4. Menilai komunikasi dan perilaku professional.	
9.	Tata letak station	Model ruang IGD	
10	Kebutuhan Laboran	Jumlah Laboran : 1 orang Tugas Laboran : sebagai asisten, membantu kandidat dalam tindakan pemasangan CVC, mempersiapkan hecting set, menyiapkan cairan dan infus set, membantu menyambung CVC dengan selang infus setelah terpasang, membantu kandidat dalam hecting	
11	Peralatan yang	Setting ruang IGD, Peralatan ruang IGD	

	dibutuhkan	- CVC fr 7 set - Cadangan wire CVC - Spuit 3 cc, 5 cc, 10 cc - Cairan, Infus set, tiang infus - Nacl 0,9 atau water untuk pemasangan - Lidocain 2 % - Benang silk 3,0 - Povidone iodine - Alkohol - Sarung tangan steril 6,5 7 7,5 - Topi operasi dan masker 2 Set pemasangan CVC - Nampan alat - Kain steril lubang - Cawan dengan label povidone iodine, alcohol, nacl 0,9 - Gaun steril - Kassa - Pinset - Needle holder - Gunting benang - Manometer - Collar brace - Sungkup non rebreathing - Nasal canul - Sarung tangan non steril	3 set 2 buah @ 10 buah 1 set 1 buah 2 buah 3 buah 1 botol 1 botol @ 10 buah @ 1 box 1 buah 1 buah 3 buah 1 buah 5 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah
13	Kebutuhan Manekin	Manekin CVC dan manekin full body dengan molase jejas di perut	
14	Penulis	TIM SOAL OSCE ATI	
15	Referensi	ATLS dan PTC	

RUBRIC ACTUAL MARK
OSCE STATION KEGAWATDARURATAN

Aspek yang Dinilai	0	1	2	3	Bobot	Skor
1. Evaluasi Pra Anestesi Peserta melakukan tindakan survey primer Airway: bebas, memasang <i>collar brace</i>. Breathing: suara napas vesikuler, laju napas 30 x/menit, SpO₂ 97% dengan <i>Non Rebreathing</i> 8 lpm. Circulation: Laju nadi 140 x/menit, tekanan/volume lemah, tekanan darah 75/36 mmHg. Disability: <i>respons to pain</i>. Exposure and Environment: jejas di perut, perut tegang dan ada nyeri tekan	Peserta ujian tidak bisa melakukan tindakan.	Peserta melakukan hanya 1 - 2 tindakan survey primer.	Peserta melakukan hanya 3- 4 tindakan survey primer.	Peserta melakukan tindakan survey primer dengan lengkap runut.	2	
2. Keterampilan Klinis Pemasangan CVC <i>subclavia</i> : - Mempersiapkan alat cvc set, tiang infus, ambu bag, obat emergensi. - Memberikan salam, memperkenalkan diri dan menjelaskan tindakan yang akan dilakukan. - Memasang alat monitor pada pasien dan monitor tanda-tanda vital pasien. - Cuci Tangan dan memakai sarung tangan steril. - Identifikasi marker. - Desinfeksi area yang sudah diidentifikasi. - Pemasangan kain steril yang berlubang. - Dilakukan anestesi lokal pada area cvc. - Penusukan jarum cvc sambil dilakukan aspirasi. - Aspirasi (+) dilakukan pemasangan <i>guidewire</i>. - Jarum cvc dicabut kemudian dimasukan dilator. - Dilator dicabut kemudian insersi cvc sampai kedalaman yang telah ditentukan. - Tes aspirasi (+), tes aliran balik (+). - Fiksasi dengan jahitan dan tutup dengan kassa steril. - Mencuci tangan - Permintaan foto toraks setelah pemasangan cvc	Peserta tidak melakukan pemasangan CVC.	Peserta ujian tidak berhasil melakukan pemasangan CVC.	Peserta ujian melakukan semua tahapan pemasangan CVC Namun tidak runut.	Peserta ujian melakukan semua tahapan pemasangan CVC benar dan runut.	4	

3. Manajemen paska tindakan. Tindakan yang dilakukan setelah pemasangan cvc pada pasien ini. 1. Resusitasi cairan. 2. Pengukuran CVP. 3. Monitoring dan evaluasi komplikasi pemasangan cvc	Peserta tidak melakukan manajemen paska pemasangan cvc.	-	Peserta melakukan manajemen paska pemasangan cvc tidak lengkap.	Peserta melakukan manajemen paska pemasangan cvc dengan lengkap.	2	
4. Komunikasi dan Perilaku Profesional Meminta izin secara lisan dan melakukan di bawah ini secara lengkap: 1. melakukan setiap tindakan dengan berhati-hati dan teliti sehingga tidak membahayakan pasien dan diri sendiri 2. memperhatikan kenyamanan pasien 3. melakukan tindakan sesuai prioritas 4. menunjukkan rasa hormat kepada pasien 5. mengetahui keterbatasan dengan merujuk atau melakukan konsultasi bila diperlukan	Peserta sama sekali tindakan melakukan tindakan	Meminta izin secara lisan dan 1-2 point.	Meminta izin secara lisan dan 3-4 point.	Meminta izin secara lisan dan melakukan semua.	2	
TOTAL SKOR						

.....,

Penguji,

(.....)

**SOAL UJIAN OSCE STATION
KEGAWATDARURATAN**

1	No. Station	4
2	Judul Station	Penanganan Peningkatan Tekanan Intra Kranial (TIK) – Kegawatdaruratan
3	Waktu yang dibutuhkan	17 menit
4	Tujuan Station	Menilai kemampuan evaluasi pasien, diagnosis dan problem aktual – potensial, keterampilan klinis, monitoring dan manajemen penyulit, komunikasi, edukasi dan profesionalisme
5	Kompetensi	1. Evaluasi pra anestesi 2. Diagnosis dan problem aktual – potensial 3. Rencana tindakan anestesi 4. Keterampilan klinis 5. Monitoring dan manajemen penyulit 6. Manajemen pasca anestesia 7. Komunikasi, edukasi dan profesionalisme
6	Kategori	1. Anestesi obstetri 2. Anestesi bedah saraf 3. Anestesi regional dan manajemen nyeri 4. Anestesi bedah toraks 5. Anestesi pediatrik 6. Anestesi kegawatdaruratan 7. Anestesi urologi 8. Anestesi untuk penyakit khusus (endokrin, metabolik, penyulit kardiovaskuler) 9. Anestesi bedah kepala leher 10. Anestesi bedah rawat jalan / luar kamar bedah 11. Anestesi pada prosedur invasif minimal 12. Terapi intensif
7	Instruksi untuk peserta	<u>Skenario Klinik</u> Wanita 45 tahun mengalami kecelakaan lalu lintas masuk ruang resusitasi tampak perlukaan di kepala dan leher, kesadarannya menurun (GCS: E1M4V2). <u>Instruksi Untuk Peserta:</u> 1. Lakukan evaluasi terhadap pasien! 2. Sebutkan problem aktual dan problem potensial terhadap pasien! 3. Lakukan tindakan pengelolaan jalan napas pada pasien! 4. Terjadi perubahan hemodinamik. Sebutkan monitoring dan manajemen penyulit pada pasien!
8	Instruksi untuk penguji	<u>Instruksi Umum</u> 1. Pastikan identitas peserta ujian pada kartu ujian 2. Tulislah nama dan nomor peserta ujian pada lembar penilaian !

		3. Amatilah dan berilah skor (0/1/2/3) atas tugas yang dikerjakan peserta ujian serta skor global rating sesuai rubrik penilaian 4. Hindarilah interupsi dan/atau tindakan selain daripada yang diminta
--	--	---

		dalam instruksi penguji ! 5. Berikan informasi/hasil yang dibutuhkan secara lisan/tulisan hanya apabila peserta ujian telah melakukan dan/atau mengusulkan jenis pemeriksaan yang dimaksud (perhatikan instruksi khusus)! 6. Taatilah peraturan serta etika penguji selama menjalankan tugas sebagai penguji OSCE KATI INTRUKSI KHUSUS 1. Penguji mengamati dan menilai tindakan evaluasi kegawatdaruratan yang dilakukan peserta: Penguji memberikan data bila diminta oleh peserta Anamnesis 1. <i>Allergies</i> = tidak ada 2. <i>Medications</i> = tidak ada 3. <i>Past medical history</i> = Riwayat penyakit dahulu tidak pernah sakit yang serius 4. <i>Last meal</i> = 2 jam sebelum kecelakaan 5. <i>Events</i> = kecelakaan dan mengalami penurunan kesadaran Pemeriksaan fisik Tanda vital • Laju napas 14 x/menit • Tekanan darah 150/90 mmHg • Laju nadi 100 x/menit, tekanan/volume cukup • Temperatur 36.5°C Pemeriksaan fisik dalam batas normal Pemeriksaan penunjang • Belum dilakukan 2. Penguji menilai peserta menyebutkan problem aktual dan potensial pada pasien ini Problem aktual 1. Penurunan kesadaran 2. Luka di kepala dan leher Potensial problem 3. Obstriksi jalan napas 4. Trauma cervical
--	--	---

		5. Hipoksia 6. <i>Scondary Brain Injury</i> 7. Peningkatan TIK 8. Herniasi otak 3. Penguji menilai peserta melakukan keterampilan tindakan Rapid Sequence Induction. 1. Memberikan <i>informed consent</i>. 2. Memberikan premedikasi: • Metoklopramid 10 mg intravena segera mungkin dan diulang tiap 2-4 jam sampai operasi dimulai. • Obat golongan <i>proton pump inhibitor</i> (PPI). 3. Memakai sarung tangan non steril. 4. Menyiapkan peralatan intubasi (STATICS): • Scope: laringoskop dan stetoskop • Tube: ETT dengan ukuran yang sesuai • Airway: <i>Oropharyngeal airway</i> • Tapes (plester) • Introducer (mandrin/ <i>stylet</i>) • Connector • Suction berfungsi baik 5. Menyiapkan obat anestesi yang diperlukan. 6. Memposisikan pasien <i>head up position</i> minimal 30°. 7. Memberikan preoksigenasi dengan O2 100% selama 3 – 5 menit. 8. Memberikan obat hipnotik – sedatif untuk induksi dengan agen intravena (propofol 2mg/kg), pelumpuh otot kerja cepat (rocuronium 1,2 mg/kgbb atau suksinilkolin). 9. Melakukan <i>cricoid pressure</i> (<i>sellick's maneuver</i>) oleh asisten. 10. Tidak memberikan ventilasi tekanan positif. 11. Melakukan intubasi setelah pelumpuh otot bekerja. 12. Mengembangkan <i>cuff</i> ETT. 13. Menyambungkan connector ETT dengan sirkuit anestesi. 14. Melakukan konfirmasi posisi ETT. 15. Asisten melepaskan penekanan cricoid. 16. Melakukan fiksasi ETT dengan <i>tape</i>/ plester. 4. Penguji menilai monitoring dan manajemen penyulit pasien ini: 1. Penguji menyebutkan tanda vital pasien bila ditanyakan peserta: Tekanan darah = 220/110 mmHg Laju nadi = 40 x/menit ETCO2 = 45 SpO2 = 98%
--	--	---

		2. Peserta ujian menyebutkan pengelolaan TIK : - Posisi head up 30 derajat - Kontrol ventilasi : Hiperventilasi target PCO₂ 30-35. - Terapi hiperosmoler , mannitol 0,25 – 1 gr/kgBB - Ventrikulostomi - Kraniektomi - Koma barbiturate - Mild Hypotermi 5. Penguji menilai komunikasi, edukasi serta perilaku profesionalisme peserta	
9	Tata letak ruangan	Model kamar UGD	
10	Kebutuhan laboran	Jumlah laboran : 1 Tugas laboran : sebagai penata anestesi, membantu peserta dalam melakukan persiapan dan tindakan intubasi dan pengelolaan TIK.	
11	Peralatan yang dibutuhkan	- Peralatan ruang UGD - Laringoskop blade 3, 4 - ETT 7, 7.0, 7.5, 8.0 - Stetoskop - Tensimeter - Pen light - Thermometer - Sarung tangan tidak steril - Sput berlabel - Pentotal - Propofol - Fentanyl - Lidokain 2% - Rocuronium - Vecuronium - Sput cuff - Suction cateter - Mesin suction - Oropharing no 3 dan 4 - Sungkup muka no 3,4,5 - AMBU -	@1 buah @ 2 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 box 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah @1 buah @1 buah 1 buah
12	Kebutuhan manekin	Manekin pengelolaan jalan napas 1 buah	
13	Penulis	Tim Soal OSCE ATI	

14	Referensi	Butterworth JF, Mackey DC, Wasnick JD, editors. Morgan and Mikhail's clinical anesthesiology. 6 ed. New York: McGraw Hill Professional; 2018.
----	-----------	---

RUBRIK ACTUAL MARK
ANESTESI KEGAWATDARURATAN

Aspek yang dinilai	0	1	2	3	Bobot	Skor
1. Evaluasi Pra Anestesi 1. Anamnesis • <i>Allergies</i> • <i>Medications</i> • <i>Past medical history</i> • <i>Last meal</i> • <i>Events</i> yang lalu 2. Pemeriksaan fisik • Tanda vital • Pemeriksaan fisik dalam batas normal 3. Pemeriksaan penunjang • Laboratorium - Darah rutin - Faal hemostasis - Darah kimia • EKG • CTScan	Kandidiat tidak melakukan evaluasi pra anestesi	-	Peserta ujian melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang namun TIDAK LENGKAP.	Peserta ujian melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang secara LENGKAP	2	
2. Problem aktual dan problem potensial Problem aktual a. Penurunan kesadaran b. Luka di kepala dan leher	Peserta ujian tidak menyampaikan problem	Peserta ujian menyampaikan 1-3 problem	Peserta ujian menyampaikan 4-7 problem	Peserta ujian menyampaikan semua problem	2	

Potensial problem a. Obstriksi jalan napas b. Trauma cervical c. Hipoksia d. <i>Scondary Brain Injury</i> e. Peningkatan TIK f. Herniasi otak	aktual dan potensial	aktual dan potensial	aktual dan potensial	aktual dan potensial		
3. Keterampilan klinis Keterampilan tindakan anestesi spinal 1. Memberikan <i>informed consent</i>. 2. Memberikan premedikasi: • Metoklopramid 10 mg intravena segera mungkin dan diulang tiap 2-4 jam sampai operasi dimulai. • Obat golongan <i>proton pump inhibitor</i> (PPI). 3. Memakai sarung tangan non steril. 4. Menyiapkan peralatan intubasi (STATICS): • Scope: laringoskop dan stetoskop • Tube: ETT dengan ukuran yang sesuai • Airway: <i>Oropharyngeal airway</i> • Tapes (plester) • Introducer (mandrin/ stylet) • Connector • Suction berfungsi baik	Peserta tujian tidak melakukan tindakan.	Peserta ujian melakukan tindakan intubasi bukan RSI	Peserta ujian melakukan tindakan RSI TIDAK LENGKAP dan TIDAK RUNUT.	Peserta ujian melakukan tindakan RSI LENGKAP dan RUNUT	3	

5. Menyiapkan obat anestesi yang diperlukan. 6. Memposisikan pasien <i>head up position</i> minimal 30°. 7. Memberikan preoksigenasi dengan O ₂ 100% selama 3 – 5 menit. 8. Memberikan obat hipnotik – sedatif untuk induksi dengan agen intravena (propofol 2mg/kg), pelumpuh otot kerja cepat (rocuronium 1,2 mg/kgbb atau suksinilkolin). 9. Melakukan <i>cricoid pressure (sellick's maneuver)</i> oleh asisten. 10. Tidak memberikan ventilasi tekanan positif. 11. Melakukan intubasi setelah pelumpuh otot bekerja. 12. Mengembangkan <i>cuff</i> ETT. 13. Menyambungkan connector ETT dengan sirkuit anestesi. 14. Melakukan konfirmasi posisi ETT. 15. Asisten melepaskan penekanan cricoid. 16. Melakukan fiksasi ETT dengan <i>tape/</i> plester.						
4. Monitoring dan manajemen penyulit 1. Peserta ujian melakukan monitoring hemodinamik 2. Peserta ujian menyebutkan pengelolaan TIK	Peserta ujian tidak menyebutkan monitoring	Peserta ujian menyebutkan monitoring dan 1-3	Peserta ujian melakukan monitoring dan 4-6	Peserta ujian menyebutkan monitoring dan semua	2	

a. Posisi head up b. Kontrol ventilasi : Hiperventilasi target PcO ₂ 30-35. c. Terapi hiperosmoler , mannitol 0,25 – 1 gr/kgBB d. Ventrikulostomi e. Koma barbiturate f. Kraniektomi g. Hipotermi	dan manajemen penyulit.	manajemen penyulit.	manajemen penyulit.	manajemen penyulit.		
4. Komunikasi dan perilaku profesional 1. Melakukan setiap tindakan dengan berhati-hati dan teliti sehingga tidak membahayakan pasien dan diri sendiri 2. Memperhatikan kenyamanan pasien 3. Melakukan tindakan sesuai prioritas 4. Menunjukkan rasa hormat pada pasien 5. Mengetahui keterbatasan dengan merujuk atau melakukan konsultasi bila diperlukan	Peserta ujian tidak meminta meminta izin secara lisan dan sama sekali tidak melakukan poin yang diminta	Peserta ujian meminta izin secara lisan dan melakukan 1-2 poin yang diminta	Peserta ujian meminta izin secara lisan dan melakukan 3-4 poin yang diminta	Peserta meminta izin secara lisan dan melakukan poin-poin secara lengkap	1	
TOTAL SKOR						

.....,

Penguji,

(.....)

SOAL UJIAN OSCE STATION KEGAWATDARURATAN

1	Nomor Station	5
2	Judul Station	Luka Bakar - CVC
3	Waktu yang dibutuhkan	17 menit
4	Tujuan Station	Menilai kemampuan melakukan Evaluasi Preoperative, Diagnosa dan problem potensial – aktual, rencana tindakan anestesi, Manajemen Penyulit Kegawatdaruratan
5	Kompetensi :	1. Evaluasi Pra Anestesia 2. Diagnosis Dan Problem Aktual – Potensial 3. Rencana Tindakan Anestesi 4. Keterampilan Klinis 5. Monitoring dan manajemen penyulit 6. Manajemen Paska Anestesia 7. Komunikasi, Edukasi Dan Profesionalisme
6	Kategori	1. Anestesia Obstetrik 2. Anestesia Bedah Saraf 3. Anestesia Regional Dan Manajemen Nyeri 4. Anestesia Bedah Toraks 5. Anestesia Pediatrik 6. Anestesia Kegawatdaruratan 7. Anestesia Urologi 8. Anestesia Untuk Penyakit Khusus (Endokrin, Metabolik, Penyulit Kardiovaskular) 9. Anestesia Bedah Kepala Leher 10. Anestesia Bedah Rawat Jalan / Luar Kamar Bedah 11. Anestesia Pada Prosedur Invasif Minimal 12. Terapi Intensif
7	Intruksi untuk peserta ujian	<u>Skenario Klinik :</u> Seorang Laki-laki 52 tahun, berat badan 50 kg, korban kebakaran 4 jam yang lalu di konsulkan ke ruang resusitasi. Pada pemeriksaan tidak didapatkan tanda tanda trauma inhalasi. Luka bakar 60% di regio abdominal dan ekstremitas bawah. <u>Intruksi untuk peserta :</u> 1. Sampaikan pada penguji rencana resusitasi cairan menurut rumus Parkland! 2. Lakukan inform consent dengan benar dan lakukan tindakan pemasangan kateter vena sentral!
8	Intruksi untuk penguji	<u>INSTRUKSI UMUM</u> 1. Pastikan identitas peserta ujian pada kartu ujian 2. Tulislah nama dan nomor peserta ujian pada lembar penilaian! 3. Amatilah dan berilah skor (0/1/2/3) atas tugas yang dikerjakan peserta ujian serta skor <i>Global Rating</i> sesuai rubrik penilaian 4. Hindarilah interupsi dan/atau tindakan selain daripada yang diminta dalam intruksi penguji! 5. Berikan informasi/hasil yang dibutuhkan secara lisan/tulisan

		hanya apabila peserta ujian telah melakukan dan/atau mengusulkan jenis pemeriksaan yang dimaksud (perhatikan instruksi khusus)! 6. Taatilah peraturan serta etika penguji selama menjalankan tugas sebagai penguji OSCE - ATII INSTRUKSI KHUSUS: 1. Penguji menilai rencana resusitasi cairan menurut rumus Parkland yang disampaikan peserta. Jumlah Cairan : $4 \times 50 \times 60 = 12000$ ml Jenis Cairan : kristaloid Cara Pemberian cairan : • 8 jam pertama : 6000 ml / 8 jam sejak jam kejadian • 8 jam kedua : 3000 ml / 8 jam • 8 jam ketiga : 3000 ml / 8 jam 2. Penguji menilai prosedur pemasangan kateter vena sentral yang dilakukan peserta ujian yaitu : 1. Mempersiapkan alat cvc set, tiang infus, ambu bag, obat emergensi 2. Memberikan salam, memperkenalkan diri dan menjelaskan tindakan yang akan dilakukan 3. Memasang alat monitor pada pasien dan monitor tanda-tanda vital pasien 4. Identifikasi marker 5. Cuci Tangan dan memakai sarung tangan Steril 6. Desinfeksi area yang sudah diidentifikasi 7. Pemasangan kain steril bolong 8. Dilakukan anestesi lokal pada area cvc 9. Penusukan jarum CVC sambil dilakukan aspirasi 10. Aspirasi (+) dilakukan pemasangan guidewire 11. Jarum CVC dicabut kemudian dimasukan dilator 12. Dilator dicabut kemudian insersi cvc sampai kedalaman yang telah ditentukan 13. Tes aspirasi (+), tes aliran balik (+) 14. Fiksasi dengan jahitan dan tutup dengan kassa steril 15. Mencuci tangan 16. Permintaan foto thoraks setelah pemasangan cvc 3. Penguji menilai penjelasan peserta pada pasien tentang a. Tindakan: Pemasangan kateter vena sentral b. Manfaat: akses intra vena besar, mengukur kecukupan cairan c. Resiko: perdarahan, pneumothorax, gangguan irama jantung d. Efek samping: nyeri lokasi penusukan, infeksi e. Alternatif tindakan : akses infus perifer
9	Tata letak station	Model ruang IGD
10	Kebutuhan Laboran	Jumlah Laboran : 1 orang Tugas Laboran : sebagai asisten, membantu kandidat dalam tindakan pemasangan

		CVC, mempersiapkan hecting set, menyiapkan cairan dan infus set, membantu menyambung CVC dengan selang infus setelah terpasang, membantu kandidat dalam hecting
11	Peralatan yang dibutuhkan	Setting ruang IGD Peralatan ruang IGD - CVC fr 7 set 1 buah - Cadangan wire CVC 1 buah - Sduit 3 cc, 5 cc, 10 cc @ 1 buah - Cairan, Infus set, tiang infus @ 1 buah - Nacl 0,9 atau water untuk pemasangan 1 buah - Lidocain 2 % 1 buah - Benang silk 3,0 1 buah - Povidone iodine 1 botol - Alkohol 1 botol - Sarung tangan steril 6,5 7 7,5 @ 1 pasang - Topi operasi dan masker @ 1 kotak 2 Set pemasangan CVC - Nampan alat 1 buah - Kain steril lubang 1 buah - Cawan dengan label povidone iodine, alcohol, nacl 0,9 @ 1 buah - Gaun steril @ 1 buah - Kassa @ 5 buah - Pinset 1 buah - Needle holder 1 buah - Gunting benang 1 buah
13	Kebutuhan Manekin	Manekin CVC
14	Penulis	Tim OSCE ATI
15	Referensi	SSC 2012

RUBRIC ACTUAL MARK
OSCE STATION KEGAWATDARURATAN

Aspek yang Dinilai	0	1	2	3	Bobot	Nilai
1. Rencana tindakan Anestesi 1. Jumlah cairan 2. Jenis cairan 3. Cara pemberian	Peserta tidak ampu menentukan diagnose dan Peserta tidak mampu menjelaskan rencana anestesi	Peserta ujian hanya mampu menyampaikan satu item rencana resusitasi dengan tepat	Peserta ujian hanya mampu menyampaikan dua item rencana resusitasi dengan tepat	Peserta ujian mampu menyampaikan rencana resusitasi dengan tepat.	3	
2. Keterampilan klinis	Peserta ujian tidak melakukan prosedur pemasangan kateter vena sentral		Peserta ujian melakukan prosedur pemasangan kateter vena sentral namun tidak lengkap	Peserta ujian melakukan prosedur pemasangan kateter vena sentral dengan benar, lengkap dan runut	4	
3. Komunikasi, Edukasi Dan Profesionalisme 1. Tindakan 2. Manfaat 3. Resiko 4. Efek samping 5. Alternatif tindakan	Peserta ujian tidak meminta izin secara lisan dan sama sekali tidak melakukan poin profesionalisme.	Meminta izin secara lisan dan melakukan 1-2 point	Meminta izin secara lisan dan melakukan 3 point.	Meminta izin secara lisan dan melakukan point di bawah ini secara lengkap.	3	

SOAL UJIAN OSCE STATION ANESTESIA KEGAWATDARURATAN

1	Nomor Station	
2	Judul Station	Manajemen Penyulit Kegawatdaruratan
3	Waktu yang dibutuhkan	20 menit
4	Tujuan Station	Menilai kemampuan melakukan Evaluasi Preoperative, Diagnosa dan problem potensial – aktual, rencana tindakan anestesi, Manajemen Penyulit Kegawatdaruratan
5	Kompetensi :	1. Evaluasi Preoperative 2. Diagnosa dan problem potensial - aktual 3. Rencana tindakan anestesi 4. Keterampilan klinis 5. Monitoring dan manajemen penyulit 6. Manajemen paska bedah 7. Komunikasi, edukasi dan profesionalisme
6	Kategori	Anestesi Kegawatdaruratan
7	Intruksi untuk peserta ujian	<u>Skenario Klinik :</u> Laki-laki 52 tahun dibawa ke IGD dengan ambulan setelah terluka akibat kebakaran rumah. Lukanya terdapat pada kedua lengan atas, seluruh badan bagian depan dan paha kanan. Tanda vitalnya HR 115 x/menit, frekuensi napas 25 x/menit, tekanan darah 158/92 mmHg dan saturasi 93% menggunakan oksigen nasal kanul. Pada saat mengeluh nyeri, suara pasien terdengar parau dan terbatuk-batuk dengan dahak kehitaman. Direncanakan akan dilakukan tindakan debridement luka. Instruksi untuk peserta : 1. Lakukan evaluasi preoperative 2. Sebutkan diagnosa dan problem potensial – aktual 3. Sebutkan dan lakukan rencana tindakan anestesi
8	Instruksi untuk penguji	<u>Skenario Klinik :</u> Laki-laki 52 tahun dibawa ke IGD dengan ambulan setelah terluka akibat kebakaran rumah. Lukanya terdapat pada kedua lengan atas, seluruh badan bagian depan dan paha kanan. Tanda vitalnya HR 115 x/menit, frekuensi napas 25 x/menit, tekanan darah 158/92 mmHg dan saturasi 93% menggunakan oksigen nasal kanul. Pada saat mengeluh nyeri, suara pasien terdengar parau dan terbatuk-batuk dengan dahak kehitaman. Direncanakan akan dilakukan tindakan debridement luka. Instruksi untuk peserta : 1. Lakukan evaluasi preoperative 2. Sebutkan diagnosa dan problem potensial – aktual 3. Sebutkan dan lakukan rencana tindakan anestesi

		Intruksi penguji : INSTRUKSI UMUM 1. Pastikan identitas peserta ujian pada kartu ujian 2. Tulislah nama dan nomor peserta ujian pada lembar penilaian! 3. Amatilah dan berilah skor (0/1/2/3) atas tugas yang dikerjakan peserta ujian serta skor <i>Global Rating</i> sesuai rubrik penilaian 4. Hindarilah interupsi dan/atau tindakan selain daripada yang diminta dalam instruksi penguji! 5. Berikan informasi/hasil yang dibutuhkan secara lisan/tulisan hanya apabila peserta ujian telah melakukan dan/atau mengusulkan jenis pemeriksaan yang dimaksud (perhatikan instruksi khusus)! 6. Taatilah peraturan serta etika penguji selama menjalankan tugas sebagai penguji OSCE - ATI! INSTRUKSI KHUSUS : 1. Penguji mengamati dan menilai tindakan preoperatif yang dilakukan peserta dan memberikan hasil pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang bila diminta oleh peserta. Peserta menanyakan : Anamnese Alergi (-), Medication (-), Past illness (-), Last eaten (baru saja makan dan minum sebelum kebakaran), Event (-) Pemeriksaan Klinis: BB 52 kg, TB 168 cm. Kesadaran Compos mentis GCS15 E4V5M6, Pupil isokor 3mm/3mm RC +/+, bulu mata habis terbakar Leher: tidak teraba limfonodi, luka bakar Frekuensi nafas 25 x/menit, suara pernafasan vesikuler suara tambahan tidak ada, bersuara parau dan batuk saat mengeluh sakit Tekanan darah 158/92 mmHg, Nadi 115 x/menit, kuat, Jantung : suara jantung normal, Suhu 37°C. Abdomen: luka bakar Produksi urine : urine pekat Pemeriksaan penunjang : Hasil Laboratorium : Darah Rutin : Hb 15,1 gr%, Ht 51%, WBC 12 k/μL, Plt 200 gr/dl Faal Hemostasis : PPT10,9 (12,2) , APTT 35,8 (30,7) Bun (Ureum) : 78 mg/dl, Creatinin 1,0 mg/dl Na 148 mmol/L, Kalium 5,2 mmol/L ,Cl 100 mmol/L Faal Hati :AST 189, ALT 163, albumin 3,0, globulin 3,42 Glukosa 90 mg/dl, Thorak foto : CTR<50% C/P dbn EKG : Sinus Takikardia. 2. Diagnosa dan problem potensial – aktual. Diagnosa : Luka Bakar Derajat II Problem aktual potensial:
--	--	--

		- difficult airway management - lambung penuh - kemungkinan dehidrasi Persiapan preoperative : 1. Pastikan euvolemia dengan rehidrasi terlebih dahulu (memahami rule of nine dan Formula Baxter) 2. Pencegahan aspirasi pneumonia : 30 ml oral non particulated antacid + metocloperamide 10 mg iv + H2 blocker iv 3. Persiapan intubasi pada lambung penuh (7P: Preparation, Preoxygenation, Pretreatment, Paralysis, Protection, Placement, Post intubation management) 3. Penguji menilai Manajemen anestesi yang dilakukan peserta Pilihan Anestesi : General Anestesi intubasi dengan RSI Rencana Tindakan Anestesi : 1. STATIC, menyiapkan obat anestesi yang diperlukan, mengecek mesin anestesi dan alat monitor pasien, memakai alat pelindung diri (minimal handschoen) 2. Siapkan 3 ukuran ETT, memilih pipa endotracheal dengan ukuran lebih kecil : 6 atau 6,5 mm 3. Induksi yang dalam dengan agen IV cepat (propofol / etomidate), analgetik (fentanyl), dan bila ada Muscle relaxan kerja cepat Rocuronium 1 mg/kgbb 4. Diberikan ventilasi tekanan positif, bila sudah dalam dan rileks 5. mengambil laryngoskop dengan tangan kiri, membuka mulut penderita tanpa ekstensi kepala, menyusuri lidah dari kiri ke kanan hingga tampak epiglotis dan plica vocalis 6. insersi pipa endotracheal 7. kembangkan cuff, 8. auskultasi untuk simetrisasi suara napas, 9. fiksasi 10. Mampu melakukan teknik rumatan anestesi umum dengan volatile anestesi 4. Penguji menilai manajemen paska operative yang disebutkan dan ditulis peserta 1. Monitoring hemodinamik dan kemungkinan munculnya komplikasi 2. Pilihan utama analgesia sistemik opioid intravena menggunakan syringe pump 3. Disarankan menggunakan PCA karena pemberian dosis opioid intravena lebih mencerminkan kebutuhan pasien.
--	--	--

9		
10	Peralatan yang dibutuhkan	Setting ruangan dokter-pasien - Meja dan kursi dokter 1 set - Kursi pasien 1 buah - Meja dan kursi penguji 1 set - Meja peralatan 1 buah - Meja operasi 1 set - Manekin 1 buah - Stetoskop 1 buah - Monitor Pasien 1 buah - Laringoskop 1 buah - Sungkup Muka 1 buah - Ambu Bag 1 buah - ETT 7 6,5 6 1 buah - Plester 1 buah - Sarung tangan non steril - Rekam medis 5 lembar - Tempat sampah tertutup 1 buah - Tissue 1 kotak - Jam dinding 1 buah

LEMBAR PENILAIAN

STATION MANAJEMEN PENYULIT KEGAWATDARURATAN

Kandidat Residen : _____

Aspek yang Dinilai	0	1	2	3	Bobot	Nilai
1. Preoperatif Evaluation	Peserta ujian tidak melakukan tindakan Atau melakukan tetapi tidak sesuai perintah Atau melakukan tetapi tidak sesuai masalah klinik pasien atau tidak melakukan pemeriksaan fisik	Kandidat hanya mampu identifikasi 1-2 point dengan tepat, lengkap dan benar dari 3 point tapi tidak lengkap	Peserta mampu identifikasi 2-3 point tapi tidak lengkap	Peserta ujian menanyakan dan melakukan pemeriksaan klinis pada: 1. Pastikan euvoemia dengan rehidrasi terlebih dahulu (memahami rule of nine dan Formula Baxter) 2. Pencegahan aspirasi pneumonia : 30 ml oral non particulated antacid + metocloperamide 10 mg iv + H2 blocker iv 3. Persiapan intubasi pada lambung penuh (7P: Preparation, Preoxygenation, Pretreatment, Paralysis, Protection, Placement, Post intubation management)	3	
2. Diagnosa Problem potensial - actual	Peserta tidak menyebutkan diagnose dan problem actual potensial	Peserta hanya mampu menentukan diagnose	Peserta mampu menentukan diagnose namun tidak lengkap menjelaskan problem actual potensial	Peserta mampu menentukan diagnosa dan problem actual potensial Diagnosa : Luka Bakar Derajat II Problem aktual potensial: - difficult airway management - lambung penuh - kemungkinan dehidrasi	5	
3. Rencana tindakan Anestesi dan keterampilan	Peserta tidak ampu menentukan diagnose dan Peserta tidak mampu	Peserta mampu menentukan tindakan anestesi tp tidak lengkap dan	Peserta mampu menentukan tindakan anestesi dan menjelaskan rencana	Peserta mampu menentukan tindakan anestesi dan menjelaskan rencana anestesi Dan melakukan	5	

klinis	menjelaskan rencana anestesi	menjelaskan rencana anestesi namun tidak lengkap dan runut dan tidak melakukan	anestesi namun tidak lengkap dan runut dan melakukan	Pilihan Anestesi : General Anestesi intubasi dengan RSI Rencana Tindakan Anestesi : 1. STATIC, menyiapkan obat anestesi yang diperlukan, mengecek mesin anestesi dan alat monitor pasien, memakai alat pelindung diri (minimal handschoen) 2. Siapkan 3 ukuran ETT, memilih pipa endotrakeal dengan ukuran lebih kecil : 6 atau 6,5 mm 3. Induksi yang dalam dengan agen IV cepat (propofol / etomidate), analgetik (fentanyl), dan bila ada Muscle relaxan kerja cepat Rocuronium 1 mg/kgbb 4. Diberikan ventilasi tekanan positif, bila sudah dalam dan rilex 5. mengambil laryngoskop dengan tangan kiri, membuka mulut penderita tanpa ekstensi kepala, menyusuri lidah dari kiri ke kanan hingga tampak epiglotis dan plica vocalis 6. insersi pipa endotracheal 7. kembangkan cuff, 8. auskultasi untuk simetrisasi suara napas, 9. fiksasi 10. Mampu melakukan teknik rumatan anestesi umum dengan volatile anestesi		
4. Komunikasi, edukasi dan profesionalisme	Peserta ujian tidak meminta izin secara lisan dan sama sekali tidak melakukan poin berikut:	Meminta izin secara lisan dan 1-2 poin berikut : 1. melakukan setiap tindakan dengan berhati-hati dan	Meminta izin secara lisan dan 3 poin berikut: 1. melakukan setiap tindakan dengan berhati-hati dan	Meminta izin secara lisan dan melakukan di bawah ini secara lengkap : 1. melakukan setiap tindakan dengan berhati-hati dan teliti sehingga tidak membahayakan pasien dan	3	

	1. melakukan setiap tindakan dengan berhati-hati dan teliti sehingga tidak membahayakan pasien dan diri sendiri 2. memperhatikan kenyamanan pasien 3. melakukan tindakan sesuai prioritas 4. menunjukkan rasa hormat kepada pasien mengetahui keterbatasan dengan merujuk atau melakukan konsultasi bila diperlukan	teliti sehingga tidak membahayakan pasien dan diri sendiri 2. memperhatikan kenyamanan pasien 3. melakukan tindakan sesuai prioritas 4. menunjukkan rasa hormat kepada pasien mengetahui keterbatasan dengan merujuk atau melakukan konsultasi bila diperlukan	teliti sehingga tidak membahayakan pasien dan diri sendiri 2. memperhatikan kenyamanan pasien 3. melakukan tindakan sesuai prioritas 4. menunjukkan rasa hormat kepada pasien mengetahui keterbatasan dengan merujuk atau melakukan konsultasi bila diperlukan	diri sendiri 2. memperhatikan kenyamanan pasien 3. melakukan tindakan sesuai prioritas 4. menunjukkan rasa hormat kepada pasien mengetahui keterbatasan dengan merujuk atau melakukan konsultasi bila diperlukan		
--	---	--	--	--	--	--

II. Global performance

Beri tanda (✓) pada kolom yang disediakan sesuai dengan penilaian Anda secara umum terhadap kemampuan peserta ujian!

Tidak lulus	Borderline	Lulus	Superior

.....,

Penguji,

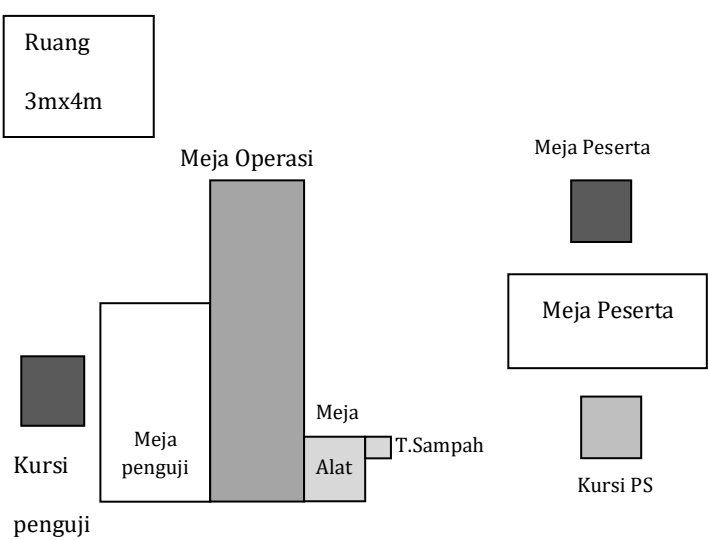
(.....)

SOAL UJIAN OSCE STATION ANESTESIA KEGAWATDARURATAN

1	Nomor Station	
2	Judul Station	Manajemen Penyulit Emergensi
3	Waktu yang dibutuhkan	20 menit
4	Tujuan Station	Menilai kemampuan melakukan Evaluasi Preoperative, Diagnosa dan problem potensial – aktual, Keterampilan klinis, dan komunikasi edukasi dan profesionalisme
5	Kompetensi :	1. Evaluasi Preoperative 2. Diagnosa dan problem potensial - aktual 3. Rencana tindakan anestesi 4. Keterampilan klinis 5. Monitoring dan manajemen penyulit 6. Manajemen paska bedah 7. Komunikasi, edukasi dan profesionalisme
6	Kategori	Anestesi Kegawat daruratan
7	Intruksi untuk peserta ujian	<u>Skenario Klinik :</u> Seorang laki-laki umur 26 tahun dibawa ke IGD dengan keluhan pusing dan sesak napas setelah mengalami kecelakaan lalu lintas. Pasien sedang mengendarai sepeda motor dengan kecepatan sedang lalu ditabrak oleh motor lain dari belakang, pasien jatuh terguling guling di aspal, pasien sempat pingsan lalu dibawa ke Rumah Sakit Instruksi untuk peserta : 1. Evaluasi Survei primer dan sekunder 2. Diagnosa dan problem potensial – aktual 3. Keterampilan klinis 4. Komunikasi, edukasi dan profesionalisme
8	Instruksi untuk penguji	<u>Skenario Klinik :</u> Seorang laki-laki umur 26 tahun dibawa ke IGD dengan keluhan pusing dan sesak napas setelah mengalami kecelakaan lalu lintas. Pasien sedang mengendarai sepedamotor dengan kecepatan sedang lalu ditabrak oleh motor lain dari belakang, pasien jatuh terguling guling di aspal, pasien sempat pingsan lalu dibawa ke Rumah Sakit Instruksi untuk peserta : 1. Evaluasi survey primer dan sekunder 2. Diagnosa dan problem potensial – aktual 3. Keterampilan klinis 4. Komunikasi, edukasi dan profesionalisme

		Instruksi penguji : <u>INSTRUKSI UMUM</u> 1. Pastikan identitas peserta ujian pada kartu ujian 2. Tulislah nama dan nomor peserta ujian pada lembar penilaian! 3. Amatilah dan berilah skor (0/1/2/3) atas tugas yang dikerjakan peserta ujian serta skor <i>Global Rating</i> sesuai rubrik penilaian 4. Hindarilah interupsi dan/atau tindakan selain daripada yang diminta dalam instruksi penguji! 5. Berikan informasi/hasil yang dibutuhkan secara lisan/tulisan hanya apabila peserta ujian telah melakukan dan/atau mengusulkan jenis pemeriksaan yang dimaksud (perhatikan instruksi khusus)! 6. Taatilah peraturan serta etika penguji selama menjalankan tugas sebagai penguji OSCE - ATI! INSTRUKSI KHUSUS : 1. Penguji mengamati dan menilai tindakan preoperatif yang dilakukan peserta dan memberikan hasil pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang bila diminta oleh peserta. Dan memberikan penilaian tentang tindakan needle thoracosintesis Initial Assessment A: Airway clear B: Frekuensi nafas 30 x/menit, vocal fremitus kanan > kiri, nyeri tekan (+), hipersonor pada region torak kanan, dan suara vesikuler kiri > kanan C: Tekanan darah 110/70 mmHg, Nadi 105 x/menit, kuat, Jantung : suara jantung normal, Suhu 36,8°C. D: Alert (sadar baik) E: inspeksi nampak jejas pada torak dekstra Peserta menanyakan : Anamnese Alergi (-), Medication (-), Past illness (-), Last eaten (baru saja makan dan minum sebelum kejadian), Event (-) Secondary survey BB 52 kg, TB 168 cm. Kesadaran Compos mentis GCS15 E4V5M6, Pupil isokor 3mm/3mm RC
--	--	--

		Leher: tidak teraba limfonodi Frekuensi nafas 30 x/menit, nampak jejas pada torak dekstra, vocal fremitus kanan lebih besar dari kiri, didapatkan nyeri tekan hipersonor pada region torak kanan, dan suara vesikuler kiri lebih jelas dibanding kanan Tekanan darah 110/70 mmHg, Nadi 105 x/menit, kuat, Jantung : suara jantung normal, Suhu 36.8C. Abdomen: jejas (-) supel, nyeri tekan (-) Produksi urine : urine pekat Pemeriksaan penunjang : Hasil Laboratorium : Darah Rutin : Hb 13,1 gr%, Ht 41%, WBC 14 k/μL, Plt 230 gr/dl Faal Hemostasis : PPT 10,9 (12,2) , APTT 28,8 (30,7) Bun (Ureum) : 18 mg/dl, Creatinin 1,0 mg/dl Na 138 mmol/L, Kalium 4,2 mmol/L ,Cl 100 mmol/L Faal Hati :AST 189, ALT 163, albumin 3,5 Glukosa 90 mg/dl, Thorak foto : CTR<50% C/P terdapat pneumothorax kanan EKG : Sinus Takikardia. 2. Diagnosa dan problem potensial – aktual. Diagnosa : Pneumothorax Problem aktual: - Lambung penuh - Distress nafas Problem potensial - Hipotermia - Gagal nafas 3. Penguji menilai Manajemen trauma primary dan secondary survei yang dilakukan peserta. Penguji melakukan penilaian tindakan needle thoracosintesis: 1. Menentukan lokasi di ICS 2 linea mid clavikula 2. Lakukan desinfeksi dan memperkecil lapangan operasi dengan doek lobang 3. Digunakan jarum nomer besar (14) untuk menusuk tepi atas iga ketiga 4. Cabut jarum dari abbocath.
--	--	---

		5. Lakukan difiksasi
9		 Ruang 3mx4m Meja Operasi Meja Peserta Meja Peserta Kursi Meja penguji Meja Alat T.Sampah Kursi PS Kursi penguji
10	Peralatan yang dibutuhkan	Setting ruangan dokter-pasien - Meja dan kursi dokter 1 set - Kursi pasien 1 buah - Meja dan kursi penguji 1 set - Meja peralatan 1 buah - Meja operasi 1 set - Manekin 1 buah - Stetoskop 1 buah - Monitor Pasien 1 buah - Laringoskop 1 buah - Sungkup Muka 1 buah - Ambu Bag 1 buah - ETT 7 6,5 6 1 buah - Plester 1 buah - Sarung tangan non steril - Rekam medis 5 lembar - Tempat sampah tertutup 1 buah - Tissue 1 kotak - Jam dinding 1 buah

LEMBAR PENILAIAN
STATION ANESTESIA KEGAWATDARURATAN

Kandidat Residen : _____

Aspek yang Dinilai	0	1	2	3	Bobot	Nilai
1. Preoperatif Evaluation	Kandidat tidak melakukan initial assessment/ primary survey	Kandidat mampu melakukan semua pemeriksaan fisik sesuai masalah klinik pasien dengan menerapkan prinsip sebagai berikut secara tidak lengkap Pemeriksaan tanda vital : a. Airway b. Breathing c. Circulation d. Disability e. Environment	Kandidat mampu melakukan semua pemeriksaan fisik sesuai masalah klinik pasien dengan menerapkan prinsip sebagai berikut Pemeriksaan tanda vital : f. Airway g. Breathing h. Circulation i. Disability j. Environment Namun tidak melakukan cuci tangan atau memakai alat pelindung diri	Kandidat mampu melakukan semua initial assessment: 1. Mencuci tangan sebelum dan sesudah pemeriksaan. 2. Memakai alat pelindung diri 3. Pemeriksaan tanda vital a. Airway b. Breathing c. Circulation d. Disability e. Environment	4	
2. Diagnosa Problem potensial - actual	Peserta tidak menyebutkan diagnosa dan problem aktual dan potensial	Peserta hanya mampu menentukan diagnosa	Peserta mampu menentukan diagnose namun tidak lengkap menjelaskan problem aktual dan potensial	Peserta mampu menentukan diagnosa dan problem aktual-potensial secara lengkap	4	

3. keterampilan klinis	Peserta tidak ampu menentukan diagnose dan Peserta tidak mampu menjelaskan rencana anestesi	Peserta mampu menentukan tindakan anestesi dan tindakan emergency tp tidak lengkap dan menjelaskan rencana anestesi namun tidak lengkap dan runut dan tidak melakukan	Peserta mampu menentukan tindakan anestesi dan tindakan emergency serta menjelaskan rencana anestesi namun tidak lengkap dan runut dan melakukan	Peserta mampu menentukan tindakan anestesi dan menjelaskan rencana anestesi Dan melakukan PilihanAnestesi : General Anestesi intubasi dengan RSI Rencana Tindakan Anestesi : Rencana Tindakan Anestesi : 1. STATIC, menyiapkan obat anestesi yang diperlukan, mengecek mesin anestesi dan alat monitor pasien, memakai alat pelindung diri (minimal handschoen) 2. Siapkan 3 ukuran ETT, memilih pipa endotrakeal dengan ukuran lebih kecil : 6 atau 6,5 mm 3. Induksi yang dalam dengan agen IV cepat (propofol / etomidate), analgetik (fentanyl), dan bila ada Muscle relaxan kerja cepat Rocuronium 1 mg/kgbb 4. Diberikan ventilasi tekanan positip, bila sudah dalam dan rilex 5. mengambil laryngoskop dengan tangan kiri,	5	
-------------------------------	---	---	--	--	----------	--

				membuka mulut penderita tanpa ekstensi kepala, menyusuri lidah dari kiri ke kanan hingga tampak epiglotis dan plica vocalis 6. insersi pipa endotracheal 7. kembangkan cuff, 8. auskultasi untuk simetrisasi suara napas, 9. fiksasi		
4.Komunikasi, edukasi dan profesionalisme	Peserta ujian tidak meminta izin secara lisan dan sama sekali tidak melakukan poin berikut: 1.melakukan setiap tindakan dengan berhati-hati dan teliti sehingga tidak membahayakan pasien dan diri sendiri 2.memperhatikan kenyamanan pasien 3.melakukan tindakan sesuai prioritas 4.menunjukkan	Meminta izin secara lisan dan 1-2 poin berikut : 1. melakukan setiap tindakan dengan berhati-hati dan teliti sehingga tidak membahayakan pasien dan diri sendiri 2. memperhatikan kenyamanan pasien 3. melakukan tindakan sesuai prioritas 4. menunjukkan rasa hormat kepada pasien	Meminta izin secara lisan dan 3 poin berikut: 1. melakukan setiap tindakan dengan berhati-hati dan teliti sehingga tidak membahayakan pasien dan diri sendiri 2. memperhatikan kenyamanan pasien 3. melakukan tindakan sesuai prioritas 4. menunjukkan rasa hormat kepada pasien	Meminta izin secara lisan dan melakukan di bawah ini secara lengkap: 1. melakukan setiap tindakan dengan berhati-hati dan teliti sehingga tidak membahayakan pasien dan diri sendiri 2. memperhatikan kenyamanan pasien 3. melakukan tindakan sesuai prioritas 4. menunjukkan rasa hormat kepada pasien mengetahui keterbatasan dengan merujuk atau melakukan konsultasi bila diperlukan	3	

	rasa hormat kepada pasien mengetahui keterbatasan dengan merujuk atau melakukan konsultasi bila diperlukan	mengetahui keterbatasan dengan merujuk atau melakukan konsultasi bila diperlukan	mengetahui keterbatasan dengan merujuk atau melakukan konsultasi bila diperlukan			
--	---	--	--	--	--	--

II. Global performance

Beri tanda (✓) pada kolom yang disediakan sesuai dengan penilaian Anda secara umum terhadap kemampuan peserta ujian!

Tidak lulus	Borderline	Lulus	Superior

.....,
Penguji,

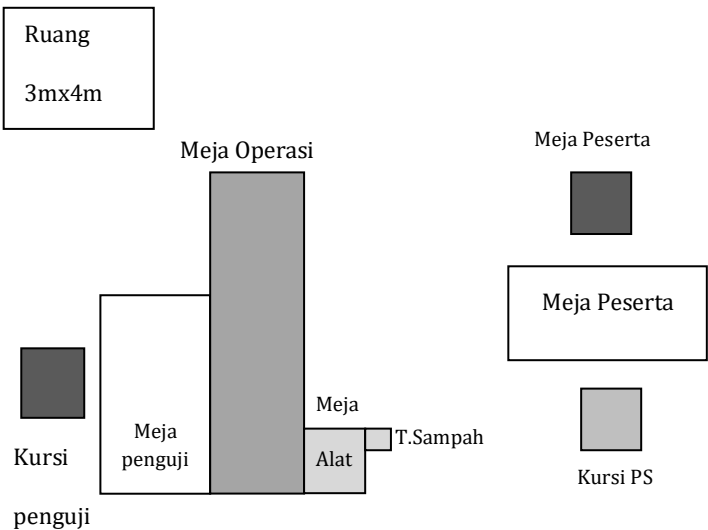
(.....)

SOAL UJIAN OSCE STATION ANESTESIA KEGAWATDARURATAN

1	Nomor Station	
2	Judul Station	Manajemen Penyulit Emergeni
3	Waktu yang dibutuhkan	20 menit
4	Tujuan Station	Menilai kemampuan melakukan Evaluasi Preoperative, Diagnosa dan problem potensial – aktual, Keterampilan klinis, dan komunikasi edukasi dan profesionalisme
5	Kompetensi :	1. Evaluasi Preoperative 2. Diagnosa dan problem potensial - aktual 3. Rencana tindakan anestesi 4. Keterampilan klinis 5. Monitoring dan manajemen penyulit 6. Manajemen paska bedah 7. Komunikasi, edukasi dan profesionalisme
6	Kategori	Anestesi Kegawat daruratan
7	Intruksi untuk peserta ujian	<u>Skenario Klinik :</u> Seorang laki-laki umur 26 tahun dibawa ke IGD dengan keluhan pusing dan sesak napas setelah mengalami kecelakaan lalu lintas. Pasien sedang mengendarai sepeda motor dengan kecepatan sedang lalu ditabrak oleh motor lain dari belakang, pasien jatuh terguling guling di aspal, pasien sempat pingsan lalu dibawa ke Rumah Sakit Instruksi untuk peserta : 1. Evaluasi Survei primer dan sekunder 2. Diagnosa dan problem potensial – aktual 3. Keterampilan klinis 4. Komunikasi, edukasi dan profesionalisme
8	Instruksi untuk penguji	<u>Skenario Klinik :</u> Seorang laki-laki umur 26 tahun dibawa ke IGD dengan keluhan pusing dan sesak napas setelah mengalami kecelakaan lalu lintas. Pasien sedang mengendarai sepedamotor dengan kecepatan sedang lalu ditabrak oleh motor lain dari belakang, pasien jatuh terguling guling di aspal, pasien sempat pingsan lalu dibawa ke Rumah Sakit Instruksi untuk peserta : 1. Evaluasi survey primer dan sekunder 2. Diagnosa dan problem potensial – aktual

		3. Keterampilan klinis 4. Komunikasi, edukasi dan profesionalisme Instruksi penguji : <u>INSTRUKSI UMUM</u> 1. Pastikan identitas peserta ujian pada kartu ujian 2. Tulislah nama dan nomor peserta ujian pada lembar penilaian! 3. Amatilah dan berilah skor (0/1/2/3) atas tugas yang dikerjakan peserta ujian serta skor <i>Global Rating</i> sesuai rubrik penilaian 4. Hindarilah interupsi dan/atau tindakan selain daripada yang diminta dalam instruksi penguji! 5. Berikan informasi/hasil yang dibutuhkan secara lisan/tulisan hanya apabila peserta ujian telah melakukan dan/atau mengusulkan jenis pemeriksaan yang dimaksud (perhatikan instruksi khusus)! 6. Taatilah peraturan serta etika penguji selama menjalankan tugas sebagai penguji OSCE - ATI! INSTRUKSI KHUSUS : 1. Penguji mengamati dan menilai tindakan preoperatif yang dilakukan peserta dan memberikan hasil pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang bila diminta oleh peserta. Dan memberikan penilaian tentang tindakan needle thoracosintesis Initial Assessment A: Airway clear B: Frekuensi nafas 30 x/menit, vocal fremitus kanan > kiri, nyeri tekan (+), hipersonor pada region torak kanan, dan suara vesikuler kiri > kanan C: Tekanan darah 110/70 mmHg, Nadi 105 x/menit, kuat, Jantung : suara jantung normal, Suhu 36,8°C. D: Alert (sadar baik) E: inspeksi nampak jejas pada torak dekstra Peserta menanyakan : Anamnese Alergi (-), Medication (-), Past illness (-), Last eaten (baru saja makan dan minum sebelum kejadian), Event (-) Secondary survey BB 52 kg, TB 168 cm.
--	--	---

		Kesadaran Compos mentis GCS15 E4V5M6, Pupil isokor 3mm/3mm RC Leher: tidak teraba limfonodi Frekuensi nafas 30 x/menit, nampak jejas pada torak dekstra, vocal fremitus kanan lebih besar dari kiri, didapatkan nyeri tekan hipersonor pada region torak kanan, dan suara vesikuler kiri lebih jelas dibanding kanan Tekanan darah 110/70 mmHg, Nadi 105 x/menit, kuat, Jantung : suara jantung normal, Suhu 36.8C. Abdomen: jejas (-) supel, nyeri tekan (-) Produksi urine : urine pekat Pemeriksaan penunjang : Hasil Laboratorium : Darah Rutin : Hb 13,1 gr%, Ht 41%, WBC 14 k/μL, Plt 230 gr/dl Faal Hemostasis : PPT10,9 (12,2) , APTT 28,8 (30,7) Bun (Ureum) : 18 mg/dl, Creatinin 1,0 mg/dl Na 138 mmol/L, Kalium 4,2 mmol/L ,Cl 100 mmol/L Faal Hati :AST 189, ALT 163, albumin 3,5 Glukosa 90 mg/dl, Thorak foto : CTR<50% C/P terdapat pneumothorax kanan EKG : Sinus Takikardia. 2. Diagnosa dan problem potensial – aktual. Diagnosa : Pneumothorax Problem aktual: - Lambung penuh - Distress nafas Problem potensial - Hipotermia - Gagal nafas 3. Penguji menilai Manajemen trauma primary dan secondary survei yang dilakukan peserta. Penguji melakukan penilaian tindakan needle thoracosintesis: 1. Menentukan lokasi di ICS 2 linea mid clavikula 2. Lakukan desinfeksi dan memperkecil lapangan operasi dengan doek lobang 3. Digunakan jarum nomer besar (14) untuk
--	--	--

		menusuk tepi atas iga ketiga 4. Cabut jarum dari abbocath. 5. Lakukan difiksasi
9		 Ruang 3mx4m Meja Operasi Meja Peserta Meja Peserta Kursi penguji Meja penguji Meja Alat T.Sampah Kursi PS
10	Peralatan yang dibutuhkan	Setting ruangan dokter-pasien - Meja dan kursi dokter 1 set - Kursi pasien 1 buah - Meja dan kursi penguji 1 set - Meja peralatan 1 buah - Meja operasi 1 set - Manekin 1 buah - Stetoskop 1 buah - Monitor Pasien 1 buah - Laringoskop 1 buah - Sungkup Muka 1 buah - Ambu Bag 1 buah - ETT 7 6,5 6 1 buah - Plester 1 buah - Sarung tangan non steril - Rekam medis 5 lembar - Tempat sampah tertutup 1 buah - Tissue 1 kotak - Jam dinding 1 buah

LEMBAR PENILAIAN
STATION ANESTESIA KEGAWATDARURATAN

Kandidat Residen : _____

Aspek yang Dinilai	0	1	2	3	Bobot	Nilai
1. Preoperatif Evaluation	Kandidat tidak melakukan initial assessment/ primary survey	Kandidat mampu melakukan semua pemeriksaan fisik sesuai masalah klinik pasien dengan menerapkan prinsip sebagai berikut secara tidak lengkap Pemeriksaan tanda vital : a. Airway b. Breathing c. Circulation d. Disability e. Environment	Kandidat mampu melakukan semua pemeriksaan fisik sesuai masalah klinik pasien dengan menerapkan prinsip sebagai berikut Pemeriksaan tanda vital : f. Airway g. Breathing h. Circulation i. Disability j. Environment Namun tidak melakukan cuci tangan atau memakai alat pelindung diri	Kandidat mampu melakukan semua initial assessment: 1. Mencuci tangan sebelum dan sesudah pemeriksaan. 2. Memakai alat pelindung diri 3. Pemeriksaan tanda vital a. Airway b. Breathing c. Circulation d. Disability e. Environment	4	
2. Diagnosa Problem potensial - actual	Peserta tidak menyebutkan diagnosa dan problem aktual dan potensial	Peserta hanya mampu menentukan diagnosa	Peserta mampu menentukan diagnose namun tidak lengkap menjelaskan problem aktual dan potensial	Peserta mampu menentukan diagnosa dan problem aktual-potensial secara lengkap	4	

3. keterampilan klinis	Peserta tidak ampu menentukan diagnose dan Peserta tidak mampu menjelaskan rencana anestesi	Peserta mampu menentukan tindakan anestesi dan tindakan emergency tp tidak lengkap dan menjelaskan rencana anestesi namun tidak lengkap dan runut dan tidak melakukan	Peserta mampu menentukan tindakan anestesi dan tindakan emergency serta menjelaskan rencana anestesi namun tidak lengkap dan runut dan melakukan	Peserta mampu menentukan tindakan anestesi dan menjelaskan rencana anestesi Dan melakukan PilihanAnestesi : General Anestesi intubasi dengan RSI Rencana Tindakan Anestesi : Rencana Tindakan Anestesi : 1. STATIC, menyiapkan obat anestesi yang diperlukan, mengecek mesin anestesi dan alat monitor pasien, memakai alat pelindung diri (minimal handschoen) 2. Siapkan 3 ukuran ETT, memilih pipa endotrakeal dengan ukuran lebih kecil : 6 atau 6,5 mm 3. Induksi yang dalam dengan agen IV cepat (propofol / etomidate), analgetik (fentanyl), dan bila ada Muscle relaxan kerja cepat Rocuronium 1 mg/kgbb 4. Diberikan ventilasi tekanan positip, bila sudah dalam dan rilex 5. mengambil laryngoskop dengan tangan kiri,	5	
-------------------------------	---	---	--	--	----------	--

				membuka mulut penderita tanpa ekstensi kepala, menyusuri lidah dari kiri ke kanan hingga tampak epiglotis dan plica vocalis 6. insersi pipa endotracheal 7. kembangkan cuff, 8. auskultasi untuk simetrisasi suara napas, 9. fiksasi		
4.Komunikasi, edukasi dan profesionalisme	Peserta ujian tidak meminta izin secara lisan dan sama sekali tidak melakukan poin berikut: 1.melakukan setiap tindakan dengan berhati-hati dan teliti sehingga tidak membahayakan pasien dan diri sendiri 2.memperhatikan kenyamanan pasien 3.melakukan tindakan sesuai prioritas 4.menunjukkan	Meminta izin secara lisan dan 1-2 poin berikut : 1. melakukan setiap tindakan dengan berhati-hati dan teliti sehingga tidak membahayakan pasien dan diri sendiri 2. memperhatikan kenyamanan pasien 3. melakukan tindakan sesuai prioritas 4. menunjukkan rasa hormat kepada pasien	Meminta izin secara lisan dan 3 poin berikut: 1. melakukan setiap tindakan dengan berhati-hati dan teliti sehingga tidak membahayakan pasien dan diri sendiri 2. memperhatikan kenyamanan pasien 3. melakukan tindakan sesuai prioritas 4. menunjukkan rasa hormat kepada pasien	Meminta izin secara lisan dan melakukan di bawah ini secara lengkap: 1. melakukan setiap tindakan dengan berhati-hati dan teliti sehingga tidak membahayakan pasien dan diri sendiri 2. memperhatikan kenyamanan pasien 3. melakukan tindakan sesuai prioritas 4. menunjukkan rasa hormat kepada pasien mengetahui keterbatasan dengan merujuk atau melakukan konsultasi bila diperlukan	3	

	rasa hormat kepada pasien mengetahui keterbatasan dengan merujuk atau melakukan konsultasi bila diperlukan	mengetahui keterbatasan dengan merujuk atau melakukan konsultasi bila diperlukan	mengetahui keterbatasan dengan merujuk atau melakukan konsultasi bila diperlukan			
--	---	--	--	--	--	--

II. Global performance

Beri tanda (✓) pada kolom yang disediakan sesuai dengan penilaian Anda secara umum terhadap kemampuan peserta ujian!

Tidak lulus	Borderline	Lulus	Superior

.....,
Penguji,

(.....)

TERAPI INTENSIF (ICU)

SOAL UJIAN OSCE STATION TERAPI INTENSIF

1.	No. station	
2.	Judul station	Preeklamsia berat dengan oedem pulmo
3.	Waktu yang dibutuhkan	20 menit
4.	Tujuan station	Peserta ujian mampu melakukan pemeriksaan fisik, menegakan diagnosis dan penatalaksanaan di ICU
5.	kompetensi	1. Kemampuan pemeriksaan fisik 2. Kemampuan tes/prosedur klinis atau interpretasi data untuk menunjang diagnosis 3. Penegakan diagnosis 4. Tatalaksana nonfarmakologis 5. Tatalaksana farmakologis 6. Komunikasi dan edukasi 7. Perilaku profesional
6.	Kategori	Critical care
7.	Instruksi untuk peserta	skenario klinik : Seorang wanita 24 tahun dikonsul masuk ICU dengan post SC dengan sesak nafas. Riwayat penyakit : pasien post SC emergensi atas indikasi fetal distress 1 jam yang lalu, sebelumnya pasien mengeluh sesak nafas sejak 1 hari yang lalu, selama hamil pasien hipertensi dan kedua kaki bengkak. Pemeriksaan fisik saat ini pasien nampak gelisah. Frekuensi napas 35 kali/menit, tensi 170/100 mmHg, nadi 120 kali/menit teraba kuat, akral dingin. Saturasi oksigen 92 % dengan oksigen 12 ltr/mnt NRM. Suhu 36,8 C. Tugas : 1. Lakukan pemeriksaan fisik untuk pasien ini 2. Tentukan prosedur klinis untuk menunjang diagnosis 3. Tentukan diagnosis klinis 4. Lakukan tatalaksana nonfarmakologis dan farmakologis serta monitoring setelah tindakan. 5. Tentukan kemungkinan penyulit atau komplikasi tatalaksana nonfarmakologis dan farmakologis serta antisipasi awal penyulit tersebut.
8.	Instruksi untuk penguji	skenario klinik : Seorang wanita 24 tahun dikonsul masuk ICU dengan post SC dengan sesak nafas. Riwayat penyakit : pasien post SC emergensi atas indikasi fetal distress 1 jam yang lalu, sebelumnya pasien mengeluh sesak nafas sejak 1 hari yang lalu, selama hamil pasien hipertensi dan kedua kaki bengkak. Pemeriksaan fisik saat ini pasien nampak gelisah. Frekuensi napas 35 kali/menit, tensi 170/100 mmHg, nadi 120 kali/menit teraba kuat, akral dingin. Saturasi oksigen 92 % dengan oksigen 12 ltr/mnt NRM. Suhu 36,8 C. Tugas : 1. Lakukan pemeriksaan fisik untuk pasien ini 2. Tentukan prosedur klinis untuk menunjang diagnosis 3. Tentukan diagnosis klinis 4. Lakukan tatalaksana nonfarmakologis dan farmakologis

		Instruksi untuk penguji : 1. Penguji mengamati dan menilai penampilan peserta berdasarkan lembar penilaian penguji menilai kemampuan peserta untuk melakukan pemeriksaan fisis Inspeksi : frekuensi nafas, tanda-tanda distress nafas, rektrasi, sianosis, pernafasan cuping hidung, gelisah palpasi : perkusi : pekak, batas jantung auskultasi : suara nafas kiri kanan, bunyi tambahan 2. Penguji tidak diperbolehkan melakukan interupsi ataupun bertanya kepada peserta selain yang ditentukan 3. Penguji memberitahukan data pemeriksaan fisik dan laboratorium sesuai scenario. 4. Penguji memberikan hasil pemeriksaan penunjang Hb : 9 gr/dl, Lekosit 24.000. Platelet : 120.000/ml³, Proteine uria (+2) AGD : pH : 7.2, PaO₂ : 50, PaCO₂ : 25, HCO₃ : 18, BE: -6 Ronsen thorax : oedem pulmo EKG : Sinus takikardi, 120x, normoaxis 5. Penguji menilai kemampuan diagnosis Diagnosis : Pembacaan AGD : Asidosis metabolik kompensasi alkalosis respiratorik dengan hipoksemia. Diagnosis Klinis : Preeklamsia berat dengan oedem pulmo dengan gagal napas tipe 1 (hipoksemia) Kriteria gagal napas : PaO₂ : < 50, PaCO₂ > 50 Frekuensi napas > 35, tanda-tanda distress napas 6. Penguji menilai kemampuan peserta ujian dalam tatalaksana nonfarmakologi dan farmakologi Nonfarmakologis : Lakukan intubasi (hanya menyebut, tidak memperagakan) Setting ventilator : Initial setting ventilator : Mode Pressure/volume control ventilation, Predicted body weight : 60 Kg. TV : 360 ml, RR : 12 X/mnt, PEEP : 5, I:E ratio 1:2, FiO₂ 100%. Penilaian klinis/monitoring setelah setting awal ventilator Fisis : Suara napas, hemodinamik, oksigenasi (saturasi) Farmakologis : Restriksi cairan MgSO₄ 4g iv loading 15 menit, dilanjutkan 1-3g/jam Anti hipertensi : Nifedipine 3x10 mg Diuretik : Furosemid bolus/syringepump Analgetik post op : NSAID (paracetamol 1gr/ 8jam), fentanyl 0,5 mcg/kgBB/jam (30 mcg/jam) 7. Penguji menilai kemampuan peserta ujian memprediksi kemungkinan penyulit serta antisipasinya. Penyulit/komplikasi : Kejang / eklamsia (terapi MgSO₄) Toksitas MgSO₄ (hiporefleks, terapi ca glukonas)
--	--	--

		Hipotensi (kekurangan cairan dan efek obat, setting ventilator) antisipasi nilai status volume dan pemberian cairan Desaturasi (setting ventilator tidak adekuat, masalah mekanik: ETT, tubing ventilator, endobronkial, lendir, pneumotoraks) antisipasi evaluasi ulang setting ventilator (TV ekspirasi, PEEP, I:E ratio) Tanda-tanda gagal jantung.
9.	Denah ruangan	The diagram illustrates the layout of a simulation room. It features a yellow rectangular area labeled 'Meja peguji' (exam table) and a smaller yellow rectangle labeled 'Kursi penguji' (exam chair). To the right of the exam table is a blue rectangle labeled 'Meja alat' (instrument table). Further right is a green cross symbol labeled 'Tiang infus' (IV stand). On the far right is a blue rectangular area labeled 'Tempat tidur' (bed) containing a blue circle representing a 'Manekin' (manikin).
10.	Peralatan yang dibutuhkan	1. Ventilator + lung test 2. Tabung oksigen 3. Bed side Monitor simulasi 4. Tempat tidur 5. Masker oksigen 6. Stetoskop 7. Tiang infus + infus set
11.	Penulis	ada dalam data base
12.	Referensi	Morgan & Michail's Clinical Anesthesiologi 5th edition Oh's Intensive care Manual, 7th edition

RUBRIK ACTUAL MARK

SOAL UJIAN OSCE STATION TERAPI INTENSIF

Aspek yang Dinilai	0	1	2	3	Bobot	Skor
1. Kemampuan Tes/Prosedur Klinis atau Interpretasi Data untuk Menunjang Diagnosis	Peserta ujian mengusulkan pemeriksaan penunjang selain yang telah ditetapkan	Peserta ujian hanya dapat mengusulkan 1 pemeriksaan penunjang dengan tepat tetapi tidak dapat memberikan interpretasi dengan benar,	Peserta ujian hanya dapat mengusulkan 2 pemeriksaan penunjang dengan tepat tetapi interpretasi dengan tidak benar	Peserta ujian mengusulkan pemeriksaan penunjang dengan tepat dan dapat memberikan interpretasi dengan benar terhadap pemeriksaan: • AGD • Foto thoraks • EKG	3	
2. Kemampuan Memprediksi Penyulit dan Diagnosis Definitif Pasien Kritis	Peserta ujian tidak dapat menyampaikan problema klinis dan tidak menyampaikan alasan	Peserta ujian hanya menyampaikan problema klinis dengan benar tetapi tidak menyampaikan alasan	Peserta ujian hanya menyampaikan problema klinis dengan benar tetapi alasan tidak lengkap	Peserta ujian dapat menyampaikan problema klinis PEB dengan Oedema pulmo 1. Hipertensi, 2. Pasien post partum 3. Edema tungkai 4. Protein uria 5. Sesak nafas 6. Rontgen thorax : infiltrat diffuse bilateral	3	
3. Kemampuan Penatalaksanaan	Peserta ujian tidak dapat	Peserta kurang lengkap melakukan tata laksana	Peserta kurang lengkap melakukan tata laksana	Peserta tepat melakukan tata laksana pada pasien	3	

Pasien Kritis dan Penyulit (Non-Farmakologis)	melakukan tata laksana pada pasien (dapat menyebutkan <4)	pada pasien (dapat menyebutkan 4-6)	pada pasien (dapat menyebutkan 7-8 tetapi tidak menyebutkan salah satu poin 3, 4, 5, dan 6)	(dapat menyebutkan 7-8 termasuk poin 3, 4, 5, dan 6) meliputi : • Setting ventilator dengan benar dari semua parameter 1. Mode Pressure/ Volume Control Ventilation, 2. Volume tidal awal 8 ml/kg PBW = 480 ml dan dikurangi 1 ml/Kg PBW setiap ≤ 2jam sampai tercapai VT 6 ml/Kg PBW (360 ml) 3. PPlat ≤30 cmH2O 4. PEEP minimal 5 cm H2O 5. FiO2 ≤ 0,6 dengan target SO2 minimal 88% atau 88%-95% atau PaO2 55-80 mmHg 6. Respirasi rate 12-16 x/menit 7. I : E ratio 1 : 2 8. Head up 20-30 derajat		
4. Kemampuan tata laksana	Peserta ujian tidak dapat	Peserta kurang lengkap melakukan tata laksana	Peserta kurang lengkap melakukan tata laksana	Farmakologis : 1. Restriksi cairan	3	

farmakologis	melakukan tata laksana pada pasien (dapat menyebutkan <2)	pada pasien (dapat menyebutkan 2-3)	pada pasien (dapat menyebutkan tetapi tidak menyebutkan salah satu poin)	2. MgSO ₄ 4g iv loading 15 menit, dilanjutkan 1-3g/jam 3. Anti hipertensi : Nifedipine 3x10 mg 4. Diuretik : Furosemid bolus/syringepump 5. Analgetik post op : NSAID (paracetamol 1gr/8jam), fentanyl 0,5 mcg/kgBB/jam (30 mcg/jam)		
5. Kemampuan mengantisipasi penyulit/ komplikasi Pasien Kritis	Peserta ujian tidak dapat melakukan tata laksana pada pasien	Peserta kurang lengkap melakukan tata laksana pada pasien (dapat menyebutkan 2-3)	Peserta kurang lengkap melakukan tata laksana pada pasien (dapat menyebutkan tetapi tidak menyebutkan salah satu poin)	Penyulit/ komplikasi : 1. Kejang / eklamsia (terapi MgSO ₄) Toksisitas MgSO ₄ (hiporefleks, terapi Ca glukonas) 2. Hipotensi (kekurangan cairan dan efek obat, setting ventilator) antisipasi nilai status volume dan pemberian cairan	2	

				3. Desaturasi (setting ventilator tidak adekuat, masalah mekanik: ETT, tubing ventilator, endobronkial, lendir, pneumotoraks) antisipasi evaluasi ulang setting ventilator (TV ekspirasi, PEEP, I:E ratio) 4. Tanda-tanda gagal jantung		
6. Komunikasi, Edukasi dan Profesionalisme	Peserta ujian tidak meminta meminta izin secara lisan dan sama sekali tidak melakukan point yang diminta	Peserta ujian meminta izin secara lisan dan melakukan 1-2 point yang diminta	Peserta ujian meminta izin secara lisan dan melakukan 3-4 point yang diminta	Peserta meminta izin secara lisan dan melakukan hal di bawah ini secara lengkap: 1. Melakukan setiap tindakan dengan berhati-hati dan teliti sehingga tidak membahayakan pasien dan diri sendiri 2. Memperhatikan kenyamanan pasien 3. Melakukan tindakan sesuai prioritas 4. Menunjukkan rasa	1	

				hormat kepada pasien 5. Mengetahui keterbatasan dengan merujuk atau melakukan konsultasi bila diperlukan		
TOTAL SKOR						

II. Global performance

Beri tanda (√) pada kolom yang disediakan sesuai dengan penilaian Anda secara umum terhadap kemampuan peserta ujian!

Tidak lulus	Borderline	Lulus	Superior

.....,

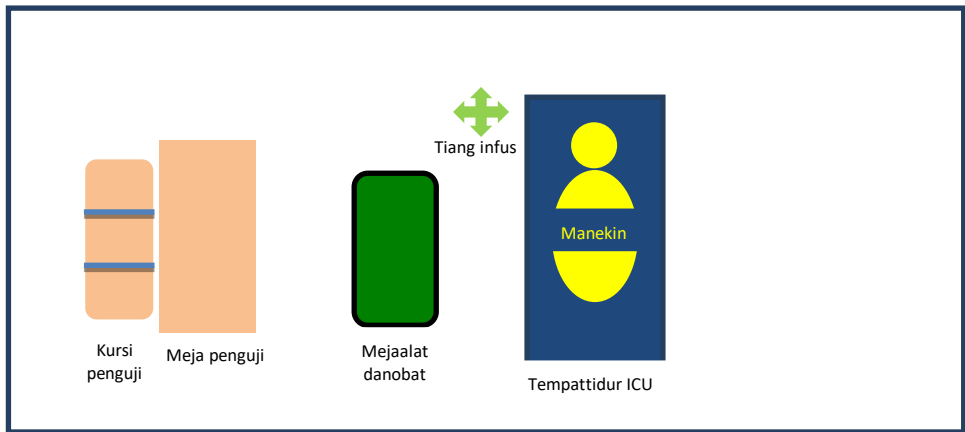
Penguji,

(.....)

SOAL UJIAN OSCE STATION TERAPI INTENSIF

1.	No. Station	5
2.	Judul Station	Gagal Nafas + Syok Kardiogenik
3.	WaktuYang Dibutuhkan	20 menit
4.	Tujuan Station	Tes / Prosedur Klinis atau Interpretasi Data untuk Menunjang Diagnosis, MemprediksiPenyulitdan Diagnosis DefinitifPasienKritis, PenatalaksanaanPasienKritisdanPenyulit (Farmakologisdan Non-Farmakologis), Komunikasi, EdukasidanProfesionalisme
5.	Kompetensi	1. <i>Initial Assessment / Primary Survey</i> 2. Kemampuan Tes / Prosedur Klinis atau Interpretasi Data untuk Menunjang Diagnosis 3. Kemampuan Memprediksi Penyulit dan Diagnosis Definitif Pasien Kritis 4. Kemampuan Penatalaksanaan Pasien Kritis dan Penyulit (Farmakologis dan Non-Farmakologis) 5. Kemampuan Monitoring 6. Komunikasi, Edukasi dan Profesionalisme
6.	Kategori	1. Anestesia Obstetrik 2. Anestesia Bedah Saraf 3. Anestesia Regional Dan Manajemen Nyeri 4. Anestesia Bedah Toraks 5. Anestesia Pediatrik 6. Anestesia Kegawatdaruratan 7. Anestesia Urologi 8. Anestesia Untuk Penyakit Penyakit Khusus (Endokrin, Metabolik, Penyulit Kardiovaskular) 9. Anestesia Bedah Kepala Leher 10. Anestesia Bedah Rawat Jalan / Luar Kamar Bedah 11. Anestesia Pada Prosedur Invasif Minimal 12. Terapi Intensif
7.	Instruksi Untuk Peserta	<u>SKENARIO KLINIK:</u> Seorang laki-laki 50 tahun, tinggi badan 65 inchi, masuk keICU setelahdirujuk dari RS luar dengan keluhan sesak nafas. 3 hari sebelumnya pasien menjalani perawatan di ICCU karena nyeri dada. <u>INSTRUKSI UNTUK PESERTA:</u> 1. Usulkan pada penguji pemeriksaan penunjang dan interpretasinya. 2. Tentukan diagnosis klinispasienini. 3. Sampaikan pada penguji penatatalaksanaan farmakologisdan non-farmakologisdan setting ventilator untuk pasien ini.
8.	Instruksi Untuk Penguji	<u>INSTRUKSI UMUM</u> 1. Pastikan identitas peserta ujian pada kartu ujian 2. Tulislah nama dan nomor peserta ujian pada lembar penilaian! 3. Amatilah dan berilah skor (0/1/2/3) atas tugas yang dikerjakan peserta ujian serta skor <i>Global Rating</i> sesuai rubrik penilaian 4. Hindarilah interupsi dan/atau tindakan selain daripada yang diminta

	dalam instruksi pengujian! - Berikan informasi/hasil yang dibutuhkan secara lisan/tulisan hanya apabila peserta ujian telah melakukan dan/atau mengusulkan jenis pemeriksaan yang dimaksud (perhatikan instruksi khusus)! - Taatilah peraturan serta etika pengujian selama menjalankan tugas sebagai pengujian OSCE - KATI! <u>INSTRUKSI KHUSUS</u> Pengujian mengamati dan menilai penampilan peserta berdasarkan lembar penilaian Pengujian memberikan kertas berisi informasi mengenai pasien, yang berisi <i>Initial Assessment</i>: - Jalan nafas bebas, snoring/gargling/crowing: -/-/- - Frekuensi napas 35 kali/menit, retraksi iga (+), sianosis, pernafasan cuping hidung, ronchi basah (+) seluruh lapangan paru, SpO₂ 82% (oksigen 12 ltr/mnt via NRM) - Perfusi dingin/basah/pucat, nadi 130 kali/menit teraba halus, tekanan darah 70/40 mmHg, tampak vena jugular distensi - Kesadaran somnolen, pupil isokor, RC (+/+) simetris - Telah terpasang foley kateter, dengan produksi urine (-) - Abdomen soepel, bising usus (+) normal - Dijumpai edem pada ekstremitas bawah Pengujian menjawab hasil pemeriksaan penunjang (hanya jika diminta oleh peserta!) dan menilai interpretasi yang dilakukan oleh peserta uji! Pemeriksaan Penunjang: AGDA : pH: 7.15, PaO₂: 47, PaCO₂: 50, HCO₃: 12, BE: -12, SaO₂: 85% Interpretasi: Kombinasi Asidosis metabolik dan respiratorik dengan hipoksemia Pengujian memberikan foto thoraks pada peserta ujian Interpretasi: Cardiomegaly dan Edema Paru Darah rutin: Hb: 9 gr/dl, Leukosit: 15.000, Platelet: 138.000/ml³ Interpretasi: Anemia, leukositosis Laktat: 5 mmol/L Interpretasi: Hiperlaktanemia Pengujian memberikan hasil EKG pada peserta ujian Interpretasi: OMI Anteroseptal Pengujian menilai diagnosis klinis Diagnosis Klinis : - Gagal Napas Tipe 1 dan 2 - Syok Kardiogenik - Edema Paru Akut Pengujian menilai kemampuan peserta ujian dalam tatalaksana dan setting ventilator
--	--

		• Non-Farmakologis: – Intubasi dengan teknik RSI – Setting ventilator :Mode Pressure/ Volume Control Ventilation, <i>Predicted Body Weight:</i> 60 Kg, TV:240-360 ml, MV: 6 liter, RR: 20 x/mnt, PEEP: ≥ 8 cmH2O, I:E ratio 1:2, FiO2: 100%, P.Plateau: <30 cmH2O • Farmakologis: – Restriksi Terapi cairan – Inotropik – Diuretik – Sedasi dan Analgesia – Nutrisi – Stress Ulcer Prevention – Glucose Control – Thromboembolitic Prophylaxis		
9.	Denah Ruang	 The diagram illustrates the layout of an ICU room. It includes a 'Kursi penguji' (exam chair) and a 'Meja penguji' (exam table) on the left. In the center is a 'Meja alat dan obat' (equipment and drug table). To the right is a 'Tempat tidur ICU' (ICU bed) with a 'Manekin' (manikin) on it. A 'Tiang infus' (infusion stand) is positioned between the equipment table and the bed. A green cross symbol is above the infusion stand.		
10	Instruksi Pasien Standar	-		
11	Kebutuhan Laboran	Jumlah Laboran : 1 orang Tugas Laboran : Berperan sebagai Perawat Ruang Perawatan Intensif		
12	Peralatan Yang Dibutuhkan	<table><tr><td>Setting Ruang Rawat Intensif – Meja dan kursi penguji – Tempat sampah – Meja peralatan dan obat – Ventilator + lung test – Mesin suction + selang suction – Tabung oksigen – Tempat tidur pasien – Stetoskop – Tiang infus + infus set – Sarung tangan non steril – Jam dinding – Plester – Gunting – Nier bekken (bengkok) </td><td> – 3 set – 1 Buah – 1 buah – 1 set – 1 set – 1 buah – 1 buah – 1 buah – 1 buah – 2 pasang – 1 buah – 1 buah – 1 buah – 1 buah </td></tr></table>	Setting Ruang Rawat Intensif – Meja dan kursi penguji – Tempat sampah – Meja peralatan dan obat – Ventilator + lung test – Mesin suction + selang suction – Tabung oksigen – Tempat tidur pasien – Stetoskop – Tiang infus + infus set – Sarung tangan non steril – Jam dinding – Plester – Gunting – Nier bekken (bengkok)	– 3 set – 1 Buah – 1 buah – 1 set – 1 set – 1 buah – 1 buah – 1 buah – 1 buah – 2 pasang – 1 buah – 1 buah – 1 buah – 1 buah
Setting Ruang Rawat Intensif – Meja dan kursi penguji – Tempat sampah – Meja peralatan dan obat – Ventilator + lung test – Mesin suction + selang suction – Tabung oksigen – Tempat tidur pasien – Stetoskop – Tiang infus + infus set – Sarung tangan non steril – Jam dinding – Plester – Gunting – Nier bekken (bengkok)	– 3 set – 1 Buah – 1 buah – 1 set – 1 set – 1 buah – 1 buah – 1 buah – 1 buah – 2 pasang – 1 buah – 1 buah – 1 buah – 1 buah			

		– Sulfast Atropin 0,25mg – Lidocaine 2% – Midazolam 5mg – Fentanyl 100mcg/Morphine 10mg/ Pethidin100mg – Propofol 200mg – Rocuronium 50mg /Atracurium 50mg / Vecuronium 10mg – ETT 7.5,7, 6.5 – Suction cath no 12, 14 – NG tube no 16, 18 – IV cath no 18, 20 – 3 way stop cock – Laringoskop – Oropharyngeal airway – Sungkup muka – FotoThoraks (Cardiomegaly + Edema Paru) – EKG (OMI Anteroseptal) – AlatTulis Kantor	– 2 ampul – 2 ampul – 1 ampul – 2ampul – 1ampul – 1 ampul – Masing-masing 1 buah – Masing-masing 1 buah – Masing-masing 1 buah – Masing-masing 1 buah – 1 buah – 1 buah – 1 buah – 1 set – 1 buah – 1 buah – 3 set <i>(Harus disediakan semua obat dan peralatan yang akan dipakai)</i>
13	Kebutuhan Manekin	Manekinintubasidewasa (1 buah)	
14	Penulis	-	
15	Referensi	Morgan,GE; Mikhail, MS; Murray, MJ; 2006	

RUBRIK ACTUAL MARK

SOAL UJIAN OSCE STATION TERAPI INTENSIF

Aspek yang Dinilai	0	1	2	3	Bobot	Skor
1. Kemampuan Tes/Prosedur Klinis atau Interpretasi Data untuk Menunjang Diagnosis	Peserta ujian mengusulkan pemeriksaan penunjang selain yang telah ditetapkan	Peserta ujian hanya dapat mengusulkan 1 pemeriksaan penunjang dengan tepat dan dapat memberikan interpretasi dengan benar yang didalamnya termasuk pemeriksaan : • AGDA • Foto thoraks	Peserta ujian hanya dapat mengusulkan 2-3 pemeriksaan penunjang dengan tepat dan dapat memberikan interpretasi dengan benar yang didalamnya termasuk pemeriksaan : • AGDA • Foto thoraks	Peserta ujian mengusulkan pemeriksaan penunjang dengan tepat dan dapat memberikan interpretasi dengan benar terhadap pemeriksaan: • AGDA • Foto thoraks • Darah lengkap • Laktat • EKG	2	
3. Kemampuan Memprediksi Penyulit dan Diagnosis Definitif Pasien Kritis	Peserta ujian tidak dapat menyampaikan diagnosis klinis	Peserta hanya menyampaikan 1 dari 3 diagnosis klinis	Peserta ujian hanya menyampaikan 2 dari 3 diagnosis klinis	Peserta ujian dapat menyampaikan seluruh diagnosis klinis: 1. Gagal Napas Tipe 1 dan 2 2. Syok Kardiogenik 3. Edema Paru Akut	2	
4. Kemampuan Penatalaksanaan Pasien Kritis dan Penyulit (Farmakologis dan Non-Farmakologis)	Peserta ujian tidak dapat melakukan tata laksana pada pasien	Peserta hanya dapat melakukan tata laksana pada pasien meliputi : • Intubasi teknik RSI • Setting ventilator	Peserta tepat melakukan tata laksana pada pasien meliputi : • Intubasi teknik RSI • Setting ventilator Namun hanya dapat menyebutkan 4 dari 8 terapi farmakologis	Peserta tepat melakukan tata laksana pada pasien meliputi : • Intubasi teknik RSI • Setting ventilator • 8 terapi farmakologis	4	
5. Komunikasi,	Peserta ujian	Peserta ujian meminta izin	Peserta ujian meminta	Peserta meminta izin		

Edukasi dan Profesionalisme	tidak meminta izin secara lisan dan sama sekali tidak melakukan point yang diminta	secara lisan dan melakukan 1-2 point yang diminta	izin secara lisan dan melakukan 3-4 point yang diminta	secara lisan dan melakukan hal di bawah ini secara lengkap: 1. Melakukan setiap tindakan dengan berhati-hati dan teliti sehingga tidak membahayakan pasien dan diri sendiri 2. Memperhatikan kenyamanan pasien 3. Melakukan tindakan sesuai prioritas 4. Menunjukkan rasa hormat kepada pasien 5. Mengetahui keterbatasan dengan merujuk atau melakukan konsultasi bila diperlukan		
TOTAL SKOR						

II. Global performance

Beri tanda (✓) pada kolom yang disediakan sesuai dengan penilaian Anda secara umum terhadap kemampuan peserta ujian!

Tidak lulus	Borderline	Lulus	Superior

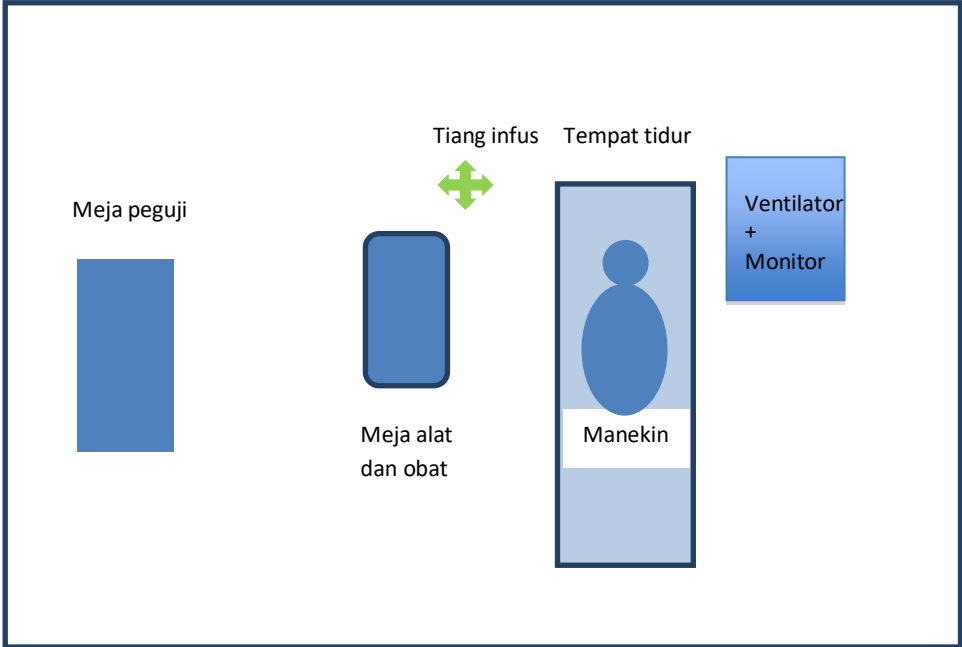
.....,
Penguji,

(.....)

SOAL UJIAN OSCE STATION TERAPI INTENSIF

1.	No. station	7
2.	Judul station	Gagal Nafas
3.	Waktu yang dibutuhkan	20 menit
4.	Tujuan station	Menilai kemampuan Initial assessment / primary survey, memprediksi penyulit dan diagnosis definitif pasien kritis, penatalaksanaan pasien kritis dan penyulit (farmakologis dan nonfarmakologis)
5.	kompetensi	1. Initial assessment / primary survey 2. Kemampuan tes/prosedur klinis atau interpretasi data untuk menunjang diagnosis 3. Kemampuan memprediksi penyulit dan diagnosis definitif pasien kritis 4. Kemampuan penatalaksanaan pasien kritis dan penyulit (farmakologis dan nonfarmakologis) 5. Kemampuan monitoring 6. Komunikasi Edukasi dan Perilaku profesional
6.	Kategori	1. Anestesi obstetri 2. Neuroanestesi 3. Anestesi Regional dan Manajemen Nyeri 4. Anestesi Kardiovaskular 5. Anestesi Pediatrik 6. Anestesi Kegawat daruratan 7. Anestesi Urologi 8. Anestesi untuk penyakit Endokrin, metabolic dan penyakit – penyakit khusus 9. ICU 10. Anestesi pada kepala leher
7.	Instruksi untuk peserta	Skenario Klinik : Seorang laki-laki 60 tahun Panjang badan 64 inci, masuk ICU dirujuk dari RS luar dengan keluhan penurunan kesadaran. 3 hari yang lalu pasien menjalani laparotomi kausa peritonitis Instruksi untuk peserta: 1. Lakukan Initial assesment untuk pasien ini 2. Tentukan prosedur klinis untuk penunjang diagnosis 3. Tentukan diagnosis klinis 4. Lakukan intubasi dan setting ventilator pada pasien ini 5. Lakukan monitoring paska setting ventilator
8.	Instruksi untuk penguji	Skenario Klinik : Seorang laki-laki 60 tahun Panjang badan 64 inci, masuk ICU dirujuk dari RS luar dengan keluhan penurunan kesadaran. 3 hari yang lalu pasien menjalani laparotomi kausa peritonitis. Instruksi untuk peserta: 1. Lakukan Initial assesment untuk pasien ini 2. Tentukan prosedur klinis untuk penunjang diagnosis 3. Tentukan diagnosis klinis 4. Lakukan intubasi dan setting ventilator pada pasien ini 5. Lakukan monitoring paska setting ventilator

		Instruksi untuk penguji : <u>INSTRUKSI UMUM</u> 1. Pastikan identitas peserta ujian pada kartu ujian 2. Tulislah nama dan nomor peserta ujian pada lembar penilaian! 3. Amatilah dan berilah skor (0/1/2/3) atas tugas yang dikerjakan peserta ujian serta skor <i>Global Rating</i> sesuai rubrik penilaian 4. Hindarilah interupsi dan/atau tindakan selain daripada yang diminta dalam instruksi penguji! 5. Berikan informasi/hasil yang dibutuhkan secara lisan/tulisan hanya apabila peserta ujian telah melakukan dan/atau mengusulkan jenis pemeriksaan yang dimaksud (perhatikan instruksi khusus)! 6. Taatilah peraturan serta etika penguji selama menjalankan tugas sebagai penguji OSCE - ATI! <u>INSTRUKSI KHUSUS</u> 1. Penguji mengamati dan menilai penampilan peserta berdasarkan lembar penilaian. Penguji menilai kemampuan peserta untuk melakukan pemeriksaan fisik. Penguji menyampaikan hasil setelah kandidat melakukan pemeriksaan. Hasil pemeriksaan : Pasien tampak gelisah, respon dengan rangsangan nyeri. Sensorium somnolen, pupil isokor RC +/- kanan = kiri Airway clear, Frekwensi napas 35 kali/menit, rektrasi iga, sianosis, pernafasan cuping , suara nafas vesikuler mengeras, rochi basah (+) Tekanan darah 80/50 mmHg, Laju nadi 120 kali/menit teraba halus, akral dingin. Temperatur 39 C Saturasi oksigen 92 % dengan oksigen 12 ltr/mnt NRM, 2. Penguji memberitahukan data pemeriksaan fisik dan laboratorium sesuai skenario. Penguji memberikan hasil pemeriksaan penunjang Hb : 9 gr/dl, Lekosit 24.000. Platelet :80.000/ml³. Lactat 4 mmol/L Interpretasi : Anemia, leukositosis, trombositopeni AGD : pH : 7.2, PaO₂ : 50, PaCO₂ : 25, HCO₃ : 18, BE: -6 Pembacaan AGD : Asidosis metabolik kompensasi alkalosis respiratorik dengan hipoksemia. 3. Penguji menilai diagnosis klinis Diagnosis Klinis : Syok sepsis dengan gagal napas tipe 1 (hipoksemia) 4. Penguji penilaian intubasi dan setting ventilator pada pasien tersebut Lakukan intubasi teknik RSI Setting ventilator : Initial setting ventilator : Mode Pressure/volume control ventilation, Predicted body weight : 60 KG. TV : 360 ml, RR : 12 X/mnt, PEEP : 5, I:E ratio 1:2, FiO₂ 100%. 5. Penguji penilaian monitoring setelah setting ventilator. Penilaian klinis/monitoring setelah setting awal ventilator • Penguji menyebutkan hasil pemeriksaan peserta : Tekanan darah 110/60 mmHg, Nadi 100 x/i, akral dingin, Temperature 37,5 C Sp O₂ 96%, UOP 40 cc/jam. AGD • Head elevation
--	--	--

		• DOPE (Dislodge, Obstruction, Pneumothorax, Equipment failure) • Hipotensi (kekurangan cairan dan efek obat, setting ventilator) antisipasi nilai status volume dan pemberian cairan • Antisipasi evaluasi ulang setting ventilator (TV ekspirasi, PEEP, I:E ratio)
9.	Denah ruangan	
10.	Peralatan yang dibutuhkan	1. Meja dan kursi penguji 2. Tempat sampah medis 3. Tempat sampah non medis 4. Meja peralatan 5. Ventilator + lung test 6. Tabung oksigen 7. Bed side Monitor simulasi 8. Tempat tidur pasien 9. Simple mask 10. Stetoskop 11. Pen light 12. Tiang infus + infus set 13. Manequine intubasi 14. Sarung tangan non steril 15. Plaster 16. Gunting 17. Laryngoscope 18. ETT no 7, 7,5 19. Ambu bag 20. Masker no 3, 4 21. Suction
11.	Penulis	Tim Item Soal OSCE ATI
12.	Referensi	Morgan: clinical of anesthesiology edisi V

**RUBRIK ACTUAL MARK
STATION ICU**

I. Rubrik Penilaian

Aspek yang Dinilai	0	1	2	3	Bobot	Skor
1. Initial assessment / primary survey	Kandidat tidak melakukan initial assessment/ primary survey	-	Kandidat mampu melakukan semua pemeriksaan fisik sesuai masalah klinik pasien dengan menerapkan prinsip sebagai berikut namun tidak lengkap: 1. Mencuci tangan sebelum dan sesudah pemeriksaan. 2. Pemeriksaan tanda vital a. Airway b. Breathing c. Circulation d. Disability	Kandidat mampu melakukan semua pemeriksaan fisik sesuai masalah klinik pasien dengan menerapkan prinsip sebagai berikut: 1. Mencuci tangan sebelum dan sesudah pemeriksaan. 2. Pemeriksaan tanda vital a. Airway b. Breathing c. Circulation d. Disability	2	
2. Kemampuan tes/prosedur klinis atau interpretasi data untuk menunjang diagnosis	Peserta tidak meminta pemeriksaan penunjang	Peserta meminta pemeriksaan penunjang namun tidak lengkap	Peserta meminta pemeriksaan penunjang dengan tepat Namun Tidak bisa memberikan interpretasi dengan benar	Meminta pemeriksaan penunjang dengan tepat dan dapat memberikan interpretasi dengan benar. – Darah rutin : Anemia, leukositosis, trombositopeni – Lactat – AGD : Asidosis metabolik kompensasi alkalosis respiratorik dengan hipoksemia.	2	
3. Kemampuan memprediksi penyulit dan diagnosis definitif pasien kritis	Peserta tidak mendiagnosa pasien	-	Peserta mendiagnosa dengan tidak lengkap	Peserta tepat mendiagnosa Diagnosis Klinis : Syok sepsis dengan gagal napas tipe 1 (hipoksemia)	2	
4. Kemampuan penatalaksanaan pasien kritis dan	Peserta tidak melakukan penatalaksanaan pada	Peserta melakukan intubasi dan setting ventilator dengan tidak tepat	Peserta melakukan intubasi dengan tepat namun	Peserta tepat melakukan penatalaksanaan : Lakukan intubasi teknik RSI	4	

penyulit (farmakologis dan nonfarmakologis)	pasien tersebut		tidak tepat melakukan setting ventilator	Setting ventilator : Initial setting ventilator : Mode Pressure/volume control ventilation, Predicted body weight : 60 KG. TV : 360 ml, RR : 12 X/mnt, PEEP : 5, I:E ratio 1:2, FiO2 100%.		
5. Kemampuan monitoring	Peserta tidak melakukan monitoring	-	Peserta melakukan pemeriksaan penilaian klinis pada pasien namun tidak lengkap	Peserta melakukan pemeriksaan Penilaian klinis/monitoring setelah setting awal ventilator dengan lengkap • Vital sign, AGD • Head elevation • DOPE • Hipotensi • Antisipasi evaluasi ulang setting ventilator	1	
6. Komunikasi dan Perilaku profesional	Peserta ujian tidak meminta izin secara lisan dan sama sekali tidak melakukan point berikut: 1. melakukan setiap tindakan dengan berhati-hati dan teliti sehingga tidak membahayakan pasien dan diri sendiri 2. memperhatikan kenyamanan pasien	meminta izin secara lisan dan 1-2 point berikut: 1. melakukan setiap tindakan dengan berhati-hati dan teliti sehingga tidak membahayakan pasien dan diri sendiri 2. memperhatikan kenyamanan pasien 3. melakukan tindakan sesuai prioritas 4. menunjukkan rasa hormat kepada pasien 5. mengetahui keterbatasan	meminta izin secara lisan dan 3-4 point berikut: 1. melakukan setiap tindakan dengan berhati-hati dan teliti sehingga tidak membahayakan pasien dan diri sendiri 2. memperhatikan kenyamanan pasien 3. melakukan tindakan sesuai prioritas 4. menunjukkan rasa hormat kepada pasien 5. mengetahui keterbatasan dengan merujuk atau melakukan konsultasi	meminta izin secara lisan dan melakukan di bawah ini secara lengkap: 1. melakukan setiap tindakan dengan berhati-hati dan teliti sehingga tidak membahayakan pasien dan diri sendiri 2. memperhatikan kenyamanan pasien 3. melakukan tindakan sesuai prioritas 4. menunjukkan rasa hormat kepada pasien 5. mengetahui keterbatasan dengan merujuk atau	3	

	3. melakukan tindakan sesuai prioritas 4. menunjukkan rasa hormat kepada pasien 5. mengetahui keterbatasan dengan merujuk atau melakukan konsultasi bila diperlukan	dengan merujuk atau melakukan konsultasi bila diperlukan	bila diperlukan	melakukan konsultasi bila diperlukan		
TOTAL SKOR						

II. Global performance

Beri tanda (√) pada kolom yang disediakan sesuai dengan penilaian Anda secara umum terhadap kemampuan peserta ujian!

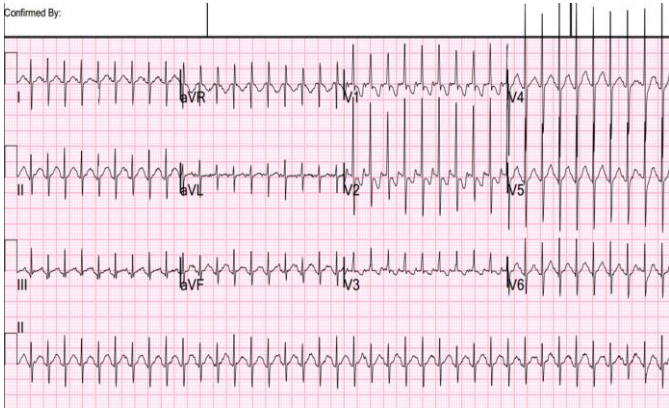
Tidak lulus	Borderline	Lulus	Superior

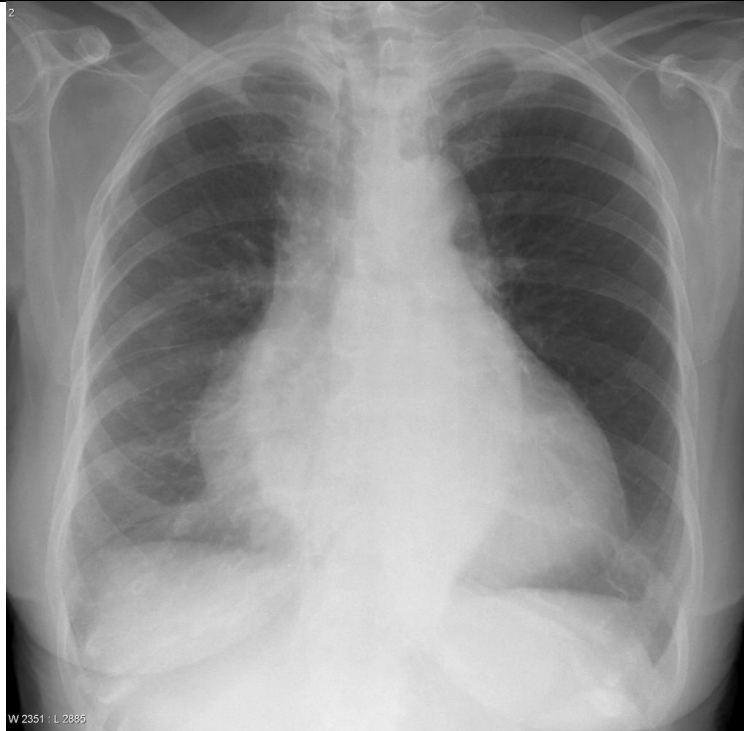
.....
Penguji,

(.....)

SOAL UJIAN OSCE STATION TERAPI INTENSIF

1.	No. Station	
2.	Judul Station	Terapi Intensif – Kardioversi pada <i>Supraventricular Tachycardia</i>
3.	Waktu Yang Dibutuhkan	17 menit
4.	Tujuan Station	Tes / Prosedur Klinis atau Interpretasi Data untuk Menunjang Diagnosis, Memprediksi Penyulit dan Diagnosis Definitif Pasien Kritis, Penatalaksanaan Pasien Kritis dan Penyulit (Farmakologis dan Non-Farmakologis), Komunikasi, Edukasi dan Profesionalisme
5.	Kompetensi	1. <i>Initial Assessment / Primary Survey</i> 2. Kemampuan Tes / Prosedur Klinis atau Interpretasi Data untuk Menunjang Diagnosis 3. Kemampuan Memprediksi Penyulit dan Diagnosis Definitif Pasien Kritis 4. Kemampuan Penatalaksanaan Pasien Kritis dan Penyulit (Farmakologis dan Non-Farmakologis) 5. Kemampuan Monitoring 6. Komunikasi, Edukasi dan Profesionalisme
6.	Kategori	1. Anestesia Obstetrik 2. Anestesia Bedah Saraf 3. Anestesia Regional Dan Manajemen Nyeri 4. Anestesia Bedah Toraks 5. Anestesia Pediatrik 6. Anestesia Kegawatdaruratan 7. Anestesia Urologi 8. Anestesia Untuk Penyakit Khusus (Endokrin, Metabolik, Penyulit Kardiovaskular) 9. Anestesia Bedah Kepala Leher 10. Anestesia Bedah Rawat Jalan / Luar Kamar Bedah 11. Anestesia Pada Prosedur Invasif Minimal 12. Terapi Intensif
7.	Instruksi Untuk Peserta	<u>SKENARIO KLINIK:</u> Pasien laki-laki 45 tahun dirawat di ICU untuk observasi pasca laparotomi, mengeluhkan dada berdebar-debar, pusing, nafas agak berat. Pasien sadar penuh, tekanan darah 85/40 mmHg, laju nadi 160 x/mnt, teraba lemah, laju nafas 22 x/mnt, SpO₂ 96% dengan O₂ nasal kanul 3 lpm. Pasien dengan riwayat diabetes mellitus dalam terapi insulin, gula darah terkontrol. Pasien juga memiliki riwayat gagal jantung, dengan terapi bisoprolol 1x2.5mg, furosemid 1x20 mg. <u>INSTRUKSI UNTUK PESERTA:</u> 1. Usulkan dan interpretasi hasil pemeriksaan penunjang untuk membantu menegaskan diagnosis pada pasien ini 2. Tentukan diagnosis masalah pasien saat ini dan jelaskan dasar diagnosis tersebut 3. Lakukan penatalaksanaan kardioversi menggunakan kardioverter bifasik pada pasien ini
8.	Instruksi	<u>INSTRUKSI UMUM</u>

	Untuk Penguji	1. Pastikan identitas peserta ujian pada kartu ujian 2. Tulislah nama dan nomor peserta ujian pada lembar penilaian! 3. Amatilah dan berilah skor (0/1/2/3) atas tugas yang dikerjakan peserta ujian serta skor <i>Global Rating</i> sesuai rubrik penilaian 4. Hindarilah interupsi dan/atau tindakan selain daripada yang diminta dalam instruksi penguji! 5. Berikan informasi/hasil yang dibutuhkan secara lisan/tulisan hanya apabila peserta ujian telah melakukan dan/atau mengusulkan jenis pemeriksaan yang dimaksud (perhatikan instruksi khusus)! 6. Taatilah peraturan serta etika penguji selama menjalankan tugas sebagai penguji OSCE - KATI! <u>INSTRUKSI KHUSUS</u> Penguji menjawab hasil pemeriksaan penunjang (hanya jika diusulkan dan diminta oleh peserta!) dan menilai interpretasi yang dilakukan oleh peserta uji! 1. Pemeriksaan Penunjang: • EKG  Interpretasi : Supraventricular Tachycardia, gelombang QRS sempit, tidak didahului oleh gelombang P • Elektrolit darah : Na 137 Ca ion 1,2 K 2,7 Mg 1,2 Cl 101 Interpretasi : Hipokalemia • Foto thoraks :
--	----------------------	---



Interpretasi: kardiomegali

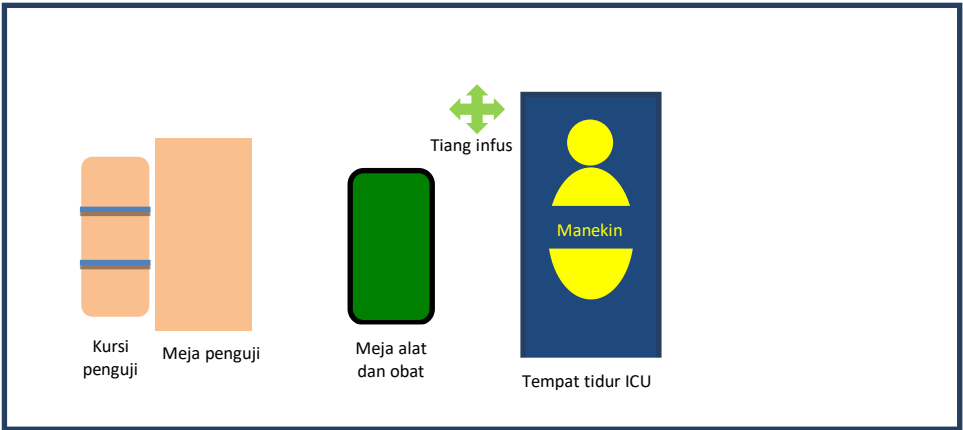
- **Pemeriksaan penunjang lain : dalam batas normal**

2. Peserta mendiagnosis masalah pasien sebagai SVT tidak stabil :

1. EKG : SVT, HR 160 x/mnt
2. Hipotensi TD 85/40 mmHg
3. Keluhan lemas, pusing dan nafas agak berat
4. Faktor resiko berupa hipokalemia, riwayat gangguan irama jantung sebelumnya

3. Penguji menilai kemampuan peserta ujian dalam tatalaksana non-farmakologis berupa Kardioversi

1. Memperoleh *informed consent* dari pasien atau keluarga pasien
2. Mempersiapkan peralatan dan perlengkapan kardioversi
3. Memberikan sedasi dan analgesia sesuai kebutuhan
4. Membuka baju pasien dan memasang elektrode EKG yang terhubung dengan alat kardioversi
5. **Menyalakan alat kardioversi dan memilih mode synchronous (SYNC)**
6. Menentukan energi sebesar 50 – 100 Joule bifasik
7. Memberikan jeli konduktor pada paddle
8. Meletakkan paddle pada daerah midclavícula kanan dan apex jantung
9. Menekan tombol *charge*
10. Mengingatkan untuk jangan ada yang menyentuh pasien
11. **Melakukan *discharge* dengan menekan tombol pada kedua paddle dan menahan tombol sampai kardioversi berhasil dilakukan.**
12. Evaluasi irama jantung

9.	Denah Ruang	 The diagram illustrates the layout of an ICU room. It includes a testing chair (Kursi penguji) and a testing table (Meja penguji) on the left. In the center, there is a table for drugs and instruments (Meja alat dan obat). To the right of this table is an IV stand (Tiang infus). On the far right is a patient bed (Tempat tidur ICU) with a manikin (Manekin) lying on it.	
10	Instruksi Pasien Standar	-	
11	Kebutuhan Laboran	Jumlah Laboran : 1 orang Tugas Laboran : Berperan sebagai Perawat Ruang Perawatan Intensif	
12	Peralatan Yang Dibutuhkan	Setting Ruang ICU – Meja dan kursi penguji – Tempat sampah – Meja peralatan dan obat – Defibrilator bifasik – Mesin suction + selang suction – Sumber oksigen – Tempat tidur pasien – Stetoskop – Tiang infus + infus set – Sarung tangan non steril – Jam dinding – Plester – Gunting – Sulfast Atropin 0,25mg – Lidocaine 2% – Midazolam 5mg – Fentanyl 100mcg/Morphine 10mg/ Pethidin100mg – Propofol 200mg – IV cath no 18, 20 – Sungkup muka – Foto Thoraks (Cardiomegaly) – EKG (SVT, HR 160-170x/mnt) – Jeli konduktor – Nasal kanula – Monitor pasien – Elektroda EKG	– 3 set – 1 Buah – 1 buah – 1 set – 1 set – 1 buah – 1 buah – 1 buah – 1 buah – 1 buah – 2pasang – 1 buah – 1 buah – 1 buah – 2 ampul – 2 ampul – 1 ampul – 2 ampul – 1 ampul – Masing-masing 1 buah – 1 buah – 1 buah – 1 buah – 1 buah – 1 set – 3 buah
13	Kebutuhan	Manekin untuk defibrilasi	

	Manekin	
14	Penulis	dr. Adhrie
15	Referensi	ACLS-AHA

RUBRIK ACTUAL MARK

SOAL UJIAN OSCE STATION TERAPI INTENSIF

Aspek yang Dinilai	0	1	2	3	Bobot	Skor
1. Kemampuan Tes/Prosedur Klinis atau Interpretasi Data untuk Menunjang Diagnosis Pemeriksaan penunjang dan interpretasinya : 1. EKG : SVT, HR 160x/mnt 2. Elektrolit : Hipokalemia 3. FOTO TORAKS : Kardiomegali 4. Pemeriksaan penunjang lain dalam batas normal	Peserta ujian tidak mengusulkan pemeriksaan penunjang EKG atau interpretasi EKG salah, meskipun mengusulkan pemeriksaan penunjang lain	Peserta ujian mengusulkan pemeriksaan penunjang EKG dan interpretasi benar	Peserta ujian mengusulkan pemeriksaan penunjang EKG dan interpretasi benar ditambah 1 pemeriksaan penunjang lain	Peserta ujian mengusulkan pemeriksaan penunjang EKG dan interpretasi benar ditambah 2 pemeriksaan penunjang lain	2	
2. Kemampuan Memprediksi Penyulit dan Diagnosis Definitif Pasien Kritis Diagnosis SVT tidak stabil, atas dasar : 1. EKG : SVT, HR 160 x/mnt 2. Hipotensi 3. Keluhan lemas, pusing dan nafas agak berat 4. Faktor resiko berupa hipokalemia, riwayat gangguan irama jantung sebelumnya	Peserta ujian tidak dapat menentukan diagnosis klinis	Peserta ujian dapat menentukan diagnosis klinis dengan benar tetapi tidak menyampaikan penjelasan dasar diagnosisnya	Peserta ujian dapat menentukan diagnosis klinis dengan benar tetapi hanya menyampaikan 1-3 dasar diagnosisnya	Peserta ujian dapat menentukan diagnosis klinis dengan benar dan menyampaikan penjelasan 4 dasar diagnosisnya	3	
3. Kemampuan Penatalaksanaan Pasien Kritis dan Penyulit (Non-Farmakologis)	Peserta dapat melakukan 1-3 langkah-langkah tata laksana pada	Peserta dapat melakukan 4-7 langkah-langkah tata laksana pada	Peserta dapat melakukan 8-10 langkah-langkah tata laksana pada	Peserta dapat melakukan langkah-langkah tata laksana pada	4	

Langkah-langkah tatalaksana kardioversi : 1. Memperoleh <i>informed consent</i> dari pasien atau keluarga pasien 2. Mempersiapkan peralatan dan perlengkapan kardioversi 3. Memberikan sedasi dan analgesia sesuai kebutuhan 4. Membuka baju pasien dan memasang elektrode EKG yang terhubung dengan alat kardioversi 5. Menyalakan alat kardioversi dan memilih mode synchronous (SYNC) 6. Menentukan energi sebesar 50 – 100 Joule 7. Memberikan jeli konduktor pada paddle 8. Meletakkan paddle pada pasien 9. Menekan charge 10. Mengingatkan untuk jangan ada yang menyentuh pasien 11. Melakukan discharge dengan menekan kedua paddle dan menahan tombol sampai kardioversi berhasil dilakukan. 12. Evaluasi irama jantung	pasien	pasien (harus meliputi langkah nomor 5 dan 11) atau melakukan langkah lainnya tapi tidak meliputi langkah nomor 5 dan 11.	pasien (harus meliputi langkah nomor 5 dan 11)	pasien dengan lengkap		
4. Komunikasi, Edukasi dan Profesionalisme	Peserta ujian tidak meminta meminta izin secara lisan dan sama sekali	Peserta ujian meminta izin secara lisan dan melakukan 1-2	Peserta ujian meminta izin secara lisan dan melakukan 3-4	Peserta meminta izin secara lisan dan melakukan hal di bawah ini secara	1	

	tidak melakukan point yang diminta	point yang diminta	point yang diminta	lengkap: 1. Melakukan setiap tindakan dengan berhati- hati dan teliti sehingga tidak membahayakan pasien dan diri sendiri 2. Memperhatikan kenyamanan pasien 3. Melakukan tindakan sesuai prioritas 4. Menunjukkan rasa hormat kepada pasien 5. Mengetahui keterbatasan dengan merujuk atau melakukan konsultasi bila diperlukan		
TOTAL SKOR						

II. Global performance

Beri tanda (✓) pada kolom yang disediakan sesuai dengan penilaian Anda secara umum terhadap kemampuan peserta ujian!

Tidak lulus	Borderline	Lulus	Superior

.....
Penguji,

(.....)

SOAL UJIAN OSCE STATION TERAPI INTENSIF

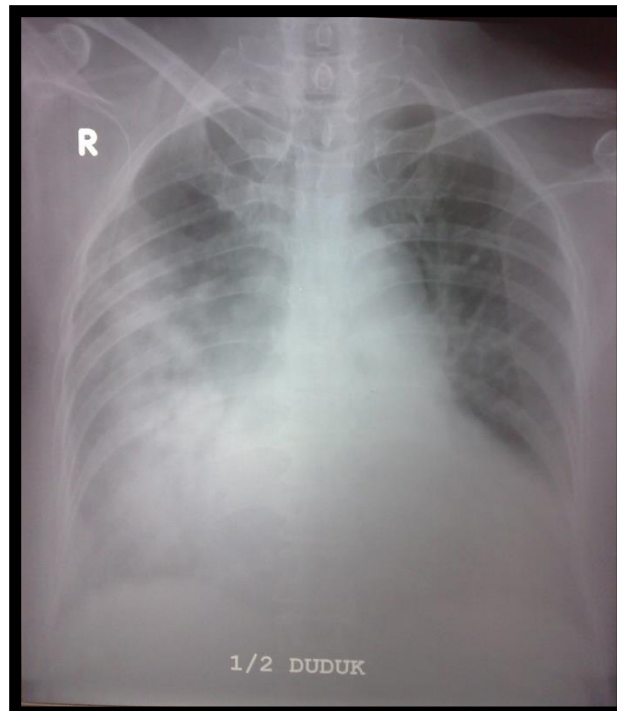
1	Nomor Station	2
2	Judul Station	Sepsis – <i>Setting</i> awal (<i>initial</i>) ventilator
3	Waktu yang dibutuhkan	17 menit
4	Tujuan station	Menilai kemampuan melakukan <i>initial assessment</i> , kemampuan melakukan tes / prosedur klinis atau interpretasi data untuk menunjang diagnosis, kemampuan memprediksi penyulit dan diagnosis definitif pasien kritis, kemampuan menatalaksana pasien kritis dan penyulit (farmakologis dan non-farmakologis), dan komunikasi, edukasi serta profesionalisme.
5	Kompetensi	1. <i>Initial Assessment / Primary Survey</i> 2. Kemampuan Tes / Prosedur Klinis atau Interpretasi Data untuk Menunjang Diagnosis 3. Kemampuan Memprediksi Penyulit dan Diagnosis Definitif Pasien Kritis 4. Kemampuan Penatalaksanaan Pasien Kritis dan Penyulit (Farmakologis dan Non-Farmakologis) 5. Kemampuan Monitoring 6. Komunikasi, Edukasi dan Profesionalisme
6	Kategori	1. Anestesia Obstetrik 2. Anestesia Bedah Saraf 3. Anestesia Regional Dan Manajemen Nyeri 4. Anestesia Bedah Toraks 5. Anestesia Pediatrik 6. Anestesia Kegawatdaruratan 7. Anestesia Urologi 8. Anestesia Untuk Penyakit Khusus (Endokrin) 9. Anestesia Bedah Kepala Leher 10. Anestesia Bedah Rawat Jalan / Luar Kamar Bedah 11. Anestesia Pada Prosedur Invasif Minimal 12. Terapi Intensif
7	Instruksi untuk peserta	<u>Skenario Klinik:</u> Seorang laki-laki, usia 64 tahun, panjang badan 163 cm, masuk ke ICU karena sesak napas dan penurunan kesadaran. Pasien ini telah dirawat di bangsal dengan diagnosis <i>community acquired pneumonia</i> (CAP) satu hari sebelum masuk ke ICU dengan terapi ceftriakson 1 gram tiap 12 jam dan azithromycin 500 mg tiap 24 jam. Riwayat penyakit dahulu: DM (diabetes melitus tipe II). <u>Instruksi Untuk Peserta:</u> 1. Lakukan <i>initial assessment</i>! 2. Usulkan dan lakukan interpretasi pemeriksaan penunjang yang diperlukan untuk menegakkan diagnosis! 3. Sebutkan diagnosis dan penyulit pasien! 4a. Sebutkan tatalaksana pasien (resusitasi awal)!

		b.Lakukan setting awal (<i>initial</i>) ventilator!
8	Instruksi untuk penguji	INSTRUKSI UMUM 1. Pastikan identitas peserta ujian pada kartu ujian. 2. Tulislah nama dan nomor peserta ujian pada lembar penilaian. 3. Amatilah dan berilah skor (0/1/2/3) atas tugas yang dikerjakan peserta ujian serta skor <i>Global Rating</i> sesuai rubrik penilaian. 4. Hindarilah interupsi dan/atau tindakan selain daripada yang diminta dalam instruksi penguji. 5. Berikan informasi/hasil yang dibutuhkan secara lisan/tulisan hanya apabila peserta ujian telah melakukan dan/atau mengusulkan jenis pemeriksaan yang dimaksud (perhatikan instruksi khusus). 6. Taatilah peraturan serta etika penguji selama menjalankan tugas sebagai penguji OSCE – ATI. INSTRUKSI KHUSUS 1. Penguji menilai <i>initial assessment</i> yang dilakukan peserta ujian. Bila peserta ujian melakukan pemeriksaan di bawah ini, penguji menyampaikan hasil pada peserta. 1. Memeriksa jalan napas (A): • Bebas, tidak ada snoring, tidak ada gurgling 2. Memeriksa pernapasan (B): • Laju Napas = 30 x/menit, nafas spontan • SpO₂ = 89% • Bunyi napas di ronkhi basah kasar di paru kanan • Terpasang oksigen NRM 10 l/menit 3. Memeriksa sirkulasi (C): • TD = 81/40 (54)mmHg • Laju Nadi = 140 x/menit • Akral teraba hangat 4. Memeriksa kesadaran (D): somnolen (GCS 13) 5. Memeriksa <i>exposure</i> (E): suhu → 39 °C 2. Penguji menilai Kemampuan Tes / Prosedur Klinis atau Interpretasi Data untuk Menunjang Diagnosis yang di sampaikan oleh peserta ujian. Bila peserta ujian meminta pemeriksaan di bawah ini, penguji menyampaikan hasil pada peserta. 1) Pemeriksaan Laboratorium Darah Rutin • Hb = 9 g/dL • Ht = 30 % • Leukosit = 24.000 /uL • Trombosit = 155.000 /uL • Diff. count (Basofil/ Eosinofil/ Neutrofil Batang/ Neutrofil Segmen/ Limfosit/ Monosit) = 0/1/80/15/5/0 Analisis Gas Darah (AGD) • pH = 7,25 • PaCO₂ = 28 • PaO₂ = 58 • HCO₃ = 12 • BE = - 8 • P/F Ratio = 64

Laktat = 4,1
 Albumin = 3,0 g/dL
 Natrium = 147 mmol/L
 Klorida = 98 mmol/mL
 Kalium = 5,1 mmol/L
Ureum = 91 mg/dL
Kreatinin = 2,1 mg/dL
GDS = 221 mg/dL
 Bilirubin = 1 mg/dL

Kesan = Anemia, Asidosis metabolik hiperlaktatemia, Hipoksemia, AKIN II, Hiperglikemia

2) Pemeriksaan Foto Toraks



Kesan = infiltrat paru kanan sesuai pneumonia

3. **Penguji menilai Kemampuan Memprediksi Penyulit dan Diagnosis Definitif Pasien Kritis yang disampaikan oleh peserta ujian.**

Diagnosis: Syok sepsis + Gagal Napas Tipe I + CAP + DM tipe II + Anemia + AKIN II

Penyulit: Syok refrakter, Henti jantung

4. **Penguji menilai Kemampuan Penatalaksanaan Pasien Kritis dan Penyulit (Farmakologis dan Non-Farmakologis) disampaikan oleh peserta ujian.**

a. **Resusitasi awal:**

- 1) Intubasi dan ventilasi mekanik
- 2) Resusitasi cairan kristaloid 30 mL/kg mulai dari 1 jam pertama diagnosis
- 3) Vasopresor selama atau setelah resusitasi cairan sampai target MAP ≥ 65 mmHg
- 4) Mengambil darah untuk kultur
- 5) Memberikan antibiotik spektrum luas dalam waktu 1 jam pertama diagnosis
- 6) Pasang kateter urin dan ukur produksi urin tiap jam

		b. Penguji menilai <i>setting</i> ventilasi mekanik inisial peserta ujian 1) Menentukan mode ventilator: Pressure Control atau Volume Control 2) Menentukan Predicted Body Weight (PBW) $PBW = 50 + 0,91 \times (160 - 152,4) = 59,6 \approx 60 \text{ kg}$ 3) Menentukan Volume Tidal (VT) = 6-8 ml/kg $VT = 360 - 480 \text{ ml}$ (Jika, Pressure control maka P inspirasi disetting sampai target VT tersebut) 4) Menentukan Minute Ventilation (MV) $MV = 100 \text{ ml/kg} = 5 \text{ L}$ 5) Menentukan laju napas (RR) $RR = MV/VT = 11 - 14 \text{ x/menit}$ 6) Menentukan PEEP $PEEP \text{ awal} = 5 \text{ cmH}_2\text{O}$ 7) Menentukan FiO_2 $FiO_2 \text{ awal} 100\%$, kemudian diturunkan sampai $SpO_2 \geq 95\%$ 8) Menentukan I:E ratio $I:E \text{ ratio awal} = 1:2$ 9) Mengamati Pplateau di monitor P_{plateau} tidak lebih dari 30 cmH ₂ O 10) Memeriksa AGD pasca <i>setting</i> awal 5. Penguji menilai Komunikasi, edukasi dan profesionalisme yang dilakukan oleh peserta ujian	
9	Tata letak station	Model ruang ICU	
10	Kebutuhan Laboran	1 orang sebagai perawat ICU	
11	Peralatan yang dibutuhkan	Setting ruang ICU : Peralatan: • Monitor pasien • Ventilator • Stetoskop dewasa • <i>Tensimeter</i> • <i>Simple mask</i> • SpO₂ portable • <i>Trolley emergency</i> • Senter • Termometer • <i>Print out</i> foto toraks sesuai kasus • <i>Syringe pump</i> Obat: • Obat anestesi lokal (lidokain 2%) • Sput berlabel	• 1 buah • 1 buah • 1 buah • 1 buah • 1 buah • 1 buah • 1 buah • 1 buah • 1 buah • 1 buah • 1 buah • 1 buah • 1 buah • 1 buah
12	Kebutuhan manekin	Manekin dewasa dengan <i>simple mask</i>	
13	Penulis	TIM SOAL OSCE ATI	

13	Referensi	1) Singer M, Deutschman CS, Seymour CW, Shankar-Hari M, Annane D, Bauer M, et al. The third international consensus definitions for sepsis and septic shock (sepsis-3). JAMA J Am Med Assoc. 2016;315(8):801–10. 2) Rhodes A, Evans LE, Alhazzani W, Levy MM, Antonelli M, Ferrer R, et al. Surviving sepsis campaign: international guidelines for management of sepsis and septic shock: 2016. Intensive Care Med. 2017;45(3):1–67. 3) Levy MM, Evans LE, Rhodes A. The surviving sepsis campaign bundle: 2018 update. Intensive Care Med. 2018;1–4. 4) Mendonca C, Balasubramanian S. The Objective Structured Clinical Examination in Anaesthesia. 2013. UK: tfm publishing Ltd.
----	-----------	---

RUBRIK ACTUAL MARK
SOAL UJIAN OSCE STATION TERAPI INTENSIF

Aspek yang Dinilai	0	1	2	3	Bobot	Skor
1. Initial Assessment / Primary Survey 1. Periksa jalan napas (A) 2. Periksa pernapasan (B) 3. Periksa sirkulasi (C) 4. Periksa kesadaran (D) 5. Periksa <i>exposure</i> (E)	Tidak memeriksa A, B, C D dan E.	-	Memeriksa A, B, C, D, E namun tidak lengkap.	Memeriksa A, B, C, D, E secara lengkap.	2	
2. Kemampuan Tes / Prosedur Klinis atau Interpretasi Data untuk Menunjang Diagnosis 1. Pemeriksaan Laboratorium Kesan = Anemia, Asidosis metabolik hiperlaktatemia, Hipoksemia, AKIN II, Hiperglikemia 2. Pemeriksaan Foto Toraks Kesan = Infiltrat paru kanan sesuai pneumonia	TIDAK melakukan pemeriksaan penunjang dan interpretasinya.	Melakukan SEBAGIAN KECIL pemeriksaan penunjang dan interpretasi TIDAK benar .	Melakukan SEBAGIAN BESAR pemeriksaan penunjang dan interpretasi dengan BENAR .	Melakukan SEMUA pemeriksaan penunjang dan interpretasi dengan BENAR .	1	
3. Kemampuan Memprediksi Penyakit dan Diagnosis Definitif Pasien Kritis Diagnosis: 1. Syok sepsis 2. Gagal Napas Tipe I 3. CAP 4. DM tipe II 5. Anemia 6. AKIN II Penyakit: 7. Syok refrakter 8. Henti jantung	TIDAK mampu memprediksi penyakit dan menegaskan diagnosis definitif.	Mampu memprediksi 1-2 penyakit dan diagnosis definitif. TIDAK meliputi SYOK SEPSIS .	Mampu memprediksi 3-4 penyakit dan diagnosis definitif. Salah satunya meliputi SYOK SEPSIS .	Mampu memprediksi 5-8 penyakit dan diagnosis definitif. Salah satunya meliputi SYOK SEPSIS .	2	
4a. Kemampuan Penatalaksanaan Pasien Kritis dan Penyakit (Farmakologis dan Non-Farmakologis) Resusitasi awal: 1. Intubasi dan ventilasi mekanik	Mampu melakukan <2 penatalaksanaan pasien kritis.	Mampu melakukan 2-3 penatalaksanaan pasien kritis.	Mampu melakukan 4-5 penatalaksanaan pasien kritis.	Mampu melakukan penatalaksanaan pasien kritis dengan LENGKAP	2	

2. Resusitasi cairan kristaloid 30 mL/kg mulai dari 1 jam pertama diagnosis 3. Vasopresor selama atau setelah resusitasi cairan sampai target MAP ≥ 65 mmHg 4. Mengambil darah untuk kultur 5. Memberikan antibiotik spektrum luas dalam waktu 1 jam pertama diagnosis 6. Pasang kateter urin dan ukur produksi urin tiap jam						
4b. Kemampuan Penatalaksanaan Pasien Kritis dan Penyulit (Farmakologis dan Non-Farmakologis) Setting inisial ventilator: 1. Menentukan mode ventilator: Pressure Control atau Volume Control 2. Menentukan Predicted Body Weight (PBW) 3. Menentukan Volume Tidal (VT) = 6-8 ml/kg 4. Menentukan Minute Ventilation (MV) 5. Menentukan laju napas (RR) 6. Menentukan PEEP 7. Menentukan FiO ₂ 8. Menentukan I:E ratio 9. Mengamati Pplateau di monitor 10. Memeriksa AGD pasca <i>setting</i> awal	Mampu melakukan <3 penatalaksanaan pasien kritis dengan lengkap	Mampu melakukan 3-6 penatalaksanaan pasien kritis dengan lengkap	Mampu melakukan 7-9 penatalaksanaan pasien kritis dengan lengkap	Mampu melakukan penatalaksanaan pasien kritis dengan LENGKAP dan RUNUT .	2	
6. Komunikasi, Edukasi dan Profesionalisme 1. Melakukan setiap tindakan dengan berhati-hati dan teliti sehingga tidak membahayakan pasien dan diri sendiri 2. Memperhatikan kenyamanan pasien 3. Melakukan tindakan sesuai prioritas 4. Menunjukkan rasa hormat kepada pasien 5. Mengetahui keterbatasan dengan merujuk atau melakukan konsultasi bila diperlukan	Peserta ujian tidak meminta izin secara lisan dan sama sekali tidak melakukan poin yang diminta	Peserta ujian meminta izin secara lisan dan melakukan 1-2 poin yang diminta	Peserta ujian meminta izin secara lisan dan melakukan 3-4 poin yang diminta	Peserta meminta izin secara lisan dan melakukan poin-poin secara lengkap	1	
TOTAL SKOR						

SOAL UJIAN OSCE STATION TERAPI INTENSIF

1	Nomor Station	7
2	Judul Station	Station dinamis: Terapi Intensif – ARDS (dinamis)
3	Waktu yang dibutuhkan	17 menit
4	Tujuan station	Menilai kemampuan melakukan <i>initial assessment</i> , kemampuan melakukan tes / prosedur klinis atau interpretasi data untuk menunjang diagnosis, kemampuan memprediksi penyulit dan diagnosis definitif pasien kritis, kemampuan menatalaksana pasien kritis dan penyulit (farmakologis dan non-farmakologis), dan komunikasi, edukasi serta profesionalisme.
5	Kompetensi	1. <i>Initial Assessment / Primary Survey</i> 2. Kemampuan Tes / Prosedur Klinis atau Interpretasi Data untuk Menunjang Diagnosis 3. Kemampuan Memprediksi Penyulit dan Diagnosis Definitif Pasien Kritis 4. Kemampuan Penatalaksanaan Pasien Kritis dan Penyulit (Farmakologis dan Non-Farmakologis) 5. Kemampuan Monitoring 6. Komunikasi, Edukasi dan Profesionalisme
6	Kategori	1. Anestesia Obstetrik 2. Anestesia Bedah Saraf 3. Anestesia Regional Dan Manajemen Nyeri 4. Anestesia Bedah Toraks 5. Anestesia Pediatrik 6. Anestesia Kegawatdaruratan 7. Anestesia Urologi 8. Anestesia Untuk Penyakit Penyakit Khusus (Endokrin) 9. Anestesia Bedah Kepala Leher 10. Anestesia Bedah Rawat Jalan / Luar Kamar Bedah 11. Anestesia Pada Prosedur Invasif Minimal 12. Terapi Intensif
7	Instruksi untuk peserta	Skenario Klinik: Seorang laki-laki, usia 40 tahun, panjang badan 160 cm, didorong ke ruang resusitasi IGD karena sesak napas dan penurunan kesadaran. Pasien ini dirujuk dari rumah sakit lain selama 2 hari karena trauma

		tumpul toraks. Tidak ada riwayat pemberian cairan dalam jumlah banyak dan tidak menderita penyakit jantung. Nb: pada station ini akan ada monitor dinamis Instruksi Untuk Peserta: 1. Lakukan <i>initial assessment/ primary survey</i>! 2. Usulkan pemeriksaan penunjang yang diperlukan dan lakukan interpretasi! 3. Sebutkan diagnosis dan penyulit yang dapat terjadi! 4 a. Lakukan setting awal (<i>initial</i>) ventilator! - b.Lakukan pemantauan pasca setting awal (<i>initial</i>) ventilator!
8	Instruksi untuk penguji	Instruksi Penguji: INSTRUKSI UMUM 1. Pastikan identitas peserta ujian pada kartu ujian. 2. Tulislah nama dan nomor peserta ujian pada lembar penilaian. 3. Amatilah dan berilah skor (0/1/2/3) atas tugas yang dikerjakan peserta ujian serta skor <i>Global Rating</i> sesuai rubrik penilaian. 4. Hindarilah interupsi dan/atau tindakan selain daripada yang diminta dalam instruksi penguji. 5. Berikan informasi/hasil yang dibutuhkan secara lisan/tulisan hanya apabila peserta ujian telah melakukan dan/atau mengusulkan jenis pemeriksaan yang dimaksud (perhatikan instruksi khusus). 6. Taatilah peraturan serta etika penguji selama menjalankan tugas sebagai penguji OSCE – ATI. INSTRUKSI KHUSUS Penguji mengatur monitor dinamis: • Laju Napas = 35 x/menit • SpO2 = 80% • Tekanan Darah = 141/85 (105)mmHg • Laju Nadi = 140 x/menit, reguler

		1. Penguji mengamati dan menilai <i>initial assessment / primary survey</i> yang dilakukan peserta ujian Bila peserta ujian melakukan pemeriksaan di bawah ini, penguji menyampaikan hasil pada peserta. Airway (A): - Bebas, pasien terintubasi Breathing (B): - Laju Napas = 35 x/menit, <i>bagging</i> manual - SpO2 = 80% - Suara napas vesikuler menurun di paru kanan dan kiri - ETT terhubung dengan <i>Bag-Valve-Mask</i> atau <i>Jackson reese</i> 10 l/menit Circulation (C): - Tekanan Darah = 141/85 (105) mmHg - Laju Nadi = 140 x/menit, <i>reguler</i> - Akral teraba dingin Dissability (D): kesadaran <i>respond to pain</i> (GCS E2M4Vterintubasi) Exposure (E): suhu → 36,2 °C 2. Penguji menilai Kemampuan Tes / Prosedur Klinis atau Interpretasi Data untuk Menunjang Diagnosis yang di sampaikan oleh peserta ujian Bila peserta ujian melakukan pemeriksaan di bawah ini, penguji menyampaikan hasil pada peserta. 1) Pemeriksaan Laboratorium Darah Rutin - Hb = 13,3 g/dL - Ht = 40 % Leukosit = 13.300 /uL - Trombosit = 155.000 /uL - Diff. count (Basofil/ Eosinofil/ Neutrofil Batang/ Neutrofil Segmen/ Limfosit/ Monosit) = 0/1/60/15/5/0 Analisis Gas Darah (AGD)
--	--	---

- pH = 7,01
- PaCO₂ = 58
- PaO₂ = 50
- HCO₃ = 14
- BE = - 8
- P/F Ratio = 50

Laktat = 4,1

Albumin = 3,5 g/dL

Natrium = 147 mmol/L

Klorida = 98 mmol/mL

Kalium = 6,8 mmol/L

Ureum = 48 mg/dL

Kreatinin = 1,0 mg/dL

GDS = 221 mg/dL

Bilirubin = 1 mg/dL

Interpretasi = Asidosis respiratorik dan metabolik (proses ganda), Hipoksemia, Hiperlaktatemia, Hiperkalemia, Hiperglikemia

2) Pemeriksaan Foto Toraks



Interpretasi = ARDS

		3. Penguji menilai Kemampuan Memprediksi Penyulit dan Diagnosis Definitif Pasien Kritis yang disampaikan oleh peserta ujian Diagnosis: Trauma tumpul toraks (contusio pulmonum) + Gagal Napas Tipe I dan II + ARDS + Hiperkalemia + Hiperglikemia Penyulit: Hipoksemia persisten, Henti jantung 4. Penguji menilai <i>setting</i> ventilasi mekanik inisial peserta ujian: 1) Menentukan Predicted Body Weight (PBW) $PBW = 50 + 0,91 \times (160 - 152,4) = 59,6 \approx 60 \text{ kg}$ 2) Menentukan mode ventilator: Pressure Control atau Volume Control 3) Menentukan Volume Tidal (VT) = 8 ml/kg $VT = 480 \text{ ml}$ (Jika, Pressure control maka P inspirasi disetting sampai target VT tersebut) 4) Menentukan PEEP $PEEP \text{ awal} = 5 \text{ cmH}_2\text{O}$ 5) Menentukan FiO₂ $FiO_2 \text{ awal} = 100\%$ 6) Menentukan Minute Ventilation (MV) $MV = 100 \text{ ml/kg} = 5 \text{ L}$ 7) Menentukan laju napas (RR) RR disesuaikan (maksimum 35 x/menit) untuk mencapai MV 8) Menentukan I:E ratio $I : E = 1 : 1,0 - 1,3$ 9) Mengamati Pplateau di monitor Pplateau tidak lebih dari 30 cmH₂O 5. Penguji menilai pemantauan pasca <i>setting</i> ventilasi mekanik inisial peserta ujian
--	--	--

		Penguji mengubah <i>setting</i> monitor menjadi: • Tekanan darah = 120/60 mmHg • Laju nadi = 136 x/menit • Laju napas = 32 x/menit • SpO2 = 82% • Penguji menyampaikan Pplateau = 25 cmH2O (jika peserta ujian menanyakan) • Jika peserta menaikkan setting PEEP sampai 12 cmH2O, penguji mengubah SpO2 menjadi 95% Penguji menilai peserta mengubah <i>setting</i> monitor menjadi: 1) Menaikkan PEEP sampai target SpO2 88-95% 2) Menurunkan FiO2 sampai target SpO2 88-95% 6. Penguji menilai Komunikasi, edukasi dan profesionalisme yang dilakukan oleh peserta ujian	
9	Tata letak station	Model ICU	
10	Kebutuhan Laboran	1 orang sebagai perawat ICU	
11	Peralatan yang dibutuhkan	Setting ruang ICU : Peralatan: • Monitor dinamis : ipad • Ventilator • Stetoskop dewasa • Senter • Termometer • <i>Print out</i> foto toraks sesuai kasus	@ 2 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah
12	Kebutuhan manekin	Manekin dewasa yang sudah terintubasi dan dihubungkan dengan <i>Bag-Valve Mask</i> atau <i>jackson reese</i>	

13	Penulis	TIM OSCE KATI
	Referensi	1) ARDSnet NIH NHLBI ARDS Clinical Network Mechanical Ventilation Protocol Summary. Diakses dari: ardsnet.org/files/ventilator_protocol_2008-07.pdf. 2) Marino PM. Acute respiratory Distress Syndrome. Dalam: Marino's The Little ICU Book. Edisi ke-2. Philadelphia: Wolters Kluwer, 2017. 3) Kapadia FN, Bhutada U. Mechanical Ventilation in Acute Respiratory Distress Syndrome. 4) The ARDS Definition Task Force. Acute Respiratory Distress Syndrome. JAMA. 2012; E1-8.

RUBRIK ACTUAL MARK
STATION TERAPI INTENSIF

Aspek yang Dinilai	0	1	2	3	Bobot	Skor
1. Initial Assessment / Primary Survey 1. Memeriksa jalan napas (A) 2. Memeriksa pernapasan (B) 3. Memeriksa sirkulasi (C) 4. Memeriksa kesadaran (D)	Tidak memeriksa A, B, C dan D.	-	Memeriksa A, B, C, D namun tidak lengkap.	Memeriksa A, B, C, D secara lengkap.	2	
2. Kemampuan Tes / Prosedur Klinis atau Interpretasi Data untuk Menunjang Diagnosis 1. Pemeriksaan Laboratorium Kesan = Asidosis respiratorik dan metabolik, Hipoksemia, Hiperlaktatemia, Hiperkalemia, Hiperglikemia 2. Pemeriksaan Foto Toraks Kesan = ARDS	TIDAK melakukan pemeriksaan penunjang dan interpretasinya.	Melakukan SEBAGIAN KECIL pemeriksaan penunjang dan interpretasi TIDAK benar.	Melakukan SEBAGIAN BESAR pemeriksaan penunjang dan interpretasi dengan BENAR.	Melakukan SEMUA pemeriksaan penunjang dan interpretasi dengan BENAR.	1	
3. Kemampuan Memprediksi Penyulit dan Diagnosis Definitif Pasien Kritis Diagnosis:	TIDAK mampu menegaskan diagnosis definitif dan penyulit.	Mampu memprediksi 1-2 diagnosis definitif dan penyulit.	Mampu memprediksi 3-4 diagnosis definitif dan penyulit. Salah	Mampu memprediksi 5-7 diagnosis definitif dan penyulit. Salah	2	

1. Trauma tumpul toraks (contusio pulmonum) 2. Gagal Napas Tipe I dan Tipe II 3. ARDS 4. Hiperkalemia 5. Hiperglikemia Penyulit yang dapat terjadi: 6. Hipoksemia persisten 7. Henti jantung			satunya meliputi ARDS.	satunya meliputi ARDS.		
4a. Kemampuan Penatalaksanaan Pasien Kritis dan Penyulit (Farmakologis dan Non-Farmakologis) <i>Setting</i> inisial ventilator: 1) Menentukan Predicted Body Weight (PBW) $PBW = 50 + 0,91 \times (160 - 152,4) = 59,6 \approx 60 \text{ kg}$ 2) Menentukan mode ventilator: Pressure Control atau Volume Control 3) Menentukan Volume Tidal (V_T) = 8 ml/kg $V_T = 480 \text{ ml}$	Mampu melakukan <4 penatalaksanaan pasien kritis.	Mampu melakukan 5-6 penatalaksanaan pasien kritis.	Mampu melakukan penatalaksanaan pasien kritis dengan LENGKAP dan TIDAK RUNUT ATAU Mampu melakukan 7-8 penatalaksanaan pasien kritis.	Mampu melakukan penatalaksanaan pasien kritis dengan LENGKAP dan RUNUT	2	

(Jika, Pressure control maka P inspirasi disetting sampai target VT tersebut) 4) Menentukan PEEP PEEP awal = 5 cmH₂O 5) Menentukan FiO₂ FiO₂ awal 100% 6) Menentukan Minute Ventilation (MV) MV = 100 ml/kg = 5 L 7) Menentukan laju napas (RR) RR disesuaikan (maksimum 35 x/menit) untuk mencapai MV 8) Menentukan I:E ratio I : E = 1 : 1,0–1,3 9) Mengamati Pplateau di monitor Pplateau tidak lebih dari 30 cmH₂O						
4b. Kemampuan Penatalaksanaan Pasien Kritis dan Penyulit (Farmakologis dan Non-Farmakologis) Pemantauan pasca <i>setting</i> inisial ventilator: 1) Menaikkan PEEP sampai 12 (target SpO₂ 88-95%)	Tidak mengubah <i>setting</i> ventilator.	-	Menaikkan PEEP.	Menaikkan PEEP sampai 12 dan menurunkan FiO ₂ .	2	

Menurunkan FiO2 (target SpO2 88-95%)						
5. Komunikasi, Edukasi dan Profesionalisme 1. Melakukan setiap tindakan dengan berhati-hati dan teliti sehingga tidak membahayakan pasien dan diri sendiri 2. Memperhatikan kenyamanan pasien 3. Melakukan tindakan sesuai prioritas 4. Menunjukkan rasa hormat kepada pasien 5. Mengetahui keterbatasan dengan merujuk atau melakukan konsultasi bila diperlukan	Peserta ujian tidak meminta izin secara lisan dan sama sekali tidak melakukan poin yang diminta	Peserta ujian meminta izin secara lisan dan melakukan 1-2 poin yang diminta	Peserta ujian meminta izin secara lisan dan melakukan 3-4 poin yang diminta	Peserta meminta izin secara lisan dan melakukan poin-poin secara lengkap	1	
TOTAL SKOR						